



Número: **0801310-44.2026.8.10.0001**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**

Órgão julgador: **1ª Vara da Infância e da Juventude de São Luís**

Última distribuição : **12/01/2026**

Valor da causa: **R\$ 10.000,00**

Assuntos: **Tratamento médico-hospitalar**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
ALESSANDRO MACIEL FERNANDES (REPRESENTANTE LEGAL)	JEFFERSON CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
J. H. D. S. F. (AUTOR)	JEFFERSON CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (REU)	YASMIN BREHMER HANDAR (ADVOGADO)
HOSPITAL SAO DOMINGOS LTDA. (REU)	VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA (ADVOGADO)

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
174954893	17/03/2026 17:31	Parecer MPMA	Petição
173660942	03/03/2026 13:24	Decisão (expediente)	Decisão (expediente)
173511849	02/03/2026 12:03	Intimação	Intimação
173058280	27/02/2026 11:18	Decisão	Decisão
173012732	24/02/2026 14:11	Manifestação	Petição
173012734	24/02/2026 14:11	COMPROVANTE PAGAMENTO ACORDO JOSE HENRIQUE DA SILVA FERNANDES	Documento Diverso
172977215	24/02/2026 11:01	Petição	Petição
172685978	20/02/2026 14:12	Ato Ordinatório	Ato Ordinatório
172684499	20/02/2026 14:12	HSD X Alessandro Maciel Fernandes contestação negativa internação.pdf	Contestação
172684512	20/02/2026 14:12	Negativa Jose Henrique da Silva Fernandes	Documento Diverso
172684513	20/02/2026 14:12	Autorização após Liminar Jose Henrique Silva Fernandes	Documento Diverso
172684514	20/02/2026 14:12	ALTA José Henrique da Silva Fernandes	Documento Diverso
172684516	20/02/2026 14:12	1_PDFsam_JOSE HENRIQUE S FERNANDES prontuário	Documento Diverso
172684517	20/02/2026 14:12	37_PDFsam_JOSE HENRIQUE S FERNANDES prontuário	Documento Diverso
172684518	20/02/2026 14:12	75_PDFsam_JOSE HENRIQUE S FERNANDES prontuário	Documento Diverso
172684520	20/02/2026 14:12	112_PDFsam_JOSE HENRIQUE S FERNANDES prontuário	Documento Diverso
172685976	20/02/2026 14:12	149_PDFsam_JOSE HENRIQUE S FERNANDES prontuário	Documento Diverso

17094 8931	29/01/2026 17:22	Petição	Petição
17094 7907	29/01/2026 17:14	Termo de acordo	Petição
17057 4433	26/01/2026 16:34	Petição	Petição
17053 4446	26/01/2026 12:07	Ato Ordinatório	Ato Ordinatório
17053 4436	26/01/2026 12:07	HSD x Alessandro Maciel Fernandes embargos de declaração premissa equivocada.pdf	Embargos de Declaração
17053 4439	26/01/2026 12:07	Substabelecimento interno Hospital São Domingos assinado 2025	Documento Diverso
17053 4441	26/01/2026 12:07	Substabelecimento - Grupo Dasa - Hospital São Domingos - 2025	Documento Diverso
17053 4442	26/01/2026 12:07	Procuração e atos - Grupo Dasa - Hospital São Domingos - 2025	Documento Diverso
17053 4444	26/01/2026 12:07	24 ACS_HSD_CISAO E REDUCAO KS	Documento Diverso
17014 2708	21/01/2026 10:34	Petição	Petição
17010 2469	20/01/2026 18:47	Intimação	Intimação
16977 5042	15/01/2026 16:08	Cumprimento de liminar	Petição
16977 5044	15/01/2026 16:08	Documentos Comprobatórios do Cumprimento de Liminar	Documento Diverso
16974 3290	15/01/2026 12:12	Pedido de habilitação	Petição
16974 3293	15/01/2026 12:12	PROCURAÇÃO - Amil - José Lauro Seixas Advogados - Ad Judicia - 2051 - Amil - José Lauro Seixas Advog	Documento Diverso
16974 3294	15/01/2026 12:12	ESTATUTO SOCIAL - parte 1	Documento Diverso
16974 3295	15/01/2026 12:12	ESTATUTO SOCIAL - parte 2	Documento Diverso
16974 3297	15/01/2026 12:12	Substabelecimento	Documento Diverso
16974 3298	15/01/2026 12:12	CARTA DE PREPOSIÇÃO	Documento Diverso
16962 3462	14/01/2026 10:28	Petição	Petição
16962 5192	14/01/2026 10:28	Gmail - Decisao	Documento Diverso
16957 0201	14/01/2026 10:10	Ciência MPMA	Petição
16951 7125	13/01/2026 09:28	Citação	Citação
16951 7124	13/01/2026 09:28	Citação	Citação
16951 1385	13/01/2026 08:39	Intimação	Intimação
16951 1384	13/01/2026 08:39	Intimação	Intimação
16948 6445	12/01/2026 19:25	Decisão	Decisão
16947 6465	12/01/2026 15:26	Certidão	Certidão
16941 5667	12/01/2026 14:32	Decisão	Decisão
16940 8191	11/01/2026 15:45	Petição Inicial	Petição Inicial
16940 8192	11/01/2026 15:45	Doc. 01 - Procuração e declaração de hipossuficiência - José Henrique da Silva Fernandes	Procuração
16940 8193	11/01/2026 15:45	Doc. 02 - Certidão de Nascimento com CPF - José Henrique	Documento de identificação
16940 8194	11/01/2026 15:45	Doc. 03 - Documento de ident do genitor	Documento de identificação

16940 8195	11/01/2026 15:45	Doc. 04 - Comprovante de residência	Comprovante de endereço
16940 8196	11/01/2026 15:45	Doc. 05 - Receita-Requisição Médica - Hospital São Domingos	Documento Diverso
16940 8197	11/01/2026 15:45	Doc. 06 - Negativa do plano de saúde	Documento Diverso

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, pelo Promotor de Justiça signatário, vem apresentar parecer de mérito, na forma que se segue.

1. RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada por **José Henrique da Silva Fernandes**, nascido em 06/03/2025, neste ato representado por seu genitor, Alessandro Maciel Fernandes, em face de **Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Hospital São Domingos LTDA**.

Conforme a exordial, o infante deu entrada no Hospital São Domingos em **11/01/2026**, apresentando quadro de febre, tosse ladrante e intensa prostração, sendo diagnosticado com Laringite Aguda (CID J04.0). Diante da gravidade e necessidade de monitorização, suporte de oxigênio e medicação hospitalar, houve indicação médica imediata para internação em **UTI Pediátrica**. Contudo, a operadora de saúde negou a cobertura sob o fundamento de carência contratual.

Cronologia Processual Relevante:

- 13/01/2026:** Decisão interlocutória deferindo a tutela antecipada de urgência (ID 169486445), determinando a imediata internação e custeio integral do tratamento pelos requeridos, sob pena de multa diária.
- 15/01/2026:** Petição da operadora Amil (ID 169775042) confirmando o cumprimento da medida liminar.
- 18/01/2026:** O paciente recebeu alta hospitalar após melhora do quadro clínico, conforme relatório médico de evolução (ID 170534444 e seguintes).
- 26/01/2026:** Juntada de documentos diversos e atos ordinatórios (IDs 170534444, 170534446, 170574433).
- 29/01/2026:** Protocolo de **Petição de Acordo** (IDs 170947907 e 170948931), na qual as partes informam a composição da lide, com a operadora confirmando a obrigação de fazer e o cumprimento da liminar.
- 20/02/2026:** Apresentação de contestação pelo Hospital São Domingos (ID 172684499) e documentos de negativa (IDs 172684512 e 172684513).
- 02/03/2026:** Intimação eletrônica deste representante do Ministério Público para manifestação como fiscal da ordem jurídica.

É o breve relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO



A intervenção deste órgão ministerial fundamenta-se no **art. 127 da Constituição Federal** e no **art. 201, incisos VIII e IX, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90)**, visando zelar pelo respeito aos direitos assegurados à criança e ao adolescente.

Do Direito à Saúde e da Prioridade Absoluta A questão central orbita o direito fundamental à saúde de um infante de apenas dez meses, cuja vida foi posta em risco por uma negativa administrativa baseada em cláusulas contratuais de carência. A **Constituição Federal, em seu art. 227**, estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com **prioridade absoluta**, o direito à vida e à saúde.

O **Estatuto da Criança e do Adolescente**, em seu **art. 11**, reforça o acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde, proibindo qualquer forma de negligência que coloque em risco a integridade do menor. No caso em tela, o diagnóstico de laringite aguda com necessidade de UTI pediátrica configurava perigo concreto e atual.

Da Ilegalidade da Negativa de Cobertura É pacífico na jurisprudência pátria e na doutrina que, em casos de **urgência e emergência**, as cláusulas de carência devem ser mitigadas em favor da preservação da vida. A saúde não é mercadoria, e a responsabilidade entre hospital e operadora de plano de saúde é **solidária** perante o paciente em situação de risco. A imposição da obrigação de fazer via tutela de urgência foi, portanto, medida acertada e em consonância com o ordenamento jurídico.

Da Autocomposição As partes peticionaram conjuntamente informando a realização de acordo, no qual a operadora de saúde reconhece a obrigação e o cumprimento da medida liminar, satisfazendo a pretensão autoral. Considerando que o direito à saúde do infante foi integralmente garantido e que ele já obteve alta hospitalar com alta taxa de sucesso clínico, não há óbice à homologação da avença.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, na qualidade de **fiscal da ordem jurídica**, este **MPMA** manifesta-se:

Pela **HOMOLOGAÇÃO** do termo de acordo firmado entre as partes (IDs 170947907 e 170948931), por entender que ele atende ao **superior interesse da criança** e encerra a controvérsia de forma célere e eficaz;

Pela consequente **EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO**, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.

É o parecer.

São Luís/MA, data da assinatura eletrônica.

MÁRCIO THADEU SILVA MARQUES

Promotor de Justiça



Tipo de ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

Autor: SEGREDO DE JUSTIÇA

Advogado do(a) AUTOR: JEFFERSON CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MA25841

Advogado do(a) REPRESENTANTE LEGAL: JEFFERSON CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MA25841

Requerido: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado do(a) REU: YASMIN BREHMER HANDAR - PR97751

Advogado do(a) REU: VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - MA4749-A

Vistos e examinados de id n.º 173058280(Publicado nos termos do Provimento n.º 39/2020-CGJMA):1. Isto posto, conheço os embargos declaratórios opostos em Id. 170534436 e no mérito, rejeito-os integralmente.12. Intimem-se. Abra-se vista dos autos ao MPE. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de homologação de acordo judicial formulado entre as partes, Ids. 172977215 e 173012732. São Luís, 24 de fevereiro de 2026. **JOSÉ AMÉRICO ABREU COSTA**.Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Infância e Juventude de São Luís





ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS

Processo n.º 0801310-44.2026.8.10.0001

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Nesta data, nos termos do Provimento n.º 22/2018 da CGJMA, INTIMO eletronicamente o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para que se manifeste nos autos como fiscal da ordem jurídica. São Luís, 02/03/2026.

WALDEMIR CARDOSO ALVES

Tecnico Judiciario Sigiloso



VISTOS

-

1. Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA., já devidamente qualificado nos autos, em face da decisão proferida no id. 169486445, sob a alegação de omissão e erro material.

2. Sustenta a embargante que *“(...) sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para que seja eliminado o erro material (premissa fática equivocada) apontado, para que seja individualizada as obrigações de cada um dos requeridos, a fim de que não seja aplicada multa ao Hospital por descumprimento que foi ocasionado exclusivamente pelo convênio: a) para a operadora de saúde, AUTORIZAR E CUSTEAR todo o tratamento indicado ao paciente, inclusive autorizar e custear os OPMEs necessários para a realização do procedimento; b) para o Hospital, submeter o autor ao tratamento solicitado, assim que autorizado pelo convênio.”.*

3. Eis em síntese, o relato necessário. Decido.

4. Tempestivos os embargos declaratórios, conheço-os.

5. Recurso com previsão no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm cabimento quando, em qualquer decisão judicial, houver obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria o julgador se manifestar expressamente ou ainda, caso haja erro material.

6. A embargante fundamenta seu pedido sob a alegação de existência de omissão e erro material no *decisum* embargado, apontando que *“(...) Inicialmente, verifica-se ter a decisão liminar deixado, data venia, de individualizar qual seria “O demandado” a quem a obrigação de fazer foi imposta. Sendo assim, de logo, identifica-se tal omissão, mostrando-se necessário o esclarecimento de para qual parte requerida o Juízo determinou a obrigação de autorizar e custear a internação e demais procedimentos indicados ao paciente. Além disso, a se considerar que o Juízo tenha imposta obrigação para os dois demandados, ou seja, para a operadora de saúde e também para o hospital, identifica-se ter a decisão liminar incorrido ainda, permissa venia, em erro material por premissa fática equivocada.”.*

7. Verifica-se, contudo, que os argumentos lançados pela embargante em sua peça, tem por objeto a reapreciação do mérito da questão, inclusive com a reanálise do conjunto probatório, o que não se admite.

8. A reforma ou invalidação de decisão pelo próprio Juízo prolator, somente pode ocorrer nas hipóteses em que há



previsão legal para o Juízo de retratação e, por ser exceção à regra de análise do mérito recursal, não deve ser interpretada extensivamente.

9. A jurisprudência é clara neste sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO . DESATENDIMENTO ÀS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO .

1. Os embargos de declaração tem cabimento contra qualquer decisão e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. 2. São descabidos os embargos declaratórios quando buscam meramente rediscutir, com intuito infringente, o mérito da decisão impugnada, providência incompatível com a via eleita . 3. A mera desconformidade do embargante com a rejeição da tese que entende cabível não caracteriza omissão, devendo ser atacada pelo meio processual idôneo, e não pela via estreita dos embargos de declaração. Omissão inexistente. 4 . Em face da discussão acerca de eventual prequestionamento e considerando a disciplina do art. 1.025 do CPC/2015, os elementos que a parte suscitou nos embargos de declaração serão considerados como prequestionados mesmo com sua rejeição, desde que tribunal superior considere que houve erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ou seja, o novo CPC acabou por consagrar expressamente a tese do prequestionamento ficto, na linha de como o STF pacificou entendimento por meio do verbete sumular 356. (TRF-4 - AC: 50217478320214047000 PR, Relator.: LUIZ FERNANDO WOVK PENTEADO, Data de Julgamento: 25/06/2024, 10ª Turma)" (Fonte: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/trf-4/2578296703>, acesso em 17.10.2025 às 09:27h)

10. Assim, considerando que os embargos de declaração não conferem ao juízo *a quo* a prerrogativa de retratar-se dos termos da decisão antes prolatada, eventual discussão tendente a alterar o mérito da causa cabe apelação ou agravo de instrumento, a depender do caso concreto, para a Superior Instância, face o encerramento da jurisdição de primeiro grau com a prolação de sentença/decisão.

11. Isto posto, conheço os embargos declaratórios opostos em Id. 170534436 e no mérito, rejeito-os integralmente.

12. Intimem-se. Abra-se vista dos autos ao MPE. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de homologação de acordo judicial formulado entre as partes, Ids. 172977215 e 173012732.

São Luís, 24 de fevereiro de 2026.

JOSÉ AMÉRICO ABREU COSTA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Infância e Juventude de São Luís



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE SÃO LUÍS/MA

PROCESSO Nº 0801310-44.2026.8.10.0001



AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, devidamente qualificada nos autos da presente demanda ajuizada por **JOSÉ HENRIQUE DA SILVA FERNANDES**, representado por seu genitor **ALESSANDRO MACIEL FERNANDES**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de sua advogada infra-assinada, juntar aos autos o comprovante de pagamento do acordo celebrado, requerendo sua homologação e a consequente extinção do processo.

Termos em que pede deferimento.
(Local e data da assinatura eletrônica)

YASMIN BREHMER HANDAR

OAB/DF nº 64.819

OAB/PR nº 97.751

OAB/AP nº 5.448

OAB/SE nº 1.754A

OAB/SP nº 53.5137

BRASÍLIA SÃO PAULO ARACAJU CURITIBA RECIFE

juridico@seixasadv.com

seixasadv.com





Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: 2000499011

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERN

Agência: 0262

Conta corrente: 58300 - 8

Dados da conta creditada:

Nome: JEFFERSON

Agência: 4525

Conta corrente: 51720 - 9

Valor: R\$ 5.000,00

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 20/02/2026 às 04:40:15 via Sispag, CTRL 002751216840000.

Autenticação:

30B31EEDF3089090E0504932B0ED8E7E5F5F0B5A

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itaú.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



**AO JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS,
DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS - MA**

Processo nº 0801310-44.2026.8.10.0001

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA FERNANDES, menor impúbere, representado por seu genitor **ALESSANDRO MACIEL FERNANDES**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seu advogado signatário, reiterar o pleito de **homologação do acordo extrajudicial** em juízo, nos termos do artigo 725, VIII e 515, II, ambos do CPC, bem como a consequente extinção do feito nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, visto que o acordo fora devidamente cumprido pela 1ª requerida, conforme pactuado.

Termos em que pede deferimento.

São Luís - MA, 24 de fevereiro de 2026.

Jefferson Carneiro de Oliveira Júnior

OAB/MA 25.841





TJMA
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
1ª Vara da Infância e da Juventude de São Luís

Processo nº. 0801310-44.2026.8.10.0001–PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: ALESSANDRO MACIEL FERNANDES e outros

ADVOGADO: Advogado do(a) AUTOR: JEFFERSON CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MA25841

Advogado do(a) REPRESENTANTE LEGAL: JEFFERSON CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MA25841

RÉU: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

ADVOGADO: Advogado do(a) REU: YASMIN BREHMER HANDAR - PR97751

Advogado do(a) REU: VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - MA4749-A

ATO ORDINATÓRIO

(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, art. 1º, Inciso XIII, da CGJ/MA)

Em virtude das atribuições que me são conferidas por Lei, e em obediência ao que dispõe o art. 93, inciso XIV da Constituição Federal, art. 203 § 4º do CPC e no Provimento nº. 22/2018-CGJ, art. 1º, Inciso XIII, INTIMO a parte Autora, por intermédio do seu procurador, para que, apresente(m) a sua resposta à(s) Contestação(ões), no prazo prazo legal.

SÃO LUÍS/MA, Sexta-feira, 20 de Fevereiro de 2026

Datado e assinado digitalmente



AO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SÃO LUIS - MARANHÃO**Processo nº 0801310-44.2026.8.10.0001****Requerente: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA FERNANDES, representado por ALESSANDRO MACIEL FERNANDES****Requeridos: HOSPITAL SÃO DOMINGOS E AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA**

HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA, já qualificado nos autos da ação supra epigrafada, que contra si e outro move **JOSÉ HENRIQUE DA SILVA FERNANDES, representado por ALESSANDRO MACIEL FERNANDES**, por suas advogadas ao final assinadas, vem perante V. Exa. apresentar sua **CONTESTAÇÃO**, o que faz pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

1. DA TEMPESTIVIDADE

A citação do São Domingos foi promovida, em 13/01/2026, através de seu domicílio eletrônico, com registro de ciência na data de 14/01/2026 (vide data para manifestação na Aba “Expedientes” do processo).

Para as citações por domicílio eletrônico, o prazo de contestação se inicia após o quinto dia útil depois da confirmação da ciência (Resolução CNJ nº 569, de 13/08/2024), então, a princípio, o prazo em questão teria início na data de 21/01/2026.

Contudo, considerando que, do dia 14/01/2026, quando houve ciência automática, até o dia 20/01/2026, os prazos processuais ainda estavam suspensos devido ao recesso forense (art. 220 do CPC/15), motivo pelo qual os 5 dias que antecedem o termo inicial só foram computados a partir do dia 21/01/2026, quando os prazos processuais tiveram seu reinício (fim do recesso forense). Dessa forma, o termo inicial do prazo para contestar prorrogou-se para o dia 28/01/2026 (vide aba expedientes do processo).



Já o termo final, este se prorrogou para dia 20/02/2026, haja vista que não houve expediente forense nos dias 16,17 e 18/02/2026, em virtude do período de Carnaval (Resolução GP 131/2025, do TJ/MA). Assim, protocola a presente manifestação na data ao final consignada é a mesma tempestiva.

2. BREVE SINTESE DA EXORDIAL - DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NOS AUTOS – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO HOSPITAL E NÃO APRECIADOS – DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AUTOR E OPERADORA DE SAÚDE, PARA ENCERRAR A DEMANDA

Alega o autor que, em 11/01/2025, deu entrada na emergência do Hospital São Domingos, apresentando quadro clínico grave, caracterizado por tosse ladrante, febre e intensa prostração.

Diz que, após avaliação inicial, recebeu indicação de internação em UTI, para monitorização hospitalar intensiva, suporte contínuo de oxigênio e administração medicamentosa adequada.

Informa que a operadora de saúde negou autorização a essa internação em UTI, sob alegação de ainda estar o autor cumprindo prazo de carência contratual.

Afirma que a negativa foi abusiva, por se tratar de atendimento de emergência.

Pedidos: a) concessão de tutela de urgência, para compelir os requeridos a autorizarem e realizarem a internação do autor em UTI; b) procedência da ação, com confirmação da tutela e condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais (honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa).

Em resposta ao pleito formulado, o Juízo concedeu a tutela pleiteada e, assim, determinou ao demandado que autorizassem e custassem *“integralmente a internação e todos os procedimentos necessários para a manutenção e preservação da vida do infante José Henrique da Silva Fernandes, de forma imediata, a contar da intimação desta decisão, com a garantia de tratamento e atendimento integral e especializado”*.

Considerando que o Juízo não individualizou qual seria “O demandado” a quem a obrigação de fazer foi importa e, além disso, considerando que o encargo de autorizar e custear



procedimentos/internações dos beneficiários é exclusivo das operadoras de saúde e nunca dos hospitais, que são meros prestadores de serviço hospitalar, o São Domingos opôs embargos de declaração, o qual não foi ainda apreciado.

Seguindo o trâmite processual, em 29/01/2026, o autor e a operadora de saúde requerida firmaram acordo para encerramento da demanda, mediante o qual a AMIL se comprometeu a pagar, a título de danos morais e honorários advocatícios, o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). As partes pediram a homologação do acordo e, em petição protocolada no ID 170948931, o autor manifestou, claramente, a intenção de que, diante da homologação do acordo, o processo fosse definitivamente extinto, **concluindo-se, assim, pelo encerramento da demanda também em face do Hospital, até porque o manejo da ação foi motivado pela negativa de autorização da AMIL, para a internação indicada ao requerente.**

3. PRELIMINARMENTE

3.1 VERDADE DOS FATOS - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA

Ab initio, cumpre esclarecer que o Hospital São Domingos não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, isto porque é completamente alheio à relação jurídico-processual em questão, mantida entre autor/beneficiário e operadora de saúde, **tanto que o autor, ao firmar acordo com a requerida AMIL – que negou inicialmente autorização à sua internação, pugnou pela extinção definitiva do feito, o que evidencia o encerramento da lide em face também do hospital.**

O autor deu entrada na emergência pediátrica do Hospital São Domingos em 11/01/2026. Nesse momento, foi avaliado em consulta médica, sendo-lhe prescritos exames laboratoriais e de imagem e observação em leito da emergência pediátrica, até que os resultados dos exames ficassem disponíveis, para o paciente ser reavaliado.

Com o resultado dos exames, o autor foi reavaliado e, aí sim, o diagnóstico de laringite aguda foi confirmado e a internação foi indicada.

Aqui abre-se um parêntese para esclarecer que, enquanto os exames eram realizados, enquanto os resultados desses exames não eram liberados e enquanto as medicações iniciais eram



administradas, o paciente NÃO ficou desassistido. Ao contrário, a criança foi acomodada em leito da observação pediátrica e, nesse leito, ficou recebendo todos os cuidados que se faziam necessários para estabilização do seu quadro clínico, **até porque esse leito de observação é estruturado com todos os aparelhos de monitorização dos sinais vitais e cardíacos, assim como no espaço em que esses leitos estão dispostos, tem-se posto médico e de enfermagem, possibilitando que o paciente seja acompanhado permanentemente.**

Ressalta-se, ainda, que no atendimento inicial de emergência, a criança não recebeu logo indicação para internação, mas recebeu, como dito acima, indicação para ficar sob observação em leito da emergência pediátrica, **até que os resultados dos exames ficassem prontos, para que a equipe médica pudesse também confirmar o diagnóstico e escolher a terapêutica adequada.**

Sendo assim, desde a sua admissão na emergência e mesmo antes de que fosse proferida a decisão liminar concessiva da tutela de urgência – o que ocorreu em 12/01/2026, o Hospital já estava ofertando a devida assistência ao paciente – desde 11/01/2026, sem que tivesse ocorrido qualquer negativa de atendimento por parte do nosocômio.

O resultado dos exames permitiu se definir o diagnóstico e, a partir daí, a internação do paciente foi indicada, para tratamento clínico.

Ante a necessidade de internação, o hospital encaminhou a solicitação de autorização ao plano de saúde, seguindo, assim, os trâmites do processo de autorização, conforme regras estabelecidas pela própria operadora de saúde.

É praxe adotada pelo hospital, no momento da internação, que o paciente ou seu representante firmem termo de responsabilidade (autorizando o tratamento e, caso advenha negativa de cobertura do plano de saúde, responsabilizando-se pelas despesas hospitalares), termo de assunção de dívida e contrato particular de prestação de serviços, mediante os quais também se responsabilizam pelas despesas gerada com o atendimento/tratamento, se o plano de saúde negar autorização para o procedimento.

No caso dos autos, esses documentos foram firmados pelo genitor e representante do paciente, posto que era a praxe administrativa interna do nosocômio, a qual NÃO configura ato ilícito e nem conduta abusiva do hospital.

Pois bem. **O plano de saúde requerido não concedeu a cobertura à internação, sob justificativa de que o paciente ainda estava cumprindo prazo de carência contratual.**



Também é praxe do hospital que, diante da negativa de cobertura, a continuidade do tratamento seja oferecido de forma particular, até que o paciente resolva a pendência junto ao seu plano de saúde ou até que seja proferida decisão liminar, concedendo tutela de urgência e compelindo o plano de saúde a autorizar o tratamento. Na presente demanda, foi assim que se deu, à medida que o representante e genitor do paciente firmou os termos acima citados, autorizando a continuidade do atendimento de forma particular **e, mesmo diante da negativa de cobertura, o paciente foi acomodado em leito de UTI e continuou sendo tratado e assistido pelo hospital.**

E, ao ser deferida a tutela de urgência, tão logo houve a concessão da autorização pelo plano de saúde – por força de decisão liminar – **o hospital converteu a conta hospitalar da internação para conta convênio, não cobrando nenhum valor do paciente.**

Destaca-se que, desde a admissão da paciente, o hospital cumpriu os protocolos de solicitação de autorização, exigidos pela própria operadora de saúde e encaminhou, a tempo, as guias de solicitação de autorização ao plano de saúde.

É certo que **a inconformidade autoral subsiste evidentemente em torno da negativa de cobertura pelo convênio Requerido, para o tratamento médico indicado à criança.** Nesse contexto, há que se reconhecer, de pronto, que o hospital ofertou a assistência médico-hospitalar sem falhas e, por conseguinte, não gerou dano algum à saúde do paciente.

Sabe-se que a decisão do consumidor em procurar uma instituição de saúde privada implica a premissa de um vínculo obrigacional materializado em um acordo de vontades, em que as partes se obrigam a cumprir prestações recíprocas, competindo ao hospital a prestação dos serviços contratados e ao paciente o pagamento do preço correspondente a esses serviços, seja diretamente, seja por meio de plano de saúde.

Diante da negativa de cobertura pela operadora de saúde, insta esclarecer que o Hospital São Domingos, **em nenhum momento, recusou-se a prestar qualquer atendimento médico-hospitalar ao menor, sendo certo que, para que o paciente fosse submetido à requisitada assistência médico-hospitalar por meio de convênio, era necessário que o serviço fosse autorizado pelo plano de saúde junto ao nosocômio, até porque o São Domingos é um estabelecimento hospitalar provado que presta seus serviços mediante cobertura dos planos de saúde conveniados ou mediante contraprestação direta por parte do paciente.**



Nesse sentido, apesar da negativa de cobertura à internação do paciente, o Hospital não mediu esforços para obter a autorização do plano e fornecer todas as informações necessárias para que a parte autora, através de seu representante, tomasse as providências cabíveis junto à sua operadora, eis que é com esta que mantém contrato de custeio de prestação de serviços hospitalares.

Com isso, vê-se que, **se houve lesão ao direito do Autor, esta foi perpetrada por sua operadora de plano de saúde, que não se viu apta a ofertar cobertura ao atendimento médico indicado, não havendo, em verdade, qualquer conduta abusiva ou ilícita praticada pelo hospital ao Demandante. Tal assertiva é tão verdadeira que a operadora de saúde ré firmou acordo extrajudicial com o autor, para pagamento do valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, pela negativa inicial de autorização, pedindo as partes a homologação desse acordo nestes autos e a extinção definitiva da demanda.**

Assim, é notório que o Hospital São Domingos, por ser alheio ao contrato de prestação de serviços médico-hospitalares do Autor com o seu plano de saúde, bem como aos fatos que deram ensejo à presente demanda, deve ser considerado ilegítimo para figurar no polo passivo desta.

Neste sentido, entende a jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NORMAS CONSUMERISTAS. NÃO INCIDÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA COM OXIGENAÇÃO POR MEMBRANA - ECMO. NEGATIVA. ROL DA ANS. DIVERGÊNCIA QUANTO A TAXATIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. APELO ADESIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. REPARAÇÃO MORAL NÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as normas do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, como é o caso dos autos, devendo a relação entre as partes ser submetida aos termos da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, além da aplicação das normas do Código Civil, notadamente as previstas nos artigos 421 e 422. 2. Conforme entendimento já consagrado nesta e. Corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 3. Além de o procedimento ECMO se enquadrar dentro das excepcionalidades elencadas no AgInt no REsp 1934658/CE, em que a



Segunda Seção do c. STJ estabeleceu parâmetros para arcar com tratamentos não constantes do rol da ANS, com o advento da Lei n. 14.454 de 21 de setembro de 2022, que alterou o texto da Lei nº 9.656 de 03 de junho de 1998, trouxe a previsão de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada incorporação, constitui referência básica para os planos privados. Ressarcimento devido. 4. Durante o período de internação, a unidade hospitalar é prestadora de serviço para o plano de saúde, que é o efetivo responsável pelo custeio dos tratamentos, serviços e demais despesas necessárias utilizadas pelo paciente/beneficiário. Os dispêndios devem ficar restritos ao que está contratado entre beneficiário/paciente e seu plano. No caso de recusa do plano, o pagamento será do próprio paciente se este contratar diretamente com a Casa de Saúde. Relação jurídica distinta. Ilegitimidade do hospital reconhecida. 5. Não há falar em condenação por dano moral quando, no momento em ocorreram os fatos, ainda claudicantes as decisões sobre a taxatividade do rol e ter o problema de saúde do autor decorrido da COVID-19, que atemorizou todos os seres humanos, particularmente aqueles que foram acometidos pela doença e os respectivos familiares diante da incerteza quanto aos protocolos clínicos que deveriam ser adotados. 6. Apelação e Recurso Adesivo improvidos. (TJ-DF 07058611920218070001 1654707, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/01/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL - NEGATIVA DE COLOCAÇÃO DE STENT - PLANO CONTRATADO ANTES DA LEI 9.656/98 - NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO CONTRATANTE ALTERAÇÃO DO PLANO. - Embora credenciado da ré, o hospital não possui vínculo contratual com o autor, sendo a operadora de saúde a única que reúne condições de titularizar a obrigação e de atender o comando legal - Conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, as cláusulas excludentes do fornecimento de próteses e órteses não podem ser invocadas quando a entrega de tais materiais for essencial e necessária à realização e ao sucesso do procedimento cirúrgico ou tratamento de saúde cobertos pelo plano contratado pelo consumidor - Ainda que o contrato de seguro de saúde tenha sido celebrado antes do advento da Lei nº 9.656/98, as previsões nele contidas devem ser interpretadas à luz e em consonância com as disposições do Código de Defesa do Consumidor - Cabia à seguradora notificar o contratante para, querendo, alterar seu contrato de prestação de serviços para outro que enquadrasse aos preceitos legais trazidos pela Lei 9.656/98.

(TJ-MG - AC: 10000160560793003 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 05/11/2018, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2018)



Isto posto, é inconteste que deve a presente lide ser extinta sem resolução de mérito quanto ao Hospital São Domingos, dada a sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI do CPC, razão pela qual desde já se requer que seja acolhida a referida preliminar.

4. DO MÉRITO

4.1 DA DEVIDA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - ART. 14, § 3º, I DO CDC – AUSÊNCIA DE DANOS A SEREM INDENIZADOS PELO HOSPITAL

Ressalta-se que o ora Contestante não teve nenhuma participação ou ingerência na relação contratual mantida entre o Requerente e seu plano de saúde, sempre sendo TERCEIRO ALHEIO A PRESENTE RELAÇÃO JURÍDICA. Por certo, todo o cerne da pretensão do Requerente reside na negativa de autorização perpetrada pelo plano de saúde demandado, procedimento administrativo sobre o qual o nosocômio não detém qualquer ingerência.

Nesta senda, ressalta-se que o ato de autorizar ou não os serviços médico-hospitalares é privativo do plano de saúde, o qual detém responsabilidade quanto a eventuais intercorrências relativas a tais procedimentos administrativos.

Outrossim, oportuna é a transcrição de decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na qual se reconhece que o então nosocômio, por ser estabelecimento privado, presta seus serviços por meio de autorizações dos planos de saúde, sendo estes últimos responsáveis pelos danos causados por imbrólios administrativos. Veja-se a título exemplificativo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DECLARATÓRIA C/C INDENIZA-TÓRIA. RECONVENÇÃO. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO. RESPONSABILIDADE DO PACIENTE E/OU RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO. A prestação dos serviços médico-hospitalares restou incontroversa, bem como comprovada pelo hospital a negativa de cobertura das despesas pelo plano de saúde da autora. Boletim de atendimento assinado pela autora no qual consta que, deixando o plano de saúde de cobrir as despesas, a paciente e/ou responsável ficam obrigados ao pagamento da conta hospitalar, parcial ou total. A relação existente entre a operadora do plano de saúde e a autora é distinta da existente entre a autora e o hospital. Negado o pagamento da cobertura pelo plano cabe à autora tomar as providências em face



da operadora e não contra o hospital, o qual, na verdade, prestou o serviço e não recebeu a contraprestação, nem do plano, nem da autora. Por outro lado, não há como perquirir, neste momento, a responsabilidade da operadora pelo pagamento, uma vez que a autora desistiu da ação em relação à UNIMED. Comprovada a origem da dívida e a responsabilidade da autora pelo adimplemento, ausente prova do pagamento, não há falar em inexigibilidade do débito, nem tampouco em ilicitude da inscrição negativa, o que exclui a pretensão de indenização pelo dano moral. Fundamentos da sentença adotados como razões de decidir, com os devidos acréscimos. Honorários majorados nos termos do § 11º, do art. 85, do CPC. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70081393126, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 29-08-2019) (TJ-RS – AC: 70081393126 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 29/08/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2019)

Neste ponto, cabe esclarecer que a responsabilidade civil se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: a) defeito do serviço; b) evento danoso e c) relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano. Portanto, é certo que, ausente a relação de causalidade entre o dano alegado e a conduta do agente, inexistente defeito na prestação de serviço, oportunidade em que não há que se falar em obrigação de indenizar, **o que, conforme demonstrado, é justamente o caso dos autos em relação ao Hospital.**

Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor preconiza expressamente que não há dever de indenizar quando o fornecedor prova que o defeito na prestação do serviço é inexistente ou que o evento danoso decorreu exclusivamente por culpa de terceiro, senão se veja:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexistia.

Vê-se, assim, que nenhuma irregularidade ou ilicitude foi praticada pelo nosocômio, não podendo responsabilizar quem não causou nem por ação ou omissão supostos danos, tendo em vista que não restou provado o nexo de causalidade existente entre a narrativa do Autor, os danos alegados e a conduta do Hospital.



Diante da configuração da excludente de responsabilidade constante no art. 14, § 3º, II do Código de Defesa do Consumidor, requer-se a improcedência da presente demanda em relação ao Hospital São Domingos.

4.2 DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS EM FACE DO NOSOCÔMIO QUANTO AOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL

Inicialmente, vem o hospital suscitar o descabimento da inversão do ônus da prova, haja vista que o nosocômio está acostando a esta peça de defesa todos os documentos relativos ao atendimento ofertado ao paciente.

Ademais, a inversão do ônus *probandi* se mostra descabida também porque o autor não provou o fato constitutivo de seu alegado direito, em relação ao Hospital, à medida que os documentos juntados à inicial não provam que o Hospital tenha negado atendimento/internação à criança, **o que, por si só, já afasta o dever de indenizar, posto que não resta demonstrada a fundamentação fática necessária ao deferimento do pleito indenizatório contra o hospital.**

E, quanto à negativa de cobertura, **a qual não confunde com negativa de atendimento**, esta só pode ser atribuída ao plano de saúde, **à medida que não cabe ao hospital autorizar ou negar qualquer tipo de procedimento indicado aos beneficiários de plano de saúde conveniados, devendo se reconhecer que o nosocômio atua como mera prestador do serviço hospitalar.**

Portanto, o autor não demonstrou o fato constitutivo de seu alegado direito, o que era ônus seu fazer, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015:

*Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (...)*

Os documentos acostados à inicial, nenhum deles servem como prova de que o nosocômio falhou no atendimento/tratamento do paciente.

Deste modo, **considerando que não há prova inconteste de falha na prestação do serviço ofertado pelo São Domingos**, é evidente que o Nosocômio não tem nenhuma responsabilidade com o fato narrado na inicial, não se podendo falar em qualquer dever de



indenizar. Se o requerente afirma certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito, a dúvida ou insuficiência de prova quanto a tais fatos constitutivos milita contra a pretensão autoral, fazendo-se necessário que juiz julgue o pedido improcedente se a parte autora não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito.

Em que pese o ônus da prova incumbir ao fornecedor de serviço, em hipóteses de alegada falha na prestação dos serviços, **o fato é que, neste caso, a inversão do ônus da prova dos fatos narrados na inicial acarretaria verdadeira prova diabólica, visto que é impossível ao hospital produzir prova negativa, demonstrando que não atuou com falha no atendimento do paciente.**

Assim sendo, diante da total ausência de provas quanto aos alegados danos suportados pelo autor, não se admite seja imputado ao Contestante o ônus legal que é exclusivo do paciente, pelo que se requer seja indeferido o pedido de inversão do ônus da prova.

Aliás, deve-se destacar que o Hospital ofertou seus serviços hospitalares de forma eficiente e satisfatória, não havendo qualquer indício de falha no atendimento e cabendo se invocar, em favor do Nosocômio o art. 14, § 3º, inciso I, do CDC.

5. DOS PEDIDOS

DIANTE DO EXPOSTO, pugna o nosocômio, ora Contestante, pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, julgando V. Exa. extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao Hospital São Domingos LTDA, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Se assim não entender esse Juízo, caso seja ultrapassada a preliminar supracitada, requer seja julgada IMPROCEDENTE *in totum* a demanda em relação ao Hospital, à mingua de provas que comprovem a prática, pelo São Domingos, de ato lesivo ao autor **e, principalmente, porque o autor já firmou acordo extrajudicial com a AMIL, no qual a operadora, ao se comprometer pagar danos morais no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), acaba reconhecendo que, de fato, houve a negativa inicial de cobertura à internação indicada ao paciente.**

Por oportuno, pede também o hospital a homologação desse acordo firmado entre autor e AMIL e **a determinação de extinção do feito, também em face do São Domingos, por restar demonstrado nesta peça de defesa que o nosocômio não deu causa aos fatos narrados na inicial.**



Por fim, protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidas, notadamente pela juntada de novos documentos.

Termos em que, pede e espera deferimento.

São Luís (MA), 20 de fevereiro de 2026.

Valéria Lauande Carvalho Costa

OAB/MA 4.749

Luciana M^a Chaves Mendes Rego

OAB/MA 4.979



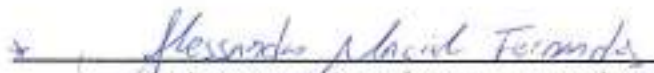
DECLARAÇÃO

O hospital São Domingos, em atenção ao dever de informação, comunica ao Sr.(a) o motivo de negativa de autorização ou status do pedido para realização do procedimento e/ou serviço solicitado, conforme exposto abaixo:

Nome do Paciente	Jose Henrique da Silva Fernandes
N° da Carteira	095391714
Convênio	Amil
Número do Pedido	487139417
Status do Pedido	Negado
Data da Ocorrência	11.01.2026
Motivo	Carência contratual

Para maiores informações, necessário que entre em contato com o seu plano de saúde.

Hospital São Domingos


Assinatura paciente/representante legal



FICHA DE ATENDIMENTO
INTERNAÇÃO



9108291

Nome do Paciente		Prontuário Único		Data	Obs.:	Horário
Jose Henrique da Silva Fernandes		1116047		11/01/2026		08:17:29
Convênio		Caráter Atend.		Código Segurado		Nº Atendimento
PARTICULAR		☐ Eletiva ☒ Urg.		095391714		9.108.291
Sexo		Data Nascto. / Idade		Profissão		
☒ Masculino ☐ Feminino		06/03/2025 0 anos		Autônomo		
Cor	Nº Doc. Identidade	C.P.F.		Nacionalidade		Estado Civil
				Brasileiro		Solteiro
Endereço		Bairro			CEP	
Rua 4G 4		Cidade Operária			65058247	
Compl Endereço		Cidade			Estado	Telefone
a		São Luís			MA	985108882

Nome do Médico	Nº CRM	
Helida Cristina Alcantara Vicente - Pediatria	4026	
		Recepcionista
		helida.vicente



amil

GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO

V.4.0
Atualizado em 01/05/2019

2 - N° Guia em Possessão 9478119

1 - Registro ANS 326305	2 - Número da Guia Autorizada pelo Operadora	3 - Data de Autorização 11/01/2026	4 - Sexo	5 - Data de Validade da Guia
----------------------------	--	---------------------------------------	----------	------------------------------

Dr. Helga Cristina Alcântara Vicente
CRM: 4026 - PA
Medicina Pediátrica

Dados do Beneficiário		
6 - Número da Câmera 095391714	7 - Validade da Câmera 11/01/2026	8 - Atendimento de RH N
9 - Nome Social Jose Henrique da Silva Fernandes		
10 - Nome Jose Henrique da Silva Fernandes		

Dados do Contratado Solicitante	
11 - Código na Operadora 10461132	12 - Nome do Contratado Hospital Sao Domingos Ltda
13 - Nome do Profissional Solicitante Helida Cristina Alcântara Vicente	14 - Conselho Profissional 06
15 - Número no Conselho 4026	16 - UF MA
17 - Código CBO 225124	

Dados do Hospital Local Solicitado / Dados da Internação					
18 - Código na Operadora / CNPJ 10461132	19 - Nome do Hospital Local Solicitado Hospital Sao Domingos Ltda	20 - Data sugerida para internação			
21 - Caracter do Atendimento	22 - Tipo de Internação 4	23 - Regime de Internação 2			
24 - Gênero, Outras Solicitações	25 - Previsão de uso de CPAP N	26 - Previsão de uso de oximetria N			

27 - Indicação Clínica PACIENTE COM FEBRE, DISPNEICO, COM TOSSE LADRANTE, POUCA MELHORA NA OBSERVAÇÃO NECESSITA DE MONITORIZAÇÃO E OXIGENIOTERAPIA
--

Hipóteses Diagnósticas				
28 - CID 10 Principal (Opcional) J040	29 - CID 10 (1) (Opcional)	30 - CID 10 (2) (Opcional)	31 - CID 10 (3) (Opcional)	32 - Indicação de Alergia (alergia ou doença relacionada) 9

Procedimentos Solicitados					
33 - Tabo	34 - Código de procedimento	35 - Descrição	36 - Qtd Solic.	37 - Qtd Autor.	
01 22	10104011	Atendimento do intensivista diário (por dia e por paciente)	1	0	
02 22	10104020	Atendimento Médico Do Intensivista Em UTI Geral Ou Pediátrica (Plantão De	2	0	
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					

Dados de Autorização		
38 - Data Prevista da Admissão Hospitalar	39 - Gênero, Outras Solicitações	40 - Tipo de Atendimento Autorizado 52
41 - Código na Operadora / CNPJ autorizado 10461132	42 - Nome do Hospital Local Autorizado Hospital Sao Domingos Ltda	43 - Código CBO 2308665

44 - OBSERVAÇÃO Adicional	
Atendimento	

45 - Data da Solicitação	46 - Assinatura do Profissional Solicitante	47 - Assinatura do Beneficiário ou Responsável	48 - Assinatura do Responsável pela Autorização
--------------------------	---	--	---



Contrato de Prestação de Serviços Médico-Hospitalares para Paciente Particular ou Usuário de Plano de Saúde firmado entre as partes qualificadas abaixo.

Contratada: Hospital São Domingos CNPJ: 11008293000130
Endereço: Av. Jerônimo de Albuquerque, 540 - Bequimão - São Luís - MA
Paciente: José Henrique da Silva Fernandes
RG: CPF:
Endereço: Rua 4G, 4 a Cidade Operária São Luís MA
Tel.: 098 988274397 Cel.: 985108882

Assinatura: _____

Contratante: Alessandro Maciel Fernandes

RG: - CPF: 05152176386
Endereço: Rua 4G, 4 a Cidade Operária São Luís MA
Tel.: 988274397

Assinatura: 

Nº Atendimento: 9108291 Data do Atendimento: 11/01/2026 08:17:29 Leito: L.02

CLÁUSULA 1ª - O paciente e o contratante (simplesmente - particular), nomeados e qualificados na forma acima, expressamente contratam o Hospital para fins de autorizar a cobrança de forma particular da internação e/ou atendimento de emergência do paciente, qualquer atendimento eletivo solicitado pelo médico interessado, executado por si ou por terceiros especializados, independente de autorização prévia, todo e qualquer procedimento, diagnósticos, terapêuticos, laboratoriais, clínicos e cirúrgicos, necessários ao adequado e eficaz tratamento indicado pelo médico.

CLÁUSULA 2ª - O paciente e o contratante (simplesmente - usuário de plano de saúde), nomeados e qualificados na forma acima, expressamente contratam o Hospital para fins de autorizar a cobrança de forma particular da internação e/ou atendimento de emergência do paciente, qualquer atendimento eletivo solicitado pelo médico interessado, executado por si ou por terceiros especializados, independente de autorização prévia, todo e qualquer procedimento, diagnósticos, terapêuticos, laboratoriais, clínicos e cirúrgicos, necessários ao adequado e eficaz tratamento indicado pelo médico, quando seu plano de saúde recusar e não autorizar qualquer evento relacionado a seu atendimento.

Parágrafo Primeiro: No caso de serviços prestados por profissionais e empresas terceirizadas pelo Hospital contratado, necessários ao integral tratamento e recuperação do paciente, fica o particular ou usuário de plano de saúde ciente que deverão custear os honorários desses profissionais.

Parágrafo Segundo: A execução dos serviços contratados relativos ao tratamento de qualquer natureza, depende da expressa requisição do médico responsável pelo paciente.

Parágrafo Terceiro: Havendo recusa de cobertura do plano de saúde, fica desde já informado e advertido o paciente usuário de plano de saúde em referência, que só serão admitidos pacientes que estiverem vinculados aos planos de saúde credenciados e pertencentes à rede de contratados do Hospital, não se configurando ilícito passível de indenização ou de responsabilidade civil ou penal, a cobrança de valores não cobertos pelos planos de forma particular pelo Hospital, através do faturamento da conta hospitalar e respectiva cobrança extrajudicial ou judicial, por se tratar de exercício regular do direito à cobrança pelos serviços prestados em se tratando de instituição privada de saúde, não credenciada ao Sistema Único de Saúde ou a atividade filantrópica de qualquer natureza.

CLÁUSULA 3ª - Para fins de definição, o atendimento ao paciente é continuado podendo ser compreendido por atendimento na emergência seguido de internação, dos quais serão gerados números de atendimentos distintos.

CLÁUSULA 4ª - O Hospital não será responsabilizado por perda, furto, extravio ou qualquer outro evento envolvendo quaisquer pertences do particular ou usuário de plano de saúde e de seus familiares (celulares, eletrônicos, dinheiro, jóias, próteses dentárias, porta cédulas, bolsas etc.), sendo de inteira responsabilidade do seu possuidor enquanto permanecer no interior do estabelecimento hospitalar contratado, quer nos apartamentos, na emergência, nas salas de exames ou em quaisquer outras dependências do contratado, salvo quando a guarda for confiada ao contratado.

Parágrafo Único: Fica o particular ou usuário de plano de saúde obrigado a alertar seus familiares e acompanhantes do inteiro teor do caput desta cláusula, a fim de que guardem e mantenham sob sua responsabilidade e atenção todos os seus pertences, assim como das demais orientações constantes no Guia de Orientações.

CLÁUSULA 5ª - O particular ou usuário de plano de saúde declara estar ciente de sua dupla relação contratual decorrente do tratamento médico-hospitalar a si dispensado, quais sejam:

- I - a relação Hospital x Paciente, obrigando-se o Hospital a oferecer toda a infraestrutura e todos os serviços hospitalares disponíveis ao tratamento do paciente, incluindo-se hotelaria, enfermagem e nutrição;
- II - a relação Médico x Paciente, quando não tiver havido autorização para os médicos credenciados do plano de saúde ou não houver cobertura do especialista pela OPS (usuário de plano de saúde), o paciente particular ou usuário de plano de saúde poderão escolher o profissional médico e equipe distintos daqueles do Hospital, condicionada aos requisitos da condição de médico para aprovação da Diretoria Médica do Hospital, cadastramento para que o mesmo tenha acesso ao Regimento, Login e Senha de uso obrigatório no âmbito do hospital, podendo com estes contratar diretamente, ou seja, sem interferência do hospital.

a) Os honorários ficarão a cargo do paciente/responsável ou de sua família e serão desvinculados da conta hospitalar, devendo sua quitação ser feita a partir de prévio ajuste diretamente com o(s) profissional(is) contratado(s), exceto Anestesiistas e Intensivistas da UTI.

b) Havendo contratação de profissionais não pertencentes ao hospital contratado, exceto Anestesiistas e Intensivistas da UTI, deverão o particular ou usuário de plano de saúde dirigir-se a tais profissionais para o fim de obter informações e/ou explicações sobre seu diagnóstico, tratamento adotado, procedimentos realizados e demais informações técnicas pertinentes à evolução do seu estado clínico, estendendo a obrigação ao contratado de prestar tais informações (vide prontuário).

CLÁUSULA 6ª - O particular ou usuário de plano de saúde assumem solidariamente, em caráter irrevogável e inetratável, independente de nomeação, a obrigação de pagar, todas e quaisquer quantias devidas em razão do tratamento médico hospitalar prestado ao paciente.

CLÁUSULA 7ª - O particular ou usuário de plano de saúde declaram estar cientes de que todos os pagamentos devidos ao hospital em virtude do tratamento recebido deverão ser realizados nos termos desta cláusula e do termo de assunção de dívida, oportunidade em que será emitida a fatura de prestação de serviços, acompanhada da respectiva conta hospitalar, com discriminação dos procedimentos realizados, devidamente aceita pelo paciente, ou, na impossibilidade deste, por seu responsável, o qual neste ato será nomeado por aquele como seu bastante procurador para este fim específico, e na gravidade do estado do paciente que não puder exprimir sua atuação ou outorga de poderes, o responsável estará ciente da assunção da dívida em nome do paciente/contratante para os devidos fins de direito.

Parágrafo Primeiro: As taxas, diárias, gases medicinais e demais serviços técnicos, serão cobrados com base nos preços especificados na Lista Referencial de Diárias e Taxas do Hospital São Domingos, e não incluem o fornecimento de materiais e medicamentos utilizados, que serão cobrados separadamente, de acordo com as normas previstas neste Contrato.

a) Na taxa de diária do acompanhante não há previsão de alimentação, exceto nos casos previstos na Lei.

Parágrafo Segundo: Os medicamentos e materiais hospitalares serão cobrados pelo contratado com base na coluna "preços de venda ao consumidor", do Brasilindico (última edição) e os materiais descartáveis serão cobrados segundo a lista Simpro (última edição), seguindo preço indicado na coluna "preço de fábrica" com acréscimo de 42,86%. Os materiais e medicamentos que não constarem dessas listas serão cobrados com base nos preços dos fabricantes ou fornecedores.

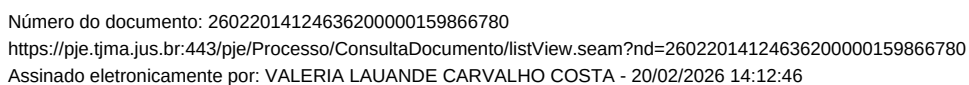


2 - N° Gula no Prestador

5 - Curso de Gestão Ambiental pela Opetecsa

4. Verf.	35 - Gross Part.	36 - Cédigne na Opera
----------	------------------	-----------------------

Associação da Profissão de

CATE02318

Nome

Jose Henrique da Silva Fernandes

Data Nascto

06/03/2025 10 meses

Nº CPF

Endereço

Rua 4G, nº 4, Cidade Operária a

Município

São Luís - MA

Telefone

988274397

Hash

5B6D68B9BD47F8A47F4305DDDE361051

Atendimento

9.108.291

Data Entrada

11/01/2026 08:17

Data Alta

18/01/2026 10:53

Nº Identidade

Unidade

516

Dt. Assinatura

18/01/2026 10:35:04

Documento assinado digitalmente em 2026/01/18 10:35:04, por Médico(a) Luiz Jorge Matos CRM 1532

1. Data da internação:

11/01/2026 08:17:29
2. Motivo da internação:

ADMISSÃO: CRIANÇA 10 MESES DEU ENTRADA EM GRANDE SALA COM TOSSE LADRANTE E FEBRE.
3. Resumo da evolução e plano terapêutico:

PACIENTE SEM FEBRE, TOSSE SECA ESPARSA

ALTA COM RECEITA E ORIENTAÇÕES PARA DOMICILIO
4. Resultado dos principais exames:

HC: LEUCO-11160 56SEG 34LT 2 ATIP PLAQ- 486MIL PCR-0,02

COPRO: RTV/HEMACIAS/EPF- NEGATIVOS

RX TORAX- ESPESSAMENTOS PB E PH
5. Diagnóstico da alta:

J04.0 Laringite aguda /
6. Orientações para a alta:

RETORNO AMBULATORIAL
7. Reconciliação Medicamentosa

7.1 Medicações usadas no domicílio antes da internação:

FERRO 2 gts 1x ao dia ; VITAMINA D 2 gts 1x ao dia ;

7.2 Receita atual para casa:

PROBIOTICO+SINTOMATICOS
8. Necessidade de Reabilitação pós alta hospitalar:

() Fisioterapia

() Psicologia

() Fonoaudiologia

() Nutrição

() Outros:
9. Data da alta:

18012026



Evolução Médico

Paciente	Jose Henrique da Silva Fernandes			Atendimento	9.108.253	
Data Nascto	06/03/2025	10 Meses		Prontuário	1.116.047	
Sexo	Masculino			Dt. Entrada	11/01/2026 04:43:36	
Telefone	98 985108882			Convênio	AMIL 883 AMIL S380 QC	
Leito	L 01					
Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
11/01/2026 04:58	11/01 04:59	Médico(a)	Evolução Médico		Beatriz Morais Costa	CRM 12223
Hash: 6367137AF36383748FF805526E573B7F				Dt. Assinatura: 11/01/2026 05:58		
Documento assinado digitalmente em 11/01/2026 05:58:02, por Médico(a) Beatriz Moraes Costa CRM 12223						

Primeiro atendimento pronto-socorro pediatria

1. Peso: 9,7 kg

2. História da doença atual

CRIANÇA 10 MESES DEU ENTRADA EM GRANDE SALA COM TOSSE LADRANTE E FEBRE.

3. Doenças prévias: (X) NÃO () SIM

4. Uso de medicações:

5. Alergias: (X) NÃO () SIM

6. Exame Físico

REG, ACIANÓTICO, ANICTÉRICO, FEBRIL, NORMOCORADO, SUDOREICO, CHOROSO

AR: MV PRESENTE, ESTRIDOR LARÍNGEO

HD: LARINGITE AGUDA

7. Conduta:

() Alta com receita e orientações

(X) Observação / Coleta de exames - NBZ COM ADRENALINA + DEXA + RXT

() Internação



A - Reavaliação Pediátrica

Paciente	Jose Henrique da Silva Fernandes			Atendimento	9.108.253	
Data Nascto.	06/03/2025	10 Meses		Prontuário	1.116.047	
Sexo	Masculino			Dt. Entrada	11/01/2026 04:43:36	
Telefone	98 985108882			Convênio	AMIL 883 AMIL S380 QC	
Leito	L 01					
Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
11/01/2026 07:03	11/01 07:04	Médico(a)	A - Reavaliação		Beatriz Morais Costa	CRM 12223
Hash: 4B5FB3C4D36AE016C4168C3C733FD859				Dt. Assinatura: 11/01/2026 08:03		
Documento assinado digitalmente em 11/01/2026 08:03:08, por Médico(a) Beatriz Moraes Costa CRM 12223						

Reavaliação Pediátrica

Hora: 06:55

Estado clínico atual:
MELHORA IMPORTANTE, PORÉM AINDA APRESNETANDO TOSSE LADRANTE E ROUQUIDÃO -
MELHORA DA FEBRE.
MANTÉM SINAIS VITAIS ESTÁVEIS, COM BOA SATURAÇÃO (95%) E FC ADEQUADA.

RX TORAX SEM ALTERAÇÕES

PRESCREVO MAIS UM CICLO DE ADRENALINA + CLENIL NBZ + DEIXO RECEITA PARA CASA
ALTA APENAS APÓS REAVALIAÇÃO MÉDICA

Exames complementares:

Desfecho:

Beatriz Moraes Costa
Médico(a) CRM 12223



Evolução Médico

Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo: Masculino
Telefone: 98 985108882
Leito: L 01

Atendimento: 9.108.253
Prontuário: 1.116.047
Dt. Entrada: 11/01/2026 04:43:38
Convênio: AMIL 883 AMIL S380 QC

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
11/01/2026 08:14	11/01 08:16	Médico(a)	Evolução Médico		Helida Cristina Alcantara Vicente	CRM 4026

Hash: 59297D0E4D33A4B539CA7290B67C2D35 Dt. Assinatura: 11/01/2026 09:13:36
Documento assinado digitalmente em 11/01/2026 09:13:36, por Médico(a) Helida Cristina Alcantara Vicente CRM 4026

**SOLICITO INTERNAÇÃO EM LEITO UTI PED
SAT 98%
T;37
FR 23
PACIENTE AINDA COM TOSSE ROUCA,ESTADO FEBRIL,
POUCA MELHORA APOS MEDICAÇÕES
TOLERA DIETA V.O.
RX DE TORAX ESPESSAMENTO BRONQUICO
CD;INTERNAÇÃO UTI PED
AP;RONCOS**

Helida Cristina Alcantara Vicente
Médico(a) CRM 4026



Ev.Enf.- Classificação de Risco/PED

Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo: Masculino
Telefone: 98 985108882
Leito: L 01

Atendimento: 9.108.253
Prontuário: 1.116.047
Dt. Entrada: 11/01/2026 04:43:36
Convênio: AMIL 883 AMIL S380 QC

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
11/01/2026 05:06	11/01 05:09	Enfermeiro(a)	Ev.Enf.- Classificação		Patricia Dalana de Farias	

Hash: 09F6C9424974D88EBC320D564A545C07

Dt. Assinatura: 11/01/2026 06:07

Documento assinado digitalmente em 11/01/2026 06:07:35, por Enfermeiro(a) Patricia Dalana de Farias

Evolução de Enfermagem - Classificação de Risco Pediátrica.

1. **Queixa principal:** MENOR COM TSSE LADRANTE E FEBRE, TAX 38,3, REALIZADO MEICAÇÃO CONFORME PRESCRITO
2. **Realizado protocolo de febre na classificação de risco?** Sim (☒) Não (☐) NA (☐)
3. **Sinais de alarme?** ((Ex: Desconforto respiratório? Dor intensa? Desidratação?))
4. **Tem critérios para abertura de protocolo de sepse:** Sim (☐) Não (☒) NA (☐)
(Ex: Febre? Saturação de oxigênio menor e/ou igual a 92%? Sonolência excessiva? Taquicardia?)
5. **A criança tem histórico de condições preexistentes ou comorbidades relevantes?**
(Ex: Asma, Cardiopatias, doenças neurológicas, imunodeficiência etc.)
6. **Reprocura em 48h?** Sim (☐) Não (☒) NA (☐)

Classificação: Vermelho (☐) ~~Amarelo~~ (☒) Verde (☐)

Patricia Dalana de Farias
Enfermeiro(a)



Justificativa de punção

Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo: Masculino
Telefone: 98 985108882
Leito: L.01

Atendimento: 9.108.253
Prontuário: 1.118.047
Dt. Entrada: 11/01/2026 04:43:36
Convênio: AMIL 883 AMIL 5380 QC

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
11/01/2026 05:20	11/01 05:23	Técnico/Auxiliar Enfermagem	Justificativa de punção		Gessica Pereira Franca	COREN 1009336-TE

Hash: 35067A07BBAEEA6DD0C43079CB5B65D4

Dt. Assinatura: 11/01/2026 06:21

Documento assinado digitalmente em 11/01/2026 06:21:30, por Técnico(a) de Enfermagem Gessica Pereira Franca COREN 1009336-TE

Avaliação: Justificativa de punção de Acesso Venoso Periférico - Novo

1 - Indicação do Procedimento: Paciente com necessidade de acesso venoso periférico para administração de medicação intravenosa. **Avaliação da rede venosa realizada e punção efetuada conforme protocolo. Punciono o paciente:** : 1ª Punção

2 - Punciono a rede venosa no seguinte local, levando em consideração a condição vascular e a escolha do paciente: : MSD - membro superior direito

3 - Realizo as tentativas de punção conforme padrões de segurança, respeitando o limite máximo estabelecido pela ANVISA:

Obs: Cada profissional pode realizar no máximo 2 tentativas, totalizando até 4 conforme normas da ANVISA. Cada tentativa deve ser registrada individualmente na evolução do paciente. : Uma única tentativa

4 - Utilizo as seguintes tecnologias para otimizar o procedimento, conforme necessidade: : Nenhuma

5 - Solicitado e usados os seguintes materiais para realizar a punção do paciente:

Cateter usado: : Introcán

Calibre do cateter usado nº: : 24

Quantidade: : 1

Usado para estabilização/ cobertura do cateter: : Fixador Estéril IV FIX

Foi solicitado e usado o seguinte equipo multivias (extensor): : Não foi usado extensor

5.1 - Usado conector valvulado (MAX ZERO) conforme recomendação em boas práticas para prevenção de infecção de correntes sanguíneas? : Não

5.2 - Usado lenços com álcool para assepsia.

Escolha a opção: : 1

6. Realizado flushing do cateter para testar fluxo e refluxo conforme recomendações de boas práticas: : Sim, com bom fluxo e refluxo

6.1 - Usado seringas salinizadas conforme recomendações de boas práticas no total de: : 1

7.

Usado cateter introcan no intra-operatório: : Não

7.2

Solicitado e usado equipo: : Sim

Quantas unidades e para quais medicações? : 1 EQUIPO SORO FISIOLÓGICO

Gessica Pereira Franca
Técnico(a) de Enfermagem COREN 1009336-TE

Impresso em: 27/01/2026 15:

Página 1/2

cleidiane.lima

CATE00588



Justificativa de punção

Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito L.01

Atendimento 9.108.253
Prontuário 1.116.047 2
Dt. Entrada 11/01/2026 04:43:36
Convênio AMIL 883 AMIL S380 QC

Anotações de enfermagem (ex: uso de luvas, uso de equipamentos, uso de agulhas etc) : 1 EQUIPO +1 INTROCAN 24 +1 TEGADERM+1 POLIFIX+1 PAR DE LUVA

8 - Punção com sucesso? : Sim

8.1 - Feito medicações após punção, quais e que horários? : SORO FISIOLÓGICO+ DEXAMETASONA

Gessica Pereira França
Técnico(a) de Enfermagem COREN 1009336-TE

Impresso em: 27/01/2026 15:

Página 2/2

cleidiane.lima

CATE00598





9108253
Atendimento

Hospital São Domingos
Prescrição Eletrônica Paciente
Pronto socorro



12650974
Prescrição

Paciente	Jose Henrique da Silva Fernandes	Atendimento	9.108.253
Data Nascto	06/03/2025 10m 5d	Convênio	AMIL / 883 AMIL S380 QC
Data Entrada	11/01/2026 04:43:38	Liberação	11/01/2026 04:57:11
Médico Resp	Dra. Beatriz Moraes Costa (CRM 12223)	Data Prescr.	11/01/2026 04:56:26
Médico Pres	Dra. Beatriz Moraes Costa (CRM 12223)	Prontuário	1.116.047
Lib. Enferm	Beatriz Moraes Costa CRM - 12223	Leito e Setor	
Validade	11/01/2026 04:57:00 até 12/01/2026 18:59:59	E-mail	sandromf26@gmail.com
DI.Assinatura	11/01/2026 05:55:51		
Hash	AB7593D90038060BAA5F845CF94E9C01		

Documento assinado digitalmente em 11/01/2026 05:55:51, por Médico(a) Beatriz Moraes Costa CRM 12223

CID

Urgência enfermagem:

Urgência médica:

Alergias:

Procedimentos, Serviços e Exames

1 RX - Tórax PA + Perfil

Beatriz Moraes Costa
Médica
CRM-MA 12.223

Dra. Beatriz Moraes Costa (CRM 12223)

Liberação: 11/01/2026 04:57:11

Página: 1/1

beatriz.costa

CATE00624





Contrato de Prestação de Serviços Médico-Hospitalares para Paciente Particular ou Usuário de Plano de Saúde firmado entre as partes qualificadas abaixo.

Contratada: Hospital São Domingos Ltda
Endereço: Av. Jerônimo de Albuquerque, 540 - Bequimão - São Luís - MA
Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
RG: - CPF:
Endereço: Rua 4G, 4 a Cidade Operária São Luís MA
Tel.: 098 988274397 **Cel.:** 985108862

CNPJ: 11006293000130



Assinatura: _____

Contratante: Alessandro Maciel Fernandes

RG: - CPF: 05152176386
Endereço: Rua 4G, 4 a Cidade Operária São Luís MA
Tel.: 988274397

Assinatura: _____

Nº Atendimento: 9108253 **Data do Atendimento:** 11/01/2025 04:43:36

CLÁUSULA 1ª - O paciente e o contratante (simplesmente - particular), nomeados e qualificados na forma acima, expressamente contratam o Hospital para fins de autorizar a cobrança de forma particular da internação e/ou atendimento de emergência do paciente, qualquer atendimento eletivo solicitado pelo médico internista, executado por si ou por terceiros especializados, independente de autorização prévia, todo e qualquer procedimento, diagnósticos, terapêuticos, laboratoriais, clínicos e cirúrgicos, necessários ao adequado e eficaz tratamento indicado pelo médico.

CLÁUSULA 2ª - O paciente e o contratante (simplesmente - usuário de plano de saúde), nomeados e qualificados na forma acima, expressamente contratam o Hospital para fins de autorizar a cobrança de forma particular da internação e/ou atendimento de emergência do paciente, qualquer atendimento eletivo solicitado pelo médico internista, executado por si ou por terceiros especializados, independente de autorização prévia, todo e qualquer procedimento, diagnósticos, terapêuticos, laboratoriais, clínicos e cirúrgicos, necessários ao adequado e eficaz tratamento indicado pelo médico, quando seu plano de saúde recusar e não autorizar qualquer evento relacionado a seu atendimento.

Parágrafo Primeiro: No caso de serviços prestados por profissionais e empresas terceirizadas pelo Hospital contratado, necessários ao integral tratamento e recuperação do paciente, fica o particular ou usuário de plano de saúde ciente que deverão custear os honorários desses profissionais.

Parágrafo Segundo: A execução dos serviços contratados relativos ao tratamento de qualquer natureza, depende da expressa requisição do médico responsável pelo paciente.

Parágrafo Terceiro: Havendo recusa de cobertura do plano de saúde, fica desde já informado e advertido o paciente usuário de plano de saúde em referência, que só serão admitidos pacientes que estiverem vinculados aos planos de saúde credenciados e pertencentes à rede de contratados do Hospital, não se configurando ilícito passível de indenização ou de responsabilidade civil ou penal, a cobrança de valores não cobertos pelos planos de forma particular pelo Hospital, através do faturamento da conta hospitalar e respectiva cobrança extrajudicial ou judicial, por se tratar de exercício regular do direito à cobrança pelos serviços prestados em se tratando de instituição privada de saúde, não credenciada ao Sistema Único de Saúde ou a atividade filantrópica de qualquer natureza.

CLÁUSULA 3ª - Para fins de definição, o atendimento ao paciente é continuado podendo ser compreendido por atendimento na emergência seguido de internação, dos quais serão gerados números de atendimentos distintos.

CLÁUSULA 4ª - O Hospital não será responsabilizado por perda, furto, extravio ou qualquer outro evento envolvendo quaisquer pertences do particular ou usuário de plano de saúde e de seus familiares (celulares, eletrônicos, dinheiro, jóias, próteses dentárias, porta óculas, bolsas etc.), sendo de inteira responsabilidade do seu possuidor enquanto permanecer no interior do estabelecimento hospitalar contratado, quer nos apartamentos, na emergência, nas salas de exames ou em quaisquer outras dependências do contratado, salvo quando a guarda for confiada ao contratado.

Parágrafo Único: Fica o particular ou usuário de plano de saúde obrigado a alertar seus familiares e acompanhantes do inteiro teor do caput desta cláusula, a fim de que guardem e mantenham sob sua responsabilidade e atenção todos os seus pertences, assim como das demais orientações constantes no Guia de Orientações.

CLÁUSULA 5ª - O particular ou usuário de plano de saúde declara estar ciente de sua dupla relação contratual decorrente do tratamento médico-hospitalar a si dispensado, quais sejam:

I - a relação Hospital x Paciente, obrigando-se o Hospital a oferecer toda a infraestrutura e todos os serviços hospitalares disponíveis ao tratamento do paciente, incluindo-se hotelaria, enfermagem e nutrição;

II - a relação Médico x Paciente, quando não tiver havido autorização para os médicos credenciados do plano de saúde ou não houver cobertura do especialista pela OPS (operadora de plano de saúde), o paciente particular ou usuário de plano de saúde poderão escolher o profissional médico e equipe distintos daqueles do Hospital, condicionada aos requisitos da condição de médico para aprovação da Diretoria Médica do Hospital, cadastramento para que o mesmo tenha acesso ao Regimento, Login e Senha de uso obrigatório no âmbito do hospital, podendo com estes contratar diretamente, ou seja, sem interferência do hospital.

a) Os honorários ficarão a cargo do paciente/responsável ou de sua família e serão desvinculados da conta hospitalar, devendo sua quitação ser feita a partir de prévio ajuste diretamente com o(s) profissional(is) contratado(s), exceto Anestesiistas e Intensivistas da UTI.

b) Havendo contratação de profissionais não pertencentes ao hospital contratado, exceto Anestesiistas e Intensivistas da UTI, deverão o particular ou usuário de plano de saúde dirigir-se a tais profissionais para o fim de obter informações e/ou explicações sobre seu diagnóstico, tratamento adotado, procedimentos realizados e demais informações técnicas pertinentes à evolução do seu estado clínico, estendendo a obrigação ao contratado de prestar tais informações (vide prontuário).

CLÁUSULA 6ª - O particular ou usuário de plano de saúde assumem solidariamente, em caráter irrevogável e irrenunciável, independente de nomeação, a obrigação de pagar, todas e quaisquer quantias devidas em razão do tratamento médico hospitalar prestado ao paciente.

CLÁUSULA 7ª - O particular ou usuário de plano de saúde declaram estar cientes de que todos os pagamentos devidos ao hospital em virtude do tratamento recebido deverão ser realizados nos termos desta cláusula e do termo de assunção de dívida, oportunidade em que será emitida a fatura de prestação de serviços, acompanhada da respectiva conta hospitalar, com discriminação dos procedimentos realizados, devidamente aceita pelo paciente, ou, na impossibilidade deste, por seu responsável, o qual neste ato será nomeado por aquele como seu bastante procurador para este fim específico, e na gravidade do estado do paciente que não puder exprimir sua anuência ou outorga de poderes, o responsável estará ciente da assunção da dívida em nome do paciente/contratante para os devidos fins de direito.

Parágrafo Primeiro: As taxas, diárias, gases medicinais e demais serviços técnicos, serão cobrados com base nos preços especificados na Lista Referencial de Diárias e Taxas do Hospital São Domingos, e não incluem o fornecimento de materiais e medicamentos utilizados, que serão cobrados separadamente, de acordo com as normas previstas neste Contrato.

a) Na taxa de diária de acompanhante não há previsão de alimentação, exceto nos casos previstos na Lei.

Parágrafo Segundo: Os medicamentos e materiais hospitalares serão cobrados pelo contratado com base na coluna "preços de venda ao consumidor", do Brasilindes (última edição) e os materiais descartáveis serão cobrados segundo a lista Simpro (última edição), seguindo preço indicado na coluna "preço de fábrica".



Contrato de Prestação de Serviços Médico-Hospitalares para Paciente Particular ou Usuário de Plano de Saúde firmado entre as partes qualificadas abaixo.

com acréscimo de 42,85%. Os materiais e medicamentos que não constarem dessas listas serão cobrados com base nos preços dos fabricantes ou fornecedores, acrescidos de 42,85%, percentual este que corresponde à taxa de estocagem e dispensação.

a) Prescrita a medicação, o paciente tem a opção de desistir do uso sem custo, desde que o faça antes da abertura e preparação.

Parágrafo Terceiro: As OPME's - Órteses, Próteses e Materiais Especiais, necessários ao atendimento dos usuários, segundo solicitação médica, serão requisitados e pagos diretamente ao fornecedor pelo particular ou usuário de plano de saúde.

Parágrafo Quarto: O particular ou usuário de plano de saúde pagará ao contratado, a título de taxa de serviços do material OPME, o valor correspondente a 15% (quinze por cento) do valor unitário constante da Nota Fiscal correspondente. Esta taxa se refere à responsabilidade técnica, verificação da procedência, esterilização e aplicação do material a cargo do Hospital.

CLÁUSULA 8ª - Na hipótese de o paciente ou contratante (simplesmente - particular), não pagar a conta hospitalar a que estiver obrigado, no prazo de 24 horas (conforme termo de assunção de dívida), ficam os mesmos desde já cientes de que o hospital adotará as medidas cabíveis para a cobrança dos valores, inclusive por meio da rede bancária, notificando extrajudicialmente o paciente e/ou seu responsável contratual, efetuar o protesto do título dado em garantia, bem como a respectiva negativação do nome do paciente e do contratante inadimplente junto aos órgãos de proteção creditícia.

Parágrafo Único: Na hipótese do paciente ou contratante (simplesmente - usuário de plano de saúde) não pagar a conta hospitalar a que estiver obrigado, no prazo de 30 dias (conforme termo de assunção de dívida), ficam os mesmos desde já cientes de que o hospital adotará as medidas cabíveis para a cobrança dos valores, inclusive por meio da rede bancária, podendo efetuar o protesto do título dado em garantia, bem como a respectiva negativação do nome do paciente e do contratante inadimplente junto aos órgãos de proteção creditícia, seguindo, inclusive os termos da cláusula 10ª.

CLÁUSULA 9ª - O particular ou usuário de plano de saúde desde já autorizam o Hospital contratado a proceder com a transferência do paciente para rede do SUS, no caso de impossibilidade financeira para pagamento de seu tratamento no hospital, transferência esta que somente será realizada depois de atendidas as situações de emergência e urgência e estando o paciente em condição clínica para tanto.

CLÁUSULA 10ª - Em caso de cobrança de quaisquer valores devidos e não pagos, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, fica o particular ou usuário de plano de saúde obrigado ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) a partir do dia seguinte ao vencimento, bem como a aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária de débitos pelo IGP/MF/GV, ou em caso de extinção deste, por outro índice que venha a substituí-lo.

CLÁUSULA 11ª - O particular ou usuário de plano de saúde declara ter ciência e aceita que o Hospital contratado enviará as contas não adimplidas para cobrança através de empresa terceirizada após 30 dias de inadimplimento, incidindo, ainda, encargos de honorários profissionais e custas.

E por estarem de comum acordo, justo e contratado, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, elegendo o foro da cidade de São Luís, como o único e competente para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

HOSPITAL SÃO DOMINGOS

TESTEMUNHAS:

ASSINATURA: _____
NOME: _____
CPF: _____

ASSINATURA: _____
NOME: _____
CPF: _____





2. N° Guia de Prestador: 487136826exp001

1 - Registro ANS 326309		3 - Número da Guia Prioritária	
4 - Data da Autolização 11/01/2026		5 - Senha 000029900317818	6 - Data de Validade da Senha 12/03/2026
7 - Número da Guia Atualizada pelo Operadora 487136828			
Dados do Beneficiário			
8 - Número da Carteira 005381754	9 - Cidade de Origem	10 - Nome JOSE HENRIQUE DA SILVA FERNANDES	11 - Nome Social
12 - Atendimento a R7 N			
Dados do Estabelecimento			
13 - Código do Operadora 10461132		14 - Nome do Estabelecimento HOSPITAL SAO DOMINGOS	
15 - Nome do profissional solicitante LEONARDO DA VINCE SILVA MARTINS		16 - Conselho profissional CRM	17 - Número no Conselho 5675
18 - UF MA		19 - Código CBO 225124	20 - Assinatura do Profissional Solicitante
Dados da Solicitação / Procedimento ou Item Ambulatorial Solicitado			
21 - Código de Atendimento 2	22 - Data da Solicitação 11/01/2026	23 - Indicação Clínica PEDIDO MÉDICO EM ANEXO	
24 - Indicador de Cobertura Especial			
25 - Tabela 01 - 22	26 - Código do Procedimento ou Item ambulatorial 10101039	27 - Descrição Consulta Em Pronto Socorro	28 - Qtd. Sess. 1.0
29 - Tabela 02 -			30 - Qtd. Sess. 1.0
31 - Tabela 03 -			
32 - Tabela 04 -			
Dados do contrato/convênio			
33 - Código do Operadora 10461132		34 - Nome do Estabelecimento HOSPITAL SAO DOMINGOS	
35 - Código CNES 236665			
Dados de Identificação			
36 - Tipo de Atendimento 04	37 - Indicação de Atividade (relatório ou doença relacionada)	38 - Tipo de Consulta	39 - Motivo de Exatidão do Atendimento
40 - Registro de atendimento		41 - Índice Orçamentário	
Dados de Execução / Procedimentos e Exames Realizados			
42 - Data	43 - Hora Inicial	44 - Hora Final	45 - Tabela
1 -			46 - Código do Procedimento 10101039
2 -			47 - Quantidade Consulta Em Pronto Socorro
3 -			48 - Qtd.
4 -			49 - %
5 -			50 - %
51 - Valor Unitário (R\$)		52 - Valor total (R\$)	
53 - Valor total (R\$)			
Identificação do Profissional (Opcional)			
54 - Reg. Prof.	55 - Grau prof.	56 - Código no Operadora PP	57 - Nome do profissional
58 - Conselho profissional		59 - Número no Conselho	60 - UF
61 - Assinatura do Beneficiário ou Responsável		62 - Código CBO	
63 - Data de Realização do Procedimento ou Serviço			
64 -	65 -	66 -	67 -
68 -	69 -	70 -	71 -
72 - Observação / Justificativa			
Pedido: 487136828 PEDIDO MÉDICO EM ANEXO			
73 - Total de Procedimentos (R\$)	74 - Total de Taxas e aluguéis (R\$)	75 - Total de Materiais (R\$)	76 - Total OPNIE (R\$)
77 - Total de Medicamentos (R\$)	78 - Total de Cotas médicas (R\$)	79 - Total Geral (R\$)	
80 - Assinatura do Responsável pelo Atendimento		81 - Assinatura do Beneficiário ou Responsável	
		82 - Assinatura do Estabelecimento	

Downloaded from <http://ajphaphysocpharmacology.physocpharmacology.aipr.org/> on 01/12/2016 06:45:58

Página: 1 de 1

Time = 04:02:00



Número do documento: 26022014124667700000159866784

<https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26022014124667700000159866784>

Assinado eletronicamente por: VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - 20/02/2026 14:12:47

Num. 172684516 - Pág. 10

Nome	Jose Henrique da Silva Fernandes	Atendimento	9.108.291
Data Nascto	06/03/2025 10 meses	Data Entrada	11/01/2026 08:17
Nº CPF		Data Alta	18/01/2026 10:53
Endereço	Rua 4G, nº 4, Cidade Operária - a	Nº Identidade	
Município	São Luís - MA	Unidade	516
Telefone	988274397	Dt. Assinatura	18/01/2026 10:35:04
Hash	5B6D68B9BD47F8A47F4305DDDE361051		

Documento assinado digitalmente em: 2026/01/18 10:35:04, por Médico(a) Luiz Jorge Matos CRM 1532

1. Data da internação: 11/01/2026 08:17:29

2. Motivo da internação:

ADMISSÃO: CRIANÇA 10 MESES DEU ENTRADA EM GRANDE SALA COM TOSSE LADRANTE E FEBRE.

3. Resumo da evolução e plano terapêutico:

PACIENTE SEM FEBRE, TOSSE SECA ESPARSA
ALTA COM RECEITA E ORIENTAÇÕES PARA DOMICILIO

4. Resultado dos principais exames:

HC: LEUCO-11160 56SEG 34LT 2 ATIP PLAQ- 486MIL PCR-0,02
CÓPRO: RTV/HEMACIAS/EPF- NEGATIVOS

RX TORAX- ESPESSAMENTOS PB E PH

5. Diagnóstico da alta: J04.0 Laringite aguda /

6. Orientações para a alta:RETORNO AMBULATORIAL

7. Reconciliação Medicamentosa

7.1 Medicações usadas no domicílio antes da internação: FERRO 2 gts 1x ao dia ; VITAMINA D 2 gts 1x ao dia ;

7.2 Receita atual para casa: PROBIOTICO+SINTOMATICOS

8. Necessidade de Reabilitação pós alta hospitalar:

() Fisioterapia () Psicologia () Fonoaudiologia () Nutrição () Outros:

9. Data da alta: 18/01/2026



Nome: Jose Henrique da Silva Fernandes

Dt. Nasc.: 06/03/2025

Idade: 10m 5d

Data: 11/01/2026

SOLICITO RT PCR SARS COV2, VRS, INFLUENZA A, B
FEBRE, DESCONFORTO RESPIRATORIO, ROUQUIDAO, TOSSE PERSISTENTE


Dr(a) Heida Cristina Alcantara Vicente
Médica - Pediatra
CRM-MA 4026

Heida Cristina Alcantara Vicente
CRM4026

Hospital São Domingos Ltda. - Fone (98) 3216-8100R. Jerônimo de Albuquerque, 540 São Luis - Maranhão - CEP 65060-642



MEU HSD
* Baixe o aplicativo que ajuda a cuidar de você

WHATSAPP HSD
Agende também seus exames através do nosso Whatsapp.





Paciente **Jose Henrique da Silva Fernandes**

Data Nascto 06/03/2025 10m 5d

Data Entrada 11/01/2026 04:43:36

Médico Resp Dra. Beatriz Moraes Costa (CRM 12223)

Médico Pres Dra. Beatriz Moraes Costa (CRM 12223)

Lib. Enferm Beatriz Moraes Costa CRM - 12223

Validade: 11/01/2026 07:08:00 até 12/01/2026 18:59:59

Dt.Assinatura 11/01/2026 08:04:10

Hash 16AF9C9C45D7B4F43F6F3AF5796BD9FD

Atendimento 9.108.253

Convênio AMIL / 883 AMIL S380 QC

Liberção 11/01/2026 07:05:51

Data Prescr. 11/01/2026 07:05:04

Prontuário 1.116.047

Leito e Setor

E-mail sandromf26@gmail.com

Documento assinado digitalmente em 11/01/2026 08:04:10, por Médico(a) Beatriz Moraes Costa CRM 12223

CID

Urgência enfermagem:

Urgência médica:

Alergias:

Prescrição	Dose	Intervalo/Horário
Nebulização c/ Adrenalina com O²		Agora
Adren 1mg/1mL inj- EPINEfrina -USO INALATORIO	3 mg Agora In	07:05
Cloreto de Sodio 0,9% 10ml inj	0,1 ml Agora In	07:05
Nebulização Clenil + S.F com O²		Agora
Clenil A sol nbz 2ml	0,5 ml Agora In	07:05
Cloreto de Sodio 0,9% 10ml inj	3 ml Agora In	07:05

Beatriz Moraes Costa
CRM MA 12.223

Dra. Beatriz Moraes Costa (CRM 12223)

Liberção: 11/01/2026 07:05:51

Página 1/1

beatriz.costa

CATE00624



1=02



9108253
Atendimento

Hospital São Domingos
Prescrição Eletrônica Paciente



12651012
Prescrição

Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10m 5d
Data Entrada: 11/01/2026 04:43:36
Médico Resp: Dra. Beatriz Moraes Costa (CRM 12223)
Médico Pres: Dra. Beatriz Moraes Costa (CRM 12223)
Lib. Enferm: Beatriz Moraes Costa CRM - 12223
Validade: 11/01/2026 06:37:00 até 12/01/2026 18:59:59
Dt.Assinatura: 11/01/2026 07:37:09
Hash: 353052DFA487016C4B4471BB8A389296

Atendimento: 9.108.253
Convênio: AMIL / 883 AMIL S380 QC
Liberação: 11/01/2026 06:38:50
Data Prescr.: 11/01/2026 06:36:13
Prontuário: 1.116.047
Leito e Setor:
E-mail: sandromf26@gmail.com

Documento assinado digitalmente em 11/01/2026 07:37:09, por Médico(a) Beatriz Moraes Costa CRM 12223.

CID

Urgência enfermagem:

Urgência médica:

Alergias:

Suplemen/Modul/Pediat	Intervalo	Dose	Aplicação	Vel. de Infusão
Leite Po Nan 2 Confort 800g	3/3 h	30 g	Oral	ml/h

Beatriz Moraes Costa
Médica
CRM-MA 12.223

Dra. Beatriz Moraes Costa (CRM 12223)



Paciente	Jose Henrique da Silva Fernandes	Atendimento	9.108.253	
Data Nascto	08/03/2025 10m 5d	Convênio	AMIL / 683 AMIL S380 QC	
Data Entrada	11/01/2026 04:43:36	Liberção	11/01/2026 04:57:11	
Médico Resp	Dra. Beatriz Moraes Costa (CRM 12223)	Data Prescr	11/01/2026 04:56:26	
Prescritor	Beatriz Moraes Costa CRM - 12223	Prontuário	1.118.047	
Lib. Enferm	Beatriz Moraes Costa CRM - 12223	Leito e Setor	L06 OBS UCA PEDIATRICA	
Validade:	11/01/2026 04:57:00 12/01/2026 18:59:59	Peso	0	
		Dt. Assinatura	11/01/2026 05:55:51	
Hash AB7593D90038060BAA5F845CF94E9C01				
Documento assinado digitalmente em 11/01/2026 05:55:51, por Médico(a) Beatriz Moraes Costa CRM - 12223				

Alergias:

Procedimentos, Serviços e Exames

1	RX - Tórax PA + Perfil
---	------------------------

Beatriz Moraes Costa CRM - 12223



Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nasc: 05/03/2025 0 anos
Endereço: Rua 4G, 4 a Cidade Operária São Luís MA
Convênio: AMIL
Setor Atend: 516
Hash: 19053EBA28AE44D7DFC30F5192BB8C45

Atendimento: 9108291
Prontuário: 1116047
Dt Entrada: 11/01/2026
Dt Alta: 18/01/2026
Unidade: APARTAMENTO
Dt. Assinatura: 11/01/2026 09:29:19

Documento assinado digitalmente em: 2026/01/11 09:29:19, por Médico(a) Helida Cristina Alcantara Vicente CRM 4026

Data Anamnese	Profissional	Conselho
11/01/2026 08:30:22	Helida Cristina Alcantara Vicente	CRM 4026

1. Motivo da Internação:

TOSSE LADRANTE

2. Historia da Doença Atual:

CRIANÇA 10 MESES DEU ENTRADA EM GRANDE SALA COM TOSSE LADRANTE E FEBRE.

3. Antecedentes

3.1. Pessoais:

3.2. Familiares:

3.3. Alergias:

4: Reconciliação Medicamentosa

4.1 Medicações usadas no domicílio:

4.2 Decisão médica para esta internação: ()manter; ()suspender; ()ajustar

5. Hábitos de Vida:

6. Sinais Vitais

Peso: 0 kg Altura: PAmáx: PAmín: FC: 128 FR: 30 Tax: SatO2: IMC: SC:
Glicemia:

7. Exame Físico:

REG, ACIANÓTICO, ANICTÉRICO, FEBRIL, NORMOCORADO, SUDOREICO, CHOROSO

AR: MV PRESENTE, ESTRIDOR LARÍNGEO

8. Exames Laboratoriais:

HC, PCR, TGO, TGP, U, C, PAINEL VIRAL

9. Exames de Imagens:

RX DE TORAX

10. Hipotese diagnóstica: J04.0 Laringite aguda

11: Plano terapêutico:

11.1. Programação para a internação: UTI PED

11.2. Previsão de alta: 14/01/2026 08:30 - Média probabilidade

Helida Cristina Alcantara Vicente

CRM 4026



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 96 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
11/01/2026 08:25	11/01 08:28	Médico(a)	Transição de cuidado -		Helida Cristina Alcantara Vicente	CRM 4026

Hash: 9A842337780CA0E05ED32E264515425E

Dt. Assinatura: 11/01/2026 09:25

Documento assinado digitalmente em: 11/01/2026 09:25:16, por Médico(a) Helida Cristina Alcantara Vicente CRM 4026

Transição de Cuidado para Pacientes Pediátrico

1. Gravidade

1.1- Estável, watcher, instável:
WATCHER

2. Resumo de caso

2.1- Informação relevante inicial c/antecedente:
PACIENTE HA 1 DIA COM FEBRE E TOSSE
2.2- Eventos que levaram à admissão:
ROUQUIDAO, FEBRE, DISPNEA
2.3- Evolução inicial:
TOSSE LADRANTE E FEBRE
AP; RÔNCOS
2.4- Situação atual:
SAT 98% EM AA
PERSISTENCIA DA TOSSE ROUQUIDAO, AGITAÇÃO, PALIDEZ, FEBRIL
PERFUSÃO OK, NUCA LIVRE
AP; RÔNCOS
2.5- Plano terapêutico
INTERNAÇÃO UTI PED:

3. Plano de ação

3.1- Pendências e responsabilidades:
EX DE LAB

4. Consciência Situacional e Plano

4.1- Riscos e o que está acontecendo:
CANSAÇO
4.2- Plano para risco e contingências:
INTERNAÇÃO UTI PED

5. Síntese pelo receptor

5.1- Receptor resume o que escutou:
5.2- Perguntas:

Helida Cristina Alcantara Vicente
Médico(a) CRM 4026



Paciente **Jose Henrique da Silva Fernandes**
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 96 985108882
Leito 516

Atendimento **9.108.291**
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 À 900

5.3- Citar pontos críticos:

Helida Cristina Alcantara Vicente
Médico(a) CRM 4026







9108291
Atendimento



12651099
Prescrição

Hospital São Domingos

Hospital Sao Domingos

Prescrição Eletrônica Paciente

PacienteJose Henrique da Silva Fernandes

Atendimento9.108.291

Data Nascto06/03/202510m 5d

ConvênioAMIL / 883 AMIL S380 QC

Data Entrada11/01/2026 08:17:29

Liberação11/01/2026 08:22:51

Médico RespDra. Helida Cristina Alcantara Vicente (CRM 4026)

Data Prescr.11/01/2026 08:19:25

Médico PresDra. Helida Cristina Alcantara Vicente (CRM 4026)

Prontuário1.116.047

Lib. EnfermHelida Cristina Alcantara Vicente CRM - 4026

Leito e Setor

Validade:11/01/2026 08:20:00 até 12/01/2026 18:59:59

E-mailsandromf26@gmail.com

Di.Assinatura11/01/2026 09:20:02

HashDB6F9CE4EABFC77248B98E55A7E6888A

Documento assinado digitalmente em 11/01/2026 09:20:02, por Médico(a) Helida Cristina Alcantara Vicente CRM 4026

CID

Urgência enfermagem:Urgência médica:

Alergias:

Medicamentos	Intervalo	Horários	Observação
Branda Múltiplas Alergias	3/3 h	08:20 11:20 14:20 17:20 20:20 23:20 02:20 05:20 08:20 11:20 14:20 17:20	

Soluções

Soro Glicosado 5% 250ml inj

Velocida 9,9556 gtm

Etapas: 4

Dispositivo de infusão:Equipo macrogotas simples

Horários: das 08:20 às 14:20; das 14:20 às 20:20; das 20:20 às 02:20; das 02:20 às 08:20;

Cloreto de Potassio 10% 10ml injetavelDose: 2,7 ml

Cloreto de Sodio 20% 10ml injetavelDose: 1,5 ml

Soro Glicosado 5% 250ml injDose: 175 ml

Medicamentos	Dose	Horários	Via Admin
DipirONA 500 MG/ML-2ML AMP TEUTO	0,4 ml SOS/SN		Intravenosa
Diluir 0,4 Mililitros do medicamento em 10 Mililitros de Agua p/ Injeção 10ml Administrar 10,4 Mililitros (SOS/SN Intravenosa)			
Hixizine 2mg/ml xpe 120ml	2,5 ml 8/8 h Oral	08:20 16:20 00:20 08:20	Oral
Administrar 2,5 Mililitros (8/8 h Oral) Risco Queda: sonolência e sedação.			
Ondansetrona 4 mg em 2 mL- inj	0,6 ml SOS/SN	SN	Intravenosa
Diluir 0,6 Mililitros do medicamento em 50 Mililitros de Soro Fisiologico 0,9% (NaCl) 50ml inj Administrar 50,6 Mililitros (SOS/SN Intravenosa) Estabilidade: 48 Horas Após diluição Temperatura ambiente controlada (15°C a 30°C) Recomendado acesso central			

Liberação: 11/01/2026 08:22:51

Página 1/3

Dra. Helida Vicente

Médica Pediatra

20.01.2026

helida.vicente

CATE00524

Número do documento: 26022014124667700000159866784
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26022014124667700000159866784
Assinado eletronicamente por: VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - 20/02/2026 14:12:47

Num. 172684516 - Pág. 20





9108291
Atendimento



12651099
Prescrição

Hospital São Domingos

Prescrição Eletrônica Paciente

Paciente

Jose Henrique da Silva Fernandes

Atendimento

9.108.291

Data Nascto

06/03/2025 10m 5d

Convênio

AMIL / 883 AMIL S380 QC

Data Entrada

11/01/2026 08:17:29

Liberação

11/01/2026 08:22:51

Médico Resp

Dra. Helida Cristina Alcantara Vicente (CRM 4026)

Data Prescr.

11/01/2026 08:19:25

Médico Pres

Dra. Helida Cristina Alcantara Vicente (CRM 4026)

Prontuário

1.116.047

Lib. Enferm

Helida Cristina Alcantara Vicente CRM - 4026

Leito e Setor

Validade:

11/01/2026 08:20:00 até 12/01/2026 18:59:59

E-mail

sandromf26@gmail.com

Dt.Assinatura

11/01/2026 09:20:02

Hash

DB6F9CE4EABFC77248B99E55A7E6688A

Documento assinado digitalmente em 11/01/2026 09:20:02, por Médico(a) Helida Cristina Alcantara Vicente CRM 4026

CID

Urgência enfermagem:

Urgência médica:

Alergias:

ANTOCAL 4MG/ML-10ML FR/AMP EV

2,5 ml

Agora

08:52

Intravenosa

Reconstituir cada Frasco-ampola em 10 Mililitros de Diluente Proprio

Diluir 2,5 Mililitros da reconstituição em 100 Mililitros de Soro Fisiologico 0,9% (NaCl)

100ml inj

Administrar 102,5 Mililitros (Agora Intravenosa)

Simeticona 75mg/ml gts 15ml

9 gts

8/8 h

Oral

08:30

16:30

Oral

00:30

08:30

16:30

11:30

03

11

14

UNIMEDROL 125 MG FR/AMP

5 mg

6/6 h

Intravenosa

08:20

14:20

Intravenosa

20:20

02:20

08:20

14:20

Reconstituir cada Frasco-ampola em 2 Mililitros de Diluente Proprio

Diluir 0,08 Mililitros da reconstituição em 10 Mililitros de Cloreto de Sodio 0,9% 10ml inj

Administrar 10,08 Mililitros (6/6 h Intravenosa) em 3 minutos

Estabilidade: 48 Horas Após reconstituição

Temperatura ambiente (15°C a 30°C)

Nebulização

Dose

Intervalo/Horário

Nebulização Clenil + S.F com O²

12/12 h

Clenil A sol nbz 2ml

1 ml

12/12 h

In

08:21

20:21

08:21

Cloreto de Sodio 0,9% 10ml inj

5 ml

12/12 h

In

08:21

20:21

08:21

Recomendações

Intervalo

Horários

Cabeceira do leito elevada 45° graus

Contínuo

08:20

08:20

Controle Glicêmico

Agora

08:22

30.56

182 mg/dl

Fisioterapia Respiratória 2x ao dia

FISIO 2X

10

16

Monitorização Cardíaca

Contínuo

08:20

08:20

Oximetria continua de pulso mais sensor

Contínuo

08:20

08:20

Sinais Vitais de 2/2h

2/2 h

08:20

10:20

12:20

14:20

16:20

18:20

20:20

02:20

04:20

06:20

08:20

10:20

12:20

14:20

16:20

18:20

Procedimentos, Serviços e Exames

7

PESQUISA DE SINCICIAL RESPIRATORIO

Liberação:

11/01/2026 08:22:51

Página

2/3

Dr. Helida Vicente

CATE00624



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes

Atendimento 9.108.291

Data Nascto 06/03/2025 10m 5d

Convênio AMIL / 883 AMIL S380 QC

Data Entrada 11/01/2026 08:17:29

Liberação 11/01/2026 08:22:51

Médico Resp Dra. Helida Cristina Alcantara Vicente (CRM 4026)

Data Prescr. 11/01/2026 08:19:25

Médico Pres Dra. Helida Cristina Alcantara Vicente (CRM 4026)

Prontuário 1.116.047

Lib. Enferm Helida Cristina Alcantara Vicente CRM - 4026

Leito e Setor

Validade: 11/01/2026 08:20:00 até 12/01/2026 18:59:59

E-mail sandromf26@gmail.com

Dt.Assinatura 11/01/2026 09:20:02

Hash DB6F9CE4EABFC77248B99E55A7E6888A

Documento assinado digitalmente em 11/01/2026 09:20:02, por Médico(a) Helida Cristina Alcantara Vicente CRM 4026

CID

Urgência enfermagem:

Urgência médica:

Alergias:

POTASSIO_SORO

9 SODIO_SORO

10 TGO

11 TGP

12 UREIA_SORO

20 ANTIGENO COVID (AGCOV) TESTE RAPIDO

20 CREATININA_SORO

20 GASOMETRIA_VENOSA

20 HEMOGRAMA_COMPLETO

20 Influenza A/B/H1N1 - Teste Rápido


Dra. Helida Vicente
Médico(a) Responsável
11/01/2026 09:20:02

Dra. Helida Cristina Alcantara Vicente (CRM 4026)

Liberação: 11/01/2026 08:22:51

Página 3/3

helida.vicente

CATE00524





Relatório dos Parâmetros Assistenciais do Paciente

De: 11/01/2026 Até: 11/01/2026

Paciente: Jose Henrique da Silva Fernanc Convênio: AMIL-AMIL INDIVIDUAL Atendimento: 9108291
Data nasc: 06/03/2025 10m 13d Setor / leito: Internação E-5 516 Prontuário: 1116047
Data entrada: 11/01/2026 08:17:29 Médico resp: Dra. Antonia de Jesus Barros Total BH acumulado: 1355,8

Parâmetros	Un med	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	01	02	03	04	05	06	Total
11/01/2026																										
SINAIS VITAIS																										
Temp	°C		35,7		35,7		36,4		36,1		36		36		36,5		36,1		36,7		35,9		35,8		36	
FC	bpm		112		116		118		144		130		116		101		112		111		101		125		124	
FR	mm		35		35		34		35		35		35		36		34		38		31		32		32	
Sat O2	%		97		99		98		99		100		100		97		98		97		98		95		96	
Glic cap	mg/dL					182																				
Escala dor	Ponto		FLAC		FLAC		FLAC		FLAC		FLAC		FLAC		FLAC		FLAC		FLAC		Faces		FLAC		FLAC	
Ponto dor			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Peso	kg					9,9									10		9		9		9					
GANHOS	ml		189,	102,5		9			189,		5				9	10,08					10,08	179,2				703,
Medicamento por via enteral																										
Medicamento oral						9					5				9											23
Medicamento intravenoso			10,08	102,5					10,08						10,08						10,08					142,82
Dieta enteral																										
Água por sonda																										
Soro glicosado			179,2						179,2													179,2				537,6
Pausa Dieta Enteral																										
PERDAS	ml																									
Diurese espontânea - Volume																										
ESCALA PEWS																										
Sonda Gástrica em Sifonagem																										
BALANÇO HIDRICO																										
Acumulado dia	ml		189,	291,		300,			490,		495,				504,	514,					524,	703,				



Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nasc: 06/03/2025 0 anos
Endereço: Rua 4G, 4 a Cidade Operária São Luis MA
Convênio: AMIL
Setor Atend: 516
Hash: 242CAFDE88475DA89551D74C1C5B197F

Atendimento: 9108291
Prontuário: 1116047
Dt Entrada: 11/01/2026
Dt Alta: 18/01/2026
Unidade: APARTAMENTO
DL Assinatura: 11/01/2026 11:06:06

Documento assinado digitalmente em: 2026/01/11 11:06:06, por: Viviane Cantanhede COREN 340497-ENF

Data Anamnese	Profissional	Conselho
11/01/2026 09:49:05	Viviane Cantanhede	COREN 340497-ENF

1-Procedência

() Centro cirúrgico () Eletiva (X) Emergência () Hemodinâmica

Hora da Admissão: 9H22

2-Motivo da internação/ Diagnóstico : LARINGITE AGUDA

História da doença atual:

CRIANÇA 10 MESES DEU ENTRADA EM GRANDE SALA COM TOSSE LADRANTE E FEBRE.

3-Antecedentes pessoais:

- a - Alergia / Reações Adversas: Nega Alergias ;
- b - Doenças prévias e atuais: Nega doenças ;
- c - Medicamento em uso: FERRO 2 gts 1x ao dia ; VITAMINA D 2 gts 1x ao dia ;
- d - Cirurgias anteriores:

4-Antecedentes morbidos familiares:

5-Exame físico :

CRIANÇA ADMITIDA EM GRANDE SALA PEDIATRICA COM HISTÓRIA DE TOSSE LADRANTE E FEBRE. NA CHEGADA, APRESENTAVA ESTRIDOR LARINGEO IMPORTANTE, SENDO INICIADO RESGATE COM ADRENALINA (3 CICLOS -9MG) E ADMINISTRADA DEXAMETASONA POR VIA ENDOVENOSA. ENCAMINHADA À UCA PEDIATRICA.

DURANTE PERIODO DE OBSERVAÇÃO, MANTEVE ESTRIDOR LARINGEO, POREM COM MELHORA PERCIAL DO QUADRO. INFORMADO AO MEDICO PLANTONISTA. NO MOMENTO, ENCONTRA-SE DORMINDO, REATIVA AO MANUSEIO, DISPNEIA LEVE, MANTENDO NIVEIS DE SATURAÇÃO ADEQUADOS EM AR AMBIENTE, SEM NECESSIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO.

HEMODINAMICAMENTE ESTÁVEL, AFEBRIL NO MOMENTO, PICO FEBRIL REGISTRADO ÀS 05H24. ABDOME: FLÁCIDO, INDOLOR À PALPAÇÃO, COM RUÍDOS HIDROAEREOS PRESENTES. PELE ÍNTEGRA, SEM LESÕES POR PRESSÃO, ACINÓTICA, ANICTÉRICA. EM DIETA POR VI ORAL, COM BOA ACEITAÇÃO DE

Dr. Viviane Cantanhede
COREN 340497-ENF



Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nasc: 06/03/2025 0 anos
Endereço: Rua 4G, 4 a Cidade Operária São Luis MA
Convênio: AMIL
Setor Atend: 516
Hash: 242CAFDE88475DA69551D74C1C5B197F

Atendimento: 9108291
Prontuário: 1116047
Dt Entrada: 11/01/2026
Dt Alta: 18/01/2026
Unidade: APARTAMENTO
Dt. Assinatura: 11/01/2026 11:06:06

Documento assinado digitalmente em: 2026/01/11 11:06:06, por: Viviane Cantanhede COREN 340497-ENF

FORMULA, SEM RELATO DE NAUSEAS E/OU VOMITOS . ENCONTRA-SE HIDRATADA, EXTREMIDADES BEM PERFUNDIDAS, TEC DE 2S. SEM EDEMA. ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESERVADAS.

6- Parâmetros vitais e MEWS

PA max: PA min: FC: 112 FR: 30 IRPM Tax: 35,9°C SatO2: 97% Escala de dor: FLACC / 0
Mews: @Escala_MEWS_HSD Peso: 0 kg IMC: SC: Glicemia: Resíduo gástrico:

7-Dispositivos

() Não
(X) Sim, quais e quanto tempo de uso? ACESSO VENOSO PERIFERICO EM MSD (DATADO 11/01) PERVIO

8- Riscos identificados

Escalas e Índices

- DINI (Sistema de Classificação de Pacientes Pediátricos):
- HUMPTY DUMPTY: 13
- FLEBITE:
- BRADEN (Crianças):26
- PEWS:1

9-Exames e procedimentos pendentes

Exames/ pareceres/ procedimentos

Exames imagem/ laboratório com resultados críticos: (X) Não () Sim, quais:

Parecer pendente: (X) Não () Sim, quais:

Exame pendente: (X) Não () Sim, quais:

Procedimento pendente: (X) Não () sim, quais:

Dr. Viviane Cantanhede
COREN 340497-ENF

10- Precauções de isolamento: (X) Não () Sim, motivo:

Transferido de outro hospital onde ficou por mais de 72h ou realizou procedimento



Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nasc: 06/03/2025 0 anos
Endereço: Rua 4G, 4 a Cidade Operária São Luis MA
Convênio: AMIL
Setor Atend: 516
Hash: 242CAFDE88475DA69551D74C1C5B197F

Atendimento: 9108291
Prontuário: 1116047
Dt Entrada: 11/01/2026
Dt Alta: 18/01/2026
Unidade: APARTAMENTO
Dt Assinatura: 11/01/2026 11:06:06

Documento assinado digitalmente em: 2026/01/11 11:06:06, por: Viviane Cantanhede COREN 340497-ENF

invasivo; Internou por mais de 7 dias nos últimos 3 meses ou internação em UTI;
Submetido a procedimento cirúrgico nos últimos 3 meses; Sob cuidado de Home
Care; Em programa de hemodiálise; Isolou germe em cultura realizada nesta
internação (admissão de outro setor do hospital, exceto PS; Outras necessidades
de isolamento, qual?

11-Conduta :

VERIFICAR SINAIS VITAIS A CADA 2 HORAS
MANTER BOAS PRATICAS NA PREVENÇÃO DE QUEDAS, FLEBITE E
BRONCOASPIRAÇÃO
MONITORAR E REGISTRAR SE ALTERAÇÕES NO PADRÃO RESPIRATÓRIO
MANTER CABECEIRA ELEVADA ENTRE 30 A 45°

Dr. Viviane Cantanhede
COREN 340497-ENF



Evolução de Enfermagem (PED)

Paciente	Jose Henrique da Silva Fernandes		Atendimento	9.108.291
Data Nascto.	06/03/2025	10 Meses	Prontuário	1.116.047
Sexo	Masculino		Dt. Entrada	11/01/2026 08:17:29
Telefone	98 985108882		Convênio	AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900
Leito	516			

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
12/01/2026 04:31	12/01 04:40	Enfermeiro(a)	Evolução de		Leda Barros de Castro	COREN 313019

Hash:	1D606C96CC4952B0984BAA262F8EB0A6	Dt. Assinatura:	12/01/2026 05:38
Documento assinado digitalmente em 12/01/2026 05:38:25, por Leda Barros de Castro COREN 313019			

DIAGNÓSTICO: LARINGITE

HDA: CRIANÇA 10 MESES DEU ENTRADA EM GRANDE SALA COM TOSSE LADRANTE E FEBRE REALIZADO RESGATE COM ADRENALINA, SOLICITADO E LEITO DE UTI.

NO MOMENTO, CRIANÇA EM REPOUSO NO LEITO, MONITORIZADO, NA COMPANHIA DOS PAIS, DORMINDO, REATIVO. AFEBRIL. HIDRATADO. NORMOCARDICO. PERFUSÃO PERIFERICA ADEQUADA, 2S. TAQUIPNEICO EM AR AMBIENTE, SEM SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATORIO, MANTENDO SATURAÇÃO 96%. APRESENTANDO ROUQUIDÃO E TOSSE. NUTRIÇÃO POR VIA ORAL COM POUCA ACEITAÇÃO DA DIETA OFERTADA. ABDOME SEM ALTERAÇÃO. ELIMINAÇÕES INTESTINAIS PRESENTES E DIURESE PRESENTE E ESPONTANEA EM FRALDAS. MOVIMENTA TODOS OS SEGMENTOS CORPORAIS SEM ALTERAÇÃO. PELE INTEGRAL PARA LPP, SEM EDEMAS.

AVP EM MSD DATADO DE 11/01 PÉRVIO, SEM SINAIS FLOGÍSTICOS, COM HIDRATAÇÃO VENOSA EM CURSO.

AGURADANDO LIBERAÇÃO DO CONVENIO PARA UTI E EXAMES LABORATORIAIS.

SAT: 96%
FC: 110 BPM
FR: 40 IRPM
T: 36°C

CONDUZAS:

MANTER MONITORIZAÇÃO CONTINUA
GARANTIR IDENTIFICAÇÃO SEGURA
AFERIR SSVV DE 2/2H
ATENTAR PARA ALTERAÇÃO DE PADRÃO RESPIRATORIO
ATENTAR PARA ALTERAÇÃO DE TEMPERATURA E MEDICAR CONFORME
MANTER CABECEIRA ELEVADA 30° A 45°



HOSPITAL

São Domingos

Hospital São Domingos

SAE - Prescrição e Diagnósticos de Enfermagem (novo)

PacienteJose Henrique da Silva Fernandes

Data Nascto06/03/202510 Meses

Data Entrada11/01/2026 08:17:29

EnfermeiroAfonso Silva Vieira - COREN 414295-ENF

SetorInternação E-5

HashB350DDFF38A41FDA049A040F5C613CFC

Atendimento9.108.291

ConvênioAMIL / AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

SAE1167188

Data SAE12/01/2026 13:44:28

Leito516

Dt. Assinatura12/01/2026 14:49:21

Prontuário1.118.047

Liberação12/01/2026 13:52:17

Documento assinado digitalmente em: 2026/01/12 14:49:21, por Afonso Silva Vieira COREN 414295-ENF

Diagnósticos de enfermagem

1 Condição respiratória prejudicada

2 Deficit de autocuidado

3 Risco de Infecção

4 Risco de broncoaspiração

5 Risco de Quedas

Prescrição de enfermagem

	SN	Intervalo	Horários
1 Avaliar e registrar condição respiratória		2/2 h	13 15 17 19 21 23 01 03 05 07 09 11
2 Calcular o score de queda (MORSE) 1 vez ao dia	S/N	Conforme Protocolo Instituição	SN
3 Elevar e manter cabeceira da cama a 30° a 45°		Contínuo	13
4 Manter grades elevadas, cama baixa e travada		Contínuo	13
5 Monitorar sinais de infecção (calor, dor, rubor, secreção, edema)	S/N	Conforme Protocolo Instituição	SN
6 Monitorar sinais e sintomas de broncoaspiração	S/N	Conforme Protocolo Instituição	SN
7 Posicionar paciente adequadamente		SOS/SN	
8 Realiza troca de roupa do paciente		1x ao dia	13
9 Realizar banho no leito		1x ao dia	13
10 Realizar higiene oral		1x ao dia	13
11 Realizar ronda de segurança de 2/2horas (Alto risco)		Alt Risco	13
12 Realizar troca de fralda	S/N	SOS/SN	
13 Realizar troca de roupa do leito		SOS/SN	
14 Sinalisar risco de queda (colocar pulseira e placa de identificação)		Conforme Protocolo Instituição	13

Impresso em 19/01/2026 16:09:53

Enf.: Afonso Silva Vieira - COREN 414295-ENF

Página 1

afonso. / F6133338

Paciente: Jose Henrique da Silva

Internação E-5

516

Anotação de Enfermagem*

Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo: Masculino
Telefone: 98 985108852
Leito: 516

Atendimento: 9.108.291
Prontuário: 1.116.047
Dt. Entrada: 11/01/2026 08:17:29
Convênio: AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
11/01/2026 08:28	11/01 18:20	Técnico/Auxiliar Enfermagem	Anotação de		Alaia de Cassia Ferreira Gusmao	COREN 627731-TE

Hash: 7E5F2A4C92CB119F79EB935A11A5ABE3

Dt. Assinatura: 11/01/2026 19:18

Documento assinado digitalmente em: 11/01/2026 19:18:41, por: Alaia de Cassia Ferreira Gusmao COREN 627731-TE

- recebo plantão na uca com paciente em repouso no leito na companhia de seus pais em obs acordado, responsivo, com persistência da tosse, roquidão e palidez após reavaliação médica solicitado internação com diagnóstico de laringite
- acesso venoso periférico em membro superior esquerdo funcionando sem sinais flogísticos
- nega alergia medicamentosa
- eliminações fisiológicas presente nas 24 horas
- aceitando adieta
- solicitado e usado 5 espuma gel
- respirando em aa, em oximetria de pulso e cardíaca
- segue aguardando leito

Alaia de Cassia Ferreira Gusmao
COREN 627731-TE



HSD - Relatório Consolidado

Paciente	Jose Henrique da Silva Fernandes			Atendimento	9.108.291
Data Nascto.	06/03/2025	10 Meses		Prontuário	1.116.047
Sexo	Masculino			Dt. Entrada	11/01/2026 08:17:29
Setor	UCA PED.			Convênio	PARTICULAR Enfermaria
Leito	L.02			Dt. Assinatura	
Hash					

Evoluções / Anotações

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
11/01/2026 20:12	11/01/20:18	Técnico de enfermagem	Anotações de Enfermagem - Pediatria		Luzinete Oliveira Rocha	COREN 1146836-TE

recebo plantão com paciente com diagnsotico de laringite acompanhado de sua mae ,afebril ,taquipneico,em ar ambiente ST.97%em ar ambiente
apresentando melhora da tosse,ainda com rouquidão,eliminações fisiologicas presentes ,acesso venoso periferico hidratação em curso sem sinais
flogisticos ,monitorizado mas oximetria de pulso ,mae desconhece alergia a medicação ate o momento ,aferido sinais vitais ,administrado medicações
informe prescrição medica segue aos cuidados de enfermagem .

Sinais Vitais

Data Sinal Vital	Data Liberação	Profissional	PA max	PA min	FC (bpm)	FR (bpm)	Temp. Set O ²	Glic. Cap.	Escala Dor	Valor
11/01/2026 20:07	11/01/2026 20:05	Luzinete Oliveira Rocha Falcao			101	36	38,5	97	FLACC	0

069 946 100 971-1100
Luzinete Oliveira Rocha Falcao
COREN 1146836-TE

Luzinete Oliveira Rocha Falcao
COREN 1146836-TE



Paciente	Jose Henrique da Silva Fernandes	Atendimento	9.108.291
Data Nascto.	06/03/2025 10 Meses	Prontuário	1.116.047
Sexo	Masculino	Dt. Entrada	11/01/2026 08:17:29
Telefone	98 985108882	Convênio	AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900
Leito	516		

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
11/01/2026 16:32	11/01 16:33	Farmacêutico(a)	Reconciliação na		Larissa Karyne Araujo de Magalhaes	

Hash: 9137FC9517880FA310D107D6139E7FDD Dt. Assinatura: 11/01/2026 17:30

Documento assinado digitalmente em 11/01/2026 17:30:45, por Farmacêutico (a) Larissa Karyne Araujo de Magalhaes

Plano Farmacoterapêutico

Medicamentos de uso contínuo registrados em histórico de saúde:

Vitamina D	2 gotas	1x ao dia
Ferro	3 gotas	1x ao dia

Reconciliação: Histórico confirmado com a acompanhante do paciente (mãe). Medicamentos não prescritos (suplementos).

Histórico de Saúde: Atualizado.

Interações Medicamentosas: Não há evidências significativas e com boa literatura sobre interações entre os medicamentos de horário da atual prescrição. (Fonte: Micromedex)

Comorbidades: Nega.

Hipótese diagnóstica/motivo da internação: LARINGITE AGUDA

Reações Adversas a Medicamentos: Sem relatos até o momento.

Alerta para Riscos:

Queda: Hixizine; ondansetrona (sn);
Febre:dipirona(sn); Pantoprazol;
Alergia: Nega a medicamentos.
Broncoaspiração: Não

Orientações: A equipe de enfermagem quanto aos riscos citados.

Profilaxia de TEV/TEP: Sem quimioprofilaxia até o momento.

Profilaxia de Úlcera de Stress: Pantoprazol 40mg

Paciente em tratamento oncológico: Não

Antibioticoterapia: Não.

Exames laboratoriais:

Sem exames laboratoriais recente.

Metas de cuidado/ Plano Farmacoterapêutico:

() Reconciliação medicamentosa

Larissa Karyne Araujo de Magalhaes
Farmacêutico (a)

Paciente **Jose Henrique da Silva Fernandes**
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 À 900

- () Monitorar profilaxia de TEV/TEP
- () Monitorar INR
- () Monitorar exames laboratoriais
- () Monitorar antibioticoterapia/ função renal
- (x) Monitorar reações adversas
- () Monitorar medicamentos via sonda
- () Monitorar indicação de acesso central

Larissa Karyne Araujo de Magalhaes
Farmacêutico (a)



Paciente	Jose Henrique da Silva Fernandes		Atendimento	9.108,291
Data Nascto.	06/03/2025	10 Meses	Prontuário	1.116,047
Sexo	Masculino		Dt. Entrada	11/01/2026 08:17:29
Telefone	96 985108882		Convênio	AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 Á 900
Leito	516			

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
12/01/2026 07:39	12/01 07:47	Médico(a)	Evolução Médica		Marcelo Rossany Oliveira Franco	CRM 5899

Hash:	B0A43A40236EBACF67BF1A915E88051F	Dt. Assinatura:	12/01/2026 08:44
-------	----------------------------------	-----------------	------------------

Documento assinado digitalmente em 12/01/2026 08:44:40, por Marcelo Rossany Oliveira Franco CRM 5899

1. Diagnóstico:SD GRIPAL,LARINGITE AGUDA

Peso: 9 kg

2. Alergias

3. Dias de Internação: 2 dias

4. Terapêutica atual (Antibióticos e medicações de risco):

CLENIL
ADRENALINA
METILPRED

5. Evolução das Últimas 24h:

PACIENTE ESTÁVEL HEMODINAMICAMENTE,SEM DVA OU SEDAÇÃO,EM AR AMBIENTE,TAQUIPNÉICO LEVE,MANTENDO SAT 93-97%
COM ESTRIDOR LARINGEO,TOSSE ROUCA,METALICA.
AFEBRIL NAS ULTIMAS HORAS,ACEITANDO DIETA.
ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES

6. Exame Físico

REG,AFEBRIL,HIPOCORADO,TAQUIPNÉICO MODERADO,ACIANÓTICO
AR MV RUDE,RONCOS LEVES
ACV RCR,2T,BNF,SEM SOPRO
BD FLÁCIDO,INDOLOR,RHA PRESENTES
EXTREMIDADES TEC<2S
SN ATIVO,REATIVO

7. Resultado dos exames importantes:

RX TORAX NORMAL

8. Programação do dia:

CONVERSO COM FAMILIARES
PRESCREVO DEIXO NBZ COM ADRENALINA DE 4/4H
INTENSIFICAR FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA
VIGIAR PADRAO RESPIRATÓRIO
SOLICITO EXAMES LAB DE CONTROLE
CUIDADOS INTENSIVOS

9. Previsão de alta: 14/01/2026 08:30 - Média probabilidade

10. Plano Terapeutico:UTI-PED

11. Avaliação de Riscos/Scores:

Marcelo Rossany Oliveira Franco
CRM 5899



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

11.1 Flebite:

11.2 Avaliação do risco de queda - Humpty Dumpty: 13 - Alto risco de queda

11.3 Avaliações de BradenQ (Lesão por pressão): 26 - Risco baixo

11.4 Avaliações do risco strogkids (Risco Nutricional):

Marcelo Rossany Oliveira Franco
CRM 5899



Paciente	Jose Henrique da Silva Fernandes			Atendimento	9.108.291	
Data Nascto.	06/03/2025	10 Meses		Prontuário	1.116.047	
Sexo	Masculino			Dt. Entrada	11/01/2026 08:17:29	
Telefone	98 985108882			Convênio	AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900	
Leito	516					
Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
12/01/2026 20:47	12/01 20:56	Médico(a)	Evolução Médico		Patricia Vieira Silveira	CRM 9948

Hash: F3D85A22483AE22AE9443167F2BF7F23 Dt. Assinatura: 12/01/2026 21:53
Documento assinado digitalmente em: 12/01/2026 21:53:56, por Médico(a) Patricia Vieira Silveira CRM 9948

AS 20:44
FUI CHAMADA PARA REAVALIAR O PACIENTE JOSE HENRIQUE, DORMINDO NO LEITO, TEMPERATURA 35,9°C, FR: 30, FC: 120, SPO2: 99 %, PAI SOLICITA VISITA MEDICA, ALEGANDO MENOR ESTA EM SG 5%, QUERENDO SABER SOBRE GLICEMIA, POIS TINHA ACHADO UM POUCO ALTERADA, SOLICITO DX ATUAL: 137MG/DL PRESCREVO AINDA NBZ COM CLENIL A E NBZ COM ADRENALINA CONVERSO COM OS PAIS SOBRE A GLICEMIA, TIRANDO TODAS AS DUVIDAS





9108291
Atendimento

Hospital São Domingos

Prescrição Eletrônica Paciente



12653371
Prescrição

Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10m 5d
Data Entrada: 11/01/2026 08:17:29
Médico Resp: Dra. Helida Cristina Alcantara Vicente (CRM 4026)
Prescritor: Marcelo Rossany Oliveira Franco CRM - 5899
Lib. Enferm: Marcelo Rossany Oliveira Franco CRM - 5899
Validade: 12/01/2026 19:00:00 13/01/2026 18:59:59

Atendimento: 9.108.291
Convênio: PARTICULAR / Apartamento
Liberação: 12/01/2026 08:18:46
Data Prescr: 12/01/2026 08:17:00
Prontuário: 1.116.047
Leito e Setor: L.02 UCA PED.
Peso: 9
Dt. Assinatura: 12/01/2026 09:15:52

Hash: F1F7370DF8D1E89CF679E43B6BA6DOE5

Documento assinado digitalmente em 12/01/2026 09:15:52, por Marcelo Rossany Oliveira Franco CRM - 5899

Alergias:

Dietas	Intervalo	Horários	Observação
Branda Múltiplas Alergias	3/3 h	20:20 23:20 02:20 05:20 08:20 11:20 14:20 17:20	

Soluções

Soro Glicosado 5% 250ml inj Velocida 9,9556 gtm Etapas: 4

Dispositivo de infusão: Equipo macrogotas simples

Horários: das 19 às 01; das 01 às 07; das 07 às 13; das 13 às 19;

Tipo Analgesia:

Modo:

Fluxo:

Bolus:

Dose Inicial:

Dose Limite 4h:

Dose Limite 1h: ml

Soro Glicosado 5% 250ml inj

Dose: 175 ml

Cloreto de Potassio 10% 10ml injetavel

Dose: 2,7 ml

Cloreto de Sodio 20% 10ml injetavel

Dose: 1,5 ml

Medicamentos

Dose

Horários

DipiRONA 500 MG/ML-2ML AMP TEUTO | 0,4 ml SOS/SN Intravenosa

Diluir 0,4 Mililitros do medicamento em 10 Mililitros de Agua p/ Injeção 10ml

Administrar 10,4 Mililitros (SOS/SN Intravenosa)

Janetrona 4 mg em 2 mL- inj | 0,6 ml SOS/SN Intravenosa SN

Diluir 0,6 Mililitros do medicamento em 50 Mililitros de Soro Fisiológico 0,9% (NaCl)

50ml inj

Administrar 50,6 Mililitros (SOS/SN Intravenosa)

Estabilidade: 48 Horas Após diluição

Temperatura ambiente controlada (15°C a 30°C)

Recomendado acesso central

Simeticona 75mg/ml gts 15ml | 9 gts 8/8 h Oral

00:30 08:30 16:30

Recomendações

Intervalo

Horários

Cabeceira do leito elevada 45° graus

Contínuo

08:20 08:20

Fisioterapia Respiratória 2x ao dia

FISIO 2X

10 16

Monitorização Cardíaca

Contínuo

08:20 08:20

Oximetria continua de pulso mais sensor

Contínuo

08:20 08:20

Sinais Vitais de 2/2h

2/2 h

08:20 10:20 12:20 14:20
16:20 18:20 20:20
22:20 00:20 02:20 04:20
06:20 08:20 10:20
12:20 14:20 16:20 18:20

Liberação 12/01/2026 07:35:54

Página 1/3

marcelo.franco

CATE02350



Número do documento: 26022014124667700000159866784

<https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26022014124667700000159866784>

Assinado eletronicamente por: VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - 20/02/2026 14:12:47

Num. 172684516 - Pág. 36



Paciente	Jose Henrique da Silva Fernandes	Atendimento	9.108.291
Data Nascto	08/03/2025 10m 6d	Convênio	PARTICULAR / Apartamento
Data Entrada	11/01/2026 08:17:29	Liberação	12/01/2026 08:18:48
Médico Resp	Dra. Helida Cristina Alcantara Vicente (CRM 4026)	Data Prescr.	12/01/2026 08:17:00
Prescritor	Marcelo Rossany Oliveira Franco CRM - 5899	Prontuário	1.116.047
Lib. Enferm	Marcelo Rossany Oliveira Franco CRM - 5899	Leito e Setor	L.02 UCA PED.
Validade:	12/01/2026 19:00:00 13/01/2026 18:59:59	Peso	9
		Dt. Assinatura	12/01/2026 09:15:52

Hash F1F7370DF8D1E89CF679E43B6BA6DDE5

Documento assinado digitalmente em 12/01/2026 09:15:52, por Marcelo Rossany Oliveira Franco CRM - 5899

Alergias:

Marcelo Rossany Oliveira Franco CRM - 5899

Nebulização	Dose	Intervalo/Horário
Nebulização Clenil + S.F com O²		12/12 h
Clenil A sol nbz 2ml	1 ml 12/12 h In	08:21 20:21 08:21
Cloreto de Sodio 0,9% 10ml inj	5 ml 12/12 h In	08:21 20:21 08:21
Nebulização c/ Adrenalina com O²		4/4 h
Adren 1mg/1mL inj- EPINEfrina -USO INALATORIO	3 mg 4/4 h In	07:33 11:33 15:33 19:33 23:33 03:33 07:33 11:33 15:33

Marcelo Rossany Oliveira Franco CRM - 5899





Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 08/03/2025 10m 6d
Data Entrada: 11/01/2026 08:17:29
Médico Resp: Dra. Helida Cristina Alcantara Vicente (CRM 4026)
Médico Pres: Dra. Patricia Vieira Silveira (CRM 9948)
Lib. Enferm: Patricia Vieira Silveira CRM - 9948
Validade: 12/01/2026 20:40:00 até 13/01/2026 18:59:59
Dt.Assinatura: 12/01/2026 21:37:09
Hash: FECB95ED646E273ADCFB63090C7C4447
Atendimento: 9.108.291
Convênio: AMIL / AMIL INDIVIDUAL 500
Liberação: 12/01/2026 20:40:02
Data Prescr.: 12/01/2026 20:39:29
Prontuário: 1.116.047
Leito e Setor:
E-mail: sandromf26@gmail.com

Documento assinado digitalmente em 12/01/2026 21:37:09, por Médico(a) Patricia Vieira Silveira CRM 9948

CID

Urgência enfermagem:

Urgência médica:

Alergias:

Medicamento	Dose	Intervalo/Horário
Nebulização Clenil + S.F com O ₂		12/12 h
Clenil A sol nbz 2ml	1 ml 12/12 h In	20:39 08:39 •
Cloreto de Sodio 0,9% 10ml inj	5 ml 12/12 h In	20:39 08:39 •

Patricia Vieira Silveira
Médica
CRM/MA - 9948

Dra. Patricia Vieira Silveira (CRM 9948)

Liberação: 12/01/2026 20:40:02

Página 1/1

patricia.silvei

CATE00624





Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 08/03/2025 10m 6d
Data Entrada: 11/01/2026 08:17:29
Médico Resp: Dra. Helida Cristina ALCANTARA VICENTE (CRM 4026)
Médico Pres: Dra. Patricia Vieira Silveira (CRM 9948)
Lib. Enferm: Patricia Vieira Silveira CRM - 9948
Validade: 12/01/2026 20:43:00 até 13/01/2026 18:59:59
Dt.Assinatura: 12/01/2026 21:40:44
Hash: 0F36AA48BCA8BC9CB04FCE1590915E08
Atendimento: 9.108.291
Convênio: AMIL / AMIL INDIVIDUAL 500
Liberação: 12/01/2026 20:43:37
Data Prescr.: 12/01/2026 20:42:35
Prontuário: 1.116.047
Leito e Setor:
E-mail: sandromf26@gmail.com

Documento assinado digitalmente em 12/01/2026 21:40:44, por Médico(a) Patricia Vieira Silveira CRM 9948

CID:

Urgência enfermagem:

Urgência médica:

Alergias:

Medicamento	Dose	Intervalo/Horário
Nebulização c/ Adrenalina com O₂		4/4 h
Adren 1mg/1mL inj- EPINEfrina -USO INALATORIO	3 mg 4/4 h In	20:43 00:43 04:43 08:43 12:43 16:43
Cloreto de Sodio 0,9% 10ml inj	5 ml 4/4 h In	20:43 00:43 04:43 08:43 12:43 16:43
Recomendações	Intervalo	Horários
Controle Glicêmico	Agora	20:43 137 mg/dL

Patricia Vieira Silveira
Médica

Dra. Patricia Vieira Silveira (CRM 9948)





Hospital

São Domingos



9108291

Atendimento

Hospital São Domingos

Prescrição Eletrônica Paciente



12653377

Prescrição

Paciente	Jose Henrique da Silva Fernandes	Atendimento	9.108.291
Data Nascto	06/03/2025 10m 6d	Convênio	PARTICULAR / Apartamento
Data Entrada	11/01/2026 08:17:29	Liberação	12/01/2026 08:20:28
Médico Resp	Dra. Helida Cristina Alcantara Vicente (CRM 4026)	Data Prescr.	12/01/2026 08:20:00
Prescritor	Marcelo Rossany Oliveira Franco CRM - 5899	Prontuário	1.116.047
Lib. Enferm	Marcelo Rossany Oliveira Franco CRM - 5899	Leito e Setor	L.02 UCA PED.
Validade:	12/01/2026 19:00:00 13/01/2026 18:59:59	Peso	9
Hash	F1F7370DF8D1E89CF679E43B6BA6DDE5	Dt. Assinatura	12/01/2026 09:15:52

Documento assinado digitalmente em 12/01/2026 09:15:52, por Marcelo Rossany Oliveira Franco CRM - 5899

Alergias:

Medicamentos	Dose	Horários
Decadron 10 mg em 2,5 mL- injetavel	0,7 ml 8/8 h Intravenosa DE 0,7ml (08:20)	22 06 14

Diluir 0,7 Mililitros do medicamento em 10 Mililitros de Cloreto de Sódio 0,9% 10ml inj
Administrar 10,7 Mililitros (8/8 h Intravenosa) em 4 minutos
Dose Especial: 0,7 ml às 08:20 h

Marcelo Rossany Oliveira Franco CRM - 5899

Liberação 12/01/2026 07:35:54

Página 3/3

marcelo.franco

CATE02350






9108291
Atendimento

Hospital São Domingos
Prescrição Eletrônica Paciente
Internado


12656370
Prescrição

Paciente	Jose Henrique da Silva Fernandes	Atendimento	9.108.291										
Data Nascto	06/03/2025 10m 6d	Convênio	AMIL / AMIL INDIVIDUAL 500										
Data Entrada	11/01/2026 08:17:29	Liberção	12/01/2026 17:53:48										
Médico Resp	Dra. Helida Cristina Alcantara Vicente (CRM 4026)	Data Prescr.	12/01/2026 17:53:00										
Prescritor	Marcelo Rossany Oliveira Franco CRM - 5899	Prontuário	1.116.047										
Lib. Enferm	Marcelo Rossany Oliveira Franco CRM - 5899	Leito e Setor	L 02 UCA PED.										
Validade:	12/01/2026 17:53:00 13/01/2026 18:59:59	Peso	9										
Hash	12014C4BB9581BDE8EA67A36EFC03488												
Documento assinado digitalmente em: 12/01/2026 18:52:05, por: Marcelo Rossany Oliveira Franco CRM - 5899													
Alergias:													
<table><thead><tr><th>Nebulização</th><th>Dose</th><th>Intervalo/Horário</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nebulização c/ Adrenalina com O₂</td><td></td><td>Agora</td></tr><tr><td>Adren 1mg/1mL inj- EPINEfrina -USO INALATORIO</td><td>3 mg Agora In</td><td>17:53 19:53</td></tr></tbody></table>					Nebulização	Dose	Intervalo/Horário	Nebulização c/ Adrenalina com O ₂		Agora	Adren 1mg/1mL inj- EPINEfrina -USO INALATORIO	3 mg Agora In	17:53 19:53
Nebulização	Dose	Intervalo/Horário											
Nebulização c/ Adrenalina com O ₂		Agora											
Adren 1mg/1mL inj- EPINEfrina -USO INALATORIO	3 mg Agora In	17:53 19:53											
Marcelo Rossany Oliveira Franco CRM - 5899													
Liberção 12/01/2026 17:53:48 Página 1/1 marcelo.franco CATE02350													



Número do documento: 26022014124793800000159866785

<https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26022014124793800000159866785>

Assinado eletronicamente por: VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - 20/02/2026 14:12:48

Num. 172684517 - Pág. 5





9108291
Atendimento



12654701
Prescrição

Hospital São Domingos

Prescrição Eletrônica Paciente

Paciente

Jose Henrique da Silva Fernandes

Data Nascto

06/03/2025 10m 8d

Data Entrada

11/01/2026 08:17:29

Médico Resp

Dra. Helida Cristina Alcantara Vicente (CRM 4026)

Prescritor

Marcelo Rossany Oliveira Franco CRM - 5899

Lib. Enferm

Marcelo Rossany Oliveira Franco CRM - 5899

Validade:

12/01/2026 11:55:00 13/01/2026 18:59:59

Atendimento

9.108.291

Convênio

AMIL / AMIL INDIVIDUAL 500

Liberação

12/01/2026 11:56:42

Data Prescr.

12/01/2026 11:55:00

Prontuário

1.116.047

Leito e Setor

L 02 - UCA PED.

Peso

9

Dt. Assinatura

12/01/2026 12:53:47

Hash

A9E6E745113661E27E46C0BD5ECEBBD2

Documento assinado digitalmente em 12/01/2026 12:53:47, por Marcelo Rossany Oliveira Franco CRM - 5899

Alergias:

Medicamentos	Dose	Horários
PANTOCAL 4MG/ML-10ML FR/AMP EV	2,2 ml 1x ao dia Intravenosa DE 2,2ml (11:56)	11:55 11:55 11:56

Reconstituir cada Frasco-ampola em 10 Mililitros de Diluente Proprio

Diluir 2,2 Mililitros da reconstituição em 100 Mililitros de Soro Fisiologico 0,9% (NaCl) 100ml inj

Administrar 102,2 Mililitros (1x ao dia Intravenosa) em 1 h.

Dose Especial: 2,2 ml às 11:56 h

Marcelo Rossany Oliveira Franco CRM - 5899

Liberação 12/01/2026 08:20:28

Página 1/1

marcelo.franco

CATE02350

Número do documento: 26022014124793800000159866785
<https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26022014124793800000159866785>
Assinado eletronicamente por: VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - 20/02/2026 14:12:48

Num. 172684517 - Pág. 6



Hospital
São Domingos

Relatório dos Parâmetros Assistenciais do Paciente

De: 12/01/2026 Até: 12/01/2026

Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes

Convênio: AMIL-AMIL INDIVIDUAL

Atendimento: 9108291

Data nasc: 06/03/2025 10m 13d

Setor / leito: Internação E-5 516

Prontuário: 1116047

Data entrada: 11/01/2026 08:17:29

Médico resp: Dra. Antonia de Jesus Barros

Total BH acumulado: 1355,8

Parâmetros	Un med	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	01	02	03	04	05	06	Total	
12/01/2026																											
SINAIS VITAIS																											
Temp	°C		36,1		36,2		36		35,7		35,6		35,3		35,9		36,1		35,9		35,8		35,9				
FC	bpm		115		128		142		147		152		100		120		98		120		99		111				
FR	mm		30		32		30		21		48		31		30		32		23		26		23				
Sat O2	%		96		97		96		97		96		95		99		98		97		96		97				
Glic cap	mg/dL															137											
Escala dor	Ponto		FLAC		FLAC		FLAC		FLAC		FLAC		FLAC		FLAC		FLAC		FLAC		FLAC		FLAC				
Ponto dor			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
Peso	kg								9				9														
GANHOS	ml		191,36																							191,36	
Medicamento por via enteral																											
Medicamento oral			2,5																							2,5	
Medicamento intravenoso			10,08																							10,08	
Dieta enteral																											
Água por sonda																											
Soro glicosado			179,2																							179,2	
Pausa Dieta Enteral																											
PERDAS	ml																										
Diurese espontânea - Volume																											
ESCALA PEWS																											
Sonda Gástrica em Sifonagem																											
BALANÇO HÍDRICO																											
Acumulado dia	ml		191,36																								

Impresso em: 19/01/2026 16:14:35

Página 1

F61333388306

WATE00156

Número do documento: 26022014124793800000159866785
<https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26022014124793800000159866785>
Assinado eletronicamente por: VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - 20/02/2026 14:12:48

Num. 172684517 - Pág. 7

Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 À 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
12/01/2026 09:45	12/01 10:06	Enfermeiro(s)	Evolução de		Esmeralda Pereira Silva Lobato	COREN 325780-ENF

Hash: 938CE541A1B385206DEDC924778DF339

Dt. Assinatura: 12/01/2026 11:04

Documento assinado digitalmente em 12/01/2026 11:04:54, por Esmeralda Pereira Silva Lobato COREN 325780-ENF

Avaliação: Evolução de enfermagem universal

1 - Dados da Internação :

Diagnóstico de internação : LARINGITE

Dias de hospitalização : 2

Dias no setor de cuidado : 2

Previsão de alta no plano terapêutico : 14/01/2026 08:30:17

2 - Anamnese e exame físico

Queixa atual : Tosse mais e cheia e ladrante, congestão nasal.
=ALERGIA ALIMENTAR: OVO.

Sistema neurológico

Descritivo : Na companhia e familiar, desperto, ativo e reativo, calmo.

CAM ICU : NA

Glasgow :

Paciente em ventilação mecânica : Não

Avaliação do nível de sedação :

Sistema respiratório :

Padrão/Ausculta/Observações : Taquipneico leve em ar ambiente, sem desconforto respiratorio, saturando 100%.

Sistema cardiovascular :

Ausculta/Hemodinâmica : Estavel, afebril, sem piora do quadro.

Abdome :

Aparência/Ruidos/Observações : Abdome distendido timpanico, indolor a palpação.

Dieta e Hidratação :

Tipo de dieta / Via de administração / Status / Aceitação ou Tolerância : Aceitando a dieta e formula, leite nan , sem vomitos.

Paciente possui indicação de verificação do resíduo gástrico? : Não

Eliminações Tipo/Local :

Intestinais : Evacuações presentes nas 24h.

Vesicais : Diurese presente em fralda.

Mobilidade : Deambula com auxílio

Pele :

Inspecção/Observação : Pele integra, hidratada, hipocorada, sem edema.

Escala de avaliação de pele : Risco baixo

Integridade : Integra

Risco de lesão de pele? : Não

Esmeralda Pereira Silva Lobato
COREN 325780-ENF



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 518

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 Á 900

Lesão de pele? : Não
Controle de umidade I : Não
Lesão de pele/Ferida Operatória/Outras Lesões 1 :
Quantidade :
Lesão de pele/Ferida Operatória/Outras Lesões 2 :
Quantidade :
3 - Medidas :
Sinais Vitais :
PA :
Temp : 36,4
R : 32
FC : 110
Sat : 100%
FIO2 :
DOR : 0
NEWS/PEWS : 0
Glicemias :
Hipoglicemia no período? : NÃO
Escalas :
Fugulin : Sim
Resultado :
Paciente com plaquetas < 30.000 ou RNI > 3? : NÃO
Resultado : Resultado: Alto risco de queda - Pontuação: 17

Paciente com alto risco de queda? : SIM
Ronda Assistencial : Manter grades elevadas, cama baixa e travada, mae ao lado da criança.
Flebite : Sim
Resultado : 0
Avaliação de toxicidade de quimioterapia :
Avaliação de Toxicidade? : NA
Avaliação das medidas :

4 - Protocolos

Protocolos : Não
Central :
Central? : Não
Periférico :
Periférico? : SIM
Local : MSD
Data de punção : 11/01/2026
Obs/Conduta : Observar edema e sinais de flebite
Arterial :
Arterial : NÃO

6 - Outras intervenções

Esmeralda Pereira Silva Lobato
COREN 325780-ENF



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985106882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Hemotransfusão : NÃO
Dálise/Hemodiálise : NÃO
Procedimento Cirúrgico : NÃO
Exames e pendências : NÃO
Outros procedimentos : NÃO

7 - Plano de Cuidados/ Round Multidisciplinar

Descritivo : Atenção para desconforto respiratório;
tentar para febre, dor, náuseas e vômitos;
Manter grades elevadas, cama baixa e travada;
Observar edema e sinais de flebite no acesso periférico.

Status : Mantido

8 - Desfecho

Desfecho : Internação mantida

Descritivo : Avaliado pelo pediatra, ajuste de prescrição medica.
Aguardando liminar para liberação da internação.

Esmeralda Pereira Silva Lobato
COREN 325780-ENF



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 518

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
12/01/2026 22:00	13/01 05:36	Enfermeiro(a)	Evolução de		Elciney Cardoso Coelho	COREN 598600-ENF

Hash: 3BCD25F08C827FED70DDA1EA78A2CF54

Dt. Assinatura: 13/01/2026 06:33

Documento assinado digitalmente em 13/01/2026 06:33:24, por Enfermeiro(a) Elciney Cardoso Coelho COREN 598600-ENF

DIAGNÓSTICO: LARINGITE

HDA: CRIANÇA 10 MESES DEU ENTRADA EM GRANDE SALA COM TOSSE LADRANTE E FEBRE REALIZADO RESGATE COM ADRENALINA, SOLICITADO E LEITO DE UTI.

NO MOMENTO, CRIANÇA EM REPOUSO NO LEITO, MONITORIZADO, NA COMPANHIA DOS PAIS, DORMINDO, REATIVO. AFEBRIL. HÍDRATADO. NORMOCÁRDICO. PERFUSÃO PERIFÉRICA ADEQUADA, 2S. TAQUIPNEICO EM AR AMBIENTE, SEM SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATORIO, MANTENDO SATURAÇÃO 97%. APRESENTANDO LEVE ROUQUIDÃO E TOSSE. NUTRIÇÃO POR VIA ORAL COM POUCA ACEITAÇÃO DA DIETA OFERTADA. ABDOME SEM ALTERAÇÃO. ELIMINAÇÕES INTESTINAIS PRESENTES E DIURESE PRESENTE E ESPONTÂNEA EM FRALDAS. MOVIMENTA TODOS OS SEGMENTOS CORPORAIS SEM ALTERAÇÃO. PELE ÍNTEGRA PARA LPP. SEM EDEMAS. AVP EM MSD DATADO DE 11/01 PÉRVIO, SEM SINAIS FLOGÍSTICOS, COM HÍDRATAÇÃO VENOSA EM CURSO. AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO CONVENIO PARA UTI E EXAMES LABORATORIAIS.

SAT: 97%
FC: 111 BPM
FR: 38 IRPM
T: 35,8°C

CONDUTAS:

MANTER MONITORIZAÇÃO CONTINUA
GARANTIR IDENTIFICAÇÃO SEGURA
AFERIR SSVV DE 2/2H
ATENTAR PARA ALTERAÇÃO DE PADRÃO RESPIRATORIO
ATENTAR PARA ALTERAÇÃO DE TEMPERATURA E MEDICAR CONFORME
MANTER CABECEIRA ELEVADA 30° A 45°

Elciney Cardoso Coelho
Enfermeiro(a) COREN 598600-ENF



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
12/01/2026 08:06	12/01 10:20	Técnico de enfermagem	Anotações de		Thamiris Reis Diniz	

Hash: 0256C6B5331508F58AD10563164B9CAB

Dt. Assinatura: 12/01/2026 11:18

Documento assinado digitalmente em 12/01/2026 11:18:23, por Thamiris Reis Diniz

Aa 07:00 horas recebo paciente no leito na companhia de sua responsável com diagnostico de Laringite
Em ar ambiente, verificado sinais vitais de 2/2 horas , afebril, eupneico, taquipneia leve , contactuante, ativo , reativo, fazendo uso de oxímetro de pulso e monitorização cardíaca continua, fazendo uso de pulseira de indentificação e risco de queda conforme protocolo de segurança do paciente, orientado manter grades e cabeceiras elevadas e atenção para risco de queda
AVP em MSD funcionate cursando hidratação venosa sem sinais flogísticos
Responsavel informa boa aceitação alimentar e da formula , diurese e evacuações presentes
Responsavel desconhece alergias medicamentosas
Administrado medicações conforme prescrição medica
Segue na companhia de sua responsável aguardando acomodação para UTI
Segue sobre os cuidados da equipe de Enfermagem

Thamiris Reis Diniz



Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo: Masculino
Telefone: 98 985108882
Leito: 516

Atendimento: 9.108.291
Prontuário: 1.116.047
Dt. Entrada: 11/01/2026 08:17:29
Convênio: AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 À 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
12/01/2026 14:57	12/01 18:44	Técnico de enfermagem	Anotação de		Juliane Maria Lima Silva da Silva	COREN 1311118-TE

Hash: DBA69B5B31F972B3098B3B2A6D2B2A2C

Dt. Assinatura: 12/01/2026 19:43

Documento assinado digitalmente em: 12/01/2026 19:43:54, por Técnico(a) de Enfermagem Juliane Maria Lima Silva da Silva COREN 1311118-TE

Avaliação: Anotação de enfermagem universal

1. Estado de recebimento

Descritivo: RECEBO PLANTÃO AS 13:00 H CO PACIENTE NO LEITO EM COMPANHIA DA SUA MÃE, PACIENTE INTERNO COM DIAGNOSTICO DE LARINGITE, PAIS ORIENTADOS SOBRE AS NORMAS DO SETOR SOBRE AOS RISCOS DE QUEDA E FLEBITE, MANTER GRADES E CABICERA ELEVADA, MÃE NEGA ALERGIA ALIMENTAR OU ALERGIA MEDICAMENTOSA, PACIENTE ENCONTRA-SE NO LEITO EM USO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO E AMARELA, ACORDADO, ATIVO, REATIVO, AFEBRIL, EUPNEICO EM AR AMBIENTE, NORMOTENSO E NORMOCARDICO, DIURESE E ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTE EM FRALDA DESCARTAVEL ACEITA PARCIALMENTE A DIETA OFERTADA ACESSO VENOSO PERVIO SEM SINAIS FLOGÍSTICOS, ADMINISTRADO MEDICAÇÕES CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, PRESTADO TODOS OS CUIDADOS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM, PACIENTE SEGUE AGUARDANDO LEITO EM UI.

2 - Escores

Houve alteração do News (maior ou igual a 1) / Pews (maior ou igual a 2) durante o plantão? : Não

3 - Dispositivo Vascular

Central? : NÃO

Realizado troca/instalação de conector valvulado no cateter central? : NÃO

Realizado lavagem do acesso venoso antes, entre e após cada medicação, com seringa salinizada conforme protocolo institucional de recomendações de boas práticas. : Sim

Usado quantas seringas salinizadas ? : 3

Para quais medicações foram utilizadas ? : SORO GLICOSADO+SÓDIO E POTÁSSIO, UNIMEDROL

Utilizado filtro para segurança e redução de risco de infecção e flebite : NÃO

.7 :

Periférico? : SIM

Há sinais de flebite no acesso ? : NÃO

Local : MSD

Data de punção : 11/01/2025

Obs/Conduta : ACESSO VENOSO PERVIO SEM SINAIS FLOGÍSTICOS

Realizado troca de AVP no dia? : Não

4 - Dispositivos e equipamentos

Juliane Maria Lima Silva da Silva
Técnico(a) de Enfermagem COREN 1311118-TE



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 À 900

Bota pneumática : Não

5 - Dieta

Oral : Sim
Status alimentação : Ativa

6 - Eliminações

Intestinais : Em fralda
Status : Eliminações presentes
Característica : PASTOSA
Vesicais : Em fralda
Status : Eliminações presentes
Característica : NORMAIS, PRESENTE

7 - Higiene

Banho : No leito
Oral : Escovação com auxílio
A higiene foi realizada duas vezes? : Não
Justificativa : NA
Quantas vezes realizou aspiração da cavidade oral? : 0
Troca de fraldas 1 : NÃO
Troca de fraldas 2 : NÃO
Troca de fraldas 3 : NÃO
Troca de fraldas 4 : NÃO
Troca de fraldas 5 : NÃO
Glicemia :
Controle Glicêmico : NA
ID/Queda :
Humpty Dumpty : Sim
Resultado : Resultado: Alto risco de queda - Pontuação: 17

Mantive grades elevadas e orientei família : Sim
Chequei/orientei sobre e/ou realizei quando necessário troca de pulseiras de identificação : Sim
PACIENTE COM ALTO RISCO DE QUEDA? : Sim
Ronda Assistencial : MÃE ORIENTADA MANTIVE CAMA BAIXA E GRADES ELEVADA
PAV/PNAV :
Foi realizada higiene oral pela equipe ou autocuidado : NA
Mantive cabeceira elevada : Sim
LPP :
Realizei mudança de decúbito conforme necessário :
NA : Sim
Realizei controle de umidade na troca de fraldas : NA
Acoplei coxins necessários : NA

Juliane Maria Lima Silva de Silva
Técnico(a) de Enfermagem COREN 1311118-TE



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 À 900

Realizei hidratação da pele conforme protocolo : NA

SSVV 12hs :

FC : 147

FR : 21

Dor : 0

Escala Dor : FLACC

9 - Desfecho

Descritivo : ADMINISTRADO MEDICAÇÕES CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA

AS 14:00 H ADMINISTRADO SORO GLICOSADO+SODIO E POTASSIO

AS 14:00 H ADMINISTRADO SIMETICONA VIA ORAL

AS 14:20 H ADMINISTRADO UNIMEDROL VIA EV

AS 16:20 H ADMINISTRADO HIXIZINE VIA ORAL

10 - Materiais pedidos e utilizados

Descritivo : NA

Juliane Maria Lima Silva da Silva
Técnico(a) de Enfermagem COREN 1311118-TE



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 965108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 À 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
12/01/2026 20:47	13/01 06:19	Técnico/Auxiliar Enfermagem	Anotações de		Gessica Pereira Franca	COREN 1009336-TE

Hash: DD7583AACC755B7D4C1BA16711FDBE3A

Dt. Assinatura: 13/01/2026 07:16

Documento assinado digitalmente em 13/01/2026 07:16:40, por Técnico(a) de Enfermagem Gessica Pereira Franca COREN 1009336-TE

AS 19:00 RECEBO MENOR INTERNO EM LEITO DE UTI COM DIAGNOSTICO DE LARINGITE EUPNEICO, AFEBRIL, ORIENTADO, COMUNICATIVO, DEAMBULA, ATIVO/REATIVO, COM MONITORIZAÇÃO CARDIACA COM ELETRODOS, ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES EM FRALDA, COM ACESSO VENOSO PERIFÉRICO EM MSD, COM PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, EM COMPANHIA FAMILIAR. VERIFICADO SINAIS VITAIS MENOR NEGA ALERGIA MEDICAMENTOSA. REALIZADO DX: 137MG/DL. REALIZADO NEBULIZAÇÃO COM ADRENALINA+ CLENIL. ADMINISTRADO MEDICAÇÕES CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. MENOR SEGUE EM CUIDADOS DE ENFERMAGEM, AGUARDANDO LEITO DE UTI.

Gessica Pereira Franca
Técnico(a) de Enfermagem COREN 1009336-TE



Paciente **Jose Henrique da Silva Fernandes**
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
13/01/2026 09:04	13/01 09:07	Médico(a)	Evolução Médica		Alexandre Wilson Silvestre Lopes	CRM 5412

Hash: EE40414CDC24B85B70A51BC6BA4552C4

Dt. Assinatura: 13/01/2026 10:05

Documento assinado digitalmente em 13/01/2026 10:05:34, por Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM 5412

1. Diagnóstico: Laringite + IVAS

Peso: 9 kg

2. Alergias

3. Dias de Internação: 3 dias

4. Terapêutica atual (Antibióticos e medicações de risco):

MANTIDA

5. **Evolução das Últimas 24h:** Paciente com melhora clínica, sono preservado (dormiu a noite toda [SIC]), alimentando-se adequadamente e afebril. Pouca tosse pela manhã. Sem desconforto respiratório. Mantendo saturação de O2 entre 97 - 99% em a.a.

6. **Exame Físico:** EGB, afebril, normocorado, hidratado; AR = mv+ rude; ORO = limpa; ACV = RCR em 2T, BNF, s/sopros; ABD = inocente

7. **Resultado dos exames importantes:** Sem novos exames no presente momento

8. **Programação do dia:** Aguardando leito de UTI PED

9. **Previsão de alta:** 14/01/2026 08:30 - Média probabilidade

10. **Plano Terapeutico:** MANTIDO

11. Avaliação de Riscos/Scores:

11.1 Flebite:

11.2 Avaliação do risco de queda - Humpty Dumpty: 17 - Alto risco de queda

11.3 Avaliações de BradenQ (Lesão por pressão): 24 - Risco baixo

11.4 Avaliações do risco strogkids (Risco Nutricional):

Alexandre Wilson Silvestre Lopes
CRM 5412



Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascio: 06/03/2025 10 Meses
Sexo: Masculino
Telefone: 98 985108862
Leito: 516

Atendimento: 9.108.291
Prontuário: 1.116.047
Dt. Entrada: 11/01/2026 08:17:29
Convênio: AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
13/01/2026 12:07	13/01 12:08	Médico(a)	Evolução Médica		Alexandre Wilson Silvestre Lopes	CRM 5412

Hash: EAAA7F76D6CE6E829F86882FE42A0F9B

Dt. Assinatura: 13/01/2026 13:05

Documento assinado digitalmente em 13/01/2026 13:05:19, por Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM 5412

EM TEMPO

Devido a melhora do quadro geral converto a internação de UTI para Leito de Enfermaria.

Alexandre Wilson Silvestre Lopes
CRM 5412





9108291
Atendimento

Hospital São Domingos
Prescrição Eletrônica Paciente



12657775
Prescrição

Paciente **Jose Henrique da Silva Fernandes**

Data Nascto: 06/03/2025 10m 7d

Data Entrada: 11/01/2026 08:17:29

Médico Resp: Dra. Helida Cristina Alcantara Vicente (CRM 4026)

Prescritor: Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412

Lib. Enferm: Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412

Validade: 13/01/2026 19:00:00 14/01/2026 18:59:59

Atendimento **9.108.291**

Convênio: AMIL / AMIL INDIVIDUAL 500

Liberação: 13/01/2026 09:08:14

Data Prescr.: 13/01/2026 09:07:00

Prontuário: 1.116.047

Leito e Setor: L.02 UCA PED.

Peso: 9

Dt. Assinatura: 13/01/2026 10:06:32

Hash: 1E48C83F155C5F258C70E292A4AC0D0D

Documento assinado digitalmente em 13/01/2026 10:06:32, por Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412

Alergias:

Dietas	Intervalo	Horários	Observação
Branda Múltiplas Alergias	3/3 h	20:20 23: 20 02:20 05:20 08:20 11:20 14: 20 17:20	

Suplemen/Modul/Pediat	Intervalo	Dose	Aplicação	Vel. de Infusão
LEITE PO NAN 2 CONFORT 800G	3/3 h	30 g	Oral	ml/h
Horários: 21 00 03 06 09	12 15	18		

Soluções

Soro Glicosado 5% 250ml inj	Velocida 9,9556 gtm	Etapas: 4
Dispositivo de infusão: Equipo macrogotas simples		
Horários: das 19 às 01;	das 01 às 07;	das 07 às 13;
		das 13 às 19;
Tipo Analgesia:	Modo:	Fluxo:
Dose Inicial:	Dose Limite 4h:	Dose Limite 1h: ml
Cloreto de Sodio 20% 10ml injetavel	Dose: 1,5 ml	
Soro Glicosado 5% 250ml inj	Dose: 175 ml	
Cloreto de Potassio 10% 10ml injetavel	Dose: 2,7 ml	

Medicamentos	Dose	Horários
Decadron 10 mg em 2,5 mL- injetavel	0,7 ml 8/8 h Intravenosa	19 03 11
<i>Diluir 0,7 Mililitros do medicamento em 10 Mililitros de Cloreto de Sodio 0,9% 10ml inj</i> <i>Administrar 10,7 Mililitros (8/8 h Intravenosa) em 4 minutos</i>		
DipIRONA 500 MG/ML-2ML AMP TEUTO	0,4 ml SOS/SN Intravenosa	
<i>Diluir 0,4 Mililitros do medicamento em 10 Mililitros de Agua p/ Injeção 10ml</i> <i>Administrar 10,4 Mililitros (SOS/SN Intravenosa)</i>		
Ondansetrona 4 mg em 2 mL- inj	0,6 ml SOS/SN Intravenosa	SN
<i>Diluir 0,6 Mililitros do medicamento em 50 Mililitros de Soro Fisiologico 0,9% (NaCl) 50ml inj</i> <i>Administrar 50,6 Mililitros (SOS/SN Intravenosa)</i> <i>Estabilidade: 48 Horas Após diluição</i> <i>Temperatura ambiente controlada (15°C a 30°C)</i> <i>Recomendado acesso central</i>		
PANTOCAL 4MG/ML-10ML FR/AMP EV	2,2 ml 1x ao dia Intravenosa	11:55
<i>Reconstituir cada Frasco-ampola em 10 Mililitros de Diluente Proprio</i> <i>Diluir 2,2 Mililitros da reconstituição em 100 Mililitros de Soro Fisiologico 0,9% (NaCl) 100ml inj</i> <i>Administrar 102,2 Mililitros (1x ao dia Intravenosa) em 1 h.</i>		
Simeticona 75mg/ml gts 15ml	9 gts 8/8 h Oral	00:30 08:30 16:30

Nebulização	Dose	Intervalo/Horário
-------------	------	-------------------

Liberação 13/01/2026 09:09:32

Página 1/3

Dr. Alexandre W. S. Lopes alexandre.lopes

CATE02350





Paciente **Jose Henrique da Silva Fernandes**
Data Nascto 06/03/2025 10m 7d
Data Entrada 11/01/2026 08:17:29
Médico Resp Dra. Helida Cristina Alcantara Vicente (CRM 4026)
Prescritor Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412
Lib. Enferm Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412
Validade: 13/01/2026 19:00:00 14/01/2026 18:59:59

Atendimento 9.108.291
Convênio AMIL / AMIL INDIVIDUAL 500
Liberação 13/01/2026 09:08:14
Data Prescr. 13/01/2026 09:07:00
Prontuário 1.116.047
Leito e Setor L.02 UCA PED.
Peso 9
Dt. Assinatura 13/01/2026 10:06:32

Hash 1E48C83F155C5F258C70E292A4AC0D0D

Documento assinado digitalmente em 13/01/2026 10:06:32, por Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412

Alergias:

Nebulização c/ Adrenalina com O²

Adren 1mg/1mL inj- EPINEfrina -USO
INALATORIO
Cloreto de Sodio 0,9% 10ml inj

Marcelo R. Oliveira Fran
Pediatra
CRM-MA 9899

4/4 h
20:00 04 08 12 16
20:00 04 08 12 16

Nebulização Clenil + S.F com O²

Clenil A sol nbz 2ml
Cloreto de Sodio 0,9% 10ml inj

1 ml 12/12 h In
5 ml 12/12 h In

12/12 h
20:39 08:39
20:39 08:39

Recomendações

Intervalo

Horários

Cabeceira do leito elevada 45° graus

Contínuo

08:20 08:20

Fisioterapia Respiratória 2x ao dia

FISIO 2X

10 16

Monitorização Cardíaca

Contínuo

08:20 08:20

Oximetria contínua de pulso mais sensor

Contínuo

08:20 08:20

Sinais Vitais de 2/2h

2/2 h

08:20 10:20 12:20 14:20
16:20 18:20 20:20
22:20 00:20 02:20 04:20
06:20 08:20 10:20
12:20 14:20 16:20 18:20

Dr. Alexandre Wilson Silvestre Lopes
Pediatra
CRM-MA 5412

Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412





Paciente	Jose Henrique da Silva Fernandes	Atendimento	9.108.291
Data Nascto	06/03/2025 10m 7d	Convênio	AMIL / AMIL INDIVIDUAL 500
Data Entrada	11/01/2026 08:17:29	Liberção	13/01/2026 09:09:32
Médico Resp	Dra. Helida Cristina Alcantara Vicente (CRM 4026)	Data Prescr.	13/01/2026 09:08:00
Prescritor	Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412	Prontuário	1.116.047
Lib. Enferm	Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412	Leito e Setor	L.02 UCA PED.
Validade:	13/01/2026 19:00:00 14/01/2026 18:59:59	Peso	9
		Dt. Assinatura	13/01/2026 10:06:32

Hash 1E48C83F155C5F258C70E292A4AC0D0D

Documento assinado digitalmente em 13/01/2026 10:06:32, por Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412

Alergias:

Nebulização	Dose	Intervalo/Horário
-------------	------	-------------------

Nebulização c/ Adrenalina com O₂

SOS/SN

Adren 1mg/1mL inj- EPINEfrina -USO
INALATORIO

3 mg SOS/SN In

SN

Alexandre W. S. Lopes
Pediatra
CRM 5412

Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412





hospital

São Domingos



9108291

Atendimento

Hospital São Domingos

Prescrição Eletrônica Paciente



12657178

Prescrição

Paciente

Jose Henrique da Silva Fernandes

Data Nascto

06/03/2025 10m 7d

Data Entrada

11/01/2026 06:17:29

Médico Resp

Dra. Helida Cristina Alcantara Vicente (CRM 4026)

Médico Pres

Dr. Ciro Borges Barbosa (CRM 13561)

Lib. Enferm

Ciro Borges Barbosa CRM - 13561

Validade:

13/01/2026 06:00:00 até 14/01/2026 19:59:59

Dt.Assinatura

13/01/2026 06:59:18

Hash

CA39C78B88F2EF445B2A4A518648CF15

Atendimento

9.108.291

Convênio

AMIL / AMIL INDIVIDUAL 500

Liberção

13/01/2026 06:01:00

Data Prescr.

13/01/2026 05:59:47

Prontuário

1.116.047

Leito e Setor

E-mail

sandromf26@gmail.com

Documento assinado digitalmente em 13/01/2026 06:59:18, por Médico(a) Ciro Borges Barbosa CRM 13561

CID

Urgência enfermagem:

Urgência médica:

Alergias:

Suplemen/Modul/Pediat	Intervalo	Dose	Aplicação	Vel. de Infusão
Leite Po Nan 2 Confort 800g	3/3 h	30 g	Oral	ml/h

Dr. Ciro Borges Barbosa

Pediatra

CRM-MX 13561

Dr. Ciro Borges Barbosa (CRM 13561)

Liberção: 13/01/2026 06:01:00

Página 1/1

M00051647370

CATE00624

Número do documento: 26022014124793800000159866785
<https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26022014124793800000159866785>
Assinado eletronicamente por: VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - 20/02/2026 14:12:48

Num. 172684517 - Pág. 22



Relatório dos Parâmetros Assistenciais do Paciente

De: 13/01/2026 Até: 13/01/2026

Paciente: Jose Henrique da Silva Fernanc Convênio: AMIL-AMIL INDIVIDUAL Atendimento: 9108291
Data nasc: 06/03/2025 10m 13d Setor / leito: Internação E-5 516 Prontoário: 1116047
Data entrada: 11/01/2026 08:17:29 Médico resp: Dra. Antonia de Jesus Barros Total BH acumulado: 1355,8

Parâmetros	Un med	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	01	02	03	04	05	06	Total
13/01/2026																										
SINAIS VITAIS																										
Temp	°C	35,6	35,8		36		36,2												35,6						36,5	
FC	bpm	140	106		120		123												131						104	
FR	mm	24	28		26		24												30						30	
Sat O2	%	98	97		98		97												99						98	
Glic cap	mg/dL				131																					
Escala dor	Ponto	FLAC	FLAC		FLAC		FLAC												FLAC						FLAC	
Ponto dor		0	0		0		0												0						0	
Peso	kg																								9	
GANHOS	ml																									
Medicamento por via enteral																										
Dieta enteral																										
Água por sonda																										
Pausa Dieta Enteral																										
PERDAS	ml																									
Diurese espontânea - Volume																										
ESCALA PEWS																										
Sonda Gástrica em Sifonagem																										
BALANÇO HIDRICO																										
Acumulado dia	ml																									



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone: 98 965108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
13/01/2026 09:59	13/01 10:27	Enfermeiro(a)	Evolução de		Viviane Cantanhede	COREN 340497-ENF

Hash: 717F6596E483A1337B7373A8C7311FD7

Dt. Assinatura: 13/01/2026 11:26

Documento assinado digitalmente em: 13/01/2026 11:26:13, por Viviane Cantanhede COREN 340497-ENF

Avaliação: Evolução de enfermagem universal

1 - Dados da Internação :

Diagnóstico de internação : LARINGITE / IVAS

Dias de hospitalização : 3

Dias no setor de cuidado : 3

Previsão de alta no plano terapêutico : 14/01/2026 08:30:17

2 - Anamnese e exame físico

Queixa atual : TOSSE

Sistema neurológico

Descritivo : ACORDADO, ATIVO, REATIVO , MANTENDO PADRÃO NEUROLOGICO PRESERVADO E HABITUAL

CAM ICU : NA

Glasgow : 15

Sistema respiratório :

Padrão/Ausculta/Observações : EUPNEICO, SEM SINAIS DESCONFORTO RESPIRATÓRIO, MANTENDO NIVEIS DE SATURAÇÃO ADEQUADOS

Sistema cardiovascular :

Ausculta/Hemodinâmica : HEMODINAMICAMENTE ESTÁVEL, AFEBRIL E NORMOCARDICO

Abdome :

Aparência/Ruidos/Observações : FLÁCIDO, TIMPANICO, INDOLOR A PALPAÇÃO, RHA PRESENTES

Alimentação e Hidratação :

Tipo de dieta / Via de administração / Status / Aceitação ou Tolerância : BOA ACEITAÇÃO. SEM RELATO DE NAUSEAS E/OU VOMITOS

Paciente possui indicação de verificação do resíduo gástrico? : Não

Eliminações Tipo/Local :

Intestinais : ELIMINAÇÕES INTESTINAIS SEM ALTERAÇÕES RELATADAS

Vesicais : ESPONTANEA E COLORAÇÃO HABITUAL

Mobilidade : Deambula com auxílio

Pele :

Inspeção/Observação : INTEGRAL, SEM LESÕES , ACIANÓTICA, ANICTÉRICA, HIDRATADA COM TURGOR E ELASTICIDADE PRESERVADAS

Escala de avaliação de pele : Risco baixo

Integridade : Inteira

Risco de lesão de pele? : Não

Lesão de pele? : Não

Lesão de pele/Ferida Operatória/Outras Lesões 1 :

Quantidade :

Lesão de pele/Ferida Operatória/Outras Lesões 2 :

Viviane Cantanhede
COREN 340497-ENF



Paciente **Jose Henrique da Silva Fernandes**
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Quantidade : ,

Sinais Vitais :

PA :

Temp : 36,0

FR : 30 IRPM

FC : 116 BPM

Sat : 98%

FIO2 : 21%

DOR :

NEWS/PEWS : 0

Glicemias :

Hipoglicemia no periodo? : NÃO

Escalas :

Paciente com plaquetas < 30.000 ou RNI > 3? : NÃO

Resultado : Resultado: Alto risco de queda - Pontuação: 16

Paciente com alto risco de queda? : SIM

Ronda Assistencial : ORIENTO QUANTO AOS RICOS DE QUEDA
MANTER GRADES ELEVADAS,CAMA BAIXA E TRAVADA

Resultado : 0

Avaliação de toxicidade de quimioterapia :

Avaliação de Toxicidade? : NA

4 - Protocolos

Protocolos : Não

Central :

Central? : Não

Periférico :

Periférico? : SIM

Local : MEMBRO SUPERIOR DIREITO

Data de punção : 11/01/2025

Obs/Conduta : PERVIO

Arterial :

Arterial : NÃO

6 - Outras intervenções

Hemotransfusão : NÃO

Dálise/Hemodiálise : NÃO

Procedimento Cirúrgico : NÃO

Exames e pendências : NÃO

Outros procedimentos : NÃO

7 - Plano de Cuidados/ Round Multidisciplinar

Viviane Cantanhede
COREN 340497-ENF



Paciente **Jose Henrique da Silva Fernandes**
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento **9.108.291**
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Descritivo : VERIFICAR SINAIS VITAIS A CADA 2H
MANTER BOAS PRATICAS NA PREVENÇÃO DE QUEDA, FLEBITE E BRONCOASPIRAÇÃO
MONITORAR E REGISTRAR SE ALTERAÇÕES NO PADRÃO RESPIRATÓRIO
MANTER CABECEIRA ELEVADA DE 30 A 45

Status : Mantido

8 - Desfecho

Desfecho : Internação mantida

Descritivo : CRIANÇA COM INDICAÇÃO DE LEITO EM UTI-PED. INTERNAÇÃO NÃO REALIZADA DEVIDO A NEGATIVA DO CONVENIO POR CARENÇIA CONTRATUAL. PAIS INFORMAM QUE DERAM ENTRADA EM PROCESSO JUDICIAL COM PEDIDO DE LIMINAR, PACIENTE AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL. ASSISTENCIA AO PACIENTE ESTA SENDO PRESTADA INTEGRALMENTE, SEM PREJUIZO AO CUIDADO, MANTENDO-SE MONITORIZAÇÃO E SUPORTE NECESSARIOS CONFORME AO QUADRO CLINICO

Viviane Cantanhede
COREN 340497-ENF



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
14/01/2026 05:06	14/01 05:18	Enfermeiro(a)	Evolução de		Nayara Regina Costa dos Santos	COREN 609356-ENF

Hash: BD6F3B83F3D0E6E21B7F31DED62C279D

Dt. Assinatura: 14/01/2026 06:17

Documento assinado digitalmente em 14/01/2026 06:17:35, por Enfermeiro(a) Nayara Regina Costa dos Santos COREN 609356-ENF

Avaliação: Evolução de enfermagem universal

1 - Dados da Internação :

Diagnóstico de internação : LARINGITE AGUDA/IVAS

Dias de hospitalização : 4

Dias no setor de cuidado : 2

Previsão de alta no plano terapêutico : 14/01/2026 08:30:17

2 - Anamnese e exame físico

Queixa atual : APRESENTANDO NO MOMENTO DIARREIA E VOMITOS

Sistema neurológico

Descritivo : ACORDADO, ATIVO, REATIVO , MANTENDO PADRÃO NEUROLOGICO PRESERVADO

CAM ICU : NA

Glasgow : 15

Paciente em ventilação mecânica : Não

Avaliação do nível de sedação :

Sistema respiratório :

Padrão/Ausculta/Observações : EUPNEICO, SEM SINAIS DESCONFORTO RESPIRATÓRIO, MANTENDO NIVEIS DE SATURAÇÃO NORMAIS

Sistema cardiovascular :

Ausculta/Hemodinâmica : NORMOCARDICO,NORMOTENSO,FEBRIL E HEMODINAMICAMENTE ESTAVEL

Abdome :

Aparência/Ruidos/Observações : FLÁCIDO, TIMPANICO, INDOLOR A PALPAÇÃO

Dieta e Hidratação :

Tipo de dieta / Via de administração / Status / Aceitação ou Tolerância : DIETA POR VIA ORAL BOA ACEITAÇÃO. APRESENTANDO RELATO DE NAUSEAS E VOMITOS

Paciente possui indicação de verificação do residuo gástrico? : Não

Eliminações Tipo/Local :

Intestinais : PRESENTES E LIQUIDAS

Vesicais : PRESENTES, NORMAIS E BOM FLUXO

Mobilidade : Deambula com auxílio

Pele :

Inspeção/Observação : INTEGRAL, ACIANOTICO, ANICTERICO E SEM LESOES PARA LPP

Escala de avaliação de pele : Risco baixo

Integridade : Integra

Risco de lesão de pele? : Não

Nayara Regina Costa dos Santos
Enfermeiro(a) COREN 609356-ENF



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Lesão de pele? : Não
Controle de umidade I : Não
Troca :
Realizado troca de curativo? : Não
Lesão de pele/Ferida Operatória/Outras Lesões 1 :
Quantidade : 0
Lesão de pele/Ferida Operatória/Outras Lesões 2 :
Quantidade : 0
Sinais Vitais :
PA : NA
Temp : NA
FR : 24
FC : ,
Sat : ,
FIO2 : NA
DOR : NA
NEWS/PEWS : 0
Glicemias :
Hipoglicemia no período? : NÃO
Escalas :
Paciente com plaquetas < 30.000 ou RNI > 3? : NÃO
Resultado : Resultado: Alto risco de queda - Pontuação: 16

Paciente com alto risco de queda? : NÃO
Resultado : 0
Avaliação de toxicidade de quimioterapia :
Avaliação de Toxicidade? : NA

4 - Protocolos

Protocolos : Não
Central :
Central? : Não
Periférico :
Periférico? : SIM
Local : MSE
Data de punção : 13/01/2026
Obs/Conduta : PERVIO E FUNCIONANTE
Arterial :
Arterial : NÃO

6 - Outras intervenções

Hemotransfusão : NÃO
Dálise/Hemodiálise : NÃO
Procedimento Cirúrgico : NÃO

Nayara Regina Costa dos Santos
Enfermeiro(a) COREN 609356-ENF



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Exames e pendências : NÃO
Outros procedimentos : NÃO

7 - Plano de Cuidados/ Round Multidisciplinar

Descritivo : VERIFICAR SINAIS VITAIS DE 6/6 HORAS
MANter BOAS PRATICAS NA PREVENÇÃO DE QUEDA, FLEBITE E BRONCOASPIRAÇÃO
MONITORAR E REGISTRAR SE ALTERAÇÕES NO PADRÃO RESPIRATÓRIO
MANter CABECEIRA ELEVADA DE 30 A 45

Status : Mantido

8 - Desfecho

Desfecho : Internação mantida

Descritivo : CRIANÇA EM INTERNACAO CLINICA NÃO REALIZADA DEVIDO A NEGATIVA DO CONVENIO POR
CARENCIA CONTRATUAL. PAIS INFORMAM QUE DERAM ENTRADA EM PROCESSO JUDICIAL COM PEDIDO DE
LIMINAR, PACIENTE AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL. ASSISTENCIA AO PACIENTE ESTA SENDO PRESTADA
INTEGRALMENTE, SEM PREJUIZO AO CUIDADO, MANTENDO-SE DE ACORDO PRESCRICAO MEDICA DE
CUIDADOS NECESSARIOS E SUPORTE CONFORME AO QUADRO CLINICO

Nayara Regina Costa dos Santos
Enfermeiro(a) COREN 609356-ENF



SAE - Prescrição e Diagnósticos de Enfermagem (novo)

Paciente	Jose Henrique da Silva Fernandes	Atendimento	9.108.291	Prontuário	1.116.047
Data Nasc	06/03/2025 10 Meses	Convênio	AMIL / AMIL INDIVIDUAL 500 À 900		
Data Entrada	11/01/2026 08:17:29	SAE	1167483		
Enfermeiro	Viviane Cantanhede - COREN 340497-ENF	Data SAE	13/01/2026 09:54:36	Liberação	13/01/2026 09:58:03
Sector	Internação E-5	Leito	516		
Hash	BF0B366CDAE5A11975448B1FDECB0959	Dt. Assinatura	13/01/2026 10:56:19		

Documento assinado digitalmente em: 2026/01/13 10:56:19, por: Viviane Cantanhede COREN 340497-ENF

Diagnósticos de enfermagem

1. Condição respiratória prejudicada
2. Risco de broncoaspiração
3. Risco de infecção
4. Risco de Queda (PEDIATRIA)
5. Deficit de autocuidado

Prescrição de enfermagem

	SN	Intervalo	Horários
1	Avaliar e registrar condição respiratória	Padrão 3 vezes/dia	10 15 20
2	Avaliar e registrar frequência, movimento, ritmo e esforço respiratório	Padrão 3 vezes/dia	10 15 20
3	Calcular o score de queda (Humpty dumpty)	Conforme Protocolo Instituição	10
4	Elevar e manter cabeceira da cama a 30° a 45°	Contínuo	10
5	Manter cabeceira elevada de 30° a 45° graus.	Padrão 3 vezes/dia	10 15 20
6	Manter grades elevadas e cama baixa e travada.	Contínuo	10
7	Monitorar sinais de infecção (calor, dor, rubor, secreção, edema)	Padrão 3 vezes/dia	10 15 20
8	Realizar troca de roupa do leito	Conforme Protocolo Instituição	10

Impresso em: 19/01/2026 16:10:00

Enf.: Viviane Cantanhede - COREN 340497-ENF

Página 1

viviane. / F6133338

Paciente: Jose Henrique da Silva

Internação E-5

516



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
13/01/2026 07:33	13/01 13:53	Técnico de enfermagem	Anotação de		Graciele De Sousa Dos Santos	COREN 1595188-TE

Hash: 57F75F0DD67F0037CB781F9927361D91

Dt. Assinatura: 13/01/2026 14:52

Documento assinado digitalmente em 13/01/2026 14:52:10, por Graciele De Sousa Dos Santos COREN 1595188-TE

Avaliação: Anotação de enfermagem universal

1. Estado de recebimento

Descritivo : ÀS 07:00 RECEBO PLANTÃO COM PACIENTE EM REPOUSO EM LEITO COM GRADES E CABEÇEIRAS ELEVADAS, PACIENTE EM COMPANHIA DE FAMILIARES, EM USO DE MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, E OXIMETRIA DE PULSO, NO MOMENTO RESPIRANDO EM AR AMBIENTE NO MOMENTO AFEBRIL COM DIURES PRESENTE ESPONATNIO EM FRALDAS, PACIENTE SEGUE SEM QUEIXAS ALGICAS, SEGUE AGUARDANDO LIMINAR DO PLANO, ADMINITRADO MEDICAÇÕES CONFORME PRESCRIÇÃO SEGUEOS CUIDADOS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM COM PACIENTE TRANQUILO AGUARDANO LIBERAÇÃO DE ACOMODAÇÃO EM LEITO DE UTI.

ÀS 13 PACIENTE FOI REAVALIADA E CONVESTIDO PARA INTERNAÇÃO / APARTAMENTO

2 - Escores

Houve alteração do News (maior ou igual a 1) / Pews (maior ou igual a 2) durante o plantão? : Não

3 - Dispositivo Vascular

Central? : NÃO
Realizado troca/instalação de conector valvulado no cateter central? : NÃO
Realizado lavagem do acesso venoso antes, entre e após cada medicação, com seringa salinizada conforme protocolo institucional de recomendações de boas práticas. : Sim
Usado quantas seringas salinizadas ? : 03
Para quais medicações foram utilizadas ? : LAVAGEM ENTRE AS MEDICAÇÕES
Utilizado filtro para segurança e redução de risco de infecção e flebite : NÃO
.7 :
Periférico? : SIM
Há sinais de flebite no acesso ? : NÃO
Local : MSD
Data de punção : 12/01/2026
Obs/Conduta : MANUTEÇÃO EM CURSO
Realizado troca de AVP no dia? : Não

4 - Dispositivos e equipamentos

Bota pneumática : Não

5 - Dieta

Graciele De Sousa Dos Santos
COREN 1595188-TE



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 96 985108862
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Oral : Sim
Status alimentação : Ativa

6 - Eliminações

Intestinais : Em fralda
Status : Eliminações presentes
Característica : NORMAIS
Vesicais : Em fralda
Status : Eliminações presentes
Característica : NORMAIS

7 - Higiene

Banho : No leito
Oral : Escovação com auxílio
A higiene foi realizada duas vezes? : Sim
Quantas vezes realizou aspiração da cavidade oral? : 0
Troca de fraldas 1 : NÃO
Troca de fraldas 2 : NÃO
Troca de fraldas 3 : NÃO
Troca de fraldas 4 : NÃO
Troca de fraldas 5 : NÃO
Glicemia :
Controle Glicêmico : Não
ID/Queda :
Resultado : Resultado: Alto risco de queda - Pontuação: 17

Mantive grades elevadas e orientei família : Sim
Chequei/orientei sobre e/ou realizei quando necessário troca de pulseiras de identificação : Sim
PACIENTE COM ALTO RISCO DE QUEDA? : Sim
Ronda Assistencial : ORIENTADOS A MANTER GRADES E CABIÇEIRAS ELEVADAS
PAV/PNAV :
Foi realizada higiene oral pela equipe ou autocuidado : Sim
Mantive cabeceira elevada : Sim
LPP :
Realizei mudança de decúbito conforme necessário :
Não : Sim
Realizei controle de umidade na troca de fraldas : Não
Acoplei coxins necessários : Não
Realizei hidratação da pele conforme protocolo : Não
SSVV 12hs :
FC : 140
FR : 24
Dor : 0

Graciele De Sousa Dos Santos
COREN 1595188-TE



Paciente **Jose Henrique da Silva Fernandes**
Data Nasc.to. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Escala Dor : FLACC

9 - Desfecho

Descritivo : PACIENTE TRANQUILO EM MONITORIZAÇÃO , SEGUE SEM QUEIXAS AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA LIMINAR DO PLANO , REALIZADO UMA NOVA COBERTURA DE ACESSO VENOSO PERIFERICO ,

10 - Materiais pedidos e utilizados

Descritivo : solicitado e utilizado :

- 1 tegaderm
- 20 cm de fita hypafix para fixar o acesso venoso periferico

Graciele De Sousa Dos Santos
COREN 1595188-TE



Paciente **Jose Henrique da Silva Fernandes**
Data Nascto. **06/03/2025** **10 Meses**
Sexo **Masculino**
Telefone **98 985108882**
Leito **516**

Atendimento **9.108.291**
Prontuário **1.116.047**
Dt. Entrada **11/01/2026 08:17:29**
Convênio **AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900**

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
13/01/2026 21:26	13/01 21:28	Técnico de enfermagem	Anotações de		Jucimeire Alves da Silva	COREN 788443

Hash: **E06BF84943445898424590B3E21962FC**

Dt. Assinatura: **13/01/2026 22:26**

Documento assinado digitalmente em: 13/01/2026 22:26:58, por Técnico(a) de Enfermagem Jucimeire Alves da Silva COREN 788443.

EM TEMPO SOLICITADO 01 EQUIPO PARA MEDICAÇÃO ONDASETRONA, ADMINNISTRADO AS 21:00 HORAS
MENO APRESENTOU VOMITO

Jucimeire Alves da Silva
Técnico(a) de Enfermagem COREN 788443



Paciente **Jose Henrique da Silva Fernandes**
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
13/01/2026 23:52	13/01 23:57	Técnico de enfermagem	Anotações de		Jucimeire Alves da Silva	COREN 788443

Hash: 48756384F934433986AD77113312F04C

Dt. Assinatura:

Documento assinado digitalmente em , por Técnico(a) de Enfermagem Jucimeire Alves da Silva COREN 788443

AS 19:00 HORAS RECEBO MENOR EM SEU LEITO EM COMPANHIA DE SUA MÃE EUPNEICO AFEBRIL, RESPIRANDO EM AR AMBIENTE ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES EM FRALDA, AS 21:00 HORAS MENOR APRESENTOU VÔMITO FEITO MEDICAÇÃO, FAMILIARES ORIENTADOS SOBRE RISCO DE QUEDA, MANTER GRADES E CABECEIRAS ELEVADAS, FEITO TROCA DE AVP E MSE, SEM SINAIS FLOGÍSTICOS, MENOR SEGUE AOS CUIDADOS DA ENFERMAGEM

Jucimeire Alves da Silva
Técnico(a) de Enfermagem COREN 788443



Paciente **Jose Henrique da Silva Fernandes**
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento **9.108.291**
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
14/01/2026 03:29	14/01 03:30	Técnico de enfermagem	Justificativa de punção		Jucimeire Alves da Silva	COREN 788443

Hash: E25A170372CF36BDC0CAE5A4B7A15B86

Dt. Assinatura: 14/01/2026 04:29

Documento assinado digitalmente em 14/01/2026 04:29:18, por Técnico(a) de Enfermagem Jucimeire Alves da Silva COREN 788443

Avaliação: Justificativa de punção de Acesso Venoso Periférico - Novo

1 - Indicação do Procedimento: Paciente com necessidade de acesso venoso periférico para administração de medicação intravenosa. Avaliação da rede venosa realizada e punção efetuada conforme protocolo. Punciono o paciente: : 1ª Punção

2 - Punciono a rede venosa no seguinte local, levando em consideração a condição vascular e a escolha do paciente: : MSE - membro superior esquerdo

3 - Realizo as tentativas de punção conforme padrões de segurança, respeitando o limite máximo estabelecido pela ANVISA:

Obs: Cada profissional pode realizar no máximo 2 tentativas, totalizando até 4 conforme normas da ANVISA. Cada tentativa deve ser registrada individualmente na evolução do paciente. : Uma única tentativa

4 - Utilizo as seguintes tecnologias para otimizar o procedimento, conforme necessidade: : Nenhuma

5 - Solicitado e usados os seguintes materiais para realizar a punção do paciente:

Cateter usado: : Introcath

Calibre do cateter usado nº: 24

Quantidade: 01

Usado para estabilização/ cobertura do cateter: : Fixador Estéril IV FIX

Foi solicitado e usado o seguinte equipo multivias (extensor): : Usado extensor valvulado | polifix

5.1 - Usado conector valvulado (MAX ZERO) conforme recomendação em boas práticas para prevenção de infecção de correntes sanguínea? : Não

5.2 - Usado lenços com álcool para assepsia.

Escolha a opção: 2

6. Realizado flushing do cateter para testar fluxo e refluxo conforme recomendações de boas práticas: : Sim, com bom fluxo e refluxo

6.1 - Usado seringas salinizadas conforme recomendações de boas práticas no total de: : 1

7.

Usado cateter introcan no intra-operatório: Não

7.2

Solicitado e usado equipo: Não

8 - Punção com sucesso? : Sim

Jucimeire Alves da Silva
Técnico(a) de Enfermagem COREN 788443





Hospital
São Domingos

Justificativa de punção

Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

8.1 - Feito medicações após punção, quais e que horários? : APENAS ACESSO

Jucimeire Alves da Silva
Técnico(a) de Enfermagem COREN 788443



Paciente	Jose Henrique da Silva Fernandes			Atendimento	9.108.291	
Data Nascto.	06/03/2025	10 Meses		Prontuário	1.116.047	
Sexo	Masculino			Dt. Entrada	11/01/2026 08:17:29	
Telefone	98 985108882			Convênio	AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 À 900	
Leito	516					
Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
14/01/2026 09:55	14/01 09:58	Médico(a)	Evolução Médica		Helida Cristina Alcantara Vicente	CRM 4026

Hash: D46E1DA0BC3051F895CC86B0CEE098A6 Dt. Assinatura: 14/01/2026 10:56

Documento assinado digitalmente em: 14/01/2026 10:56:36, por Médico(a) Helida Cristina Alcantara Vicente CRM 4026

1. Diagnóstico:LARINGITE+IVAS+GECA

Peso: 9 kg

Alergias

3. Dias de Internação: 4 dias

4. Terapêutica atual (Antibióticos e medicações de risco).

DECADRON
NBZ C/ AD

5. Evolução das Últimas 24h:

SEM FEBRE,ACEITA POUCO A DIETA,SEM VOMITO,COM DIARREIA
DIURESE OK

6. Exame Físico

HIDRATADO,ATIVO,AFEBRIL,EUPNEICO,EM AA SAT 98%
PERFUSAO OK
AP:RONCOS
OF:HIPEREMIADO
ABDOMEM,TIMPANICO,FLACIDO,INDOLOR A PALPAÇÃO

7. Resultado dos exames importantes:

Programação do dia:

EX DE LAB+RX

9. Previsão de alta: 16/01/2026 09:55 - Média probabilidade

10. Plano Terapeutico:

TIORFA
SUSPENSO DECADROMN
INICIO METILPREDNISOLONA-0,5MG/KG/DIA
AEROLIN SPRAY

11. Avaliação de Riscos/Scores:

11.1 Flebite:

11.2 Avaliação do risco de queda - Humpty Dumpty: 16 - Alto risco de queda

11.3 Avaliações de BradenQ (Lesão por pressão): 25 - Risco baixo

11.4 Avaliações do risco strokids (Risco Nutricional):

Helida Cristina Alcantara Vicente
Médico(a) CRM 4026





Paciente **Jose Henrique da Silva Fernandes**

Data Nascto 06/03/2025 10m 8d

Data Entrada 11/01/2026 08:17:29

Médico Resp Drs. Helida Cristina Alcantara Vicente (CRM 4026)

Prescritor Helida Cristina Alcantara Vicente CRM - 4026

Lib. Enferm Helida Cristina Alcantara Vicente CRM - 4026

Validade: 14/01/2026 19:00:00 15/01/2026 18:59:59

Hash CFFB7506181039E12B2EFF51ADC9F434

Atendimento 9.108.291

Convênio AMIL / AMIL INDIVIDUAL 500

Liberação 14/01/2026 09:49:21

Data Prescr 14/01/2026 09:36:00

Prontuário 1.116.047

Leito e Setor L12 Inter. Ped A

Peso 9,7

Dt. Assinatura 14/01/2026 10:47:57

Documento assinado digitalmente em: 14/01/2026 10:47:57, por Médico(a) Helida Cristina Alcantara Vicente CRM - 4026

Alergias:

Dietas

Intervalo

Horários

Observação

Branda Múltiplas Alergias

3/3 h

20:20 23:
20 02:20
05:20
08:20
11:20 14:
20 17:20

Suplemen/Modul/Pediat

Intervalo

Dose

Aplicação

Vel. de Infusão

LEITE PO NAN 2 CONFORT 800G

3/3 h

30 g

Oral

ml/h

Horários: 21 00 03 06 09 12 15 18

Soluções

Soro Glicosado 5% 250ml inj

Velocida 9,9556 gtm

Etapas: 4

Dispositivo de infusão: **Equipo macrogotas simples**

Horários: ~~das 19 às 01;~~ ~~das 01 às 07;~~ ~~das 07 às 13;~~ ~~das 13 às 19;~~

~~Tipo Analgesia:~~

~~Modo:~~

~~Fluxo:~~

~~Bolus:~~

~~Dose Inicial:~~

~~Dose Limite 4h:~~

~~Dose Limite 1h: ml~~

Soro Glicosado 5% 250ml inj

Dose: 175 ml

Cloreto de Potassio 10% 10ml injetavel

Dose: 2,7 ml

Cloreto de Sodio 20% 10ml injetavel

Dose: 1,5 ml

Medicamentos

Dose

Horários

DipirONA 500 MG/ML-2ML AMP TEUTO | 0,4 ml SOS/SN Intravenosa

Diluir 0,4 Mililitros do medicamento em 10 Mililitros de Agua p/ Injeção 10ml

Administrar 10,4 Mililitros (SOS/SN Intravenosa)

Ondansetrona 4 mg em 2 mL- inj | 0,6 ml SOS/SN Intravenosa SN

Diluir 0,6 Mililitros do medicamento em 50 Mililitros de Soro Fisiologico 0,9% (NaCl)

50ml inj

Administrar 50,6 Mililitros (SOS/SN Intravenosa)

Estabilidade: 48 Horas Após diluição

Temperatura ambiente controlada (15°C a 30°C)

Recomendado acesso central

PANTOCAL 4MG/ML-10ML FR/AMP EV | 2,2 ml 1x ao dia Intravenosa 11:55

Reconstituir cada Frasco-ampola em 10 Mililitros de Diluente Proprio

Diluir 2,2 Mililitros da reconstituição em 100 Mililitros de Soro Fisiologico 0,9% (NaCl)

100ml inj

Administrar 102,2 Mililitros (1x ao dia Intravenosa) em 1 h.

Simeticona 75mg/ml gts 15ml | 9 gts 8/8 h Oral 00:30 08:30 16:30

Nebulização

Dose

Intervalo/Horário

Nebulização c/ Adrenalina com O²

SOS/SN

Adren 1mg/1mL inj- EPINEfrina -USO
INALATORIO

3 mg SOS/SN In

SN

Liberação 14/01/2026 09:49:22

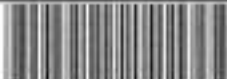
Página 1/2

helida.vicente

CATE02350







9108291
Atendimento

Hospital São Domingos
Prescrição Eletrônica Paciente



12662335
Prescrição

Paciente

Jose Henrique da Silva Fernandes

Data Nascto

06/03/2025 10m 8d

Data Entrada

11/01/2026 08:17:29

Médico Resp

Dra. Helida Cristina Alcantara Vicente (CRM 4026)

Prescritor

Helida Cristina Alcantara Vicente CRM - 4026

Lib. Enferm

Helida Cristina Alcantara Vicente CRM - 4026

Validade:

14/01/2026 19:00:00 15/01/2026 18:59:59

Atendimento

9.108.291

Convênio

AMIL / AMIL INDIVIDUAL 500

Liberação

14/01/2026 09:49:21

Data Prescr

14/01/2026 09:36:00

Prontuário

1.116.047

Leito e Setor

L12 Inter. Ped A

Peso

9,7

Dt. Assinatura

14/01/2026 10:47:57

Hash

CFFB7505181039E12B2EFF51ADC9F434

Documento assinado digitalmente em 14/01/2026 10:47:57, por Médico(a) Helida Cristina Alcantara Vicente CRM - 4026

Alergias:

Nebulização Clenil + S.F com O²

Clenil A sol nbz 2ml

Cloreto de Sodio 0,9% 10ml inj

1 ml 12/12 h In

5 ml 12/12 h In

12/12 h

~~20:39 08:39~~

~~20:39 08:39~~

Recomendações

Intervalo

Horários

Cabeceira do leito elevada 45° graus

Contínuo

08:20 08:20

Fisioterapia Respiratória 2x ao dia

FISIO 2X

10 16

Monitorização Cardíaca

Contínuo

08:20 08:20

Oximetria contínua de pulso mais sensor

Contínuo

08:20 08:20

Sinais Vitais de 2/2h

2/2 h

08:20 10:20 12:20 14:20

16:20 18:20 20:20

22:20 00:20 02:20 04:20

06:20 08:20 10:20

12:20 14:20 16:20 18:20

Helida Cristina Alcantara Vicente CRM - 4026

Liberação 14/01/2026 09:49:22

Página 2/2

helida.vicente

CATE02350



17:20 206

L-13 INT



Hospital

São Domingos



9108291

Atendimento

Hospital Sao Domingos

Prescrição Eletrônica Paciente



12662422

Prescrição

Paciente

Jose Henrique da Silva Fernandes

Data Nascto

06/03/2025 10m 8d

Data Entrada

11/01/2026 08:17:29

Médico Resp

Dra. Helida Cristina Alcantara Vicente (CRM 4026)

Prescritor

Helida Cristina Alcantara Vicente CRM - 4026

Lib. Enferm

Helida Cristina Alcantara Vicente CRM - 4026

Validade:

14/01/2026 09:52:00 15/01/2026 18:59:59

Hash

8D62D9E6F668DD694F0B8D6B053066FB

Documento assinado digitalmente em

14/01/2026 10:52:27, por Médico(a) Helida Cristina Alcantara Vicente CRM - 4026

Atendimento

9.108.291

Convênio

AMIL / AMIL INDIVIDUAL 500

Liberação

14/01/2026 09:53:55

Data Prescr.

14/01/2026 09:52:00

Prontuário

1.116.047

Leito e Setor

L12 Inter. Ped A

Peso

9

Di. Assinatura

14/01/2026 10:52:27

403

Alergias:

Medicamentos	Dose	Horários
AMODINI 100 MCG/DOSE-200DOSES FR	3 jato 6/6 h Inalatória	09:52 15:52 21:52 03:52 09:52 15:52
MEDROL 125 MG FR/AMP	3 mg 6/6 h Intravenosa	09:52 15:52 21:52 03:52 09:52 15:52

Reconstituir cada Frasco-ampola em 2 Mililitros de Diluente Proprio

Diluir 0,05 Mililitros da reconstituição em 10 Mililitros de Cloreto de Sodio 0,9% 10ml inj

Administrar 10,05 Mililitros (6/6 h Intravenosa) em 3 minutos

Estabilidade: 48 Horas Após reconstituição

Temperatura ambiente (15°C a 30°C)

Recomendações	Intervalo	Horários
Fisioterapia Respiratória 2x ao dia	FISIO 2X	10 16

516

Dra. Helida Vicente

CRM 4026

Helida Cristina Alcantara Vicente CRM - 4026

Liberação 14/01/2026 09:35:15

Página 1/1

helida.vicente

CATE02350







9108291

Atendimento



12662278

Prescrição

Hospital São Domingos

Hospital São Domingos

Prescrição Eletrônica Paciente

Paciente

Jose Henrique da Silva Fernandes

Data Nascto

08/03/2025 10m 8d

Data Entrada

11/01/2026 08:17:29

Médico Resp

Dra. Helida Cristina Alcantara Vicente (CRM 4026)

Prescritor

Helida Cristina Alcantara Vicente CRM - 4026

Lib. Enferm

Helida Cristina Alcantara Vicente CRM - 4026

Validade:

14/01/2026 09:31:00 15/01/2026 18:59:59

Hash

81576C1FE1D444F20889C55B7401ED52

Documento assinado digitalmente em

14/01/2026 10:32:18, por Médico(a) Helida Cristina Alcantara Vicente CRM - 4026

Atendimento

9.108.291

Convênio

AMIL / AMIL INDIVIDUAL 500

Liberção

14/01/2026 09:33:45

Data Prescr.

14/01/2026 09:31:00

Prontuário

1.116.047

Leito e Setor

L12 Inter. Ped A

Peso

9

Dt. Assinatura

14/01/2026 10:32:18

Alergias:

Medicamentos

Dose

Horários

Tiorfan 10mg saché 1g

1 SACHE 2x Oral

09:31 21:31

Uso acima de 3 meses.

Procedimentos, Serviços e Exames

3

ERITRÓCITOS (PESQ. N

3

PARASIT. DAS FEZES -

3

SANGUE OCULTO (PESQ.

4

ROTAVÍRUS (PESQ. NAS

Helida Cristina Alcantara Vicente CRM - 4026

Liberção

13/01/2026 09:09:32

Página

1/1

alexandre.lopes

CATE02350



Número do documento:

26022014124912900000159866786

https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26022014124912900000159866786

Assinado eletronicamente por:

VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - 20/02/2026 14:12:49

Num. 172684518 - Pág. 4





9108291

Atendimento



12662307

Prescrição

Hospital São Domingos

Prescrição Eletrônica Paciente

Paciente

Jose Henrique da Silva Fernandes

Data Nascto

06/03/2025 10m 8d

Data Entrada

11/01/2026 08:17:29

Médico Resp

Dra. Helida Cristina Alcantara Vicente (CRM 4026)

Prescritor

Helida Cristina Alcantara Vicente CRM - 4026

Lib. Enferm

Helida Cristina Alcantara Vicente CRM - 4026

Validade:

14/01/2026 09:34:00 15/01/2026 18:59:59

Atendimento

9.108.291

Convênio

AMIL / AMIL INDIVIDUAL 500

Liberção

14/01/2026 09:35:15

Data Prescr

14/01/2026 09:34:00

Prontuário

1.116.047

Leito e Setor

L12 Inter. Ped A

Peso

9

Dt. Assinatura

14/01/2026 10:34:12

Hash

13FA614F2A3558FE2A681FD77D08F5F3

Documento assinado digitalmente em 14/01/2026 10:34:12, por Médico(a) Helida Cristina Alcantara Vicente CRM - 4026

Alergias:

Procedimentos, Serviços e Exames

1

HEMOGRAMA COMPLETO

PCR (PROTEÍNA C REATIVA)

RX - Tórax PA + Perfil

Dr. Helida Vicente

CRM 4026

Helida Cristina Alcantara Vicente CRM - 4026

Liberção 14/01/2026 09:35:15

Página 1/1

helida.vicente

CATE02350

Número do documento: 26022014124912900000159866786
<https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26022014124912900000159866786>
Assinado eletronicamente por: VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - 20/02/2026 14:12:49

Num. 172684518 - Pág. 5



Relatório dos Parâmetros Assistenciais do Paciente

De: 14/01/2026 Até: 14/01/2026

Paciente: Jose Henrique da Silva Fernanc Convênio: AMIL-AMIL INDIVIDUAL Atendimento: 9108291
Data nasc: 06/03/2025 10m 13d Setor / leito: Internação E-5 516 Prontuário: 1116047
Data entrada: 11/01/2026 08:17:29 Médico resp: Dra. Antonia de Jesus Barros Total BH acumulado: 1355,8

Parâmetros	Un med	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	01	02	03	04	05	06	Total
14/01/2026																										
SINAIS VITAIS																										
Temp	°C			35,1						36,2									35,9						36,6	
FC	bpm			106						140									78						72	
FR	mm			30						30									22						28	
Sat O2	%			99						99									98						97	
Glic cap	mg/dL		49																							
Escala dor	Ponto			FLAC						FLAC									FLAC						FLAC	
Ponto dor				0						0									0						0	
Peso	kg									9,7																
GANHOS	ml																									
Medicamento por via enteral																										
Dieta enteral																										
Água por sonda																										
Pausa Dieta Enteral																										
PERDAS	ml																									
Diurese espontânea - Volume																										
ESCALA PEWS																										
Sonda Gástrica em Sifonagem																										
BALANÇO HÍDRICO																										
Acumulado dia	ml																									



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
14/01/2026 12:20	14/01 12:28	Enfermeiro(a)	Evolução de		Lianildes Sousa dos Santos	COREN 472211-ENF

Hash: 1131251AD431272F096A0D8980F71E64

Dt. Assinatura: 14/01/2026 13:27

Documento assinado digitalmente em 14/01/2026 13:27:04, por Enfermeiro(a) Lianildes Sousa dos Santos COREN 472211-ENF

Avaliação: Evolução de enfermagem universal

1 - Dados da Internação :

Diagnóstico de internação : LARINGITE AGUDA/IVAS

Dias de hospitalização : 4

Dias no setor de cuidado : 2

Previsão de alta no plano terapêutico : 16/01/2026 09:55:26

2 - Anamnese e exame físico

Queixa atual : Sem queixas no momento da visita.

Sistema neurológico

Descritivo : Menor acompanhado de responsáveis, acordado, ativo e reativo no leito, mantendo padrão neurológico habitual e preservado, pupilas isocóricas e fotorreagentes.

CAM ICU : NA

Glasgow : 15

Paciente em ventilação mecânica : Não

Avaliação do nível de sedação :

Sistema respiratório :

Padrão/Ausculta/Observações : Eupneico em ar ambiente, sem sinais de desconforto respiratório, mantendo níveis e saturação adequados.

Sistema cardiovascular :

Ausculta/Hemodinâmica : Estável hemodinamicamente, sem uso de drogas vasoativas, níveis pressóricos adequados para idade, normocárdico, afebril.

Abdome :

Aparência/Ruidos/Observações : Plano, flácido, sem fácies de dor à palpação, RHA+.

Dieta e Hidratação :

Tipo de dieta / Via de administração / Status / Aceitação ou Tolerância : Nutre - se por vo de baixa aceitação e tolerância

Sem relatos de náuseas e vômitos pela manhã

Paciente possui indicação de verificação do residuo gástrico? : Não

Eliminações Tipo/Local :

Intestinais : Presente em fralda

Vesicais : Presente em fralda

Mobilidade : Restrito ao leito

Pele :

Lianildes Sousa dos Santos
Enfermeiro(a) COREN 472211-ENF



Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo: Masculino
Telefone: 98 985108882
Leito: 516

Atendimento: 9.108.291
Prontuário: 1.116.047
Dt. Entrada: 11/01/2026 08:17:29
Convênio: AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Inspeção/Observação : Acianótico, anictérico, hidratado, sem edemas, sem lesão por pressão.

Escala de avaliação de pele : Risco baixo

Integridade : Integra

Risco de lesão de pele? : Não

Lesão de pele? : Não

Controle de umidade I : Não

Troca :

Realizado troca de curativo? : Não

Lesão de pele/Ferida Operatória/Outras Lesões 1 :

Quantidade : ,

Lesão de pele/Ferida Operatória/Outras Lesões 2 :

Quantidade : ,

Sinais Vitais :

PA : -

Temp : 36,1

FR : 26

FC : 123

Sat : 98%

FIO2 : 21%

DOR : 0

NEWS/PEWS : 0

Glicemias :

Hipoglicemia no periodo? : NÃO

Escalas :

Humpty Dumpty : Sim

Paciente com plaquetas < 30.000 ou RNI > 3? : NÃO

Resultado : Resultado: Alto risco de queda - Pontuação: 18

Paciente com alto risco de queda? : SIM

Ronda Assistencial : Manter grades elevadas

Orientações mantidas quanto aos riscos

Resultado : 0

Avaliação de toxicidade de quimioterapia :

Avaliação de Toxicidade? : NA

4 - Protocolos

Protocolos : Não

Central :

Central? : Não

Periférico :

Periférico? : SIM

Local : MSE

Data de punção : 11/01/2026

Lianides Sousa dos Santos
Enfermeiro(a) COREN 472211-ENF



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 05/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 À 900

Obs/Conduta : Pérvio, sem sinais clínicos

Arterial :

Arterial : NÃO

6 - Outras intervenções

Hemotransfusão : NÃO

Dálise/Hemodiálise : NÃO

Procedimento Cirúrgico : NÃO

Exames e pendências : NÃO

Outros procedimentos : NÃO

7 - Plano de Cuidados/ Round Multidisciplinar

Descritivo : VERIFICAR SINAIS VITAIS DE 6/6 HORAS
MANTER BOAS PRÁTICAS NA PREVENÇÃO DE QUEDA, FLEBITE E BRONCOASPIRAÇÃO
MONITORAR E REGISTRAR SE ALTERAÇÕES NO PADRÃO RESPIRATÓRIO
MANTER CABECEIRA ELEVADA DE 30 A 45

Status : Mantido

8 - Desfecho

Desfecho : Internação mantida

Descritivo : Segue aos cuidados de enfermagem

Lianildes Sousa dos Santos
Enfermeiro(a) COREN 472211-ENF



SAE - Prescrição e Diagnósticos de Enfermagem (novo)

Paciente	Jose Henrique da Silva Fernandes	Atendimento	9.108.291	Prontuário	1.116.047
Data Nascto	06/03/2025 10 Meses	Convênio	AMIL / AMIL INDIVIDUAL 500 A 900		
Data Entrada	11/01/2026 08:17:29	SAE	1167903		
Enfermeiro	Lianildes Sousa dos Santos - COREN 472211-ENF	Data SAE	14/01/2026 12:28:52	Liberação	14/01/2026 12:31:02
Setor	Internação E-5	Leito	516		
Hash:	056707AAF584ABB8B54255F843F0F2D	DL Assinatura:	14/01/2026 13:29:33		

Documento assinado digitalmente em: 2026/01/14 13:29:33, por Enfermeiro(a) Lianildes Sousa dos Santos COREN 472211-ENF

Diagnósticos de enfermagem

- 1 Desidratação
- 2 Risco de infecção
- 3 Risco de Queda (PEDIATRIA)
- 4 Risco de Broncoaspiração (PEDIATRIA)

Prescrição de enfermagem

	SN	Intervalo	Horários
1 Aplicar termo de consentimento de prevenção de risco de queda (Admissão).		Conf.Protoc.	13
2 Avaliar e registrar aceitação da dieta			00
Avaliar e registrar pele e mucosas			00
Avaliar e registrar sinais de desequilíbrio eletrolítico			00
5 Estimular ingestão de líquidos			00
6 Identificar sites/fontes de infecção.		Padrão 3 vezes/dia	15 20 10
7 Manter a cabeceira do leito elevada (30-45°) durante e após alimentação por 30 minutos.		Contínuo	13
8 Manter grades elevadas e cama baixa e travada.		Contínuo	13
9 Monitorar sinais de engasgo, tosse ou alterações respiratórias durante alimentação.		Contínuo	10:00 18:00 22:00
10 Realizar ronda assistencial.		6/6 h	13 19 01 07
11 Registrar ingestão e eliminação de líquidos		Padrão 3 vezes/dia	15 20 10
12 Sinalizar ambientes úmidos e/ou molhados para higienização do leito.		SOS/SN	
13 Sinalizar risco de queda (colocar pulseira amarela e placa de identificação)		SOS/SN	
14 Trocar acesso venoso conforme protocolo		Conf.Protoc.	13
15 Verificar e anotar sinais vitais		6/6 h	13 19 01 07



Impresso em: 19/01/2026 16:10:02

Enf.: Lianildes Sousa dos Santos - COREN 472211-ENF

Página 1

lianildes. / F6133338

Paciente: Jose Henrique da Silva

Internação E-5

516



Anotação de Enfermagem*

Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo: Masculino
Telefone: 98 985108882
Leito: 516

Atendimento: 9.108.291
Prontuário: 1.116.047
Dt. Entrada: 11/01/2026 08:17:29
Convênio: AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 À 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
14/01/2026 09:51	14/01 11:29	Técnico/Auxiliar Enfermagem	Anotação de		Aiala de Cassia Ferreira Gusmao	COREN 627731-TE

Hash: 02CACBC97ED521BB91597EA067E46E1F

Dt. Assinatura: 14/01/2026 12:27

Documento assinado digitalmente em 14/01/2026 12:27:47, por Aiala de Cassia Ferreira Gusmao COREN 627731-TE

- recebo plantão com paciente de repouso no leito na companhia de sua mae acordado, orientado, reponsivo interno com diagnostico de laringite aguda/ivas/geca
- acesso venoso periferico em membro superior esquerdo funcionando sem sinais flogisticos
- aceitando a dieta
- nega alergia medicamentosa
- eliminações fisiologicas presente nas ultimas 24 horas
- apresentando diarreia
- solicitado e usado 1 espaçador para aerodini
- segue aguardando leito

Aiala de Cassia Ferreira Gusmao
COREN 627731-TE



Paciente José Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 À 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
15/01/2026 06:50	15/01 06:53	Técnico/Auxiliar Enfermagem	Anotações de		Cleir de Jesus Santos Medeiros	COREN 217818-TE

Hash: 08BAD9342A205E08827137C516D6C7A6

Dt. Assinatura: 15/01/2026 07:52

Documento assinado digitalmente em 15/01/2026 07:52:12, por Técnico(a) de Enfermagem Cleir de Jesus Santos Medeiros COREN 217818-TE

RECEBO PLANTÃO COM PACIENTE MENRO INTERENO NA OBSERVAÇÃO PED COM QUADRO DE LARINGITE, ENCONTRA-SE ACOMPANHADO, ORIENTADO, CONTACTUANTE, AFEPROIL, RESPIRANDO EM AR AMBIENT, COM ACEITAÇÃO MODERADA DA DIETA OFERTADA
FERIDO SSVV
ACESSO VENOSO EM MIE FUNCIONANTE E SEM SINAIS FLOGÍSTICOS
NEGA ALERGIA MÉDICA, MENTOSA
ADMINISTRADO MEDICAÇÕES CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA
SEGUE AOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM E AGUARDANDO ACOMODAÇÃO EM UI

Cleir de Jesus Santos Medeiros
Técnico(a) de Enfermagem COREN 217818-TE



Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo: Masculino
Telefone: 96 985108882
Leito: 516

Atendimento: 9.108.291
Prontuário: 1.116.047
Dt. Entrada: 11/01/2026 08:17:29
Convênio: AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
15/01/2026 09:44	15/01 09:47	Médico(a)	Evolução Médica		Alexandre Wilson Silvestre Lopes	CRM 5412

Hash: 40E490F237E77873E56AB5F790515BD5 Dt. Assinatura: 15/01/2026 10:45

Documento assinado digitalmente em: 15/01/2026 10:45:46, por: Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM 5412

1. Diagnóstico: IVAS

Peso: 9,7 kg

2. Alergias NAO

3. Dias de Internação: 5 dias

4. Terapêutica atual (Antibióticos e medicações de risco):

Sintomáticos

5. Evolução das Últimas 24h: Paciente sem novos episódios diarreicos (ainda não defecou hoje). Nega febre. Paciente com leve melhora do desconforto respiratório saturando bem em a.a. (98 -99%). Melhora da tosse. Sono preservado. Alimentando-se adequadamente.

6. Exame Físico: EGB, afebril, normocorado, hidratdo, AR = mv+ rude; ORO = limpa; ABD = inocente

7. Resultado dos exames importantes: Exames coprológicos sem alterações apreciáveis

8. Programação do dia: Aguardando leito de enfermaria

9. Previsão de alta: 16/01/2026 09:55 - Média probabilidade

10. Plano Terapeutico: MANTIDO

11. Avaliação de Riscos/Scores:

11.1 Flebite:

11.2 Avaliação do risco de queda - Humpty Dumpty: 18 - Alto risco de queda

11.3 Avaliações de BradenQ (Lesão por pressão): 23 - Risco baixo

11.4 Avaliações do risco strogkids (Risco Nutricional):

Alexandre Wilson Silvestre Lopes
CRM 5412



Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo: Masculino
Telefone: 98 985108882
Leito: 516

Atendimento: 9.108.291
Prontuário: 1.116.047
Dt. Entrada: 11/01/2026 08:17:29
Convênio: AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
15/01/2026 11:45	15/01 11:46	Médico(a)	Evolução Médica		Alexandre Wilson Silvestre Lopes	CRM 5412

Hash: 404A56DB20440F891C19953B7B011158 Dt. Assinatura: 15/01/2026 12:44

Documento assinado digitalmente em: 15/01/2026 12:44:47, por: Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM 5412

EM TEMPO


Paciente voltou com quadro diarréico.

Cd: prescrevo SF0,9% EV + Florax PED VO

Alexandre Wilson Silvestre Lopes
CRM 5412





Hospital

São Domingos



9108291

Atendimento

Hospital São Domingos

Prescrição Eletrônica Paciente



12666352

Prescrição

Paciente

Jose Henrique da Silva Fernandes

Data Nascto

06/03/2025 10m 9d

Data Entrada

11/01/2026 08:17:29

Médico Resp

Dra. Helida Cristina Alcantara Vicente (CRM 4026)

Prescritor

Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412

Lib. Enferm

Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412

Validade:

15/01/2026 19:00:00 16/01/2026 18:59:59

Hash

5B329E2B311F472A201AC711678DC037

Atendimento

9.108.291

Convênio

AMIL / AMIL INDIVIDUAL 500

Liberação

15/01/2026 09:35:14

Data Prescr.

15/01/2026 09:33:00

Prontuário

1.116.047

Leito e Setor

L13 Inter. Ped A

Peso

9,7

Dt. Assinatura

15/01/2026 10:30:46

Documento assinado digitalmente em 15/01/2026 10:30:46, por Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412

Alergias:

Dietas

Intervalo

Horários

Observação

Branda Múltiplas Alergias

3/3 h

20:20 23:20
05:20 08:20
11:20 14:20
17:20

Suplemen/Modul/Pediat

Intervalo

Dose

Aplicação

Vel. de Infusão

LEITE PO NAN 2 CONFORT 800G

3/3 h

30 g

Oral

ml/h

Horários: 21:00 03:06 09:12 18:18

Soluções

Soro Glicosado 5% 250ml inj

Velocida 9,9556 gtm

Etapas: 4

Dispositivo de infusão: Equipos macropotas simples

Horários: das 19 às 01; das 01 às 07; das 07 às 13; das 13 às 19;

Tipo Analgesia: Modo: Fluxo: Bolus:

Dose Inicial: Dose Limite 4h: Dose Limite 1h: ml

Soro Glicosado 5% 250ml inj

Dose: 175 ml

Cloreto de Potassio 10% 10ml injetavel

Dose: 2,7 ml

Cloreto de Sodio 20% 10ml injetavel

Dose: 1,5 ml

Medicamentos

Dose

Horários

RODINI 100 MCG/DOSE-200DOSES FR

3 jato 6/8 h Inalatória

21:52 03:52 09:52
15:52

DipirONA 500 MG/ML-2ML AMP TEUTO

0,4 ml SOS/SN Intravenosa

Diluir 0,4 Mililitros do medicamento em 10 Mililitros de Agua p/ Injeção 10ml

Administrar 10,4 Mililitros (SOS/SN Intravenosa)

Ondansetrona 4 mg em 2 mL- inj

0,6 ml SOS/SN Intravenosa

SN

Diluir 0,6 Mililitros do medicamento em 50 Mililitros de Soro Fisiologico 0,9% (NaCl)

50ml inj

Administrar 50,6 Mililitros (SOS/SN Intravenosa)

Estabilidade: 48 Horas Após diluição

Temperatura ambiente controlada (15°C a 30°C)

Recomendado acesso central

PANTOCAL 4MG/ML-10ML FR/AMP EV

2,2 ml 1x ao dia Intravenosa

11:55

Reconstituir cada Frasco-ampola em 10 Mililitros de Diluente Proprio

Diluir 2,2 Mililitros da reconstituição em 100 Mililitros de Soro Fisiologico 0,9% (NaCl)

100ml inj

Administrar 102,2 Mililitros (1x ao dia Intravenosa) em 1 h

Simeticona 75mg/ml gts 15ml

9 gts 8/8 h Oral

08:30 18:30

UNIMEDROL 125 MG FR/AMP

3 mg 6/6 h Intravenosa

21:52 03:52 09:52
15:52

Liberação 15/01/2026 09:32:15

Página 2/3

alexandre.lopes

CATE02350

Número do documento: 26022014124912900000159866786
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26022014124912900000159866786
Assinado eletronicamente por: VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - 20/02/2026 14:12:49

Num. 172684518 - Pág. 15



9108291

Atendimento

Hospital São Domingos
Prescrição Eletrônica Paciente

Internado



12666324

Prescrição

Paciente **Jose Henrique da Silva Fernandes**
Data Nascto 06/03/2025 10m 9d
Data Entrada 11/01/2026 08:17:29
Médico Resp Dra. Helida Cristina ALCANTARA VICENTE (CRM 4026)
Prescritor Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412
Lib. Enferm Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412
Validade: 15/01/2026 09:31:00 16/01/2026 18:59:59

Atendimento **9.108.291**
Convênio AMIL / AMIL INDIVIDUAL 500
Liberação 15/01/2026 09:32:15
Data Prescr. 15/01/2026 09:31:00
Prontuário 1.116.047
Leito e Setor L13 Inter. Ped A
Peso 9,7
Dt. Assinatura 15/01/2026 10:30:46



Hash 5B329E2B311F472A201AC7116780C037

Documento assinado digitalmente em 15/01/2026 10:30:46, por Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412

Alergias:

Medicamentos	Dose	Horários
Allegra Ped 6mg/ml susp oral 60ml	2 ml 8/8 h Oral	18 18 02 10
Administrar 2 Mililitros (8/8 h Oral)		



Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412







9108291
Atendimento



12666352
Prescrição

Hospital São Domingos

Prescrição Eletrônica Paciente

Atendimento

9.108.291

Paciente

Jose Henrique da Silva Fernandes

Data Nascto

06/03/2025 10m 9d

Data Entrada

11/01/2026 08:17:29

Médico Resp

Dra. Helida Cristina Alcantara Vicente (CRM 4026)

Prescritor

Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412

Lib. Enferm

Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412

Validade:

15/01/2026 19:00:00 15/01/2026 18:59:59

Hash

5B329E2B311F472A2D1AC711678DC037

Atendimento

9.108.291

Convênio

AMIL / AMIL INDIVIDUAL 500

Liberação

15/01/2026 09:35:14

Data Prescr.

15/01/2026 09:33:00

Prontuário

1.116.047

Leito e Setor

L13 Inter. Ped A

Peso

9,7

Dt. Assinatura

15/01/2026 10:30:46

Documento assinado digitalmente em 15/01/2026 10:30:46, por: Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412

Alergias:

Reconstituir cada Frasco-ampola em 2 Mililitros de Diluente Proprio

Diluir 0,05 Mililitros da reconstituição em 10 Mililitros de Cloreto de Sodio 0,9% 10ml inj

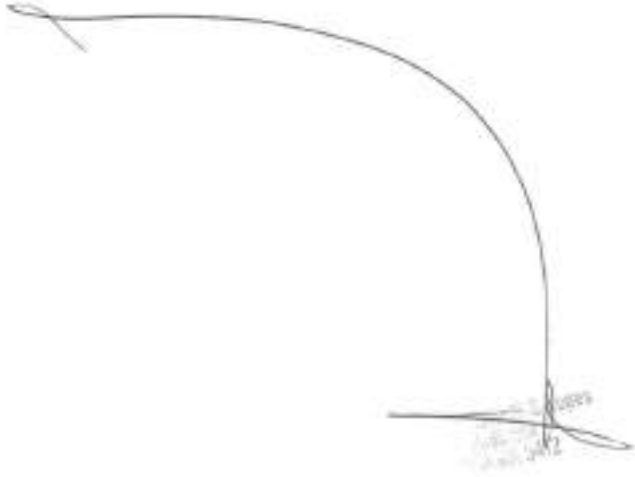
Administrar 10,05 Mililitros (6/6 h Intravenosa) em 3 minutos

Estabilidade: 48 Horas Após reconstituição

Temperatura ambiente (15°C a 30°C)

Nebulização	Dose	Intervalo/Horário
Nebulização c/ Adrenalina com O²		SOS/SN
Adren 1mg/1mL inj- EPINEfrina -USO INALATORIO	3 mg SOS/SN In	SN
Nebulização Clenil + S.F com O²		12/12 h
Clenil A sol nbz 2ml	1 ml 12/12 h In	20:39 08:39
Cloreto de Sodio 0,9% 10ml inj	5 ml 12/12 h In	20:39 08:39

Recomendações	Intervalo	Horários
Cabeceira do leito elevada 45° graus	Contínuo	08:20 08:20
Fisioterapia Respiratória 2x ao dia	FISIO 2X	10 16
Monitorização Cardíaca	Contínuo	08:20 08:20
Oximetria contínua de pulso mais sensor	Contínuo	08:20 08:20
Sinais Vitais de 2/2h	2/2 h	08:20 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 20:20 22:20 00:20 02:20 04:20 06:20 08:20 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20



Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412

Liberação 15/01/2026 09:32:15

Página 3/3

alexandre.lopes

CATE02360

Número do documento: 26022014124912900000159866786
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26022014124912900000159866786
Assinado eletronicamente por: VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - 20/02/2026 14:12:49

Num. 172684518 - Pág. 17



9108291

Atendimento



12667120

Prescrição

Paciente	Jose Henrique da Silva Fernandes	Atendimento	9.108.291
Data Nascto	06/03/2025 10m 9d	Convênio	AMIL / AMIL INDIVIDUAL 500
Data Entrada	11/01/2026 08:17:29	Liberação	15/01/2026 11:38:55
Médico Resp	Dra. Helida Cristina Alicantara Vicente (CRM 4026)	Data Prescr.	15/01/2026 11:35:00
Prescritor	Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412	Prontuário	1.118.047
Lib. Enferm	Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412	Leito e Setor	L13 Inter. Ped A
Validade:	15/01/2026 11:35:00 15/01/2026 18:59:59	Peso	9,7
Hash	807685B264BE5B8A1B33BED4C8C9BA27	Dt. Assinatura	15/01/2026 12:37:27

Documento assinado digitalmente em 15/01/2026 12:37:27, por Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412

Alergias:

Medicamentos

Dose

Horários

Soro Fisiologico 0,9% (NaCl) 250ml inj	200 ml ACM Intravenosa	ACM	11/35	23:35
Administrar 200 Mililitros (ACM Intravenosa)				
ax Ped 5ml	1 Fr 2x Oral			
Administrar 5 Mililitros (2x Oral)				

Dr. Alexandre Wilson Silvestre Lopes
CRM 5412

Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412

Liberação 14/01/2026 09:33:45

Página 1/1

helida.vicente

CATE02350





9108291

Atendimento

Hospital São Domingos
Prescrição Eletrônica Paciente



12667120

Prescrição

Internado

Paciente	Jose Henrique da Silva Fernandes	Atendimento	9.108.291
Data Nascto	06/03/2025 10m 5d	Convênio	AMIL / AMIL INDIVIDUAL 500
Data Entrada	11/01/2026 08:17:29	Liberção	15/01/2026 11:38:55
Médico Resp	Dra. Helida Cristina Alcantara Vicente (CRM 4026)	Data Prescr.	15/01/2026 11:35:00
Prescritor	Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412	Prontuário	1.116.047
Lib. Enferm	Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412	Leito e Setor	516 Internação E-5
Validade:	15/01/2026 11:35:00 16/01/2026 18:59:59	Peso	9,7
Hash	807885B264BE5B6A1833BED4C8C9BA27	Dt. Assinatura	15/01/2026 12:37:27

Documento assinado digitalmente em 15/01/2026 12:37:27, por Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412

Alergias:

Medicamentos	Dose	Horários
Soro Fisiologico 0,9% (NaCl) 250ml inj	200 ml ACM Intravenosa	ACM
Administrar 200 Mililitros (ACM Intravenosa)		
Fax Ped 5ml	1 Fr 2x Oral	11:35 23:35
Administrar 5 Mililitros (2x Oral)		

Alexandre Wilson Silvestre Lopes CRM - 5412

Bo 15/01/2026 11:38:55

Página 1/1

alexandre.lopes

CATE02350





hospital

São Domingos

Relatório dos Parâmetros Assistenciais

Paciente

De: 15/01/2026 Até: 15/01/2026

Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes

Convênio: AMIL-AMIL INDIVIDUAL

Atendimento: 9108291

Data nasc: 06/03/2025 10m 10d

Sector / leito: Internação E-5 516

Prontuário: 1116047

Data entrada: 11/01/2026 08:17:29

Médico resp: Dra. Aurea Maria Borges De

Total BH acumulado: 895,2

Parâmetros	Un med	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	01	02	03	04	05	06	Total	
15/01/2026																											
SINAIS VITAIS																											
Temp	°C					35,6					36								35,8						35,9		
FC	bpm					145					100								105						119		
FR	mm					38					30								26						28		
Sat O2	%					97					100								99						97		
Escala dor	Ponto					FLAC					FLAC								FLAC						FLAC		
Ponto dor						0					0								0						0		
Peso	kg										9,7																
GANHOS	ml																										
Medicamento por via enteral																											
Dieta enteral																											
Água por sonda																											
Pausa Dieta Enteral																											
PERDAS	ml																										
Diurese espontânea - Volume																											
ESCALA PEWS																											
Sonda Gástrica em Sifonagem																											
BALANÇO HÍDRICO																											
Acumulado dia	ml																										

Impresso em: 15/01/2026 09:59:10

Página 1

F61333388306

WATE00158



Paciente:	Jose Henrique da Silva Fernandes	Atendimento:	9108291
Data Nasc:	06/03/2025 0 anos	Prontuário:	1116047
Endereço:	Rua 4G, 4 a Cidade Operária São Luis MA	Dt Entrada:	11/01/2026
Convênio:	AMIL	Dt Alta:	
Setor Atend:	516	Unidade:	APARTAMENTO
Hash:	B1F7EE85D666DB96991A9F4227CEBA6D	Dt. Assinatura:	15/01/2026 18:37:34

Documento assinado digitalmente em: 2026/01/15 18:37:34, por Enfermeiro(a) Francisca Veronica Reis da Silva COREN 957223

Data Anamnese	Profissional	Conselho
15/01/2026 18:31:05	Francisca Veronica Reis da Silva	COREN 957223

1-Procedência

☒ () Centro cirúrgico () Eletiva (X) Emergência () Hemodinâmica

Hora da Admissão:18:00

2-Motivo da internação/História da doença atual: J04.0 Laringite aguda

3-Antecedentes pessoais:

- a - Alergia / Reações Adversas: Nega Alergias ;
- b - Doenças prévias e atuais: Nega doenças ;
- c - Medicamento em uso: FERRO 2 gts 1x ao dia ; VITAMINA D 2 gts 1x ao dia ;
- d - Cirurgias anteriores:

4-Antecedentes mórbidos familiares: -

5-Exame físico (avaliar: neurológico, respiratório, cardíaco,abdominal, MMSS e MMII, locomoção, pele, alimentação, eliminações vesicais e intestinais)
EUPNEICO E A.A.SEM SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO.MANTENDO BONS N°VEIS DE SATURAÇÃO. HEMODINAMICAMENTE ESTÁVEL.SEM USO DE DROGAS VASOATIVAS.AFEBRIL. TIMPÂNICO INDLOR A PALPAÇÃO.BOA ACEITA DA DIETA POR VIA ORAL OFERTADA + USO DE FÓRMULA . APRESENTOU HOJE 2 EPISÓDIOS DE DIARRÉIA(FEZES LÍQUIDAS). PRESENTE EM BOM FLUXO EM FALDA.

6- Parâmetros vitais e MEWS

PA max: PA min: FC: 100 FR: 30 Tax: 36 SatO2: 100 Escala de dor: FLACC / 0
Mews: @Escala_MEWS_HSD Peso: 9,7 kg IMC: SC: Glicemia : 49
Resíduo gástrico:

Francisca Veronica Reis da Silva
COREN 957223

7-Dispositivos



Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nasc: 06/03/2025 0 anos
Endereço: Rua 4G, 4 a Cidade Operária São Luis MA
Convênio: AMIL
Setor Atend: 516
Hash: B1F7EE85D665DB96991A9F4227CEBA6D

Atendimento: 9108291
Prontuário: 1116047
Dt Entrada: 11/01/2026
Dt Alta:
Unidade: APARTAMENTO
Dt. Assinatura: 15/01/2026 18:37:34

Documento assinado digitalmente em: 2026/01/15 18:37:34, por Enfermeiro(a) Francisca Veronica Reis da Silva COREN 957223

() Não
(X) Sim, quais e quanto tempo de uso? AVP EM MSE 13/01/2026

8- Riscos identificados

Escalas e Índices

- DINI (Sistema de Classificação de Pacientes Pediátricos):
- HUMPTY DUMPTY:
- FLEBITE:
- BRADEN (Crianças):
- PEWS:

9-Exames e procedimentos pendentes

Exames/ pareceres/ procedimentos

Exames imagem/ laboratório com resultados críticos: (X) Não () Sim, quais:

Parecer pendente: (X) Não () Sim, quais:

Exame pendente: (X) Não () Sim, quais:

Procedimento pendente: (X) Não () sim, quais:

10- Precauções de isolamento: (X) Não () Sim, motivo:

Transferido de outro hospital onde ficou por mais de 72h ou realizou procedimento invasivo; Internou por mais de 7 dias nos últimos 3 meses ou internação em UTI; Submetido a procedimento cirúrgico nos últimos 3 meses; Sob cuidado de Home Care; Em programa de hemodiálise; Isolou germe em cultura realizada nesta internação (admissão de outro setor do hospital, exceto PS; Outras necessidades de isolamento, qual?

11-Condução :

VERIFICAR SINAIS VITAIS DE 6/6 HORAS
MANTER BOAS PRATICAS NA PREVENÇÃO DE QUEDA, FLEBITE E
BRONCOASPIRAÇÃO
MONITORAR E REGISTRAR SE ALTERAÇÕES NO PADRÃO RESPIRATÓRIO
MANTER CABECEIRA ELEVADA DE 30 A 45

Francisca Veronica Reis da Silva

COREN 957223



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
15/01/2026 12:24	15/01 12:37	Enfermeiro(a)	Evolução de		Brenda Danielly Fernandes Santos Sousa	

Hash: 93F365B8B2B0604C681C042D78E7DE33

Dt. Assinatura: 15/01/2026 13:36

Documento assinado digitalmente em 15/01/2026 13:36:29, por Brenda Danielly Fernandes Santos Sousa

Avaliação: Evolução de enfermagem universal

Dados da Internação :
Diagnóstico de Internação : J04.0 Laringite aguda
Dias de hospitalização : 5
Dias no setor de cuidado : 3
Previsão de alta no plano terapêutico : 16/01/2026 09:55:26

2 - Anamnese e exame físico

Queixa atual : SEM QUEIXAS NO MOMENTO DA VISITA

Sistema neurológico

Descritivo : EM COMPANHIA DA MÃE, ATIVO E REATIVO AO MANUSEIO,NEUROLÓGICO COMPATÍVEL PRA IDADE
CAM ICU : NA
Glasgow : .
Paciente em ventilação mecânica : Não
Avaliação do nível de sedação :
Sistema respiratório :
Padrão/Ausculta/Observações : EUPNEICO E A.A,SEM SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO,MANTENDO NÍVEIS DE SATURAÇÃO
Sistema cardiovascular :
Ausculta/Hemodinâmica : HEMODINAMICAMENTE ESTÁVEL,SEM USO DE DROGAS VASOATIVAS,AFEBRIL
Abdome :
Aparência/Ruídos/Observações : TIMPÂNICO INDLOR A PALPAÇÃO
Dieta e Hidratação :
Tipo de dieta / Via de administração / Status / Aceitação ou Tolerância : BOA ACEITA DA DIETA POR VIA ORAL OFERTADA + USO DE FÓRMULA
Paciente possui indicação de verificação do resíduo gástrico? : Não
Eliminações Tipo/Local :
Intestinais : APRESENTOU HOJE 2 EPISÓDIOS DE DIARRÉIA(FEZES LÍQUIDAS)
Vesicais : PRESENTE EM BOM FLUXO EM FALDA
Mobilidade : Restrito ao leito
Pele :
Inspeção/Observação : ÍNTEGRA PARA LESÕES DE LPP,SEM SINAIS DE DESIDRATAÇÃO
Escala de avaliação de pele : Risco baixo
Integridade : Integra

Brenda Danielly Fernandes Santos Sousa



Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo: Masculino
Telefone: 96 985108882
Leito: 516

Atendimento: 9.108.291
Prontuário: 1.116.047
Dt. Entrada: 11/01/2026 08:17:29
Convênio: AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Risco de lesão de pele? : Não
Lesão de pele? : Não
Controle de umidade I : Não
Troca :
Realizado troca de curativo? : Não
Lesão de pele/Ferida Operatória/Outras Lesões 1 :
Quantidade :
Lesão de pele/Ferida Operatória/Outras Lesões 2 :
Quantidade :
Sinais Vitais :
Temp : 35,6
FR : 38
FC : 145
Sat : 97
FIO2 :
DOR :
NEWS/PEWS : 0
Glicemias :
Hipoglicemia no periodo? : NÃO
Escala :
Humpty Dumpty : Sim
Paciente com plaquetas < 30.000 ou RNI > 3? : NÃO
Resultado : Resultado: Alto risco de queda - Pontuação: 15

Paciente com alto risco de queda? : SIM
Ronda Assistencial : MANTER GRADES ELEVADAS E TRAVADAS
Resultado : 0
Avaliação de toxicidade de quimioterapia :
Avaliação de Toxicidade? : NA

4 - Protocolos

Protocolos : Não
Central :
Central? : Não
Periférico :
Periférico? : SIM
Local : MSE
Data de punção : 13/01/2026
Obs/Conduta : OBSERVAR SINAIS FLOGÍSTICOS
Arterial :
Arterial : NÃO

6 - Outras intervenções

Brenda Danielly Fernandes Santos Sousa



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 518

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.118.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 À 900

Hemotransfusão : NÃO
Dálise/Hemodiálise : NÃO
Procedimento Cirúrgico : NÃO
Exames e pendências : NÃO
Outros procedimentos : NÃO

7 - Plano de Cuidados/ Round Multidisciplinar

Descritivo : VERIFICAR SINAIS VITAIS DE 6/6 HORAS
MANter BOAS PRATICAS NA PREVENÇÃO DE QUEDA, FLEBITE E BRONCOASPIRAÇÃO
MONITORAR E REGISTRAR SE ALTERAÇÕES NO PADRÃO RESPIRATÓRIO
MANter CABECEIRA ELEVADA DE 30 A 45

Status : Mantido

8 - Desfecho

Desfecho : Internação mantida
Descritivo : SEGUE AOS CUIDADOS DA EQUIPE MULTI

Brenda Danielly Fernandes Santos Sousa



Ficha de Transição de Cuidados Universal

Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo: Masculino
Telefone: 98 985108882
Leito: 516

Atendimento: 9.108.291
Prontuário: 1.116.047
Dt. Entrada: 11/01/2026 08:17:29
Convênio: AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 À 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
15/01/2026 12:39	15/01 15:56	Enfermeiro(a)	Ficha de Transição de		Brenda Danielly Fernandes Santos Sousa	

Hash: 8FCBA54C4C0F8CF8DB7727A2BBEC1B79

Dt. Assinatura: 15/01/2026 16:55

Documento assinado digitalmente em: 15/01/2026 16:55:32, por: Brenda Danielly Fernandes Santos Sousa

Avaliação: Ficha de Transição de Cuidados Universal

/ Diagnóstico/ Procedimento : J04.0 Laringite aguda
Protocolos Assistenciais ou linha de cuidados? : Não
Alergias : Nega Alergia

Reconciliação Medicamentosa atualizada : Medicamento: FERRO - Dose: 2 - Unid Med: gts - Via adm: - Intervalo: 1x ao dia

Medicamento: VITAMINA D - Dose: 2 - Unid Med: gts - Via adm: - Intervalo: 1x ao dia

Situação : EM COMPANHIA DA MÃE, ACORDADO, ATIVO E REATIVO AO MANUSEIO, NEUROLÓGICO HABITUAL PARA A IDADE, EUPNEICO, EM A.A., SEM SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO, BONS NÍVEIS DE SATURAÇÃO, HEMODINAMICAMENTE ESTÁVEL, SEM USO DE DROGAS VASOATIVAS, AFEBRIL, ABDOMEM TIMPÂNICO, FLÁCIDO, INDOLOR À PALPAÇÃO, MOVIMENTA BEM OS 4 SEGMENTOS CORPORAIS EM MMSS E MMII, SEM DÉFICIT MOTOR APARENTE, LIVRE DE LESÕES PARA LPP, SEM SINAIS DE DESIDRATAÇÃO, AVP PÉRVIO E FUNCIONANTE EM MSE, HIPOCORADO, ELIMINAÇÕES INTestinaIS COM 2 EPISÓDIOS DE DIARREIA COM FEZES LÍQUIDAS HOJE, ELIMINAÇÕES VESICAIS PRESENTES E ESPONTÂNEAS EM FRALDA.

Breve Histórico : CRIANÇA 10 MESES DEU ENTRADA EM GRANDE SALA COM TOSSE LADRANTE E FEBRE.

Avaliação :

Recomendação : VERIFICAR SINAIS VITAIS A CADA 2 HORAS
MANTER BOAS PRÁTICAS NA PREVENÇÃO DE QUEDAS, FLEBITE E BRONCOASPIRAÇÃO
MONITORAR E REGISTRAR SE ALTERAÇÕES NO PADRÃO RESPIRATÓRIO
MANTER CABECEIRA ELEVADA ENTRE 30 A 45°

Pele :

Possui lesão por pressão? : Não

Se lesão domiciliar externa, foi notificado? : Não

Pendências : Não

Exames laboratoriais? : .

Exames de Imagem? : .

Parecer médico? : .

Dispositivos vasculares :

AVP : Sim

Transporte realizado em : Cadeira de rodas

Sinais Vitais :

PA max : .

Brenda Danielly Fernandes Santos Sousa



Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo: Masculino
Telefone: 98 985108882
Leito: 516

Atendimento: 9.108.291
Prontuário: 1.118.047
Dt. Entrada: 11/01/2026 08:17:29
Convênio: AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 À 900

PA min : .

FC : 145

FR : 38

Tax : 35,6

SPO² : 97

News : .

Pews : 0

Se NEWS (maior ou igual a 3)/ PEWS (maior ou igual a 2) DA TRANSFERÊNCIA, teve alguma intervenção médica? : Não se aplica

Pulseira de Identificação Segura: : Sim

Precaução e Isolamento : Não

Hora da Transferência : 15/01/2026 16:00

Paciente Cirúrgico :

.: Não

Banho com clorexidina noite anterior ao procedimento cirúrgico : Não se aplica

Banho com clorexidina até 6h antes o procedimento cirúrgico : Não se aplica

Informado Enfermagem : VIA TRANSIÇÃO DE CUIDADOS

Brenda Danielly Fernandes Santos Sousa



Evolução de Enfermagem (PED)

Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo: Masculino
Telefone: 98 985108882
Leito: 516

Atendimento: 9.108.291
Prontuário: 1.116.047
Dt. Entrada: 11/01/2026 08:17:29
Convênio: AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
16/01/2026 06:38	16/01 06:38	Enfermeiro(a)	Evolução de		Monica Cristina Da Silva Tavares	COREN 626063-ENF

Hash: 6E7CEC9936CAC0C9229CAA3B3D7F69E4

Dt. Assinatura: 16/01/2026 07:37

Documento assinado digitalmente em 16/01/2026 07:37:16, por Monica Cristina Da Silva Tavares COREN 626063-ENF

Check List - Rotina Assistencial de Enfermagem

1. Paciente apresentou temperatura $\geq 37,8^{\circ} \text{C}$?

Sim (). Conduta? _____

Não (X).

2. Paciente apresentou dor intensa?

Sim (). Conduta? _____

Não (X).

3. Paciente pontuou PEWS ≥ 3 ?

Sim (). Conduta? _____

Não (X).

4. Familiar expressa forte preocupação com o estado do paciente?

Sim (). Conduta? _____

Não (X).

5. Paciente perdeu acesso venoso periférico?

Sim (). Conduta? _____

Não (X)

Monica Cristina Da Silva Tavares
COREN 626063-ENF



SAE - Prescrição e Diagnósticos de Enfermagem (novo)

Paciente	Jose Henrique da Silva Fernandes	Atendimento	9.108.291	Prontuário	1.116.047
Data Nascto	06/03/2025 10 Meses	Convênio	AMIL / AMIL INDIVIDUAL 500 A 900		
Data Entrada	11/01/2026 08:17:29	SAE	1168387		
Enfermeiro	Francisca Veronica Reis da Silva - COREN 957223	Data SAE	15/01/2026 19:03:17	Liberação	15/01/2026 19:05:04
Sector	Internação E-5	Leito	516		
Hash:	061C70FD209F6550AF99FB4D18598E15	Dt. Assinatura:	15/01/2026 20:03:35		

Documento assinado digitalmente em 2026/01/15 20:03:35, por Enfermeiro(a) Francisca Veronica Reis da Silva COREN 957223

Diagnósticos de enfermagem

- 1 Risco de Broncoaspiração (PEDIATRIA)
- 2 Risco de infecção
- 3 Risco de Queda (PEDIATRIA)
- 4 Risco de obstrução de vias aéreas

Prescrição de enfermagem

	SN	Intervalo	Horários
1 Avaliar e registrar condição respiratória		Contínuo	20
2 Manter a cabeceira do leito elevada (30-45°) durante e após alimentação por 30 minutos.		Contínuo	20
Verificar e anotar sinais vitais		6/6 h	20 02 08 14



Paciente	Jose Henrique da Silva Fernandes	Atendimento	9.108.291	Prontuário	1.116.047
Data Nascto	06/03/2025 10 Meses	Convênio	AMIL / AMIL INDIVIDUAL 500 A 900		
Data Entrada	11/01/2026 08:17:29	SAE	1168477		
Enfermeiro	Monica Cristina Da Silva Tavares - COREN 626063-ENF	Data SAE	16/01/2026 00:03:29	Liberação	15/01/2026 23:35:46
Sector	Internação E-5	Leito	516		
Hash:	59405F4BF4D1299058BC777853C26866	Dt. Assinatura:	16/01/2026 00:34:15		

Documento assinado digitalmente em: 2026/01/16 00:34:15, por: Monica Cristina Da Silva Tavares COREN 626063-ENF

Diagnósticos de enfermagem

1. Condição respiratória prejudicada
2. Risco de Broncoaspiração (PEDIATRIA)
3. Risco de infecção
4. Risco de Queda (PEDIATRIA)
5. Diarreia

Prescrição de enfermagem

	SN	Intervalo	Horários
1. Administrar oxigenoterapia	SOS/SN		
2. Aspiração das vias aéreas para evitar acúmulo de secreções.	SOS/SN		
3. Avaliar e registrar aceitação da dieta	6/6 h		12 18 00 06
4. Avaliar e registrar características da eliminação intestinal	6/6 h		12 18 00 06
5. Avaliar e registrar condição respiratória	6/6 h		12 18 00 06
6. Avaliar e registrar frequência, movimento, ritmo e esforço respiratório	6/6 h		12 18 00 06
7. Avaliar e registrar sinais de desidratação	6/6 h		12 18 00 06
8. Calcular o score de queda (Humpty dumpy)	M		12
9. Elevar e manter cabeceira da cama a 30º a 45º	Contínuo		12
10. Manter grades elevadas e cama baixa e travada.	Contínuo		12
11. Medir e registrar oximetria de pulso	6/6 h		12 18 00 06
12. Verificar e anotar sinais vitais	6/6 h		12 18 00 06

Impresso em: 16/01/2026 10:00:35

Enf.: Monica Cristina Da Silva Tavares - COREN 626063-ENF

Página 1

monica. / F6133338

Paciente: Jose Henrique da Silva

Internação E-5

516



Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo: Masculino
Telefone: 98 985108882
Leito: 516

Atendimento: 9.108.291
Prontuário: 1.116.047
Dt. Entrada: 11/01/2026 08:17:29
Convênio: AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
15/01/2026 09:18	15/01 16:54	Técnico de enfermagem	Anotação de		Lana Celia Silva dos Santos	COREN 1539228-TE

Hash: D1C8E1DF6314F49FF22C243668CF8D84

Dt. Assinatura: 15/01/2026 17:54

Documento assinado digitalmente em 15/01/2026 17:54:21, por Técnico(a) de Enfermagem Lana Celia Silva dos Santos COREN 1539228-TE

Avaliação: Anotação de enfermagem universal

Estado de recebimento

Descritivo : ÀS 07:00 RECEBO PLANTÃO COM PACIENTE DE MENOR EM REPOUSO NO LEITO ACORDADO, ORIENTADO, RESPIRANDO EM AR AMBIENTE, ACEITANDO DIETA OFERTADA POR VIA ORAL, ELIMINAÇÕES PRESENTES, USO DE PULSIERAS DE IDENTIFICAÇÃO, OIRENTO MANTER AS GRADES E CABECEIRAS ELEVADAS E LEITO BAIXO, SEGUE AOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM.

2 - Escores

Houve alteração do News (maior ou igual a 1) / Pews (maior ou igual a 2) durante o plantão? : Não

3 - Dispositivo Vascular

..:

Central? : NÃO

Realizado troca/instalação de conector valvulado no cateter central? : NÃO

Realizado lavagem do acesso venoso antes, entre e após cada medicação, com seringa salinizada conforme protocolo institucional de recomendações de boas práticas. : Sim

Usado quantas seringas salinizadas ? : 2

Para quais medicações foram utilizadas ? : solumedrol

Realizado filtro para segurança e redução de risco de infecção e flebite : NÃO

..:

Periférico? : SIM

Há sinais de flebite no acesso ? : NÃO

Local : MSE

Data de punção : 11/01/2026

Obs/Conduta : SEM SINAIS FLOGISTICOS

Realizado troca de AVP no dia? : Não

4 - Dispositivos e equipamentos

Bota pneumática : Não

5 - Dieta

Oral : Sim

Status alimentação : Ativa

Lana Celia Silva dos Santos
Técnico(a) de Enfermagem COREN 1539228-TE



Paciente **Jose Henrique da Silva Fernandes**
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 518

Atendimento **9.108.291**
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

6 - Eliminações

Intestinais : Em fralda
Status : Eliminações presentes
Característica : PASTOSA
Vesicais : Em fralda
Status : Eliminações presentes
Característica : NORMAL

7 - Higiene

Banho : No chuveiro com auxílio
Oral : Escovação com auxílio
A higiene foi realizada duas vezes? : Sim
Quantas vezes realizou aspiração da cavidade oral? : 0
Troca de fraldas 1 : NÃO
Troca de fraldas 2 : NÃO
Troca de fraldas 3 : NÃO
Troca de fraldas 4 : NÃO
Troca de fraldas 5 : NÃO
Glicemia :
Controle Glicêmico : NA
ID/Queda :
Resultado : Resultado: Alto risco de queda - Pontuação: 18

Mantive grades elevadas e orientei família : Sim
Chequei/orientei sobre e/ou realizei quando necessário troca de pulseiras de identificação : Sim
PACIENTE COM ALTO RISCO DE QUEDA? : Sim
Ronda Assistencial : ORIENTO MANTER AS GRADES E CABECEIRA ELEVADAS E LEITO BAIXO
PAV/PNAV :
realizada higiene oral pela equipe ou autocuidado : Sim
Mantive cabeceira elevada : Sim
LPP :
Realizei mudança de decúbito conforme necessário :
NA : Sim
Realizei controle de umidade na troca de fraldas : NA
Acoplei coxins necessários : NA
Realizei hidratação da pele conforme protocolo : NA
SSVV 12hs :
FC : 72
FR : 28
Dor : 0
Escala Dor : FLACC

9 - Desfecho

Lana Celia Silva dos Santos
Técnico(a) de Enfermagem COREN 1539228-TE



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98.985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Descritivo : REALIZADO TODAS AS MEDICAÇÕES DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDICA, SEGUE ESTAVEL SEM INTERCORRENCIAS.

10 - Materiais pedidos e utilizados

Descritivo : NA

Lana Celia Silva dos Santos
Técnico(a) de Enfermagem COREN 1539228-TE



Anotação de Enfermagem*

Paciente	Jose Henrique da Silva Fernandes		Atendimento	9.108.291
Data Nascto.	06/03/2025	10 Meses	Prontuário	1.116.047
Sexo	Masculino		Dt. Entrada	11/01/2026 08:17:29
Telefone	98 985108882		Convênio	AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900
Leito	516			

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
15/01/2026 15:35	15/01 15:43	Técnico de enfermagem	Anotação de		Mariene Pinto Coelho	

Hash:	4FD591FB998C3B3ED92977A3C879F07C	Dt. Assinatura:	15/01/2026 16:42
-------	----------------------------------	-----------------	------------------

Documento assinado digitalmente em 15/01/2026 16:42:19, por Técnico(a) de Enfermagem Mariene Pinto Coelho

EM TEMPO:

AS 13:00 HORAS RECEBO PLANTAO COM PACIENTE INTERNO, ACOMPANHADO DE SUA MAE , COM QUADRO DE LARINGITE AGUDA , MENOR ENCONTRA-SE , ACORDADO, ATIVO, REATIVO, AFEBRIL, RESPIRANDO EM AR AMBIENTE, ACESSO VENOSO NO MSE, FUNCIONANTE, SEM SINAIS FLOGISTICO, AFERIDO SINAIS VITAIS E ADMINISTRADO MEDICAÇÃO DE HORARIO CONFORME A PRESCRIÇÃO MEDICA, MAE NEGA ALERGIA MEDICAMENTOSA, MENOR COM ALERGIA A OVO , DIURESE, EVACUAÇÃO PRESENTE EM FRALDAS, MAE ORIENTADA SOBRE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO E DE RISCO DE QUEDA E SOBRE MANTER CAMA BAIXA E GRADES ELEVADAS, PACIENTE SEGUE AO LEITO AOS CUIDADOS DA ENFERMAGEM. AGUARDANDO LEITO DE INTERNAÇÃO.

Mariene Pinto Coelho
Técnico(a) de Enfermagem

Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
15/01/2026 18:18	15/01 18:21	Técnico de enfermagem	Anotação de		Iria Livia Ferreira da Silva	COREN 1054512-TE

Hash:

Dt. Assinatura:

Avaliação: Anotação de enfermagem universal

Estado de recebimento

Descritivo : RECEBIDO ADMISSÃO LACTENTE COM SUA MAE SEM FEBRE , DIETA SOLICITADA EM SISTEMA NUTRICIONAL , NEGA ALERGIA , RISCO DE QUEDA , RISCO DE FLEBITE , PRESTADO CUIDADO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL , MANTENDO GRADES E CABECEIRA ELEVADA , ADMINISTRADO ALLEGRA ORAL 18:00 HORAS
HIDRATAÇÃO ENDOVENOSA TROCADO
FEZES LÍQUIDA EM FRALDA , DIURESE ESPONTANEO

2 - Escores

Houve alteração do News (maior ou igual a 1) / Pews (maior ou igual a 2) durante o plantão? : Não

3 - Dispositivo Vascular

. :
Central? : NÃO
Tipo/Local/Lateralidade : NÃO SE APLICA
Realizado troca/instalação de conector valvulado no cateter central? : NÃO
Realizado lavagem do acesso venoso antes, entre e após cada medicação, com seringa salinizada conforme protocolo institucional de recomendações de boas práticas. : Sim
Usado quantas seringas salinizadas ? : 0
Para quais medicações foram utilizadas ? : 0
Utilizado filtro para segurança e redução de risco de infecção e flebite : NÃO
.7 :
Periférico? : SIM
Há sinais de flebite no acesso ? : NÃO
Local : MSE
Data de punção : 11/01/2026
Obs/Conduta : SEM SINAIS DE FLEBITE
Realizado troca de AVP no dia? : Não

4 - Dispositivos e equipamentos

Bota pneumática : Não

5 - Dieta



Iria Livia Ferreira da Silva
COREN 1054512-TE



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Oral : Sim
Status alimentação : Ativa

6 - Eliminações

Intestinais : Em fralda
Status : Eliminações presentes
Característica : LIQUIDA
Vesicais : Em fralda
Status : Eliminações presentes
Característica : NORMAL

7 - Higiene

Banho : No chuveiro com auxílio
Oral : Higiene com espátula e enxaguante
A higiene foi realizada duas vezes? : Sim
Quantas vezes realizou aspiração da cavidade oral? : 0
Troca de fraldas 1 : NÃO
Troca de fraldas 2 : NÃO
Troca de fraldas 3 : NÃO
Troca de fraldas 4 : NÃO
Troca de fraldas 5 : NÃO
Glicemia :
Controle Glicêmico : Não
ID/Queda :
Resultado : Resultado: Alto risco de queda - Pontuação: 15

Mantive grades elevadas e orientei família : Sim
Chequei/orientei sobre e/ou realizei quando necessário troca de pulseiras de identificação : Sim
PACIENTE COM ALTO RISCO DE QUEDA? : Não
PAV/PNAV :
Foi realizada higiene oral pela equipe ou autocuidado : Não
Mantive cabeceira elevada : Sim
LPP :
Realizei mudança de decúbito conforme necessário :
Não : Sim
Realizei controle de umidade na troca de fraldas : Não
Acoplei coxins necessários : Não
Realizei hidratação da pele conforme protocolo : Não
SSVV 12hs :
FC : 100
FR : 30
Dor : 0
Escala Dor : FLACC

Irã Livia Ferreira da Silva
20/01/2026 14:12:49

Irã Livia Ferreira da Silva
COREN 1054512-TE



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

9 - Desfecho

Descritivo : ENCERRO PLANTÃO COM LACTENTE SEM QUEIXA COM SEUS FAMILIARES

10 - Materiais pedidos e utilizados

Descritivo : NÃO SE APLICA



Irta Livia Ferreira da Silva
COREN 1054512-TE



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 965108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 À 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
16/01/2026 03:22	16/01 03:38	Técnico/Auxiliar Enfermagem	Anotação de		Lucimeire Costa da Silva	COREN 480885-TE

Hash: EAC838BCFC582F45F324C3E7CD4C5167

Dt. Assinatura: 16/01/2026 04:36

Documento assinado digitalmente em 16/01/2026 04:36:48, por Técnico(a) de Enfermagem Lucimeire Costa da Silva COREN 480885-TE

Avaliação: Anotação de enfermagem universal

Estado de recebimento

Descritivo : AS 19:00HS RECEBO PACIENTE EM REPOUSO NO LEITO, AR AMBIENTE, DIETA ORAL, ALERTA, AFEBRIL, ATIVO E REATIVO, EUPNEICO, ACESSO PERIFERICO AO LADO DIREITO CURSANDO SORO F, ACOMPANHADA PELA FAMILIA, ORIENTADOS SOBRE RISCOS E NORMAS DO SETOR. AFERIDO SINAIS VITAIS.ADMINISTRADAS MEDICAÇÕES DE HORARIO. MAE 02HS RECUSA A MEDICAÇÃO POR VA ORAL ALLEGRA.ENFERMEIRA CIENTE. PRESTADO OS CUIDADOS DA ENFERMAGEM

2 - Escores

Houve alteração do News (maior ou igual a 1) / Pews (maior ou igual a 2) durante o plantão? : Não

3 - Dispositivo Vascular

..:

Central? : NÃO

Realizado troca/instalação de conector valvulado no cateter central? : NÃO

Realizado lavagem do acesso venoso antes, entre e após cada medicação, com seringa salinizada conforme protocolo institucional de recomendações de boas práticas. : Sim

Quantas seringas salinizadas ? : 2

Para quais medicações foram utilizadas ? : UNIMEDROL

Utilizado filtro para segurança e redução de risco de infecção e flebite : NÃO

.7:

Periférico? : SIM

Há sinais de flebite no acesso ? : NÃO

Local : MSD

Data de punção : 11/01/2025

Obs/Conduta : FUNCIONANTE

Realizado troca de AVP no dia? : Não

4 - Dispositivos e equipamentos

Bota pneumática : Não

5 - Dieta

Oral : Sim

Lucimeire Costa da Silva
Técnico(a) de Enfermagem COREN 480885-TE



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Status alimentação : Ativa

6 - Eliminações

Intestinais : Em fralda
Status : Eliminações presentes
Característica : NORMAL
Vesicais : Em fralda
Status : Eliminações presentes
Característica : NORMAL

7 - Higiene

Banho : No chuveiro com auxílio
Oral : Escovação com auxílio
A higiene foi realizada duas vezes? : Não
Justificativa :
Quantas vezes realizou aspiração da cavidade oral? : 0
Troca de fraldas 1 : NÃO
Troca de fraldas 2 : NÃO
Troca de fraldas 3 : NÃO
Troca de fraldas 4 : NÃO
Troca de fraldas 5 : NÃO
Glicemia :
Controle Glicêmico : Não
ID/Queda :
Resultado : Resultado: Alto risco de queda - Pontuação: 13

Mantive grades elevadas e orientei família : Sim
Chequei/orientei sobre e/ou realizei quando necessário troca de pulseiras de identificação : Sim
CIENTE COM ALTO RISCO DE QUEDA? : Não
PAV/PNAV :
Foi realizada higiene oral pela equipe ou autocuidado : Sim
Mantive cabeceira elevada : Sim
LPP :
Realizei mudança de decúbito conforme necessário :
NA : Sim
Realizei controle de umidade na troca de fraldas : NA
Acoplei coxins necessários : NA
Realizei hidratação da pele conforme protocolo : NA
SSVV 12hs :
FC : 105
FR : 26
Dor : 0
Escala Dor : FLACC

Lucimeire Costa da Silva
Técnico(a) de Enfermagem COREN 480885-TE



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

9 - Desfecho

Descritivo : ADMINISTRADA

01H / 07H SORO
03:52 AEROLIN
03:52 UNIMEDROL
22H FLORAX

10 - Materiais pedidos e utilizados

Descritivo : 2 SERINGAS DOSADORAS

Lucimeire Costa da Silva
Técnico(a) de Enfermagem COREN 480885-TE





hospital

São Domingos

Evolução Médica

Pediatria

Paciente	Jose Henrique da Silva Fernandes			Atendimento	9.108.291	
Data Nascto.	06/03/2025	10 Meses		Prontuário	1.116.047	
Sexo	Masculino			Dt. Entrada	11/01/2026 08:17:29	
Telefone	98 985108882			Convênio	AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900	
Leito	516					

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
16/01/2026 09:41	16/01 09:48	Médico(a)	Evolução Médica		Aurea Maria Borges De Morais Arouche	CRM 4304

Hash:

7553089324DE6F545848D22ED6F62DA7

Dt. Assinatura:

16/01/2026 10:47

Documento assinado digitalmente em:

16/01/2026 10:47:39, por:

Aurea Maria Borges De Moraes Arouche CRM 4304

1. Diagnóstico:

LARINGITE+IVAS+GECA

ADMISSÃO: CRIANÇA 10 MESES DEU ENTRADA EM GRANDE SALA COM TOSSE LADRANTE E FEBRE.

peso: 9 kg

2. Alergias

3. Dias de Internação: 6 dias

4. Terapêutica atual (Antibióticos e medicações de risco):

AEROLIN 6/6H

METILPREDNISOLONA 2MG/KG/DIA

NBZ CLENIL

FLORAX

5. Evolução das Últimas 24h:

PACIENTE SEM FEBRE, TOSSE SECA ESPAÇADA

POUCA CONGESTÃO, COM SECREÇÃO HIALINA E SEM ROUQUIDÃO

MANTÉM DIARREIA - FEZES LIQUIDAS EM GRANDE QUANTIDADE, JÁ FEZ HOJE

SEM VÔMITOS

ACEITA POUCO A DIETA

BOA DIURESE

6. Exame Físico

HIDRATADO,ATIVO,AFEBRIL,EUPNEICO,EM AA SAT 98%

PERFUSÃO OK

AP,MV RUDE SEM RONCOS

OF;HIPEREMIADO SEM FOCO

ABDOMEM;TIMPANICO,FLACIDO,INDOLOR A PALPAÇÃO

7. Resultado dos exames importantes:

HC: LEUCO-11160 56SEG 34LT 2 ATIP PLAQ- 486MIL PCR-0,02

COPRO: RTV/HEMACIAS/EPF- NEGATIVOS

RX TORAX- ESPESSAMENTOS PB E PH

8. Programação do dia:

CONVERSO COM FAMILIARES E ESCLAREÇO DUVIDAS

REDUZO CORTICÓIDE

ASSOCIO TIORFAN E PEDIALYTE

9. Previsão de alta: 1-2 DIAS

10. Plano Terapeutico:

Aurea Maria Borges De Moraes Arouche

CRM 4304

Impresso em:

19/01/2026 16:

Página

1/2

F61333388306

CATED0596

Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto 08/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 Á 900

SUORTE CLINICO E NUTRICIONAL
TRATAR DOENÇA DE BASE
AVALIAR ALTA APÓS MELHORA CLINICA

11. Avaliação de Riscos/Scores:

11.1 Flebite:

11.2 Avaliação do risco de queda - Humpty Dumpty: 16 - Alto risco de queda

11.3 Avaliações de BradenQ (Lesão por pressão): 25 - Risco baixo

11.4 Avaliações do risco strogkids (Risco Nutricional):

Aurea Maria Borges De Moraes Arouche
CRM 4304





9108291

Atendimento

Internado

Hospital Sao Domingos

Prescrição Eletrônica Paciente

12670280

Prescrição

Paciente

Jose Henrique da Silva Fernandes

Data Nascim

06/03/2025 10m 10d

Data Entrada

11/01/2026 08:17:29

Médico Resp

Dra. Aurea Maria Borges De Moraes Arouche (CRM 4304)

Prescritor

Aurea Maria Borges De Moraes Arouche CRM - MA 4304

Lib. Enferm

Aurea Maria Borges de Moraes Arouche CRM - MA 4304

Validade:

16/01/2026 19:00:00 17/01/2026 18:59:59

Hash

AE32C59147BED9F3657B19A37EA323DC

Atendimento

9.108.291

Convênio

AMIL / AMIL INDIVIDUAL 500

Liberacao

16/01/2026 09:23:26

Data Prescr.

16/01/2026 09:21:00

Prontuario

1.116.047

Leito e Setor

516 Internação E-5

Peso

9.7

Dt. Assinatura

16/01/2026 10:21:59

Documento assinado digitalmente em 16/01/2026 10:21:59, por Aurea Maria Borges De Moraes Arouche CRM - MA 4304

Alergias:

OVO

Dietas

Intervalo

Horários

Observação

Branda Múltiplas Alergias

3/3 h

20:20 23:20
02:20 05:20
08:20 11:20
14:20 17:20

Soluções

Soro Glicosado 5% 250ml inj

Velocida 9,9556 gtm

Etapas: 4

Dispositivo de infusão: Equipos macrogotas simples

Horários: das 19 às 01; das 01 às 07; das 07 às 13; das 13 às 19;

Tipo Analgesia: Dose Inicial: Dose Limite 4h: Fluxo: Dose Limite 1h: ml Bolus:

Soro Glicosado 5% 250ml inj Dose: 175 ml

Cloreto de Potassio 10% 10ml injetavel Dose: 2,7 ml

Cloreto de Sodio 20% 10ml injetavel Dose: 1,5 ml

Medicamentos

Dose

Horários

AERODINI 100 MCG/DOSE-200DOSES FR 3 jato 6/6 h Inalatória

22 04 10 16

Allegria Ped 6mg/ml susp oral 60ml 2 ml 8/8 h Oral

22 06 14 18

Administrar 2 Mililitros (8/8 h Oral)

Dipirona 500 MG/ML-2ML AMP TEUTO 0,4 ml SOS/SN Intravenosa

Diluir 0,4 Mililitros do medicamento em 10 Mililitros de Agua p/ Infusão 10ml

Administrar 10,4 Mililitros (SOS/SN Intravenosa)

Florax Ped 5ml 1 Fr 2x Oral

20 08

Administrar 5 Mililitros (2x Oral)

Ondansetrona 4 mg em 2 mL- inj 0,6 ml SOS/SN Intravenosa SN

Diluir 0,6 Mililitros do medicamento em 50 Mililitros de Soro Fisiologico 0,9% (NaCl)

50ml inj

Administrar 50,6 Mililitros (SOS/SN Intravenosa)

Estabilidade: 48 Horas Após diluição

Temperatura ambiente controlada (15°C a 30°C)

Recomendado acesso central

PANTOCAL 4MG/ML-10ML FR/AMP EV 2,2 ml 1x ao dia Intravenosa p6

Reconstituir cada Frasco-ampola em 10 Mililitros de Diluente Proprio

Diluir 2,2 Mililitros da reconstituição em 100 Mililitros de Soro Fisiologico 0,9% (NaCl)

100ml inj

Administrar 102,2 Mililitros (1x ao dia Intravenosa) em 1 h.

Simeticona 75mg/ml gts 15ml 9 gts 8/8 h Oral 22 06 19 16 20 30 08 30 16 30

Soro Fisiologico 0,9% (NaCl) 250ml inj 200 ml ACM Intravenosa ACM

Liberacao 16/01/2026 09:23:26

Página 1/2

aurea.arouche

CATE02350



Número do documento: 26022014124998500000159866788

<https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26022014124998500000159866788>

Assinado eletronicamente por: VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - 20/02/2026 14:12:50

Num. 172684520 - Pág. 6



Paciente	Jose Henrique da Silva Fernandes	Atendimento	9.108.291
Data Nascto	08/03/2025 10m 10d	Convênio	AMIL / AMIL INDIVIDUAL 500
Data Entrada	11/01/2026 08:17:29	Liberção	16/01/2026 09:23:26
Médico Resp	Dra. Aurea Maria Borges De Moraes Arouche (CRM 4304)	Data Prescr.	16/01/2026 09:21:00
Prescritor	Aurea Maria Borges De Moraes Arouche CRM - MA 4304	Prontuário	1.116.047
Lib. Enferm	Aurea Maria Borges de Moraes Arouche CRM - MA 4304	Leito e Setor	516 Internação E-5
Validade:	16/01/2026 19:00:00 17/01/2026 18:59:59	Peso	9,7
		Dt. Assinatura	16/01/2026 10:21:59

Hash AE32C59147BED9F3657B19A37EA323DC

Documento assinado digitalmente em 16/01/2026 10:21:59, por Aurea Maria Borges De Moraes Arouche CRM - MA 4304

Alergias: DVO

Administrar 200 Mililitros (ACM Intravenosa)

UNIMEDROL 125 MG FR/AMP | 3 mg 12/12 h Intravenosa

Reconstituir cada Frasco-ampola em 2 Mililitros de Diluente Proprio

Diluir 0,05 Mililitros da reconstituição em 10 Mililitros de Cloreto de Sodio 0,9% 10ml inj

Administrar 10,05 Mililitros (12/12 h Intravenosa) em 3 minutos

Estabilidade: 48 Horas Após reconstituição

Temperatura ambiente (15°C a 30°C)

Tiorfan 10mg saché 1g

2 SACHE 8/8 h Oral DE 2SACHE (09:22)

Dose Especial: 2 SACHE às 09:22 h

Uso acima de 3 meses.

PEDIALYTE 60 ZINCO UVA 500 ML FR

1 Fr 1x ao dia Oral DE 1Fr (09:22)

Administrar 500 Mililitros (1x ao dia Oral)

Dose Especial: 1 Fr às 09:22 h

Nebulização

Dose

Intervalo/Horário

Nebulização Clenil + S.F com O₂

Clenil A sol nbz 2ml

Cloreto de Sodio 0,9% 10ml inj

1 ml 12/12 h In

5 ml 12/12 h In

12/12 h

20:08

20:08

Nebulização c/ Adrenalina com O₂

Adren 1mg/1mL inj- EPINEfrina -USO INALATORIO

3 mg SOS/SN In

SOS/SN

SN

Recomendações

Intervalo

Horários

Cabeceira do leito elevada 45° graus

Contínuo

08:20

08:20

Monitorização Cardíaca

Contínuo

08:20

08:20

Oximetria contínua de pulso mais sensor

Contínuo

08:20

06:20

Sinais Vitais de 2/2h

2/2 h

08:20

10:20

12:20

14:20

16:20

18:20

20:20

02:20

04:20

06:20

08:20

10:20

12:20

14:20

16:20

18:20

Aurea Maria Borges De Moraes Arouche CRM - MA 4304

Liberção 16/01/2026 09:23:26

Página 2/2

aurea.arouche

CATE02350





hospital

São Domingos



9108291

Atendimento

Hospital São Domingos

Prescrição Eletrônica Paciente



12670280

Prescrição

Paciente

Jose Henrique da Silva Fernandes

Data Nascto

06/03/2025 10m 10d

Data Entrada

11/01/2026 08:17:29

Médico Resp

Dra. Aurea Maria Borges De Moraes Arouche (CRM 4304)

Prescritor

Aurea Maria Borges De Moraes Arouche CRM - MA 4304

Lib. Enferm

Aurea Maria Borges de Moraes Arouche CRM - MA 4304

Validade:

16/01/2026 19:00:00 17/01/2026 18:59:59

Atendimento

9.108.291

Convênio

AMIL / AMIL INDIVIDUAL 500

Liberacao

16/01/2026 09:23:26

Data Prescr

16/01/2026 09:21:00

Prontuario

1.116.047

Leito e Setor

516 Internação E-5

Peso

9,7

Dt. Assinatura

16/01/2026 10:21:59

Hash

AE32C59147BED9F3657B19A37EA323DC

Documento assinado digitalmente em 16/01/2026 10:21:59, por Aurea Maria Borges De Moraes Arouche CRM - MA 4304

Alergias:

Dietas

Intervalo

Horários

Observação

Branda Múltiplas Alergias

3/3 h

20:20 23:20
02:20 05:20
08:20 11:20 14:20 17:20

Sin.

Suplemen/Modul/Pediat

Intervalo

Dose

Aplicação

Vel. de Infusão

LEITE PO NAN 2 CONFORT 800G

3/3 h

30 g

Oral

ml/h

Horários: 21 00 03 06 09 12 15 18

Soluções

Soro Glicosado 5% 250ml inj

Velocida 9,9556 gtm

Etapas: 4

Dispositivo de infusão:

Equipo macrogotas simples

Horários: das 19 às 01;

das 01 às 07;

das 07 às 13;

das 13 às 19;

Tipo Analgesia:

Modo:

Fluxo:

Bolus:

Dose Inicial:

Dose Limite 4h:

Dose Limite 1h: ml

Soro Glicosado 5% 250ml inj

Dose: 175 ml

Cloreto de Potassio 10% 10ml injetavel

Dose: 2,7 ml

Cloreto de Sodio 20% 10ml injetavel

Dose: 1,5 ml

Medicamentos

Dose

Horários

ACERODINI 100 MCG/DOSE-200DOSES FR

3 jato 6/6 h Inalatória

21:52 03:52 09:52

Allegria Ped 6mg/ml susp oral 60ml

2 ml 8/8 h Oral

22 04 10 16 18:52

DipIRONA 500 MG/ML-2ML AMP TEUTO

0,4 ml SOS/SN Intravenosa

Florax Ped 5ml

1 Fr 2x Oral

09 07 22 10

Ondansetrona 4 mg em 2 mL- inj

0,6 ml SOS/SN Intravenosa

SN

PANTOCAL 4MG/ML-10ML FR/AMP EV

2,2 ml 1x ao dia Intravenosa

11:55

Reconstituir cada Frasco-ampola em 10 Mililitros de Diluente Proprio

Diluir 2,2 Mililitros da reconstituição em 100 Mililitros de Soro Fisiologico 0,9% (NaCl)

100ml inj

Liberacao 16/01/2026 09:23:26

Página 1/2

aurea.arouche

CATE02350





Relatório dos Parâmetros Assistenciais do Paciente

De: 16/01/2026 Até: 16/01/2026

Paciente: Jose Henrique da Silva Fernanc Convênio: AMIL-AMIL INDIVIDUAL Atendimento: 9108291
Data nasc: 06/03/2025 10m 13d Setor / leito: Internação E-5 516 Prontuário: 1116047
Data entrada: 11/01/2026 08:17:29 Médico resp: Dra. Antonia de Jesus Barros Total BH acumulado: 1355,8

Parâmetros	Un med	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	01	02	03	04	05	06	Total
16/01/2026																										
SINAIS VITAIS																										
Temp	°C						36,4						36,1						36,1						36,1	
FC	bpm						135						112						133						128	
FR	mm						32						26						28						28	
Sat O2	%						98						100						100						100	
Escala dor	Ponto						FLAC						FLAC						FLAC						FLAC	
Ponto dor							0						0						0						0	
GANHOS	ml							179,2					102,2	179,2												460,6
Medicamento por via enteral																										
Medicamento intravenoso													102,2													102,2
Dieta enteral																										
Água por sonda																										
Soro glicosado								179,2						179,2												358,4
Pausa Dieta Enteral																										
PERDAS	ml																									
Diurese espontânea - Volume																										
ESCALA PEWS																										
Sonda Gástrica em Sifonagem																										
BALANÇO HÍDRICO																										
Acumulado dia	ml							179,2					281,4	460,6												





Relatório dos Parâmetros Assistenciais do Paciente

De: 16/01/2026 Até: 16/01/2026

Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes Convênio: AMIL-AMIL INDIVIDUAL Atendimento: 9108291
Data nasc: 06/03/2025 10m 13d Setor / leito: Internação E-5 516 Prontuário: 1116047
Data entrada: 11/01/2026 08:17:29 Médico resp: Dra. Antonia de Jesus Barros Total BH acumulado: 1355,8

Parâmetros	Un med	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	01	02	03	04	05	06	Total
16/01/2026																										
SINAIS VITAIS																										
Temp	°C						36,4						36,1						36,1						36,1	
FC	bpm						135						112						133						128	
FR	mm						32						26						28						28	
Sat O2	%						98						100						100						100	
Escala dor	Ponto						FLAC						FLAC						FLAC						FLAC	
Ponto dor							0						0						0						0	
GANHOS	ml							179,2					102,2	179,2												460,6
Medicamento por via enteral																										
Medicamento intravenoso													102,2													102,2
Dieta enteral																										
Água por sonda																										
Soro glicosado								179,2						179,2												358,4
Pausa Dieta Enteral																										
PERDAS	ml																									
Diurese espontânea - Volume																										
ESCALA PEWS																										
Sonda Gástrica em Sifonagem																										
BALANÇO HÍDRICO																										
Acumulado dia	ml							179,2					281,4	460,6												



Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo: Masculino
Telefone: 98 985108882
Leito: 516

Atendimento: 9.108.291
Prontuário: 1.116.047
Dt. Entrada: 11/01/2026 08:17:29
Convênio: AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
16/01/2026 09:01	16/01 09:08	Enfermeiro(a)	Evolução de		Lina Paula Prazeres Moraes	COREN 624367-ENF

Hash: 6B99B72B8CDD29AAA28668048F9C166E

Dt. Assinatura:

Documento assinado digitalmente em , por Lina Paula Prazeres Moraes COREN 624367-ENF

Avaliação: Evolução de enfermagem universal

1 - Dados da Internação :

Diagnóstico de internação : LARINGITE AGUDA

Dias de hospitalização : 6

Dias no setor de cuidado : 2

Previsão de alta no plano terapêutico : 16/01/2026 09:55:26

2 - Anamnese e exame físico

Queixa atual : TOSSE SECA, CONGESTA E CORIZA

Sistema neurológico

Descritivo : LACTENTE ACOMPANHADO DE SUA MAE, ATIVO E REATIVO NO LEITO, NEUROLOGICO COMPATIVEL COM IDADE.

CAM ICU : NA

Glasgow : .

Paciente em ventilação mecânica : Não

Avaliação do nível de sedação :

Sistema respiratório :

Padrão/Ausculta/Observações : EUPNEICO EM AR AMBIENTE, SEM DESCONFORTO RESPIRATORIO, MANTENDO BONS NIVEIS DE SATURAÇÃO

Sistema cardiovascular :

Ausculta/Hemodinâmica : NORMOCARDICA, AFEBRIL, ESTAVEL

Abdome :

Aparência/Ruidos/Observações : RHA+ FLACIDO, GLOBOSO E INDOLOR A PALPAÇÃO.

Dieta e Hidratação :

Tipo de dieta / Via de administração / Status / Aceitação ou Tolerância : DIETA ORAL DE BOA ACEITAÇÃO, SEM RELATOS DE NAUSEAS E OU VOMITOS.

Paciente possui indicação de verificação do residuo gástrico? : Não

Eliminações Tipo/Local :

Intestinais : DIARREICO

Vesicais : PRESENTE EM FRALDA DE BOM FLUXO

Mobilidade : Restrito ao leito

Pele :

Inspeção/Observação : PELE INTEGRAL, LIVRE DE DAE E LPP, ACIANOTICO, ANICTERICO, HIDRATADO

Escala de avaliação de pele : Risco baixo

Integridade : Inteira

Risco de lesão de pele? : Não

Lina Paula Prazeres Moraes
COREN 624367-ENF



Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo: Masculino
Telefone: 98 985108882
Leito: 516

Atendimento: 9.108.291
Prontuário: 1.116.047
Dt. Entrada: 11/01/2026 08:17:29
Convênio: AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Lesão de pele? : Não

Controle de umidade I : Sim: Em uso de cavilon creme para prevenção de lesão por pressão e dermatite associada a incontinência (DAI)

Troca :

Realizado troca de curativo? : Não

Lesão de pele/Ferida Operatória/Outras Lesões 1 :

Quantidade :

Lesão de pele/Ferida Operatória/Outras Lesões 2 :

Quantidade :

Sinais Vitais :

PA :

Temp : 35,9

FR : 28

FC : 110

Sat : 97%

FIO2 : 21

DOR : 0

NEWS/PEWS : 0

Glicemias :

Hipoglicemia no periodo? : NÃO

Escalas :

Humpty Dumpty : Sim

Paciente com plaquetas < 30.000 ou RNI > 3? : NÃO

Resultado : Resultado: Alto risco de queda - Pontuação: 13

Paciente com alto risco de queda? : SIM

Ronda Assistencial :

Resultado : 0

Avaliação de toxicidade de quimioterapia :

Avaliação de Toxicidade? : NA

4 - Protocolos

Protocolos : Não

Central :

Central? : Não

Periférico :

Periférico? : SIM

Local : MSE

Data de punção : 11/01/2026

Obs/Conduta : SEM SINAIS FLOGISTICOS

Arterial :

Arterial : NÃO

6 - Outras intervenções

Lina Paula Prazeres Moraes
COREN 624367-ENF



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Hemotransusão : NÃO
Dálise/Hemodiálise : NÃO
Procedimento Cirúrgico : NÃO
Exames e pendências : NÃO
Outros procedimentos : NÃO

7 - Plano de Cuidados/ Round Multidisciplinar

Descritivo : VERIFICAR SINAIS VITAIS DE 6/6 HORAS
MANter BOAS PRATICAS NA PREVENÇÃO DE QUEDA, FLEBITE E BRONCOASPIRAÇÃO
MONITORAR E REGISTRAR SE ALTERAÇÕES NO PADRÃO RESPIRATÓRIO
MANter CABECEIRA ELEVADA DE 30 A 45

Status : Mantido

8 - Desfecho

Desfecho : Internação mantida
Descritivo : SEGUE AOS CUIDADOS DE EQUIPE MULTI

Lina Paula Prazeres Moraes
COREN 624367-ENF



Evolução de Enfermagem (PED)

Paciente José Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 À 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
17/01/2026 06:08	17/01 06:09	Enfermeiro(a)	Evolução de		Natanielle Gomes Bezerra	COREN 595- 588-ENF

Hash: 92293767B59CAD0151F3431494F9E394

Dt. Assinatura: 17/01/2026 07:07

Documento assinado digitalmente em 17/01/2026 07:07:42, por Enfermeiro(a) Natanielle Gomes Bezerra COREN 595-588-ENF

Check List - Rotina Assistencial de Enfermagem

1. Paciente apresentou temperatura $\geq 37,8^{\circ} \text{C}$?

Sim (). Conduta? _____

Não (X).

2. Paciente apresentou dor intensa?

Sim (). Conduta? _____

Não (X).

3. Paciente pontuou PEWS ≥ 3 ?

Sim (). Conduta? _____

Não (X).

4. Familiar expressa forte preocupação com o estado do paciente?

Sim (). Conduta? _____

Não (X).

5. Paciente perdeu acesso venoso periférico?

Sim (). Conduta? _____

Não (X)

Natanielle Gomes Bezerra
Enfermeiro(a) COREN 595-588-ENF



Paciente	Jose Henrique da Silva Fernandes	Atendimento	9.108.291	Prontuário	1.116.047
Data Nascto	06/03/2025 10 Meses	Convênio	AMIL / AMIL INDIVIDUAL 500 A 900		
Data Entrada	11/01/2026 08:17:29	SAE	1168874		
Enfermeiro	Natanielle Gomes Bezerra - COREN 595-588-ENF	Data SAE	17/01/2026 00:00:00	Liberação	16/01/2026 23:56:13
Sector	Internação E-5	Leito	516		
Hash:	1EAB047110A54ED7D798DFA9061F861D	Dt. Assinatura:	17/01/2026 00:54:42		

Documento assinado digitalmente em: 2026/01/17 00:54:42, por Enfermeiro(a) Natanielle Gomes Bezerra COREN 595-588-ENF

Diagnósticos de enfermagem

- 1 Condição respiratória prejudicada
- 2 Falta de apetite
- 3 Constipação/Incontinência fecal
- 4 Diarreia
- 5 Risco de infecção
- 6 Risco de Queda (PEDIATRIA)

Prescrição de enfermagem

	SN	Intervalo	Horários
1 Avaliar e registrar características da eliminação intestinal		Padrão 2 vezes/dia	10 15
Avaliar e registrar condição respiratória		Padrão 3 vezes/dia	10 15 20
Calcular o score de queda (Humpty dumptly)		Padrão 1 vez/dia	10
4 Elevar e manter cabeceira da cama a 30º a 45º		Padrão 3 vezes/dia	10 15 20
5 Estimular aceitação da dieta		Padrão 3 vezes/dia	10 15 20
6 Estimular ingestão de líquidos		Padrão 3 vezes/dia	10 15 20
7 Estimular ingestão hídrica		Padrão 3 vezes/dia	10 15 20
8 Manter grades elevadas e cama baixa e travada.		Padrão 3 vezes/dia	10 15 20
9 Sinalizar risco de queda (colocar pulseira amarela e placa de identificação)		Conforme Protocolo Instituição	00
10 Verificar e anotar sinais vitais		6/6 h	00 06 12 18

Impresso em: 19/01/2026 16:10:15

Enf.: Natanielle Gomes Bezerra - COREN 595-588-ENF

Página 1

natanielle. / F6133338

Paciente: Jose Henrique da Silva

Internação E-5

516



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
16/01/2026 14:44	16/01 18:58	Técnico/Auxiliar Enfermagem	Anotação de		Francineide Cabral da Rocha	COREN 945776-TE

Hash: F1CCA8B43021800763579782C38108BD

Dt. Assinatura: 16/01/2026 19:56

Documento assinado digitalmente em 16/01/2026 19:56:44, por: Francineide Cabral da Rocha COREN 945776-TE

Avaliação: Anotação de enfermagem universal

1. Estado de recebimento

Descritivo : ÀS 07:30H RECEBO PLANTÃO COM MENOR EM REPOUSO NO LEITO EM COMPANHIA DE SUA MÃE
ACORDADO,RESPIRANDO AR AMBIENTE,DIURESE E EVACUAÇÕES ESPONTANEA
ACOMPANHANTE E MENOR COM PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO

ADMINISTRADO MEDICAÇÕES DE HORARIO DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO MEDICA

2 - Escores

Houve alteração do News (maior ou igual a 1) / Pews (maior ou igual a 2) durante o plantão? : Não

3 - Dispositivo Vascular

. :
Central? : NÃO
Realizado troca/instalação de conector valvulado no cateter central? : NÃO
Realizado lavagem do acesso venoso antes, entre e após cada medicação, com seringa salinizada conforme protocolo institucional de recomendações de boas práticas. : Sim
Usado quantas seringas salinizadas ? :
Para quais medicações foram utilizadas ? :
Utilizado filtro para segurança e redução de risco de infecção e flebite : NÃO
.7 :
Periférico? : SIM
Há sinais de flebite no acesso ? : NÃO
Local :
Data de punção : 13/01/2026
Obs/Conduta : HV EM CURSO
Realizado troca de AVP no dia? : Não

4 - Dispositivos e equipamentos

Bota pneumática : Não

5 - Dieta

Oral : Sim

Francineide Cabral da Rocha
COREN 945776-TE



Paciente **Jose Henrique da Silva Fernandes**
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 96 985108882
Leito 516

Atendimento **9.108.291**
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Status alimentação : Ativa

6 - Eliminações

Intestinais : Em fralda
Status : Eliminações presentes
Característica : NORMAL
Vesicais : Em fralda
Status : Eliminações presentes
Característica : NORMAL

7 - Higiene

Banho : No chuveiro com auxílio
Oral : Escovação com auxílio
A higiene foi realizada duas vezes? : Sim
Quantas vezes realizou aspiração da cavidade oral? : 0
Troca de fraldas 1 : NÃO
Troca de fraldas 2 : NÃO
Troca de fraldas 3 : NÃO
Troca de fraldas 4 : NÃO
Troca de fraldas 5 : NÃO
Glicemia :
Controle Glicêmico : Não
ID/Queda :
Resultado : Resultado: Alto risco de queda - Pontuação: 13

Mantive grades elevadas e orientei família : Sim
Chequei/orientei sobre e/ou realizei quando necessário troca de pulseiras de identificação : Sim
PACIENTE COM ALTO RISCO DE QUEDA? : Sim
Ronda Assistencial : PAIS ORIENTADOS A MANTER CAMA BAIXA E GRADES ELEVADAS
PAV/PNAV :
Foi realizada higiene oral pela equipe ou autocuidado : Não
Mantive cabeceira elevada : Sim
LPP :
Realizei mudança de decúbito conforme necessário :
Não : Sim
Realizei controle de umidade na troca de fraldas : Não
Acoplei coxins necessários : Não
Realizei hidratação da pele conforme protocolo : Não
SSVV 12hs :
FC : 135
FR : 32
Dor : 0
Escala Dor : FLACC

Francineide Cabral da Rocha
COREN 945776-TE



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

9 - Desfecho

Descritivo : SEGUE CUIDADOS DE ENFERMAGEM COM MENOR EM REPOUSO NO LEITO EM COMPANHIA DE SUA MÃE

10 - Materiais pedidos e utilizados

Descritivo :

Francineide Cabral da Rocha
COREN 945776-TE



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
16/01/2026 21:29	17/01 00:35	Técnico/Auxiliar Enfermagem	Anotação de		Natalia de Sousa Lima	COREN 958732-TE

Hash: 059E27F633B7DBD36B1BB32C83DC14E1

Dt. Assinatura: 17/01/2026 01:34

Documento assinado digitalmente em 17/01/2026 01:34:07, por Natalia de Sousa Lima COREN 958732-TE

Avaliação: Anotação de enfermagem universal

1. Estado de recebimento

Descritivo : 19HS RECEBO PACIENTE MENOR NO LEITO ACORDADO ATIVO E REATIVO,O MESMO ESTA EM COMPANHIA FAMILIAR DURANTE A VISITA PACIENTE SEM QUEIXAS ALGICAS ACEITANDO BEM A DIETA ORAL ELIMINAÇÕES EM FRALDA VERIFICADO SINAIS VITAIS

2 - Escores

Houve alteração do News (maior ou igual a 1) / Pews (maior ou igual a 2) durante o plantão? : Não

3 - Dispositivo Vascular

Central? : NÃO
Realizado troca/instalação de conector valvulado no cateter central? : NÃO
Realizado lavagem do acesso venoso antes, entre e após cada medicação, com seringa salinizada conforme protocolo institucional de recomendações de boas práticas. : Sim
Usado quantas seringas salinizadas ? : 4
Para quais medicações foram utilizadas ? : PANTOCAL/UNIMEDOL
Utilizado filtro para segurança e redução de risco de infecção e flebite : NÃO
.7 :
Periférico? : SIM
Há sinais de flebite no acesso ? : NÃO
Local : MSE
Data de punção : 16/01/2026
Obs/Conduta : OBSERVAR SINAIS DE FLEBITE
Realizado troca de AVP no dia? : Não

4 - Dispositivos e equipamentos

Bota pneumática : Não

5 - Dieta

Oral : Sim
Status alimentação : Ativa

Natalia de Sousa Lima
COREN 958732-TE



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 À 900

6 - Eliminações

Intestinais : Em fralda
Status : Eliminações presentes
Característica : LIQUIDO
Vesicais : Em fralda
Status : Eliminações presentes
Característica : NORMAL

7 - Higiene

Banho : No chuveiro com auxílio
Oral : Escovação com auxílio
A higiene foi realizada duas vezes? : Sim
Quantas vezes realizou aspiração da cavidade oral? : 0
Troca de fraldas 1 : NÃO
Troca de fraldas 2 : NÃO
Troca de fraldas 3 : NÃO
Troca de fraldas 4 : NÃO
Troca de fraldas 5 : NÃO
Glicemia :
Controle Glicêmico : NA
ID/Queda :
Resultado : Resultado: Alto risco de queda - Pontuação: 13

Mantive grades elevadas e orientei família : Não
Chequei/orientei sobre e/ou realizei quando necessário troca de pulseiras de identificação : Não
PACIENTE COM ALTO RISCO DE QUEDA? : Não
PAV/PNAV :
Foi realizada higiene oral pela equipe ou autocuidado : NA
Mantive cabeceira elevada : NA
LPP :
Realizei mudança de decúbito conforme necessário :
NA : Sim
Realizei controle de umidade na troca de fraldas : NA
Acoplei coxins necessários : NA
Realizei hidratação da pele conforme protocolo : NA
SSVV 12hs :
FC : 112
FR : 26
Dor : 0
Escala Dor : FLACC

9 - Desfecho

Natalia de Sousa Lima
COREN 958732-TE



Paciente **Jose Henrique da Silva Fernandes**
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Descritivo : ADMINISTRADO AS MEDICAÇÕES CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA
REALIZO TROCA DO ACESSO DEVIDO OBSTRUÇÃO
07HS PASSO PLANTÃO COM PACIENTE NO LEITO EM COMPANHIA DA MAE.

10 - Materiais pedidos e utilizados

Descritivo : DISPENSADO PELA FARMACIA E UTILIZADO:
01 EQUIPO PARA PANTOCAL
SOLICITO
01 JELCO24
01 TEGADERM
POLIFIX

Natalia de Sousa Lima
COREN 958732-TE



Paciente **Jose Henrique da Silva Fernandes**
Data Nascto. 08/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento **9.108.291**
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
16/01/2026 12:17	16/01 12:20	Nutricionista	Admissão Nutricional		Suzeane Rodrigues Dias	CRN 5965

Hash: B5B9AA6A6B38917A71D9445005831EB5

Dt. Assinatura: 16/01/2026 13:19

Documento assinado digitalmente em 16/01/2026 13:19:12, por Suzeane Rodrigues Dias CRN 5965

Avaliação: ADMISSÃO NUTRICIONAL PEDIÁTRICA

Perfil Epidemiológico : Clínico

Triagem de risco nutricional - Strongkids

Nível de Complexidade : 02 - Secundário - Monitorização 2 vezes por semana

Escore total - Intervenção Nutricional : Médio risco 1 - 3 pontos (Consultar médico para diagnóstico completo, considerar intervenção nutricional. Checar peso 2x/semana, reavaliar o risco nutricional após 1 semana)

DIAGNÓSTICO : LARINGITE+IVAS+GECA

Comorbidades : nega

1.História Nutricional Prévia : Menor em leito admitido na UI em companhia da mãe durante visita nutricional. Atualmente nutrindo se por via oral com dieta branda multiplas alergias, apetite reduzido, quadro diarreico há 3 dias, hoje 1 evacuação líquida até visita, diurese presente, sem perda de peso, sem perda de peso recente. Habitualmente realiza todas as refeições diárias sem restrições. Alimentação contempla todos os grupos dos alimentos em geral. Faz uso de nan confort 2 150ml d e3/3 horas.

Restrições Alimentares

Alergia : desconhece

Intolerância : desconhece

Ingestão Hídrica : Mais de 8 copos

Faz uso de Fórmula Infantil? : Sim

Caso Sim, Quais? : nan confort 2

Hábito Intestinal Habitual? : Regular

Hábito Intestinal Atual : Diarreia

Mobilidade Física : deambula normalmente

Pele

Hidratada : Sim

Normocorada : Sim

Abdômen : Flácido

3. Antropometria

Peso atual : 9,7kg

3.1 Diagnóstico Nutricional Conforme as Curvas da OMS

Suzeane Rodrigues Dias
CRN 5965



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 À 900

P/I : peso adequado

6. Projeto Terapêutico : Deixo dieta branda multiplas alergias - fracionada 5x/dia - atingido ;
Deixo nan sem lactpse 150ml de 3/3 horas - atingido ;
Acompanhar aceitação da dieta oral acima de 75% do ofertado - em andamento;
Acompanhar regularidade da função intestinal - em andamento
Em acompanhamento nutricional.

Suzeane Rodrigues Dias
CRN 5985



Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo: Masculino
Telefone: 98 985108882
Leito: 516

Atendimento: 9.108.291
Prontuário: 1.116.047
Dt. Entrada: 11/01/2026 08:17:29
Convênio: AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
16/01/2026 11:10	16/01 13:12	Fisioterapeuta	PEDIATRIA -		Fabio Henrique Ferreira Pereira	CREFITO 295746

Hash: 5186659E23C150890DD755354ADD432A

Dt. Assinatura: 16/01/2026 14:11

Documento assinado digitalmente em 16/01/2026 14:11:00, por Fisioterapeuta Fabio Henrique Ferreira Pereira CREFITO 295746

FISIOTERAPIA - MANHÃ

DIAGNÓSTICO MÉDICO ATUAL: Laringite + IVAS + GECA

COMORBIDADES:

1. EVOLUÇÃO NAS 24 HORAS:

Lactente segue acompanhado da mãe, desperto, reativo, pouco choroso, eupnéico, sem tiragens, com tosse seca segundo relatos da acompanhante, porém sem episódios de tosse durante conduta, congestão nasal infima.

2. AVALIAÇÃO RESPIRATÓRIA

Ausculta pulmonar: MV presente, sem ruídos adventícios

Tipo de padrão respiratório: eupnéico

Suporte ventilatório/saturação: ar ambiente

Tosse: ausente durante conduta

Outros: secreção hialina fluida em pequena quantidade

Tipo de Oxigenioterapia: não se aplica

Hora inicial:

Hora final:

PLANO DE CUIDADOS COM BASE NO PLANO TERAPÊUTICO

Fisioterapia Respiratória

- ☐ Manobras de higiene brônquica
- ☒ Manobras de reexpansão pulmonar
- ☐ Padrões de incentivo à inspiração máxima
- ☐ Incentivador Respiratório
- ☐ Oscilador oral (Shaker)
- ☐ Aspiração traqueal/VAS
- ☒ Desobstrução Rínofaríngea Retrógrada
- ☐ Outros:

4. CUIDADOS RELACIONADAS À UMIDIFICAÇÃO DE GASES RESPIRATÓRIOS:

Fabio Henrique Ferreira Pereira
Fisioterapeuta CREFITO 295746



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

- Umidificação de gases respiratórios por: Filtro HMEF (); Termoumidificação (); NA (x)
- Filtro HMEF demonstrando umidificação conforme a necessidade do paciente: SIM (); Não (); NA (x).
- Umidificação térmica otimizada (câmara umidificadora com margem de água adequada e temperatura padronizada): SIM (); NÃO (); NA (x).

5. RISCOS

		Orientações
Asesdas	(x) SIM () NÃO	
Broncoaspiração	() SIM () NÃO	

6. RECOMENDAÇÕES

- Promover higiene de VAS

Fabio Henrique Ferreira Pereira
Fisioterapeuta CREFITO 295746



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985106882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
16/01/2026 18:35	16/01 18:39	Fisioterapeuta	PEDIATRIA -		Fabio Henrique Ferreira Pereira	CREFITO 295746

Hash: D263F5EAE33087758A7A6420EAE3295

Dt. Assinatura: 16/01/2026 19:38

Documento assinado digitalmente em: 16/01/2026 19:38:05, por Fisioterapeuta Fabio Henrique Ferreira Pereira CREFITO 295746

FISIOTERAPIA - TARDE

DIAGNÓSTICO MÉDICO ATUAL: Laringite + IVAS + GECA

COMORBIDADES:

1. EVOLUÇÃO NAS 24 HORAS:

Lactente segue desperto, reativo, pouco choroso, eupnéico, sem tiragens, sem tosse durante conduta, congestão nasal infima.

2. AVALIAÇÃO RESPIRATÓRIA

Ausulta pulmonar: MV presente, sem ruídos adventícios

Tipo de padrão respiratório: eupnéico

Suporte ventilatório/saturação: ar ambiente

Tosse: ausente durante conduta

Outros: secreção hialina fluida em pequena quantidade

Tipo de Oxigenioterapia: não se aplica

Hora inicial:

Hora final:

PLANO DE CUIDADOS COM BASE NO PLANO TERAPÊUTICO

Fisioterapia Respiratória

- ☐ Manobras de higiene brônquica
- ☒ Manobras de reexpansão pulmonar
- ☐ Padrões de incentivo à inspiração máxima
- ☐ Incentivador Respiratório
- ☐ Oscilador oral (Shaker)
- ☐ Aspição traqueal/VAS
- ☒ Desobstrução Rinofaringea Retrógrada
- ☐ Outros:

4. CUIDADOS RELACIONADAS À UMIDIFICAÇÃO DE GASES RESPIRATÓRIOS:

Fabio Henrique Ferreira Pereira
Fisioterapeuta CREFITO 295746



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

- Umidificação de gases respiratórios por: Filtro HMEF (); Termoumidificação (); NA (x)
- Filtro HMEF demonstrando umidificação conforme a necessidade do paciente: SIM (); Não (); NA (x).
- Umidificação térmica otimizada (câmara umidificadora com margem de água adequada e temperatura padronizada): SIM (); NÃO (); NA (x).

5. RISCOS

			Orientações
Quedas	(x) SIM	() NÃO	
Broncoaspiração	() SIM	() NÃO	

6. RECOMENDAÇÕES

- Promover higiene de VAS

Fabio Henrique Ferreira Pereira
Fisioterapeuta CREFITO 295746





Hospital
São Domingos

Evolução Médica Pediatria

Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo: Masculino
Telefone: 98 985108882
Leito: 516

Atendimento: 9.108.291
Prontuário: 1.116.047
Dt. Entrada: 11/01/2026 08:17:29
Convênio: AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Data evolução:	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
17/01/2026 07:53	17/01 07:54	Médico(a)	Evolução Médica		Marcelo Rossany Oliveira Franco	CRM 5899

Hash:

Dt. Assinatura:

1. Diagnóstico: LARINGITE+IVAS+GECA

ADMISSÃO: CRIANÇA 10 MESES DEU ENTRADA EM GRANDE SALA COM TOSSE LADRANTE E FEBRE.

so: 9 kg

2. Alergias

3. Dias de Internação: 7 dias

4. Terapêutica atual (Antibióticos e medicações de risco):

AEROLIN 6/6H
METILPREDNISOLONA 2MG/KG/DIA
NBZ CLENIL
FLORAX

5. Evolução das Últimas 24h:

PACIENTE SEM FEBRE, TOSSE SECA ESPAÇADA
POUCA CONGESTÃO, COM SECREÇÃO HIALINA E SEM ROUQUIDÃO
MANTÉM DIARREIA - FEZES LIQUIDAS, 5X ONTEM
SEM VÔMITOS
ACEITA POUCO A DIETA
BOA DIURESE

6. Exame Físico

HIDRATADO, ATIVO, AFEBRIL, EUPNEICO, EM AA SAT 98%
REFUSAO OK
AP: MV RUDE SEM RÔNCOS
OF: HIPEREMiado SEM FOCO
ABDOMEM: TIMPÂNICO, FLACIDO, INDOLOR A PALPAÇÃO

7. Resultado dos exames importantes:

HC: LEUCO-11160 56SEG 34LT 2 ATIP PLAQ- 486MIL PCR-0,02
COPRO: RTV/HEMACIAS/EPF- NEGATIVOS

RX TORAX- ESPESSAMENTOS PB E PH

8. Programação do dia:

CONVERSO COM FAMILIARES E ESCLAREÇO DUVIDAS
REDUZO CORTICÓIDE
ASSOCIO TIORFAN E PEDIALYTE

9. Previsão de alta: 1-2 DIAS

10. Plano Terapeutico:

Marcelo R. Oliveira Franco
Pediatra
CRM-MA 5899

Marcelo Rossany Oliveira Franco
CRM 5899

Impresso em: 19/01/2026 08:

Página: 1/2

F61333388306

CATE00598



Número do documento: 26022014124998500000159866788

<https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26022014124998500000159866788>

Assinado eletronicamente por: VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - 20/02/2026 14:12:50

Num. 172684520 - Pág. 28



Evolução Médica Pediatria

HOSPITAL
São Domingos

Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

SUORTE CLINICO E NUTRICIONAL
TRATAR DOENÇA DE BASE
AVALIAR ALTA APÓS MELHORA CLINICA

11. Avaliação de Riscos/Scores:

11.1 Flebite:

11.2 Avaliação do risco de queda - Humpty Dumpty: 16 - Alto risco de queda

11.3 Avaliações de BradenQ (Lesão por pressão): 25 - Risco baixo

11.4 Avaliações do risco strokids (Risco Nutricional):

Marcelo R. Oliveira Franco
Pediatra
CRM-MA 5899

Marcelo Rossany Oliveira Franco
CRM 5899





Hospital

São Domingos



9108291

Atendimento

Hospital

São Domingos

Hospital Sao Domingos

Prescrição Eletrônica Paciente



12673776

Prescrição

Paciente	Jose Henrique da Silva Fernandes	Atendimento	9.108.291	
Data Nascto	06/03/2025 10m 11d	Convênio	AMIL / AMIL INDIVIDUAL 500	
Data Entrada	11/01/2026 08:17:29	Liberação	17/01/2026 07:51:10	
Médico Resp	Dra. Aurea Maria Borges De Moraes Arouche (CRM 4304)	Data Prescr.	17/01/2026 07:50:00	
Prescritor	Marcelo Rossany Oliveira Franco CRM - 5899	Prontuário	1.116.047	
Lib. Enferm	Marcelo Rossany Oliveira Franco CRM - 5899	Leito e Setor	516 Internação E-5	
Validade:	17/01/2026 19:00:00 18/01/2026 18:59:59	Peso	9.7	
		Dt. Assinatura		

Hash

Alergias:

OVO

Dietas	Intervalo	Horários	Observação
Branda Múltiplas Alergias	3/3 h	20:20 23:20 02:20 05:20 08:20 11:20 14:20 17:20	

Suplemen/Modul/Pediat	Intervalo	Dose	Aplicação	Vel. de Infusão
LEITE PO NAN SEM LACTOSE 400G	3/3 h	25 g	Oral	ml/h
Horários: 21 00 03 06 09 12 15 18				

Soluções

Soro Glicosado 5% 250ml inj

Velocida 9,9556 gtm

Etapas: 4

Dispositivo de infusão: Equipo macrogotas simples

Horários: das 19 às 01; das 01 às 07; das 07 às 13; das 13 às 19;

Tipo Analgesia: Dose Inicial: Dose Limite 4h: Fluxo: Dose Limite 1h: ml Bolus:

Soro Glicosado 5% 250ml inj Dose: 175 ml

Cloreto de Potassio 10% 10ml injetavel Dose: 2.7 ml

Cloreto de Sodio 20% 10ml injetavel Dose: 1.5 ml

Medicamentos	Dose	Horários
AERODINI 100 MCG/DOSE-200DOSES FR	3 jato 6/6 h Inalatória	22 04 10 16
Allegria Ped 6mg/ml susp oral 60ml	2 ml 8/8 h Oral	22 06 14 18
Administrar 2 Mililitros (8/8 h Oral)		
DipIRONA 500 MG/ML-2ML AMP TEUTO	0.4 ml SOS/SN Intravenosa	
Diluir 0,4 Mililitros do medicamento em 10 Mililitros de Agua p/ Injeção 10ml		
Administrar 10,4 Mililitros (SOS/SN Intravenosa)		
Florax Ped 5ml	1 Fr 2x Oral	20 08
Administrar 5 Mililitros (2x Oral)		
Ondansetrona 4 mg em 2 mL- inj	0.6 ml SOS/SN Intravenosa	22 08
Diluir 0,6 Mililitros do medicamento em 50 Mililitros de Soro Fisiologico 0,9% (NaCl) 50ml inj		
Administrar 50.6 Mililitros (SOS/SN Intravenosa)		
Estabilidade: 48 Horas Após diluição		
Temperatura ambiente controlada (15°C a 30°C)		
Recomendado acesso central		
PANTOCAL 4MG/ML-10ML FR/AMP EV	2.2 ml 1x ao dia Intravenosa	22 08
Reconstituir cada Frasco-ampola em 10 Mililitros de Diluente Proprio		
Diluir 2,2 Mililitros da reconstituição em 100 Mililitros de Soro Fisiologico 0,9% (NaCl) 100ml inj		

Liberação 17/01/2026 07:51:11

Página 1/2

marcelo.franco

CATE02350





Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nasc: 05/03/2025 10m 11d
Data Entrada: 11/01/2026 08:17:29
Médico Resp: Dra. Aurea Maria Borges De Moraes Arouche (CRM 4304)
Prescritor: Marcelo Rossany Oliveira Franco CRM - 5899
Lib. Enferm: Marcelo Rossany Oliveira Franco CRM - 5899
Validade: 17/01/2026 19:00:00 18/01/2026 18:59:59

Atendimento: 9.108.291
Convênio: AMIL / AMIL INDIVIDUAL 500
Liberação: 17/01/2026 07:51:10
Data Prescr: 17/01/2026 07:50:00
Prontuário: 1.116.047
Leito e Setor: 516 Internação E-5
Peso: 9,7
Dt. Assinatura:

Hash

Alergias: , CVO ,

Administrar 102,2 Mililitros (1x ao dia Intravenosa) em 1 h.

PEDIALYTE 60 ZINCO UVA 500 ML FR | 1 Fr 1x ao dia Oral

Administrar 500 Mililitros (1x ao dia Oral)

Imeticona 75mg/ml gts 15ml | 9 gts 8/8 h Oral ~~22~~ 06 14 00:30 08:30 16:30

Soro Fisiologico 0,9% (NaCl) 250ml inj | 200 ml ACM Intravenosa ACM

Administrar 200 Mililitros (ACM Intravenosa)

Tiorfan 10mg sache 1g | 2 SACHE 8/8 h Oral ~~22~~ 06 14

Uso acima de 3 meses.

UNIMEDROL 125 MG FR/AMP | 3 mg 12/12 h Intravenosa ~~21~~ 09

Reconstituir cada Frasco-ampola em 2 Mililitros de Diluente Proprio

Diluir 0,05 Mililitros da reconstituição em 10 Mililitros de Cloreto de Sodio 0,9% 10ml inj

Administrar 10,05 Mililitros (12/12 h Intravenosa) em 3 minutos

Estabilidade: 48 Horas Após reconstituição

Temperatura ambiente (15°C a 30°C)

Nebulização	Dose	Intervalo/Horário
-------------	------	-------------------

Nebulização Clenil + S.F com O²

Clenil A sol nbz 2ml

1 ml 12/12 h In ~~20 08~~

Cloreto de Sodio 0,9% 10ml inj

5 ml 12/12 h In ~~20 08~~

Nebulização c/ Adrenalina com O²

Adren 1mg/1mL inj- EPINEfrina -USO INALATORIO

3 mg SOS/SN In SN

Recomendações

Intervalo

Horários

Cabeceira do leito elevada 45° graus

Contínuo

08:20 08:20

Fisioterapia Respiratória 1x ao dia

FISIO 1X

16

Monitorização Cardíaca

Contínuo

08:20 08:20

Oximetria continua de pulso mais sensor

Contínuo

08:20 08:20

Sinais Vitais de 2/2h

2/2 h

08:20 10:20 12:20 14:20
16:20 18:20 20:20
22:20 00:20 02:20 04:20
06:20 08:20 10:20
12:20 14:20 16:20 18:20

Marcelo Rossany Oliveira Franco CRM - 5899

Liberação: 17/01/2026 07:51:11

Página 2/2

marcelo.franco

CATE02350





hospital

São Domingos

Relatório dos Parâmetros Assistenciais do Paciente

De: 17/01/2026 Até: 17/01/2026

Paciente: Jose Henrique da Silva Fernanc

Convênio: AMIL-AMIL INDIVIDUAL

Atendimento: 9108291

Data nasc: 06/03/2025 10m 13d

Setor / leito: Internação E-5 516

Prontuário: 1116047

Data entrada: 11/01/2026 08:17:29

Médico resp: Dra. Antonia de Jesus Barros

Total BH acumulado: 1355,8

Parâmetros	Un med	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	01	02	03	04	05	06	Total
17/01/2026																										
SINAIS VITAIS																										
Temp	°C					36,2							36							36						
FC	bpm					142							117							116						
FR	mm					26							33							26						
Sat O2	%					100							99							98						
Escala dor	Ponto					FLAC							FLAC							FLAC						
Ponto dor						0							0							0						
GANHOS	ml																									
Medicamento por via enteral																										
Dieta enteral																										
Água por sonda																										
Pausa Dieta Enteral																										
PERDAS	ml																									
Diurese espontânea - Volume																										
ESCALA PEWS																										
Sonda Gástrica em Sifonagem																										
BALANÇO HÍDRICO																										
Acumulado dia	ml																									

Impresso em: 19/01/2026 16:01:42

Página 1

F61333388306

WATE00155



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto 08/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 À 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
17/01/2026 11:40	17/01 11:46	Enfermeiro(a)	Evolução de		Brenda Danielly Fernandes Santos Sousa	

Hash:

Dt. Assinatura:

Avaliação: Evolução de enfermagem universal

1 - Dados da Internação :

Diagnóstico de internação : LARINGITE

Dias de hospitalização : 7

Dias no setor de cuidado : 3

Previsão de alta no plano terapêutico : 17/01/2026 09:55:00

2 - Anamnese e exame físico

Queixa atual : SEM QUEIXAS NO MOMENTO DA VISITA

Sistema neurológico

Descritivo : CRANÇA ACOMPANHADO DE SEUS PAIS, ATIVO E REATIVO NO LEITO, NEUROLOGICO COMPATIVEL COM IDADE.

CAM ICU : NA

Glasgow : .

Paciente em ventilação mecânica : Não

Avaliação do nível de sedação :

Sistema respiratório :

Padrão/Ausculta/Observações : EUPNEICO EM AR AMBIENTE, SEM DESCONFORTO RESPIRATORIO, MANTENDO BONS NIVEIS DE SATURAÇÃO

Sistema cardiovascular :

Ausculta/Hemodinâmica : NORMOCARDICA, AFEBRIL, ESTAVEL

Abdome :

Aparência/Ruidos/Observações : FLACIDO, GLOBOSO E INDOLOR A PALPAÇÃO.

Dieta e Hidratação :

Tipo de dieta / Via de administração / Status / Aceitação ou Tolerância : DIETA ORAL COM BOA ACEITAÇÃO, SEM RELATOS DE NAUSEAS E OU VOMITOS.

Paciente possui indicação de verificação do resíduo gástrico? : Não

Eliminações Tipo/Local :

Intestinais : DIARREICO

Vesicais : PRESENTE EM FRALDA DE BOM FLUXO

Mobilidade : Restrito ao leito

Pele :

Inspeção/Observação : PELE INTEGRAL, LIVRE DE DAE E LPP, ACIANOTICO, ANICTERICO, HIDRATADO

Escala de avaliação de pele : Risco baixo

Brenda Danielly Fernandes Santos Sousa



Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo: Masculino
Telefone: 98.985108882
Leito: 516

Atendimento: 9.108.291
Prontuário: 1.116.047
Dt. Entrada: 11/01/2026 08:17:29
Convênio: AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Integridade : Integra
Risco de lesão de pele? : Não
Lesão de pele? : Não
Controle de umidade I : Não
Troca :
Realizado troca de curativo? : Não
Lesão de pele/Ferida Operatória/Outras Lesões 1 :
Quantidade : ,
Lesão de pele/Ferida Operatória/Outras Lesões 2 :
Quantidade : ,
Sinais Vitais :
PA : ,
Temp : 36,2
FR : 26
FC : 142
Sat : 100
FIO2 : ,
DOR : ,
NEWS/PEWS : 0
Glicemias :
Hipoglicemia no periodo? : NÃO
Escalas :
Resultado : Resultado: Alto risco de queda - Pontuação: 15

Paciente com plaquetas < 30.000 ou RNI > 3? : NÃO
Paciente com alto risco de queda? : SIM
Ronda Assistencial : RONDA ASSISTENCIAL
Resultado : 0
Avaliação de toxicidade de quimioterapia :
Avaliação de Toxicidade? : NA

4 - Protocolos

Protocolos : Não
Central :
Central? : Não
Periférico :
Periférico? : SIM
Local : MSD
Data de punção : 16/01/2026
Obs/Conduta : OBSERVAR SINAIS FLOGÍSTICOS
Arterial :
Arterial : NÃO

6 - Outras intervenções

Brenda Danielly Fernandes Santos Sousa



Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo: Masculino
Telefone: 98 985108882
Leito: 516

Atendimento: 9.108.291
Prontuário: 1.116.047
Dt. Entrada: 11/01/2026 08:17:29
Convênio: AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 À 900

Hemotransusão : NÃO
Dálise/Hemodiálise : NÃO
Procedimento Cirúrgico : NÃO
Exames e pendências : NÃO
Outros procedimentos : NÃO

7 - Plano de Cuidados/ Round Multidisciplinar

Descritivo : VERIFICAR SINAIS VITAIS DE 6/6 HORAS
MANter BOAS PRATICAS NA PREVENÇÃO DE QUEDA, FLEBITE E BRONCOASPIRAÇÃO
MONITORAR E REGISTRAR SE ALTERAÇÕES NO PADRÃO RESPIRATÓRIO
OBSERVAR SINAIS DE DESIDRATAÇÃO
MANter CABECEIRA ELEVADA DE 30 A 45

Status : Mantido

8 - Desfecho

Desfecho : Internação mantida
Descritivo : SEGUÊ AOS CUIDADOS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

Brenda Danielly Fernandes Santos Sousa



Evolução de Enfermagem (PED)

Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo: Masculino
Telefone: 98 985106882
Leito: 516

Atendimento: 9.108.291
Prontuário: 1.116.047
Dt. Entrada: 11/01/2026 08:17:29
Convênio: AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 À 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
18/01/2026 05:39	18/01 05:39	Enfermeiro(a)	Evolução de		Ezequias Veloza Coelho	COREN 170345-ENF

Hash: 9CC5DF78D7BC58DADB461C7566A371FA

Dt. Assinatura: 18/01/2026 06:38

Documento assinado digitalmente em 18/01/2026 06:38:18, por Enfermeiro(a) UTI Ezequias Veloza Coelho COREN 170345-ENF.

Check List - Rotina Assistencial de Enfermagem

1. Paciente apresentou temperatura $\geq 37,8^{\circ}\text{C}$?

Sim (). Conduta? _____

Não (X).

2. Paciente apresentou dor intensa?

Sim (). Conduta? _____

Não (X).

3. Paciente pontuou PEWS ≥ 3 ?

Sim (). Conduta? _____

Não (X).

4. Familiar expressa forte preocupação com o estado do paciente?

Sim (). Conduta? _____

Não (X).

5. Paciente perdeu acesso venoso periférico?

Sim (). Conduta? _____

Não (X)

Ezequias Veloza Coelho
Enfermeiro(a) UTI COREN 170345-ENF



SAE - Prescrição e Diagnósticos de Enfermagem (novo)

Paciente	Jose Henrique da Silva Fernandes	Atendimento	9.108.291	Prontuário	1.116.047
Data Nascto	06/03/2025 10 Meses	Convênio	AMIL / AMIL INDIVIDUAL 500 A 900		
Data Entrada	11/01/2026 08:17:29	SAE	1169209		
Enfermeiro	Ezequias Vellozo Coelho - COREN 170345-ENF	Data SAE	18/01/2026 00:00:00	Liberação	17/01/2026 23:45:24
Setor	Internação E-5	Leito	516		
Hash:	C8F095C6E6D4E40595502B28FFBE20E6	Dt. Assinatura:	18/01/2026 00:43:53		

Documento assinado digitalmente em 2026/01/18 00:43:53, por Enfermeiro(a) UTI Ezequias Vellozo Coelho COREN 170345-ENF

Diagnósticos de enfermagem

- 1 Condição respiratória prejudicada
- 2 Obstrução de vias aéreas
- 3 Risco de Queda (PEDIATRIA)
- 4 Risco de infecção

Prescrição de enfermagem

	SN	Intervalo	Horários
1 Administrar oxigenoterapia		Padrão 3 vezes/dia	10 15 20
2 Ajustar o intervalo da terapia inalatória		Padrão 3 vezes/dia	10 15 20
3 Avaliar e registrar condição respiratória		Padrão 3 vezes/dia	10 15 20
Avaliar e registrar frequência, movimento, ritmo e esforço respiratório		Padrão 3 vezes/dia	10 15 20
5 Calcular o score de queda (Humpty dumpty)		Conf. Protoc.	23
6 Descrever características da secreção das vias aéreas		Padrão 3 vezes/dia	10 15 20
7 Elevar e manter cabeceira da cama a 30° a 45°		Contínuo	23
8 Identificar sites/fontes de infecção.		Padrão 3 vezes/dia	10 15 20
9 Manter grades elevadas e cama baixa e travada.		Contínuo	23
10 Manter vias aéreas permeáveis		Padrão 3 vezes/dia	10 15 20
11 Medir e registrar oximetria de pulso		Padrão 3 vezes/dia	10 15 20
12 Posicionar paciente adequadamente		Padrão 3 vezes/dia	10 15 20
13 Realizar higiene oral		Padrão 3 vezes/dia	10 15 20
14 Realizar nebulização		Padrão 3 vezes/dia	10 15 20
15 Realizar ronda assistencial.		6/6 h	23 05 11 17
16 Sinalizar ambientes úmidos e/ou molhados para higienização do leito.		SOS/SN	
17 Sinalizar risco de queda (colocar pulseira amarela e placa de identificação)		Conforme Protocolo Instituição	23
18 Trocar acesso venoso conforme protocolo		Conf. Protoc.	23
Verificar e anotar sinais vitais		6/6 h	23 05 11 17

Impresso em 19/01/2026 16:10:18

Enf.: Ezequias Vellozo Coelho - COREN 170345-ENF

Página 1

ezequias. / F6133338

Paciente: Jose Henrique da Silva

Internação E-5

516



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 À 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
17/01/2026 11:36	17/01 11:41	Técnico/Auxiliar Enfermagem	Anotações de		Amanda Ferreira Estrela	COREN 887762-TE

Hash: 741B14786E2A8EA34A4E85A44DF2F054

Dt. Assinatura: 17/01/2026 12:40

Documento assinado digitalmente em 17/01/2026 12:40:09, por Técnico(a) de Enfermagem Amanda Ferreira Estrela COREN 887762-TE

**RECEBO PACIENTE MENOR DE 10 MESES NO LEITO
EM COMPANHIA DE SEUS PAIS, COM ACESSO VENOSO
VERIFICO FUNCIONANTE, ACEITANDO SOMENTE A
FORMULA, NEGA FEBRE E QUEIXAS ÁLGICAS, DIURESE
PRESENTE NORMAL, EVACUAÇÃO DIARREIA HOJE POR
FRALDA, VERIFICADO SINAIS VITAIS, ADMINISTRADO
MEDICAÇÕES DE HORÁRIO, CONFORME PRESCRIÇÃO
MÉDICA, PRESTADOS TODOS CUIDADOS DA ENFERMAGEM.**

Amanda Ferreira Estrela
Técnico(a) de Enfermagem COREN 887762-TE

Impresso em: 19/01/2026 18:

Página 1/1

F61333388308

CATE00598



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Data evolução	Liberção	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
17/01/2026 18:41	17/01 18:44	Técnico de enfermagem	Anotações de		Enilde de Jesus Ferreira Santos	COREN 1258471-TE

Hash: 46C02A0111FB9543448B716282FA542B

Dt. Assinatura: 17/01/2026 19:42

Documento assinado digitalmente em 17/01/2026 19:42:58, por Enilde de Jesus Ferreira Santos COREN 1258471-TE

As 16horas recebi paciente menor, respirando espontaneamente em ar ambiente, em companhia de familiar;
Uso de dispositivo venoso;
Dieta via oral;
Eliminações em fralda
Verificado sinais vitais;
Prestado os cuidados de enfermagem;
Administrado medicações conforme prescrição medica;
As 19horas encerro cuidados sem queixas e sem intercorrências.

Enilde de Jesus Ferreira Santos
COREN 1258471-TE



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
17/01/2026 21:14	18/01 02:54	Técnico/Auxiliar Enfermagem	Anotação de		Lucimeire Costa da Silva	COREN 480885-TE

Hash: 7C28D542CD87E116B63ABD526BE8A08C

Dt. Assinatura: 18/01/2026 03:52

Documento assinado digitalmente em 18/01/2026 03:52:54, por Técnico(a) de Enfermagem Lucimeire Costa da Silva COREN 480885-TE

Avaliação: Anotação de enfermagem universal

1. Estado de recebimento

Descritivo : 19h inicio plantao paciente ativo e reativo, respirando em ar ambiente, dieta oral, na companhia de seu familiar, aferido sinais vitais, adminitrada medicações ,feito aerolin e nebulizacao de horario, prestado ocuidados da enfermagem.

2 - Escores

Houve alteração do News (maior ou igual a 1) / Pews (maior ou igual a 2) durante o plantão? : Não

3 - Dispositivo Vascular

..:

Central? : NÃO

Realizado troca/installação de conector valvulado no cateter central? : NÃO

Realizado lavagem do acesso venoso antes, entre e após cada medicação, com seringa salinizada conforme protocolo institucional de recomendações de boas práticas. : Sim

Usado quantas seringas salinizadas ? : 2

Para quais medicações foram utilizadas ? : unimedrol, pantocal

Utilizado filtro para segurança e redução de risco de infecção e flebite : NÃO

.7 :

Periférico? : SIM

Há sinais de flebite no acesso ? : NÃO

Local : msd

Data de punção : 11/01/2026

Obs/Conduta : sem flebite

Realizado troca de AVP no dia? : Não

4 - Dispositivos e equipamentos

Bota pneumática : Não

5 - Dieta

Oral : Sim

Status alimentação : Ativa

Lucimeire Costa da Silva
Técnico(a) de Enfermagem COREN 480885-TE



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108862
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

6 - Eliminações

Intestinais : Em fralda
Status : Eliminações presentes
Característica : normal
Vesicais : Em fralda
Status : Eliminações presentes
Característica : normal

7 - Higiene

Banho : No chuveiro com auxílio
Oral : Escovação com auxílio
A higiene foi realizada duas vezes? : Não
Justificativa :
Quantas vezes realizou aspiração da cavidade oral? : 0
Troca de fraldas 1 : NÃO
Troca de fraldas 2 : NÃO
Troca de fraldas 3 : NÃO
Troca de fraldas 4 : NÃO
Troca de fraldas 5 : NÃO
Glicemia :
Controle Glicêmico : Não
ID/Queda :
Resultado : Resultado: Alto risco de queda - Pontuação: 15

Mantive grades elevadas e orientei família : Sim
Chequei/orientei sobre e/ou realizei quando necessário troca de pulseiras de identificação : Sim
PACIENTE COM ALTO RISCO DE QUEDA? : Não
PAV/PNAV :
Foi realizada higiene oral pela equipe ou autocuidado : Sim
Mantive cabeceira elevada : Sim
LPP :
Realizei mudança de decúbito conforme necessário :
NA : Sim
Realizei controle de umidade na troca de fraldas : NA
Acoplei coxins necessários : NA
Realizei hidratação da pele conforme protocolo : NA
SSVV 12hs :
FC : 117
FR : 33
Dor : 0
Escala Dor : FLACC

9 - Desfecho

Lucimeire Costa da Silva
Técnico(a) de Enfermagem COREN 480885-TE





hospital
São Domingos

Anotação de Enfermagem Universal

Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 À 900

Descritivo : administrada

22h/04h aerolin
02h mae recusa allegria
036h pantocal
22h / 06h tiorfam
22h /06h simeticona
22h unimedrol
01h / 07h soro

10 - Materiais pedidos e utilizados

Descritivo : 1 equipo trocado para soro 07h
1 bureta para pantocal 06h
4 seringa dosadora

Lucimeire Costa da Silva
Técnico(a) de Enfermagem COREN 480885-TE



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108682
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 À 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
17/01/2026 12:02	17/01 12:05	Fisioterapeuta	PEDIATRIA -		Ana Caroline Silva Costa	CREFITO 136029

Hash: 970701AEA84B6A3E729ACD5ADEA6CCDC

Dt. Assinatura: 17/01/2026 13:03

Documento assinado digitalmente em 17/01/2026 13:03:28, por Fisioterapeuta Ana Caroline Silva Costa CREFITO 136029

MANHÃ

DIAGNÓSTICO MÉDICO ATUAL: Laringite + IVAS + GECA

OMORBIDADES:

1. EVOLUÇÃO NAS 24 HORAS: Lactente segue desperto, reativo, pouco choroso, eupneico, sem tiragens, sem tosse durante conduta, congestão nasal infima.

2. AVALIAÇÃO RESPIRATÓRIA

Ausculta pulmonar: MV presente, sem ruídos adventícios
Tipo de padrão respiratório: eupneico
Suporte ventilatório/saturação: ar ambiente
Tosse: ausente durante conduta
Outros: secreção hialina fluída em pequena quantidade
Tipo de Oxigenioterapia: não se aplica
Hora inicial:
Hora final:

3. PLANO DE CUIDADOS COM BASE NO PLANO TERAPÊUTICO

Fisioterapia Respiratória

- | |
|--|
| ☐ Manobras de higiene brônquica |
| ☒ Manobras de reexpansão pulmonar |
| ☐ Padrões de incentivo à inspiração máxima |
| ☐ Incentivador Respiratório |
| ☐ Oscilador oral (Shaker) |
| ☐ Aspiração traqueal/VAS |
| ☒ Desobstrução Rinofaríngea Retrograda- 4 ampolas de soro + 1 seringa 10 ml + 1 par de luvas M |
| ☐ Outros: |

4. CUIDADOS RELACIONADAS À UMIDIFICAÇÃO DE GASES RESPIRATÓRIOS:

- Umidificação de gases respiratórios por: Filtro HMEF (); Termoumidificação (); NA (x)
- Filtro HMEF demonstrando umidificação conforme a necessidade do paciente: SIM (); Não (); NA (x)
- Umidificação térmica otimizada (câmara umidificadora com margem de água adequada e temperatura padronizada); SIM (); NÃO (); NA (x)

5. RISCOS

			Orientações
Quedas	☒ SIM	☐ NÃO	
Broncoaspiração	☐ SIM	☐ NÃO	

6. RECOMENDAÇÕES

Ana Caroline Silva Costa
Fisioterapeuta CREFITO 136029



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 À 900

- Promover higiene de VAS

Ana Caroline Silva Costa
Fisioterapeuta CREFITO 136029



Paciente	Jose Henrique da Silva Fernandes			Atendimento	9.108.291	
Data Nascto	06/03/2025	10 Meses		Prontuário	1.116.047	
Sexo	Masculino			Dt. Entrada	11/01/2026 08:17:29	
Telefone	98 985108882			Convênio	AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900	
Leito	516					

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
18/01/2026 09:36	18/01 09:36	Médico(a)	Evolução Médico		Luiz Jorge Matos	CRM 1532

Hash: EC29744AB77F11CB248BE4A5C414613D Dt. Assinatura: 18/01/2026 10:35

Documento assinado digitalmente em 18/01/2026 10:35:09, por Médico(a) Luiz Jorge Matos CRM 1532

1. Data da internação: 11/01/2026 08:17:29

2. Motivo da internação:
ADMISSÃO: CRIANÇA 10 MESES DEU ENTRADA EM GRANDE SALA COM TOSSE LADRANTE E FEBRE.

3. Resumo da evolução e plano terapêutico:

PACIENTE SEM FEBRE, TOSSE SECA ESPARSA
ALTA COM RECEITA E ORIENTAÇÕES PARA DOMICILIO

4. Resultado dos principais exames:
HC: LEUCO-11160 56SEG 34LT 2 ATIP PLAQ- 486MIL PCR-0,02
COPRO: RTW/HEMACIAS/EPF- NEGATIVOS

RX TORAX- ESPESSAMENTOS PB E PH

5. Diagnóstico da alta: J04.0 Laringite aguda /

6. Orientações para a alta:RETORNO AMBULATORIAL

7. Reconciliação Medicamentosa
7.1 Medicações usadas no domicilio antes da internação: FERRO 2 gts 1x ao dia ; VITAMINA D 2 gts 1x ao dia ;
7.2 Receita atual para casa: PROBIOTICO+SINTOMATICOS

8. Necessidade de Reabilitação pós alta hospitalar:
() Fisioterapia () Psicologia () Fonoaudiologia () Nutrição () Outros:

9. Data da alta: 18012026

Luiz Jorge Matos
Médico(a) CRM 1532

Impresso em: 19/01/2026 16: Página 1/1 F61333388306 CATE00598



Relatório dos Parâmetros Assistenciais do Paciente

De: 18/01/2026 Até: 18/01/2026

Paciente: Jose Henrique da Silva Fernanc Convênio: AMIL-AMIL INDIVIDUAL Atendimento: 9108291
Data nasc: 06/03/2025 10m 13d Setor / leito: Internação E-5 516 Prontuário: 1116047
Data entrada: 11/01/2026 08:17:29 Médico resp: Dra. Antonia de Jesus Barros Total BH acumulado: 1355,8

Parâmetros	Un med	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	01	02	03	04	05	06	Total
18/01/2026																										
SINAIS VITAIS																										
Temp	°C	35,7																								
FC	bpm	109																								
FR	mm	25																								
Sat O2	%	98																								
Escala dor	Ponto	FLAC																								
Ponto dor		0																								
GANHOS	ml																									
Medicamento por via enteral																										
Dieta enteral																										
Água por sonda																										
Pausa Dieta Enteral																										
PERDAS	ml																									
Diurese espontânea - Volume																										
ESCALA PEWS																										
Sonda Gástrica em Sifonagem																										
BALANÇO HIDRICO																										
Acumulado dia	ml																									



Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo: Masculino
Telefone: 98 985108882
Leito: 516

Atendimento: 9.108.291
Prontuário: 1.116.047
Dt. Entrada: 11/01/2026 08:17:29
Convênio: AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
18/01/2026 11:09	18/01 11:10	Enfermeiro(a)	Evolução de		Natanielle Gomes Bezerra	COREN 595- 588-ENF

Hash: 1FCD104DDA5F7BACA4A1F5000F163EEC

Dt. Assinatura: 18/01/2026 12:08

Documento assinado digitalmente em: 18/01/2026 12:08:58, por Enfermeiro(a) Natanielle Gomes Bezerra COREN 595-588-ENF

Avaliação: HSD - Check List de Alta Segura

Estado Clínico

Reversão dos fatores que motivaram a internação : Sim
Condição Clínica adequada para a alta : Sim
Desfecho de Pele :
Desenvolveu lesão de pele na internação? : Não
Local : não se aplica
Etiologia : não se aplica

Exames complementares:

Orientado quanto a exames a serem realizados após a alta : Não

Orientação de alta

Realizado orientação de alta ? : Sim
Orientações : ORIENTAÇÕES PARA DOMICILIO

Educação quanto à sua doença

Sabe sobre seu diagnóstico de alta e implicações de sua doença : Sim
Orientado quanto à terapia de sua doença e reconciliação medicamentosa : Sim
Ciente das suas restrições após alta : Sim
Orientado quanto aos sinais de piora e quando deve procurar o serviço médico : Sim

Acompanhamento pós-alta

Orientado quanto à necessidade de acompanhamento ambulatorial : Não
Orientado quanto ao programa de desfecho clínico : Sim
O retorno ao médico está agendado : NA

Sumário de alta

Documento está preenchido : Sim

Natanielle Gomes Bezerra
Enfermeiro(a) COREN 595-588-ENF



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 600 A 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
18/01/2026 11:18	18/01 11:20	Técnico/Auxiliar Enfermagem	Anotação de		Francineide Cabral da Rocha	COREN 945776-TE

Hash: 9A2B308734FF0E06E6B10790C208FF0E

Dt. Assinatura: 18/01/2026 12:19

Documento assinado digitalmente em 18/01/2026 12:19:18, por Francineide Cabral da Rocha COREN 945776-TE

Avaliação: Anotação de enfermagem universal

1. Estado de recebimento

Descritivo : ÀS 07:30H RECEBO PLANTÃO COM MENOR EM REPOUSO NO LEITO EM COMPANHIA DE SUA MÃE
ACORDADO, RESPIRANDO AR AMBIENTE, DIURESE E EVACUAÇÕES PRESENTE
ACOMPANHANTE E MENOR COM PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO

ADMINISTRADO MEDICAÇÕES DE HORARIO DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO MEDICA

2 - Escores

Houve alteração do News (maior ou igual a 1) / Pews (maior ou igual a 2) durante o plantão? : Não

3 - Dispositivo Vascular

. :
Central? : NÃO
Realizado troca/instalação de conector valvulado no cateter central? : NÃO
Realizado lavagem do acesso venoso antes, entre e após cada medicação, com seringa salinizada conforme protocolo institucional de recomendações de boas práticas. : Sim
Usado quantas seringas salinizadas ? :
Para quais medicações foram utilizadas ? :
Utilizado filtro para segurança e redução de risco de infecção e flebite : NÃO
.7 :
Periférico? : SIM
Há sinais de flebite no acesso ? : NÃO
Local : MSD
Data de punção : 18/01/0202
Obs/Conduta :
Realizado troca de AVP no dia? : Não

4 - Dispositivos e equipamentos

Bota pneumática : Não

5 - Dieta

Oral : Sim

Francineide Cabral da Rocha
COREN 945776-TE



Paciente: Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto: 06/03/2025 10 Meses
Sexo: Masculino
Telefone: 98 985108882
Leito: 516

Atendimento: 9.108.291
Prontuário: 1.116.047
Dt. Entrada: 11/01/2026 08:17:29
Convênio: AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 À 900

Status alimentação : Ativa

6 - Eliminações

Intestinais : Em fralda
Status : Eliminações presentes
Característica : NORMAL
Vesicais : Em fralda
Status : Eliminações presentes
Característica : PASTOSA

7 - Higiene

Banho : No chuveiro com auxílio
Oral : Escovação com auxílio
A higiene foi realizada duas vezes? : Sim
Quantas vezes realizou aspiração da cavidade oral? : 0
Troca de fraldas 1 : NÃO
Troca de fraldas 2 : NÃO
Troca de fraldas 3 : NÃO
Troca de fraldas 4 : NÃO
Troca de fraldas 5 : NÃO
Glicemia :
Controle Glicêmico : Não
ID/Queda :
Resultado : Resultado: Alto risco de queda - Pontuação: 15

Mantive grades elevadas e orientei família : Sim
Chequei/orientei sobre e/ou realizei quando necessário troca de pulseiras de identificação : Sim
PACIENTE COM ALTO RISCO DE QUEDA? : Sim
Ronda Assistencial : PAIS ORIENTADOS
PAV/PNAV :
Foi realizada higiene oral pela equipe ou autocuidado : Não
Mantive cabeceira elevada : Sim
LPP :
Realizei mudança de decúbito conforme necessário :
Não : Sim
Realizei controle de umidade na troca de fraldas : Não
Acoplei coxins necessários : Não
Realizei hidratação da pele conforme protocolo : Não
SSVV 12hs :
FC : 109
FR : 25
Dor : 0
Escala Dor : FLACC

Francineide Cabral da Rocha
COREN 945776-TE



Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

9 - Desfecho

Descritivo : PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR

10 - Materiais pedidos e utilizados

Descritivo : .

Francineide Cabral da Rocha
COREN 945776-TE





Hospital
São Domingos

PEDIATRIA - EVOLUÇÃO FISIOTERAPIA (Respiratória)

Paciente Jose Henrique da Silva Fernandes
Data Nascto 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento 9.108.291
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 À 900

Data evolução	Liberação	Função	Tipo evolução	Especialidade	Usuário	Código prof
18/01/2026 10:53	18/01 11:58	Fisioterapeuta	PEDIATRIA -		Fabio Henrique Ferreira Pereira	CREFITO 295746

Hash: CCF7AF7598CB54D527A3CEB9F67E47363

Dt. Assinatura: 18/01/2026 12:56

Documento assinado digitalmente em 18/01/2026 12:56:50, por Fisioterapeuta Fabio Henrique Ferreira Pereira CREFITO 295746

MANHÃ

DIAGNÓSTICO MÉDICO ATUAL: Laringite + IVAS + GECA

OMORBIDADES:

1. EVOLUÇÃO NAS 24 HORAS:

Lactente segue desperto, reativo, choroso ao manejo, eupnéico, sem tiragens, sem tosse durante conduta, congestão nasal inflma.

2. AVALIAÇÃO RESPIRATÓRIA

Ausculta pulmonar: MV presente, sem ruídos adventícios

Tipo de padrão respiratório: eupnéico

Suporte ventilatório/saturação: ar ambiente

Tosse: ausente durante conduta

Outros: secreção hialina fluida em pequena quantidade

Tipo de Oxigenioterapia: não se aplica

Hora inicial:

Hora final:

3. PLANO DE CUIDADOS COM BASE NO PLANO TERAPÊUTICO

Fisioterapia Respiratória

() Manobras de higiene brônquica

(x) Manobras de reexpansão pulmonar

() Padrões de incentivo à inspiração máxima

() Incentivador Respiratório

() Oscilador oral (Shaker)

() Aspiração traqueal/VAS

(x) Desobstrução Rinofaríngea Retrógrada

() Outros:

4. CUIDADOS RELACIONADAS À UMIDIFICAÇÃO DE GASES RESPIRATÓRIOS:

• Umidificação de gases respiratórios por: Filtro HMEF () ; Termoumidificação () ; NA (x)

• Filtro HMEF demonstrando umidificação conforme a necessidade do paciente: SIM () ; Não () ; NA (x)

• Umidificação térmica otimizada (câmara umidificadora com margem de água adequada e temperatura padronizada): SIM () ; NÃO () ; NA (x)

5. RISCOS

			Orientações
Quedas	(x) SIM	() NÃO	
Broncoaspiração	() SIM	() NÃO	

Fabio Henrique Ferreira Pereira
Fisioterapeuta CREFITO 295746

Impresso em: 19/01/2026 16:

Página: 1/2

F61333388306

CATE00598



Número do documento: 26022014125076700000159868493

<https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26022014125076700000159868493>

Assinado eletronicamente por: VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - 20/02/2026 14:12:51

Num. 172685976 - Pág. 14

Paciente **Jose Henrique da Silva Fernandes**
Data Nascto. 06/03/2025 10 Meses
Sexo Masculino
Telefone 98 985108882
Leito 516

Atendimento **9.108.291**
Prontuário 1.116.047
Dt. Entrada 11/01/2026 08:17:29
Convênio AMIL AMIL INDIVIDUAL 500 A 900

6. RECOMENDAÇÕES

- Promover higiene de VAS

Fabio Henrique Ferreira Pereira
Fisioterapeuta CREFITO 295746



**AO JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS,
DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS - MA**

Processo nº 0801310-44.2026.8.10.0001

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA FERNANDES, menor impúbere, representado por seu genitor **ALESSANDRO MACIEL FERNANDES**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seu advogado signatário, declarar CIÊNCIA do acordo extrajudicial pactuado e requerer o prosseguimento do feito com a devida homologação em juízo, nos termos do artigo 725, VIII e 515, II, ambos do CPC, bem como a extinção do feito nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC.

Termos em que pede deferimento.

São Luís - MA, 29 de janeiro de 2026.

Jefferson Carneiro de Oliveira Júnior

OAB/MA 25.841



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE SÃO LUÍS/MA

PROCESSO Nº 0801310-44.2026.8.10.0001

TERMO DE ACORDO

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e JOSÉ HENRIQUE DA SILVA FERNANDES, representado por seu genitor **ALESSANDRO MACIEL FERNANDES**, devidamente representados por seus advogados infra-assinados, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar que se compuseram nesta lide, nos seguintes termos:

1. A AMIL, por mera liberalidade, confirma a obrigação de fazer deferida em sede de medida liminar, a qual já foi devidamente cumprida, conforme petição acostada aos autos sob o ID 169775042, datada de 15/01/2026, nos termos que seguem:

3.1. Ante o exposto, defiro a medida liminar pleiteada e determino que o demandado autorize e custeie integralmente a internação e todos os procedimentos necessários para a manutenção e preservação da vida do infante José Henrique da Silva Fernandes, de forma imediata, a contar da intimação desta decisão, com a garantia de tratamento e atendimento integral e especializado. 3.2. Em caso de descumprimento fixo multa diária no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, a ser revertida para o FMDCA. 3.3. Em caso de descumprimento da obrigação no prazo estipulado no item 3.1, determino o bloqueio de valores via SISBAJUD e BRBJud, em contas vinculadas ao CNPJ da parte requerida, no montante necessário para o custeio do

BRASÍLIA SÃO PAULO ARACAJU CURITIBA RECIFE



tratamento inicial de 03 (três meses), condicionado à apresentação de orçamento atualizado. 3.4. Determino a citação dos requeridos para, querendo, apresentarem contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 3.5. Dada a urgência da presente situação, esta decisão servirá como mandado judicial. 3.6. Expedientes necessários. Cumpra-se.

2. A AMIL realizará, ainda, o pagamento do valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais e de honorários advocatícios.

3. Os valores ora acordados serão depositados na conta do escritório dos patronos da Requerida, regularmente constituídos nos autos, cujos dados bancários são: Instituição bancária: Itaú Unibanco SA, Agência: 4525, Conta corrente: 51720-9, Titular: Jefferson Carneiro de Oliveira Junior, CPF: 110.611.484-16 (Chave Pix).

4. **O referido pagamento será realizado no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados do protocolo e homologação do presente termo de acordo.**

5. Declara a parte Requerida, por si e por seus patronos, que os dados bancários fornecidos na cláusula acima estão corretos. Na hipótese de eventual inconsistência dos dados bancários, a Requerida realizará o pagamento por meio de depósito judicial, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir do término do prazo originalmente estipulado para pagamento, não ensejando, em tal hipótese, a incidência de multa por inadimplemento.

6. Com o efetivo recebimento do valor acordado, a parte credora outorga à AMIL a mais ampla, plena, geral, total e irrestrita quitação, para nada mais reclamar, a qualquer título, em juízo ou fora dele.

7. A presente transação é celebrada em caráter irretratável, renunciando as partes, desde já, a qualquer recurso.

8. Diante do exposto, as partes requerem a homologação dos termos apresentados, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

BRASÍLIA SÃO PAULO ARACAJU CURITIBA RECIFE



9. Para os fins do presente acordo, consideram-se informações confidenciais todas aquelas relativas ao conteúdo, condições, valores e obrigações pactuadas neste termo, bem como às tratativas que lhe deram origem, às quais as partes tiveram acesso em razão da presente demanda, e que não sejam de domínio público.

10. As partes comprometem-se a manter absoluto sigilo sobre tais informações, abstendo-se de divulgá-las a terceiros, por qualquer meio, salvo quando exigido por lei, por determinação judicial ou para o estrito cumprimento do presente acordo, inclusive perante seus respectivos patronos e órgãos competentes.

11. Por fim, requer que todas as notificações e publicações sejam feitas em nome de **Yasmin Brehmer Handar**, advogada inscrita na **OAB/DF sob o nº 64.819**, sob pena de nulidade (art. 272, § 5º, CPC).

Termos em que pede deferimento.

(Local e data da assinatura eletrônica).

YASMIN BREHMER HANDAR

OAB/DF nº 64.819

OAB/PR nº 97.751

OAB/AP nº 5.448

OAB/SE nº 1.754A

OAB/SP nº 53.5137

BRASÍLIA SÃO PAULO ARACAJU CURITIBA RECIFE

juridico@seixasadv.com

seixasadv.com



**AO JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO
LUÍS, DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS - MA**

Processo nº 0801310-44.2026.8.10.0001

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA FERNANDES, menor impúbere, representado por seu genitor **ALESSANDRO MACIEL FERNANDES**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seu advogado signatário, apresentar:

RESPOSTA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos pelo **HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.**, o que faz nos termos que seguem:

I. BREVE SÍNTESE DOS FATOS

O autor, criança em situação de extrema vulnerabilidade e necessidade de tratamento médico urgente, ajuizou a presente ação visando assegurar seu direito fundamental à saúde e à vida, conforme garantido constitucionalmente.

A decisão liminar proferida por este digno Juízo, de forma acertada e plenamente fundamentada, deferiu a tutela antecipada determinando que o demandado autorizasse e custeasse integralmente a internação e todos os procedimentos necessários para a manutenção e preservação da vida do infante.

Irresignado, o Hospital São Domingos opôs Embargos de Declaração alegando (i) omissão quanto à individualização do demandado obrigado; e (ii) erro material por premissa fática equivocada, sustentando que ao hospital caberia apenas prestar o serviço, enquanto a autorização e custeio seriam exclusivos da operadora de plano de saúde.

II. DA AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS

2.1 Da inexistência de omissão



Contrariamente ao alegado pelo embargante, não há qualquer omissão na decisão embargada.

A decisão liminar é clara, precisa e suficientemente fundamentada, tendo determinado que o demandado autorizasse e custeasse o tratamento do autor. O uso do termo no singular não gera qualquer dúvida interpretativa, uma vez que ambos os réus são solidariamente responsáveis pela prestação de assistência à saúde do autor.

A pretensa "omissão" alegada pelo embargante não passa de tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que é vedado pela via dos embargos declaratórios, conforme pacífica jurisprudência, visto que Os embargos de declaração não se prestam ao rejugamento da causa, mas apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Portanto, a decisão judicial não precisa especificar, de forma pormenorizada, cada obrigação de cada réu quando a responsabilidade é solidária, conforme ocorre no presente caso. Trata-se de técnica processual regular e amplamente aceita.

2.2 Da inexistência de erro material ou premissa fática equivocada

O embargante alega também que a decisão teria incorrido em "*erro material por premissa fática equivocada*" ao determinar que o hospital autorizasse e custeasse o tratamento.

Tal alegação não merece prosperar.

Primeiramente, é necessário esclarecer que erro material configura-se apenas quando há equívoco evidente, manifesto e objetivo, decorrente de lapso ou descuido na transcrição de dados, datas ou informações, sem conteúdo decisório.

Sobre o tema, a jurisprudência é clara que "*O erro material, próprio a ser corrigido, de ofício ou por meio de embargos de declaração, é aquele que decorre de equívocos materiais sem conteúdo decisório ou da adoção de premissa fática manifestamente equivocada. Por outro lado, cumpre ressaltar, o inconformismo da parte com os fundamentos do julgado não constitui erro material*" (**STJ - EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.480.142 - SC (2014/0230146-2)**)



No caso em análise, não há erro material, mas sim discordância do embargante quanto ao conteúdo da decisão, o que caracteriza inequívoco inconformismo com o decidido, situação que escapa à via estreita dos embargos de declaração.

Ademais, a alegação de "premissa fática equivocada" também não se sustenta. A decisão embargada partiu de premissa correta: o autor é beneficiário de plano de saúde conveniado ao hospital embargante e necessita de tratamento médico urgente.

2.3 Da responsabilidade solidária do hospital e da operadora de plano de saúde

O cerne da questão reside em compreender que tanto o hospital quanto a operadora de plano de saúde são solidariamente responsáveis pela garantia do tratamento do paciente, especialmente quando se trata de criança ou adolescente em situação de risco.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 227:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) reforça, em seu art. 11:

Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016).

Quando o menor busca atendimento em hospital privado conveniado ao plano de saúde, estabelece-se uma cadeia de



responsabilidades que envolve tanto a operadora (que se comprometeu contratualmente a garantir a cobertura) quanto o hospital (que integra a rede credenciada e recebe diretamente o paciente).

Logo, o hospital credenciado a plano de saúde não é mero prestador passivo de serviços. Ao integrar a rede conveniada, assume obrigações perante os beneficiários, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A relação entre hospital, plano de saúde e paciente configura cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único e art. 25, § 1º, ambos do CDC), ensejando responsabilidade solidária de todos os envolvidos.

Art. 7º Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. **Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.** (grifamos)

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenuie a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1º **Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores** (grifamos)

A jurisprudência é firme neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ATENDIMENTO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE DO HOSPITAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão que condena solidariamente o hospital e o plano de saúde, com base na responsabilidade objetiva do CDC, pela



negativa indevida de atendimento, reservando o direito de regresso, não é estranha à jurisprudência desta Corte, de modo que deve ser mantida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

O hospital embargante pretende eximir-se de responsabilidade alegando que apenas "prestaria o serviço" após autorização e custeio pelo plano de saúde. Tal entendimento é manifestamente equivocado e contrário à legislação vigente. E foi justamente isso que aconteceu no presente fatídico, enquanto não houve a autorização do plano de saúde, o hospital se manteve inerte e não realizou a internação do menor.

Ademais, a Lei nº 12.653/2012 veda expressamente a exigência de caução, depósito ou qualquer forma de garantia para internação hospitalar em casos de urgência ou emergência.

No presente caso, tratando-se de criança em situação de risco que necessita de tratamento urgente, o hospital não pode condicionar o atendimento à prévia autorização da operadora, sob pena de violar direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana.

III. DO CARÁTER INFRINGENTE E PROTETÓRIO DOS EMBARGOS

Os embargos de declaração opostos pelo Hospital São Domingos não têm por objetivo sanar vícios inexistentes, mas sim rediscutir o mérito da decisão liminar, buscando modificar seu conteúdo dispositivo.

Trata-se de nítida utilização protelatória do recurso, visando postergar o cumprimento da ordem judicial e, conseqüentemente, colocando em risco a vida e a saúde do autor, uma criança.

Conforme previsto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

[...]

§2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao



embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. (grifamos).

A jurisprudência é clara quanto à caracterização de embargos protelatórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS PROTETATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC. 3. Decidida a questão em sede de decisão monocrática e agravo interno, o segundo recurso manejado com o propósito de rediscutir a matéria ostenta nítido caráter protelatório, circunstância apta a ensejar a multa de 1% sobre o valor corrigido da causa (1.026, § 2º, do Código de Processo Civil). 4. Embargos declaratórios rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1941896 SP 2021/0170337-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022).



No presente caso, resta evidente o intuito procrastinatório, uma vez que o embargante não aponta vício concreto, mas apenas manifesta discordância quanto ao conteúdo da decisão, pretendendo sua reforma.

IV. DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO

A decisão liminar proferida por este digno Juízo está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, especialmente com os princípios constitucionais da proteção integral à criança e ao adolescente e do direito fundamental à saúde.

A determinação para que o demandado (seja o hospital, seja a operadora, ou ambos solidariamente) autorize e custeie o tratamento é medida que se impõe diante da urgência do caso e da indisponibilidade do direito à vida.

Eventuais questões sobre divisão interna de responsabilidades entre hospital e operadora de plano de saúde não podem ser opostas ao paciente, tampouco podem servir de obstáculo ao seu direito de receber atendimento médico adequado.

Como bem observa a doutrina:

"A discussão sobre quem deve arcar com os custos do tratamento - se o hospital ou a operadora - é questão a ser resolvida entre eles, não podendo prejudicar o paciente, que é parte hipossuficiente na relação de consumo." (NUNES, Rizzatto. Curso de Direito do Consumidor. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 567).

V. DO REQUERIMENTO

Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência:

- a)** O conhecimento da presente resposta, por tempestiva e regular;
- b)** A rejeição integral dos Embargos de Declaração opostos pelo Hospital São Domingos Ltda., por ausência dos vícios alegados (omissão e erro material os premissa fática equivocada);



- c) A manutenção integral da decisão liminar embargada, reconhecendo-se sua correção, clareza e adequação ao caso concreto;
- d) A condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em percentual a ser arbitrado por Vossa Excelência;
- e) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessário algum esclarecimento, que seja mantida a determinação de autorização e custeio do tratamento, **esclarecendo-se apenas que tanto o Hospital quanto a Operadora de Plano de Saúde são solidariamente responsáveis pela prestação da assistência médica ao autor, podendo qualquer um deles ser compelido ao cumprimento integral da obrigação, sem prejuízo do direito de regresso entre si.**

Termos em que pede deferimento.
São Luís – MA, 26 de janeiro de 2026.

Rodrigo César Altenkirch Borba Pessoa

OAB/MA nº 6.127

Jefferson Carneiro de Oliveira Júnior

OAB/MA nº 25.841

João Gabriel Dias da Silva

OAB/MA nº 25.618





Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
1ª Vara da Infância e da Juventude de São Luís

Processo nº. 0801310-44.2026.8.10.0001-PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: ALESSANDRO MACIEL FERNANDES e outros

ADVOGADO: Advogado do(a) AUTOR: JEFFERSON CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MA25841
Advogado do(a) REPRESENTANTE LEGAL: JEFFERSON CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MA25841

RÉU: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

ADVOGADO: Advogado do(a) REU: YASMIN BREHMER HANDAR - PR97751
Advogado do(a) REU: VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - MA4749-A

ATO ORDINATÓRIO

(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, art. 1º, Inciso XIII, da CGJ/MA)

Em virtude das atribuições que me são conferidas por Lei, e em obediência ao que dispõe o art. 93, inciso XIV da Constituição Federal, art. 203 § 4º do CPC e no Provimento nº. 22/2018-CGJ, art. 1º, Inciso XIII, INTIMO a parte Embargada, por intermédio do seu procurador, para que, apresente(m) a sua resposta à Embargos de Declaração, no prazo prazo legal.

São LUÍS/MA, Segunda-feira, 26 de Janeiro de 2026

Datado e assinado digitalmente



AO JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SÃO LUÍS - MARANHÃO**Processo nº 0801310-44.2026.8.10.0001**

HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA., inscrito no CNPJ sob o nº 11006293000130, com sede nesta Capital, na Avenida Jeronimo de Albuquerque, 540, CEP: 65060-645, por seus advogados ao final assinados, com endereço profissional na Avenida Nina Rodrigues, nº 09, Qd. 09, Sala 304B, Torre 1, Edifício Lagoa Corporate, Ponta D'Areia, CEP. 65077-300, também nesta cidade, onde requer sejam enviadas eventuais intimações e/ou notificações, vem, perante Vossa Excelência, com fulcro no art. 1.022, inciso III, do CPC, opor

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO***com efeitos infringentes***

em face da decisão liminar deste Juízo (ID 169486445), constatando a **presença de omissão e erro material – premissa fática equivocada**, o que faz pelos motivos a seguir expostos.

DA TEMPESTIVIDADE

Considerando que a citação do Hospital, para cumprir a decisão liminar e contestar a ação se deu através do domicílio eletrônico e que houve registro de ciência em 14/01/2026, data em que os prazos processuais estavam suspensos devido ao recesso forense (art. 220 do COC/15), o prazo de 05 dias úteis para opor embargos de declaração teve início no primeiro dia útil após o fim do recesso, a saber 21/01/2026 e tem como termo final o dia 27/01/2026.

Assim, protocolados os presentes declaratórios nesta data, são os mesmos indiscutivelmente tempestivos.

DA OMISSÃO E DA PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA IDENTIFICADAS NA DECISÃO

(Da determinação para o Hospital autorizar e custear o tratamento do autor, que é encargo de responsabilidade exclusiva do plano de saúde)



Consoante se observa da decisão liminar proferida pelo Juízo o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor foi deferido nos seguintes termos:

“(...) III. Comando judicial

3.1. Ante o exposto, defiro a medida liminar pleiteada e determino que o demandado autorize e custeie integralmente a internação e todos os procedimentos necessários para a manutenção e preservação da vida do infante José Henrique da Silva Fernandes, de forma imediata, a contar da intimação desta decisão, com a garantia de tratamento e atendimento integral e especializado. (...)”.

Conforme se verifica do teor da decisão, foi determinado “AO DEMANDADO” que autorizassem e custeassem **integralmente a internação e todos os procedimentos necessários para a manutenção e preservação da vida do paciente.**

Inicialmente, verifica-se ter a decisão liminar deixado, data venia, de individualizar qual seria “O demandado” a quem a obrigação de fazer foi importa. Sendo assim, de logo, identifica-se tal omissão, mostrando-se necessário o esclarecimento de para qual parte requerida o Juízo determinou a obrigação de autorizar e custear a internação e demais procedimentos indicados ao paciente.

Além disso, a se considerar que o Juízo tenha imposta obrigação para os dois demandados, ou seja, para a operadora de saúde e também para o hospital, identifica-se ter a decisão liminar incorrido ainda, *permissa venia*, em erro material por premissa fática equivocada.

Isto porque, considerando que o autor buscou a realização do tratamento junto ao Hospital, **na condição de beneficiário de plano de saúde conveniado, a decisão liminar deveria ter individualizado a obrigação de cada um dos requeridos**, e não conferido também ao hospital determinação de autorizar e custear internação e demais procedimento, já que **ao Hospital, como prestador do serviço PARTICULAR, cabe APENAS promover a realização do procedimento; e ao Plano de Saúde, o qual mantém vínculo de assistência médica com o usuário, é que cabe conceder a autorização/cobertura e custeio aos procedimentos e seus materiais especiais.**

Não é encargo e tampouco obrigação do Hospital autorizar tratamento de beneficiários de convênio. **O Hospital atua como mero prestador do serviço, promovendo a realização do procedimento/internação/tratamento.**

Ora, se o hospital é o mero prestador do serviço, é incoerente e desarrazoado impor ao nosocômio que ele autorize e custeie serviço que ele próprio ofertará ao paciente. Ou seja,



além do encargo que o nosocômio assume de prestar a assistência ao paciente, não é justo que o mesmo hospital arque com as despesas geradas em função do serviço que ele próprio ofertou. Se o paciente busca o atendimento na condição de beneficiário de plano de saúde conveniado, como é o caso dos autos, ó óbvio que tanto a autorização como o pagamento das despesas devem ser feitos pela operadora de saúde, por ser dela, exclusivamente, esse ônus.

Reitera-se que a conduta do Hospital em submeter o paciente ao procedimento **fica atrelada à autorização e custeio do convênio**.

Ao Hospital, frisa-se, caber ATENDER e submeter o paciente ao procedimento, às **expensas do plano de saúde**, após autorização do *tratamento médico pela Operadora*.

Ao impor a obrigação de internação ao Hospital, o Juízo, *data venia*, além de incorrer em premissa fática equivocada, **desloca da competência e responsabilidade da operadora de saúde um encargo que é exclusivo dela**, fato que pode inclusive gerar prejuízos financeiros irreversíveis para o hospital, à medida que **a operadora de saúde pode se eximir do pagamento das despesas hospitalares (que também são de sua responsabilidade) ao argumento de que o Juízo determinou que o custeio do tratamento fosse feito também pelo hospital**.

Destarte, outra não pode ser a conduta desse juízo, *data venia*, senão pela reforma da decisão com o consequente esclarecimento no sentido de **individualizar as obrigações de cada um dos requeridos**:

- a) para a operadora de saúde, **AUTORIZAR E CUSTEAR todo o tratamento indicado ao paciente**;
- b) para o Hospital, **submeter o autor ao tratamento solicitado, assim que autorizado pelo convênio**.

Além disso, requer seja acolhido o pleito de não aplicação de multa direcionada ao Hospital São Domingos, posto que não houve descumprimento por parte do nosocômio.

CONCLUSÃO

DO EXPOSTO, requer que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para que seja eliminado o erro material (premissa fática equivocada) apontado, para que seja individualizada as obrigações de cada um dos requeridos, a fim de que não seja aplicada multa ao Hospital por descumprimento que foi ocasionado exclusivamente pelo convênio: a) para



a operadora de saúde, AUTORIZAR E CUSTEAR todo o tratamento indicado ao paciente, inclusive autorizar e custear os OPMEs necessários para a realização do procedimento; b) para o Hospital, submeter o autor ao tratamento solicitado, assim que autorizado pelo convênio.

Nestes termos, pede deferimento.

São Luís/MA, 26 de janeiro de 2026.

Valéria Lauande Carvalho Costa
OAB/MA 4.749

Luciana Maria Chaves Mendes Rego
OAB/MA 4.979



SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, com reservas, nas pessoas dos advogados **MILENA FURTADO AMORIM**, OAB/MA nº. 13.134, **LUCIANA MARIA CHAVES MENDES REGO**, OAB/MA nº 4.979, **ANA LETÍCIA GUIMARÃES DE QUEIROZ**, OAB/MA 13.315 e **MATHEUS MEDEIROS LEAL**, OAB/MA nº 22.581, todos com endereço profissional na Avenida Nina Rodrigues, nº 09, Qd. 09, Salas 304A e B, Torre 1, Edifício Lagoa Corporate, Ponta D'Areia, CEP. 65077-300 nesta cidade, os poderes que me foram outorgados por **HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.**, para atuar nos processos judiciais em trâmite no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em qualquer instância, incluindo Juizados Especiais, bem como em demandas administrativas perante o Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão (PROCON/MA).

São Luís (MA), na data do protocolo.

Valéria Lauande Carvalho Costa
OAB/MA 4.749



SUBSTABELECIMENTO

Pelo presente instrumento particular, SUBSTABELEÇO, com reserva de poderes, **ANA AMÉLIA FIGUEIREDO DINO DE CASTRO E COSTA**, inscrita na OAB/MA sob o nº 5.517; **SÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA JÚNIOR**, inscrito na OAB/MA sob o nº 5.227; **VALÉRIA LAUANDE CARVALHO COSTA**, inscrita na OAB/MA sob o nº 4.749; **ANNALISA SOUSA SILVA CORREIA**, inscrita na OAB/MA sob o nº 7.170; **LUANA OLIVEIRA VIEIRA**, inscrita na OAB/MA sob o nº 8.437; sócios do escritório profissional **DINO, FIGUEIREDO & LAUANDE ADVOCACIA**, pessoa jurídica registrada na OAB/MA sob o nº 131, com sede na Rua Nina Rodrigues, nº 9, Ed. Lagoa Corporate, Torre 1, Sala 304, Ponta D'Areia, CEP.: 65.077-300, São Luís, Maranhão/MA, os poderes que me foram conferidos por **HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.**, inscrito no CNPJ sob o nº **11.006.293/0001-30**, Específicos para representar as **Outorgantes e filiais: (i)** no foro em geral, com a cláusula ad judicium et extra, representando as Outorgantes e filiais perante qualquer órgão da administração, Juízo, Instância ou Tribunal, inclusive Tribunal Arbitral, por mais especializados que sejam, com poderes para propor contra quem de direito as demandas competentes e defendê-la nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando para tanto de todos os recursos legais e processuais, acompanhando-os até final instância; **(ii)** praticar todos e quaisquer atos processuais, em qualquer demanda judicial, arbitral ou administrativa em que as Outorgantes seja autora, ré, assistente ou oponente; **(iii)** requerer, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito em que se funda a pretensão e/ou demanda; **(iv)** receber valores ou efetuar levantamento de alvarás judiciais, somente mediante cheque nominal às Outorgantes ou mediante crédito diretamente realizado na conta corrente das Outorgantes, em Banco por ela indicado; **(v)** dar quitação, firmar acordos ou compromissos, tudo com referência não só à demanda principal, como também à reconvenção ou a quaisquer medidas cautelares, típicas ou atípicas, preventivas ou incidentais, e, ainda, nomear a autoria, denunciar a lide e chamar ao processo, e ajuizar ações rescisórias dos julgados; **(vi)** extrajudicialmente, representar as Outorgantes, também perante quaisquer pessoas jurídicas de direito público, federais, estaduais ou municipais, seus órgãos, Ministérios, Secretarias, desdobramentos e repartições de qualquer natureza, autarquias, entidades paraestatais, empresas públicas ou de economia mista, Juntas Comerciais, Receita Federal do Brasil e suas delegacias regionais, Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional de Seguridade Social, sindicatos de qualquer grau ou natureza, Delegacia do Trabalho, ou onde com esta se apresentarem, podendo, para tanto, requerer e retirar o que preciso for em proveito dela, defendendo-a, tomando vista em quaisquer processos administrativos e recorrendo de quaisquer despachos; **(vii)** assinar cartas de preposição, requerimentos, notificações, bem como receber intimações e outros documentos relativos à processos judiciais e



administrativos; e **(viii)** podendo assinar todos os documentos necessários a concretização dos negócios aqui estabelecidos.

São Paulo, 24 de janeiro de 2025.

DocuSigned by:
Rafael Gormezano
EC088063F679459...
Rafael Gormezano
OAB/SP 257.106

DocuSigned by:
Alessandra de Lima Penido
47DDEE754798455...
Alessandra de Lima Penido
OAB/SP 284.381

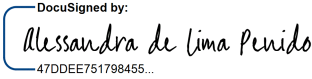


Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 39A19D47-14FA-49E8-97DB-B9CBCA2B74BB		Status: Concluído
Assunto: Complete com o Docusign: Subs 2025 - Hospital São Domingos - DFL.doc		
Hospital:		
Envelope fonte:		
Documentar páginas: 2	Assinaturas: 2	Remetente do envelope:
Certificar páginas: 2	Rubrica: 0	Ana Beatriz Rodrigues de Andrade
Assinatura guiada: Ativado		Endereço: AV JURUA, 434
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado		Barueri, 06.455-010
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília		aandrade@redeimpar.com.br
		Endereço IP: 177.82.133.28

Rastreamento de registros

Status: Original	Portador: Ana Beatriz Rodrigues de Andrade	Local: DocuSign
24/01/2025 12:05:45	aandrade@redeimpar.com.br	

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Alessandra de Lima Penido alessandra.penido@dasa.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by:  47DDEE751798455... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 191.39.153.38 Assinado com o uso do celular	Enviado: 24/01/2025 12:07:24 Visualizado: 26/01/2025 22:31:51 Assinado: 26/01/2025 22:32:29 Assinatura de forma livre
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign		
Rafael Gormezano rafael.gormezano@dasa.com.br Gerente Jurídico Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by:  EC088063F679459... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 189.3.142.202	Enviado: 24/01/2025 12:07:23 Visualizado: 24/01/2025 14:36:38 Assinado: 24/01/2025 14:37:01 Assinatura de forma livre
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign		

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	24/01/2025 12:07:24
Entrega certificada	Segurança verificada	24/01/2025 14:36:38



Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Assinatura concluída	Segurança verificada	24/01/2025 14:37:01
Concluído	Segurança verificada	26/01/2025 22:32:29
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora



**PROCURAÇÃO JURÍDICA
(GRUPO DASA)**

OUTORGANTES:

- 1. ALIANÇA BIOTECNOLOGIA LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Rua Conselheiro Tobias, nº 57, Zona 04, CEP 87.014-270, Maringá/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 08.284.269/0001-59, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 2. AMO HBA – ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR EM ONCOLOGIA LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1541, Hospital da Bahia, Bloco A, 1º Subsolo, Bairro Pituba, CEP 41810-011, inscrita no CNPJ sob o nº 04.054.849/0001-07, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 3. AMO ILHEUS - ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR EM ONCOLOGIA DE ILHEUS LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Ilhéus, Estado da Bahia, na Avenida Soares Lopes, nº 1266, Bairro Cidade Nova, CEP 45652-065, inscrita no CNPJ sob o nº 17.180.725/0001-01, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 4. AMO OESTE – ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR EM ONCOLOGIA LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Barreiras, Estado da Bahia, na Rua 19 de Maio, nº 187, Bairro Centro, CEP 47800-240, inscrita no CNPJ sob o nº 36.104.614/0001-60, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 5. AMO PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima fechada com sede na Rua Libero Badaró, n.º 293, 21º andar, conj. 21D, sala 89, CEP 01.009-000, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 24.164.970/0001-90, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 6. AMO RECÔNCAVO – ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR EM ONCOLOGIA DO RECÔNCAVO LTDA. - SCP**, sociedade em conta de participação com sede na Avenida Barros e Almeida, nº 406, sala 15, Centro, Cidade Santo Antônio de Jesus, Estado da Bahia, CEP 44571-013, inscrita no CNPJ sob o nº 31.286.380/0001-04, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 7. AMO RECÔNCAVO – ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR EM ONCOLOGIA DO RECÔNCAVO LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Avenida Dois de Julho, nº 96, 3º piso do Itaguari Shopping Center, Day Hospital, Bairro Ernesto Melo, Cidade de Santo Antônio de Jesus, Estado da Bahia, CEP 44440-900, inscrita no CNPJ sob o nº 14.328.622/0001-58, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 8. AMO SUDOESTE LTDA. - SCP**, sociedade em conta de participação com sede na Avenida Otavio Santos, nº 227, sala 813 a 818, bairro Recreio, Cidade Vitória da Conquista, Estado da Bahia, CEP 45020-210, inscrita no CNPJ sob o nº 40.811.989/0001-38, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 9. AMO SUDOESTE LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, na Avenida Oitavo Santos, nº 227, Salas 813 a 818, Bairro Recreio, CEP 45020-210, inscrita no CNPJ sob o nº 29.203.873/0001-83, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 10. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR ASSUNÇÃO S.A.**, sociedade anônima fechada com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, nº 2.229, 10º andar, Bairro Santa Cecília, CEP 01227-904, inscrita no CNPJ sob o nº 31.394.343/0001-0102.506.315/0001-30, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 11. ASSOCIAÇÃO INSTITUTO ILUMINE**, associação com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 1º andar, sala 06, Bairro Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 34.957.392/0001-01, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 12. BIODÍNAMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 19.623.257/0001-28, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua da Glória, nº 676, Bairro Liberdade, CEP 01510-000, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 13. CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Rua Jaguaruna, nº 105, Campo Grande, CEP 23.080-160, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 33.756.768/0001-49, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 14. CEDIPAR - CENTRO DE DIAGNÓSTICO PARANÁ LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Avenida Doutor Luiz Teixeira Mendes, 1.929, CEP 87015-021, inscrita no CNPJ sob o nº 03.755.354/0001-34, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;



**PROCURAÇÃO JURÍDICA
(GRUPO DASA)**

- 15. CENTRO DE DIAGNÓSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA.**, sociedade limitada com sede na Rua Baixa Verde, nº 409, Bairro Derby, Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, CEP 52010-250, inscrita no CNPJ sob o nº 12.857.736/0001-60, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 16. CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Rua Padre Pedro Pinto, nº 382, 1º ao 6º andar, Venda Nova, CEP 31.610-000, Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 42.785.345/0001-48, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 17. CENTRO DE ONCOLOGIA CLÍNICA DO RN S.A.**, sociedade anônima fechada com sede na Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, na Rua Ciro Monteiro, nº 1177, Tirol, CEP 59.022-370, inscrita no CNPJ sob o nº 02.150.342/0001-13, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 18. CENTRO DE TOMOGRAFIA POR COMPUTADOR LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Rua Peixoto Gomide, 625, 5º andar, Jardim Paulista, CEP 01.409-001, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 48.887.152/0001-84, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 19. CENTRO ESPECIALIZADO DE CITOLOGIA LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Rua Fiovarante Milanez, nº 50, loja 1, nº 52, loja 2, nº 58, salas 304 e 307, Bairro Centro, Cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 92010-240, inscrita no CNPJ sob o nº 89.949.176/0001-06, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 20. CENTRO MÉDICO JAGUARUNA LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Rua Jaguaruna, nº 105, Anexo, Parte, Campo Grande, CEP 23.080-160, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 31.416.126/0001-75, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 21. CENTRON – CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça de Botafogo, nº 228, salas 1004 a 1008, Bairro Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ sob o nº 02.864.097/0001-06, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 22. CIENTÍFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Alameda Caiapós, nº 84, Tamboré, CEP 06.460-110, Barueri/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.539.279/0001-37, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 23. CLÍNICA ARAGUAIA S.A.**, sociedade anônima fechada com sede na Alameda Araguaia, nº 943, lojas 02 e 03, Alphaville Industrial, CEP 06.455-000, Barueri/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 65.699.670/0001-93, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 24. CLÍNICA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E GINECOLÓGICA LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Praça Colombo, nº 52, Rio Vermelho, CEP 41.940-396, Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o nº 15.219.546/0001-05, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 25. CLÍNICA DE RESSONÂNCIA E MULTI-IMAGEM PETRÓPOLIS LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Dr. Nelson de Sá Earp, nº 95, salas 05, 06, 07, 08 e 09 do Shopping Center Bauhaus, Bairro Centro, CEP 25620-003, inscrita no CNPJ sob o nº 07.153.845/0001-66, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 26. CLÍNICA INTEGRADA HOMO LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Rua Campo do Brito, nº 1056, Bairro São José, Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, CEP 49015-460, inscrita no CNPJ sob o nº 32.771.537/0001-41, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 27. CLÍNICA RADIOLÓGICA MARTINS E GODOY LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Rua Padre Pedro Pinto, nº 382, subsolo, Venda Nova, CEP 31.610-000, Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 18.271.866/0001-00, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 28. CLÍNICA SOLUÇÃO MÉDICA LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Avenida São Luís Rei de França, n.º 8, Turu, Loja Rio Anil Shopping Center – Lunc 1093, 1095, 1096, piso L1, CEP 65.065-470, São Luís/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.058.733/0001-64, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 29. CON – ONCOLOGIA, HEMATOLOGIA, CENTRO DE INFUSÃO LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida



**PROCURAÇÃO JURÍDICA
(GRUPO DASA)**

Presidente Roosevelt, nº 900, Bairro São Francisco, CEP 24360-066, inscrita no CNPJ sob o nº 00.437.007/0001-75, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;

30. CPCLIN - CENTRO DE PESQUISAS CLÍNICAS LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Avenida Angélica, nº 2.162, Bairro Consolação, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01228-200, inscrita no CNPJ sob o nº 05.597.318/0001-15, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;

31. CRC SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA., sociedade empresária limitada inscrita com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Estrada da Liberdade, nº 408, Bairro da Liberdade, CEP 40375-016, inscrita no CNPJ sob o nº 14.683.538/0001-52, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;

32. CSHF - CONVÊNIO SAÚDE HOSPITAL PARANÁ LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, Rua das Camélias, nº 32, Bairro Jardim Guaporé, CEP 87060-154, inscrita no CNPJ sob o nº 03.755.354/0001-34, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;

33. BENEFÍCIOS ACESSÍVEIS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Avenida Juruá, nº 434, sala C, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav, CEP 06.455-010, Barueri/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 37.681.703/0001-32, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;

34. DASA REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Avenida Juruá, nº 434, Sala B, Alphaville, CEP 06.455-010, Barueri/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 08.158.019/0001-72, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;

35. DIAGNÓSTICO DAS AMÉRICAS S.A., sociedade anônima aberta com sede na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, CEP 06.455-010, Barueri/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 61.486.650/0001-83, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;

36. ELCORDIS CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LTDA. EPP, sociedade empresária limitada com sede na Rua Portugal, nº 368, Glória, CEP 32.340-010, Contagem/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 00.388.550/0001-20, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;

37. FERNANDO HENRIQUES PINTO JUNIOR & CIA LTDA., sociedade empresária limitada com sede social na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua Visconde de Inhaúma, nº 1.546, Bairro Higienópolis, CEP 14025-100, inscrita no CNPJ sob o nº 00.750/852/0001-04, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;

38. GEM ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA. - SCP, sociedade em conta de participação com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Conselheiro Pedro Luiz, nº 189, Bairro Rio Vermelho, CEP 41950-610, inscrita no CNPJ sob o nº 22.759.254/0001-20, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;

39. GEM ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPECIALIZADA S.A., sociedade anônima fechada com sede na Rua Conselheiro Pedro Luiz, 189, consultório 03, Rio Vermelho, Salvador/BA, CEP 41.950-610, inscrita no CNPJ sob o nº 13.420.617/0001-08, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;

40. GENERA SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Avenida Paulista, nº 1.439, salas 103 e 104, Edifício Mario Wallace Simonsen Cochrane, Bela Vista, CEP 01.311-926, São Paulo-SP, inscrita no CNPJ sob o nº 12.841.848/0001-22, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;

41. HBA S.A. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - SCP - 04, sociedade em conta de participação com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Tancredo Neves, nº 1541, Bairro Pituba, CEP 41820-021, inscrita no CNPJ sob o nº 30.588.653/0001-02, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;

42. HBA S/A ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR, sociedade anônima fechada com sede na Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1.541, Blocos A, B e C, Número de Porta 1.609, Bloco D, Pituba, CEP 41.810-011, Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.469.172/0001-22, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;

43. HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CRISTÓVÃO DA GAMA S.A., sociedade anônima fechada com sede na Avenida Doutor Erasmo, nº 18, Bairro VI. Assunção, Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, CEP 09030-010, inscrita no CNPJ sob o nº 57.482.903/0001-73, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;

44. HOSPITAL LEFORTE LIBERDADE S.A., sociedade anônima fechada com sede na Rua Galvão Bueno, nº 257, 1º andar, Liberdade, CEP 01.506-000, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 21.371.777/0001-32, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;



**PROCURAÇÃO JURÍDICA
(GRUPO DASA)**

- 45. HOSPITAL LEFORTE S.A.**, sociedade anônima fechada com sede na Rua dos Três Irmãos, nº 121, sala 01, Vila Progredior, CEP 05.615-190, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 19.803.199/0001-14, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 46. HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Avenida Jerônimo de Albuquerque, nº 540, Bairro Cohama, Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, CEP 65060-645, inscrita no CNPJ sob o nº 11.006.293/0001-30, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 47. ICA - INSTITUTO DO CÂNCER DE ALAGOINHAS LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Alagoinhas, Estado da Bahia, na Rua Conselheiro Couto, nº 204, Bairro Centro, CEP 48005-130, inscrita no CNPJ sob o nº 14.875.945/0002-42, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 48. ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.**, sociedade anônima fechada com sede na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 5º andar/parte, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05.425-905, inscrita no CNPJ sob o nº 60.884.855/0001-54, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 49. INNOVA HOSPITAIS ASSOCIADOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 08.729.864/0001-50, com sede na Cidade de Diadema, Estado de São Paulo, na Rua São Joaquim, nº 57, Bairro Centro, CEP 09911-020, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 50. INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – DASA (ICT – DASA)**, instituto com sede na Rua Alvorada, 64, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04550000, complemento: Sala: 82, inscrito no CNPJ sob o nº 12.504.029/0001-90, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 51. INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE S.J.R. PRETO LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Rua Cila, 3.104, Redentora, CEP 15.015-800, São José do Rio Preto/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 59.846.154/0001-41, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 52. INSTITUTO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA DA BAHIA LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Rua Marquês de Caravelas, 355, Térreo, Barra, CEP 40.140-241, na Cidade de Salvador, no Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 14.987.838/0001-25, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 53. ITULAB – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE ITU LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Rua Joaquim Bernardes Borges, nº 203, térreo 213, Bairro Centro, Cidade de Itu, Estado de São Paulo, CEP 13300-025, inscrita no CNPJ sob o nº 54.337.670/0001-27, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 54. LAB HORMON – LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM DOSAGENS HORMONAIS LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Avenida Dom Pedro II, nº 193, Bairro Jardim, CEP 09080-110, inscrita no CNPJ sob o nº 51.122.232/0001-53, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 55. LABORATÓRIO BIOCLÍNICO MS LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Rua Padre João Crippa, nº 1.018, Bairro Centro, Cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, CEP 79002-380, inscrita no CNPJ sob o nº 01.563.691/0001-02, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 56. LABORATÓRIO CHROMATOX LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Rua Havaí, 549, Sumaré, CEP 01.259-000, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 14.877.243/0001-17, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 57. LABORATÓRIO DAIRTON MIRANDA LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Avenida Bernardo Monteiro, nº 918, 2º andar, Santa Efigênia, CEP 30.150-283, Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 20.968.327/0001-69, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 58. LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA SÃO CAMILO LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Rua das Camélias, nº 12, Bairro Zona 05, Cidade de Maringá, Estado do Paraná, CEP 87080-340, inscrita no CNPJ sob o nº 05.992.718/0001-25, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 59. LABORATÓRIO EXAME DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Rua Joaquim Nabuco, nº 1050, sala 01, Bairro Centro, Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 93310-002, inscrita no CNPJ nº 91.687.376/0001-71, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;



**PROCURAÇÃO JURÍDICA
(GRUPO DASA)**

- 60. LABORATÓRIO NOBEL S.A.**, sociedade anônima fechada com sede na Rua Pinto Bandeira, nº 357, Salas 33 e 24, Centro, CEP 90.030-150, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 92.818.954/0001-24, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 61. LABORATÓRIO PADRÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Mauá, Estado de São Paulo, na Rua Princesa Izabel, nº 121, Bairro Vila Bocaina, CEP 09310-010, inscrita no CNPJ sob o nº 59.983.973/0001-30, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 62. LABORFASE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, Rua das Bandeiras, nº 29, Bairro Jardim, CEP 09090-780, inscrita no CNPJ sob o nº 43.326.206/0001-19, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 63. LSM PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Avenida do Contorno, nº 9797, apto. 320, Distrito Padro, CEP 30.110-067, Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 26.596.992/0001-55, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 64. LUNAV - ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Rua Aquidaban, nº 697, Bairro Centro, Cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 96200-480, inscrita no CNPJ sob o nº 00.202.369/0001-87, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 65. MANTRIS - GESTÃO EM SAÚDE CORPORATIVA LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 11.633, Bairro Brooklin Paulista, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04578-901, inscrita no CNPJ sob o nº 19.381.564/0001-40, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 66. MARIMED SERVIÇOS MÉDICOS S.A.**, sociedade anônima fechada com sede na Avenida Dr. Luiz Teixeira Mendes, nº 1.929, Bairro Zona 09, Cidade de Maringá, Estado do Paraná, CEP 87015-000, inscrita no CNPJ sob o nº 77.265.361/0001-94, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 67. MARINGÁ MEDICINA NUCLEAR LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, Rua Santos Dumont, nº 3452, Bairro Zona 01, CEP 87013-050, inscrita no CNPJ sob o nº 00.237.540/0001-93, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 68. MEDICINA NUCLEAR CONTAGEM LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Rua Portugal, nº 368, 2º andar, Bairro da Glória, CEP 32340-010, inscrita no CNPJ sob o nº 14.150.662/0001-52, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 69. MO HOLDING S.A.**, sociedade anônima fechada com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 11.633, 7º andar, Bairro Brooklin Paulista, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04578-000, inscrita no CNPJ sob o nº 19.437.400/0001-97, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 70. NAVEGANTES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima fechada com sede na Rua Anfilóbio de Carvalho, nº 29, grupos 801 e 802, Centro, CEP 20.030-901, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 24.786.753/0001-32, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 71. NEURO IMAGENS LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, nº 540, Cohama, CEP 65.060-645, inscrita no CNPJ sob o nº 63.402.689/0001-09, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 72. NOSSA SENHORA DO CARMO PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima fechada com sede na Rua Jaguaruna, nº 105, Parte, Campo Grande, CEP 23.080-160, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 38.248.384/0001-39, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 73. ONCO HEMATOS S.A.**, sociedade anônima fechada com sede na Rua Itabaiana, nº 945, Bairro São José, Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, CEP 49015-100, inscrita no CNPJ sob o nº 03.091.003/0001-76, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 74. ONCOBAHIA SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DE ONCOLOGIA LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia, na Avenida Getúlio Vargas, nº 844, Cond. Meddi Center, 3º e 5º pavimentos, Bairro Centro, CEP 44001-496, inscrita no CNPJ sob o nº 04.603.755/0001-31, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;



**PROCURAÇÃO JURÍDICA
(GRUPO DASA)**

- 75. PAQUETÁ PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima fechada com sede na Rua Alcindo Guanabara, 25, sala 1804, Centro, CEP 20.031-130, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 29.517.209/0001-09, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 76. PATOLOGIA CLÍNICA DR. GERALDO LUSTOSA CABRAL LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Carijós, nº 150, 6º andar, salas 801, 803, 805 e 806, Bairro Centro, CEP 30120-060, inscrita no CNPJ sob o nº 21.516.281/0001-00, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 77. PHD – PATOLOGIA, HISTOLOGIA, DIAGNÓSTICO E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Madre Cabrini, nº 43, Bairro Vila Mariana, CEP 04020-000, inscrita no CNPJ sob o nº 03.302.453/0001-60, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 78. PREVILAB ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Avenida Independência, nº 910, Bairro Alto, Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 13419-155, inscrita no CNPJ sob o nº 01.417.248/0001-15, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 79. RUGGERI & PIVA LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Rua Santos Dumont, nº 3.430, Bairro Zona 01, CEP 87013-050, inscrita no CNPJ sob o nº 75.309.237/0001-58, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 80. SALOMÃO E ZOPPI SERVIÇOS MÉDICOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, com sede na Rua Cubatão, nº 587, 2º andar, conjuntos 21, 22 e 23, Edifício Maj. Offices, Bairro Vila Mariana, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04013-042., inscrita no CNPJ sob o nº 45.796.554/0001-85, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 81. SANTA CELINA GESTÃO DE INFORMAÇÕES LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Praça Professor José Lannes, nº 40, 13º andar, conjunto 131, Bairro Cidade Monções, CEP 04571-100, inscrita no CNPJ sob o nº 11.803.316/0001-38, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 82. SANTA CELINA PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima fechada com sede na Rua Edson, nº 11, sala 03, Campo Belo, CEP 04.618-030, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 31.394.343/0001-01, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 83. SÃO MARCOS - SAÚDE E MEDICINA DIAGNÓSTICA S.A.**, sociedade anônima fechada com sede na Rua Pará de Minas, nº 1.035, 1.059, Bairro Minas Brasil, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30730-440, inscrita no CNPJ sob o nº 16.740.086/0001-29, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 84. SAÚDE SANTA CELINA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.**, sociedade anônima fechada com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Angélica, nº 2.229, 10º andar, Bairro Santa Celina, CEP 01227-904, inscrita no CNPJ sob o nº 10.257.164/0001-52, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 85. UNI TOM – UNIDADE DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADORIZADA LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Avenida Doutor Luiz Teixeira Mendes, nº 1.929, Bairro Zona Armazém, CEP 87015-021, inscrita no CNPJ sob o nº 79.696.753/0001-33, neste ato representada na forma dos seus documentos societários;
- 86. VALECLIN LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, Avenida Comendador de Vicente Paulo Penido, nº 184, Bairro Parque Residencial Aquarius, CEP 12246-856, inscrita no CNPJ sob o nº 50.008.812/0001-51, neste ato representada na forma dos seus documentos societários; e,
- 87. INNOVA REAL ESTATE EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade unipessoal empresária limitada, com sede na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 1º andar, sala 102ª, Edifício WTORRE Nações Unidas, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05.425-905, inscrita no CNPJ sob o nº 57.845.036/0001-93, neste ato representada na forma dos seus documentos societários.

todas as **OUTORGANTES** acima qualificadas são controladas, direta ou indiretamente, por **DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.** e possuem, dentre os seus representantes legais, os Diretores abaixo assinados, todos dotados de poderes de representação de acordo com os respectivos atos societários das **OUTORGANTES**.



**PROCURAÇÃO JURÍDICA
(GRUPO DASA)**

OUTORGADOS: NELCINA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA TROPARDI, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 22.644.247-0, expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 158.075.798-79; **JOSÉ EDUARDO ANDREOZZI**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.988.263-9 e inscrito no CPF sob o nº 132.560.558-18 e na OAB SP 118.256; **ALESSANDRA DE LIMA PENIDO**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 43.984.592-0, expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 336.920.668-48; **DANIELA MARIA SILVA VITALE HERNANDES**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 45.034.608-0, expedida pela SSP/SP e inscrita na OAB/SP sob o nº 327.662 e no CPF sob o nº 332.846.838-28; **LUCIANA CRISTINA DA SILVA**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade nº 38488387, expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 162.796.428-28; e **RAFAEL GORMEZANO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 33487252-2, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 317.999.968-32; todos com endereço comercial na cidade e estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 7.815, 1º andar, Pinheiros, CEP 05.425-070.

PODERES: Específicos para representar as Outorgantes e filiais: **(i)** no foro em geral, com a cláusula ad judicia et extra, representando as Outorgantes e filiais perante qualquer órgão da administração, Juízo, Instância ou Tribunal, inclusive Tribunal Arbitral, por mais especializados que sejam, com poderes para propor contra quem de direito as demandas competentes e defendê-la nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando para tanto de todos os recursos legais e processuais, acompanhando-os até final instância; **(ii)** praticar todos e quaisquer atos processuais, em qualquer demanda judicial, arbitral ou administrativa em que as Outorgantes seja autora, ré, assistente ou opoente; **(iii)** requerer, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito em que se funda a pretensão e/ou demanda; **(iv)** receber valores ou efetuar levantamento de alvarás judiciais, somente mediante cheque nominal às Outorgantes ou mediante crédito diretamente realizado na conta corrente das Outorgantes, em Banco por ela indicado; **(v)** dar quitação, firmar acordos ou compromissos, tudo com referência não só à demanda principal, como também à reconvenção ou a quaisquer medidas cautelares, típicas ou atípicas, preventivas ou incidentais, e, ainda, nomear a autoria, denunciar a lide e chamar ao processo, e ajuizar ações rescisórias dos julgados; **(vi)** extrajudicialmente, representar as Outorgantes, também perante quaisquer pessoas jurídicas de direito público, federais, estaduais ou municipais, seus órgãos, Ministérios, Secretarias, desdobramentos e repartições de qualquer natureza, autarquias, entidades paraestatais, empresas públicas ou de economia mista, Juntas Comerciais, Receita Federal do Brasil e suas delegacias regionais, Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional de Seguridade Social, sindicatos de qualquer grau ou natureza, Delegacia do Trabalho, ou onde com esta se apresentarem, podendo, para tanto, requerer e retirar o que preciso for em proveito dela, defendendo-a, tomando vista em quaisquer processos administrativos e recorrendo de quaisquer despachos; **(vii)** assinar cartas de preposição, requerimentos, notificações, bem como receber intimações e outros documentos relativos à processos judiciais e administrativos; e **(viii)** podendo assinar todos os documentos necessários a concretização dos negócios aqui estabelecidos.

FORMA DE REPRESENTAÇÃO: As Outorgantes serão representadas sempre em conjunto, sendo: (i) qualquer 02 (dois) Outorgados em conjunto; ou (ii) qualquer dos Outorgados em conjunto com 01 (um) Diretor Estatutário das Outorgantes.

Os Outorgados poderão praticar todos e quaisquer atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, sempre no melhor interesse das Outorgantes e em conformidade com: (i) a legislação aplicável, (ii) os atos societários das Outorgantes e (iii) as políticas e normas públicas e internas das Outorgantes, com as quais os Outorgados declaram conhecer e concordar, ficando exclusivamente responsáveis, civil e criminalmente, pelos atos praticados no âmbito do presente mandato, bem como por eventuais perdas e danos causados às Outorgantes pelo uso indevido dos poderes ora outorgados. Ficam automaticamente revogados: (i) todos os instrumentos anteriores que outorgam poderes idênticos aos especificados no presente instrumento e (ii) os poderes aqui conferidos aos Outorgados que se desligarem do quadro de funcionários das Outorgantes. **Esta procuração poderá ser substabelecida, com ou sem reserva de poderes.**



**PROCURAÇÃO JURÍDICA
(GRUPO DASA)**

PRAZO DE VALIDADE: esta procuração é válida até **30 de junho de 2025**, exceto para os poderes de **representação judicial que não possuem prazo de validade ou que poderão vigorar pela integralidade do prazo de existência da demanda judicial em questão**, conforme permitido nos atos societários das Outorgantes.

São Paulo, 23 de dezembro de 2024.

The diagram illustrates the 10 Outorgantes (granting entities) of the SINAES system, arranged in two rows of five. Each entity is represented by a box containing its name, a brief description of its role, and a small graphic of a green arrow pointing right.

- Outorgante 1:** **Ministério da Educação (MEC)**
Órgão central do Poder Executivo federal, responsável pela formulação e implementação das políticas públicas da educação.
Atua em todas as etapas do processo avaliativo.
- Outorgante 2:** **Conselho Nacional de Educação (CNE)**
Órgão colegiado de assessoramento ao MEC, responsável por emitir pareceres e recomendações sobre a educação superior.
Atua em todas as etapas do processo avaliativo.
- Outorgante 3:** **Conselho Nacional de Avaliação da Educação Superior (CNAES)**
Órgão colegiado de assessoramento ao CNE, responsável por emitir pareceres e recomendações sobre a avaliação da educação superior.
Atua em todas as etapas do processo avaliativo.
- Outorgante 4:** **Conselho Nacional de Avaliação da Educação Superior (CNAES)**
Órgão colegiado de assessoramento ao CNE, responsável por emitir pareceres e recomendações sobre a avaliação da educação superior.
Atua em todas as etapas do processo avaliativo.
- Outorgante 5:** **Conselho Nacional de Avaliação da Educação Superior (CNAES)**
Órgão colegiado de assessoramento ao CNE, responsável por emitir pareceres e recomendações sobre a avaliação da educação superior.
Atua em todas as etapas do processo avaliativo.
- Outorgante 6:** **Conselho Nacional de Avaliação da Educação Superior (CNAES)**
Órgão colegiado de assessoramento ao CNE, responsável por emitir pareceres e recomendações sobre a avaliação da educação superior.
Atua em todas as etapas do processo avaliativo.
- Outorgante 7:** **Conselho Nacional de Avaliação da Educação Superior (CNAES)**
Órgão colegiado de assessoramento ao CNE, responsável por emitir pareceres e recomendações sobre a avaliação da educação superior.
Atua em todas as etapas do processo avaliativo.
- Outorgante 8:** **Conselho Nacional de Avaliação da Educação Superior (CNAES)**
Órgão colegiado de assessoramento ao CNE, responsável por emitir pareceres e recomendações sobre a avaliação da educação superior.
Atua em todas as etapas do processo avaliativo.
- Outorgante 9:** **Conselho Nacional de Avaliação da Educação Superior (CNAES)**
Órgão colegiado de assessoramento ao CNE, responsável por emitir pareceres e recomendações sobre a avaliação da educação superior.
Atua em todas as etapas do processo avaliativo.
- Outorgante 10:** **Conselho Nacional de Avaliação da Educação Superior (CNAES)**
Órgão colegiado de assessoramento ao CNE, responsável por emitir pareceres e recomendações sobre a avaliação da educação superior.
Atua em todas as etapas do processo avaliativo.



HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.

CNPJ/MF nº 11.006.293/0001-30

NIRE 21.2.0014781-9

24ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.884.855/0001-54, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.028, 8º andar, conjunto 81, Bairro Bela Vista, CEP 01310-200, com seu Estatuto Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.3.0002082-1, neste ato representada por seus Diretores **Rogério Reis de Castro**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 113165955, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 070.805.897-38, e **Gustavo dos Santos Fernandes**, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/DF sob o nº 016558 e no CPF/MF sob o nº 024.328.784-42, ambos com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2.028, 8º andar, conjunto 81, Bairro Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01310-200, ambos com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2.028, 8º andar, conjunto 81, Bairro Bela Vista, CEP 01310-200 ("**ÍMPAR**"); única sócia do **HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.**, sociedade limitada com sede na Avenida Jeronimo de Albuquerque, nº 540, Bairro Cohama, Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, CEP 65060-645, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.006.293/0001-30, e registrada perante a Junta Comercial do Estado do Maranhão ("**JUCEMA**") sob o NIRE 21.2.0014781-9 ("**Sociedade**"); resolve alterar e consolidar o contrato social da Sociedade, de acordo com as seguintes disposições:

1. CISÃO PARCIAL E REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

1.1. A única sócia aprova, sem quaisquer ressalvas, a cisão parcial da Sociedade com a versão da parcela cindida de seu patrimônio para a ÍMPAR ("**Cisão Parcial**"), nos termos do "Protocolo e Justificação de Cisão Parcial do Hospital São Domingos Ltda. com Incorporação da Parcela Cindida pela ÍMPAR", celebrado pela administração da Sociedade e da ÍMPAR ("**Cindenda**"), cuja cópia integra a presente alteração contratual na forma do Anexo I.

1.2. Ato contínuo, a sócia ratifica a nomeação e a contratação da APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, CEP 20.021-290, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.681.365/0001-30, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob nº 005112/O-9, devidamente representada pelo seu perito/sócio ora nomeado, LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA, portador do CREA/RJ sob o nº 89100165-5, inscrito no CPF sob o nº 886.681.937-91, e inscrito no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 118.236/P-0 ("**Empresa Avaliadora**"), responsável pela avaliação a valor contábil da parcela cindida do patrimônio líquido da Sociedade



HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.

CNPJ/MF nº 11.006.293/0001-30

NIRE 21.2.0014781-9

24ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

cindida e cindenda pela ÍMPAR, com base no balanço patrimonial da Sociedade levantado em 31 de janeiro de 2024 ("Parcela Cindida"), bem como pela elaboração do respectivo laudo de avaliação ("Laudo de Avaliação").

1.3. A única sócia aprova ainda o Laudo de Avaliação, cuja cópia consta do Anexo 8.5 ao Protocolo e Justificação.

1.3.1. A Parcela Cindida a ser incorporada pela Cindenda é composta, única e exclusivamente, por ativo imobilizado de titularidade da Sociedade conforme descrito no Anexo 5.1 do Protocolo e Justificação.

1.3.2. Nos termos do Laudo de Avaliação, o valor total líquido contábil da Parcela Cindida corresponde ao montante total de R\$ 32.433.747,76 (trinta e dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos).

1.3.3. As variações patrimoniais relativas à Parcela Cindida ocorridas entre a Data-Base e a presente data serão absorvidos exclusivamente pela Cindenda.

1.4. A única sócia aprova a Cisão Parcial, de acordo com os termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação, conforme descrito no Anexo 5.1 e considerando a sua aprovação pela acinista da Cindenda.

1.4.1. Nos termos do §1º do art. 229 da Lei das S.A., a Cindenda sucederá a Sociedade, a título universal e sem solução de continuidade, em todos os elementos patrimoniais de titularidade da Sociedade e integrantes ou relacionados à Parcela Cindida.

1.4.2. Nos termos do parágrafo único do art. 233 da Lei das S.A., a Cindenda será responsável exclusivamente pelos elementos patrimoniais que lhe forem expressamente transferidos neste ato, sem qualquer solidariedade com a Sociedade.

1.4.3. Nos termos da Cláusula 6.2 do Protocolo e Justificação, consignar que a Operação acarretará a redução do capital social da Sociedade, no valor total de R\$ 32.433.747,00 (trinta e dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e quarenta e sete reais), desprezando-se os centavos da Parcela Cindida, com o cancelamento de



HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.

CNPJ/MF nº 11.006.293/0001-30

NIRE 21.2.0014781-9

24ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

32.433.747 (trinta e dois milhões, quatrocentas e trinta e três mil, setecentas e quarenta e sete) quotas de emissão da Sociedade, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real).

1.4.4. A Cisão Parcial não resultará na extinção da Sociedade, que continuará existindo, sem qualquer solução de continuidade.

1.5. Ademais, a única sócia ratifica os atos praticados pelos administradores da Sociedade no presente instrumento e autoriza a realização de todas as medidas necessárias à implementação da Cisão Parcial, incluindo as diligências perante quaisquer entidades públicas e privadas competentes.

2. CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

2.1. Em face das deliberações tomadas nos itens acima, a sócia, neste ato, decide alterar a Cláusula 5ª e consolidar o Contrato Social, que passa a vigor, a partir desta data, com a seguinte nova redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO

HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.

CNPJ/MF nº 11.006.293/0001-30

NIRE 21.2.0014781-9

Capítulo I. Denominação, Sede, Objeto e Duração

Cláusula 1ª. A Sociedade Limitada Unipessoal terá a denominação de **HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.**, sendo regida por este Contrato Social e pelas disposições da Lei nº 10.406/02, aplicáveis a este tipo societário.

Cláusula 2ª. A Sociedade tem sede na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, nº 540, Bairro Cohama, CEP 65160-642 e poderá, por deliberação da administração, constituir e encerrar filiais, em qualquer parte do País ou no exterior.

Parágrafo Único. A sociedade possui as seguintes filiais:

- (i) Avenida Jerônimo de Albuquerque, nº 540, anexo Cardiologia, Bairro Cohama, Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, CEP 65060-645, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.006.293/0002-11 e na JUCEMA sob o NIRE 21.9.0015577-6;



HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.

CNPJ/MF nº 11.006.293/0001-30

NIRE 21.2.0014781-9

24ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

- (ii) Avenida Contorno Norte, nº 145, Shopping Passeio, Térreo, Lojas 125 e 141, Bairro Cohatrac IV, Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, CEP 65054-375, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.006.293/0005-64 e na JUCEMA sob o NIRE 21.9.0026235-1;
- (iii) Estrada de São José de Ribamar, nº 1000, ROD.MA 201, KM 05, Lojas 164-C, 164-D, 165, 165-A, 166 e 167, Shopping Pátio Norte, Bairro Saramanta, Cidade de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, CEP 65110-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.006.293/0006-45 e na JUCEMA sob o NIRE 21.9.0026402-8;
- (iv) Avenida dos Holandeses, nº 200, Golden Shopping, Loja 42 A, Bairro Calhau, Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, CEP 65071-380, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.006.293/0007-26 e na JUCEMA sob o NIRE 21.9.0029259-5;
- (v) Estrada de Ribamar, nº 1000, KM 05, ROD.MA 201, Lojas 03 e 170, Bairro Saramanta, Cidade de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, CEP 65110-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.006.293/0008-07 e na JUCEMA sob o NIRE 21.9.0032481-1;
- (vi) Avenida São Luís de França, nº 8, Rio Anil Shopping Center, Anexo LUC N. 1093 – PISO L, Bairro Turu, Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, CEP 65065-470, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.006.293/0009-98 e na JUCEMA sob o NIRE 21.9.0032482-9; e,
- (vii) Avenida São Luís de França, nº 8, Rio Anil Shopping Center, Anexo LUC N. 1094 – PISO L1, Bairro Turu, Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, CEP 65065-470, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.006.293/0010-21 e na JUCEMA sob o NIRE 21.9.0032480-2.

Cláusula 3ª. A Sociedade tem por objeto social: (i) o exercício da atividade de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; (ii) atividade de ressonância magnética; (iii) serviços de complementação diagnóstica e terapêutica (exames de função pulmonar, espirometria oxigenoterapia); (iv) serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizantes, exceto ressonância magnética; (v) serviços de diagnóstico por registro gráfico – ECG, EEG e outros exames análogos; (vi) serviços de diagnóstico por métodos ópticos – endoscopia e outros exames análogos; (vii) atividade médica ambulatorial restrita a consultas; (viii) atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; e (ix) serviços de vacinação e imunização humana.

Cláusula 4ª. O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.



HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.

CNPJ/MF nº 11.006.293/0001-30

NIRE 21.2.0014781-9

24ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Capítulo II. Capital Social

Cláusula 5ª. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 12.797.340,00 (doze milhões, setecentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta reais), representado por 12.797.340 (doze milhões, setecentas e noventa e sete mil, trezentas e quarenta) quotas, com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente detidas pela única sócia, **ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.**

Parágrafo Único. A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, que responde pela integralização do capital social, nos termos do Artigo 1.052, Parágrafo 1º, do Código Civil, incluído pela Lei nº 13.874/19.

Capítulo III. Administração

Cláusula 6ª. A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta por um Diretor Presidente e os demais Diretores sem Designação Específica, embora possam vir a adotar denominações pertinentes às suas funções, conforme vier a ser estabelecido na sua eleição, observadas as atribuições constantes deste Contrato Social.

Parágrafo 1º. Os Diretores, que deverão ser residentes e domiciliados no Brasil, serão eleitos e destituídos em Alterações do Contrato Social, ou ainda em instrumento específico em apartado que, devidamente arquivado perante a Junta Comercial do Estado da sede da Sociedade, servirá como prova suficiente de sua nomeação e capacidade.

Parágrafo 2º. Os Diretores serão eleitos pelo prazo de 3 (três) anos, sendo possível sua renúncia ou destituição a qualquer tempo, devendo, necessariamente, ser formalizada em documento escrito assinado pelo referido Diretor.

Parágrafo 3º. Compete aos Diretores a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes a esse fim, incluindo o dever de zelar pela observância da lei e deste Contrato Social, bem como pelo cumprimento das deliberações tomadas nas Reuniões dos Sócios, dispondo, entre outros poderes, dos necessários para:

- (i) a aprovação das contas da administração;
- (ii) administrar, gerir e superintender os negócios sociais no âmbito do objeto social;
- (iii) expedir regimentos internos, regulamentos e outras normas da mesma natureza no tocante à administração da Sociedade;



HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.

CNPJ/MF nº 11.006.293/0001-30

NIRE 21.2.0014781-9

24ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

(iv) distribuir, entre os seus membros, as funções de administração da Sociedade, observadas as disposições deste Contrato Social e outras que venham a ser decididas pelos sócios; e

(v) outorgar mandatos em nome da Sociedade, observada a forma de representação prevista no Contrato Social.

Parágrafo 4º. O Diretor Presidente terá por atribuições superintender as atividades de administração da Sociedade, coordenando e supervisionando as atividades dos membros da Diretoria.

Parágrafo 5º. Competirá aos Diretores sem Designação Específica a prática dos atos que vierem a ser estabelecidos pelo Diretor Presidente, respondendo pelas decisões relativas à sua respectiva área de competência, observados os limites deste Contrato Social e das normas internas.

Parágrafo 6º. A Sociedade será representada (a) por quaisquer 2 (dois) Diretores em conjunto; ou (b) por um Diretor e um procurador nomeado com poderes específicos; ou, ainda, (c) por um ou mais procuradores, observado o disposto no Parágrafo 8º abaixo.

Parágrafo 7º. As procurações serão outorgadas em nome da Sociedade por quaisquer 2 (dois) Diretores em conjunto. As procurações outorgadas deverão especificar os poderes e terão prazo de validade limitado ao máximo de 3 (três) anos. As procurações para fins de representação judicial ou para fins de representação perante as repartições aduaneiras, Receita Federal, Secretarias Estaduais da Fazenda, Prefeituras, INSS, FGTS, Delegacias Regionais do Trabalho, Delegacias de Polícia, órgãos de proteção e defesa do consumidor, dentre outros órgãos públicos, excepcionalmente, a Sociedade poderá ser representada de forma isolada, por qualquer Diretor ou qualquer procurador, desde que devidamente constituído na forma deste Contrato Social. Apenas as procurações para fins de representação judicial serão outorgadas sem limitação do prazo de validade.

Parágrafo 8º. A administração da Sociedade será exercida, nos termos deste Capítulo, pelos Srs. (i) Diretor Presidente: **Rogério Reis de Castro**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 113165955, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 070.805.897-38; (ii) Diretor Financeiro: **Murilo Faria Mariani**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº



HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.

CNPJ/MF nº 11.006.293/0001-30

NIRE 21.2.0014781-9

24ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

352255596, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 348.364.918-27; (iii) Diretora de Governança Clínica: **Gláucia Andrade e Silva Palácio**, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12950001999-6, expedida pela SSP/MA, inscrita no CPF/MF sob o nº 529.054.543-34; (iv) Diretores sem designação específica: (a) **Marcelino da Cunha Machado Neto**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade RG nº 039204582010-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 790.901.337-04; (b) **Leonardo Modesti Vedolin**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 4036073999, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 682.787.720-53; e (c) **Maria José Martinez Fernandez Campos**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 8460351, expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 073.280.738-70; todos com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Bairro Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-010.

Cláusula 7ª. É expressamente vedada a sócia, aos Diretores, aos empregados e aos procuradores da Sociedade, contraírem obrigações de qualquer natureza, em nome da Sociedade, em operações estranhas ao seu objeto social, sendo tais atos considerados nulos e sem efeito com relação à Sociedade.

Capítulo IV. Deliberações Sociais

Cláusula 8ª. As deliberações sociais serão tomadas por decisão da sócia que ocorrerá, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social da Sociedade para (a) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o resultado econômico da Sociedade; (b) designar administradores, quando for o caso; e (c) tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim exigirem.

Parágrafo 1º. A Sociedade poderá, mediante deliberação da sócia, levantar balanços mensais, trimestrais ou semestrais e distribuir os lucros neles evidenciados.

Parágrafo 2º. O lucro apurado, depois de feitas as deduções previstas em lei, terá a destinação que for dada pela sócia, representante da totalidade do capital social.

Parágrafo 3º. As deliberações a respeito das matérias abaixo listadas dependerão de aprovação da sócia, além das matérias que, nos termos da lei, dependem de autorização de sócios: (i) operações de fusão, cisão ou incorporação; (ii) alteração no objeto social que implique mudança substancial nas atividades desempenhadas pela Sociedade; (iii)



HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.

CNPJ/MF nº 11.006.293/0001-30

NIRE 21.2.0014781-9

24ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

celebração ou alteração de contratos, acordos, entendimentos ou transações entre a Sociedade e pessoas físicas ou jurídicas que, direta ou indiretamente, vierem a participar de seu capital social; (iv) celebração ou alteração de contratos cujo objeto seja avaliado em montante igual ou superior a 1% do Patrimônio Líquido (PL) da sociedade controladora ou a R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), prevalecendo o de menor valor; (v) a renúncia de direitos, celebração ou alteração de contratos, acordos, entendimentos e transações entre a Sociedade e/ou sociedades em que detenha participação societária; e (vi) pedido de recuperação, judicial ou extrajudicial, autofalência ou, ainda, o início de processo de dissolução, liquidação ou extinção da Sociedade.

Parágrafo 4º. As operações devem estar em conformidade com o capital social da Companhia vigente à época dos fatos, garantindo a preservação da estrutura financeira da empresa. Qualquer transação que ultrapasse os limites estabelecidos requererá aprovação prévia por Reunião de Sócios, conforme definido neste contrato social.

Capítulo V. Cessão e Transferência de Quotas

Cláusula 9ª. As quotas da Sociedade são indivisíveis e poderão ser cedidas, transferidas, alienadas, caucionadas ou gravadas, em favor de terceiros, devendo ainda serem observadas outras deliberações que vierem a ser tomadas por escrito pela sócia a respeito da transferência de quotas da Sociedade.

Capítulo VI. Liquidação da Sociedade

Cláusula 10ª. Em caso de liquidação ou dissolução da Sociedade, o liquidante será nomeado pela sócia. Neste caso, os ativos deverão ser utilizados para pagar todas as dívidas da Sociedade. No caso de haver ativo remanescente, este deverá ser destinado à sócia.

Capítulo VII. Disposições Gerais

Cláusula 11. A nulidade, no todo ou em parte, de qualquer disposição deste Contrato Social não afetará a validade ou exequibilidade de qualquer outra disposição ou parte deste Instrumento.

Cláusula 12. Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.

Cláusula 13. Toda e qualquer controvérsia oriunda deste instrumento ou a ele de qualquer forma relacionada, inclusive quanto a sua existência, validade, cumprimento, interpretação e extinção, será definitivamente resolvida pelo juízo da Comarca da Capital do Estado do Maranhão.



HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.
CNPJ/MF nº 11.006.293/0001-30
NIRE 21.2.0014781-9

24ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

E, assim, assinam o presente instrumento, eletronicamente, dispensando-se assinaturas físicas, em conformidade com a legislação aplicável.

São Luís, 31 de maio de 2024.

Sócia:

Ímpar Serviços Hospitalares S.A. Rogério Reis de Castro	Ímpar Serviços Hospitalares S.A. Gustavo dos Santos Fernandes
---	---



ID - 18794

PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE CISÃO PARCIAL DO
HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.
COM INCORPORAÇÃO DA PARCELA CINDIDA PELA
ÍMPAR SERVIÇOS HOSPÍTALARES S.A.

30 DE MAIO DE 2024



**PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE CISÃO PARCIAL DO HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.
COM INCORPORAÇÃO DA PARCELA CINDIDA PELA
ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.**

- (i) **HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.006.293/0001-30, com sede na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, nº 540, Bairro Cohama, CEP 65.160-642, neste ato representada na forma de seu Contrato Social por seus administradores **Rogério Reis de Castro**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 113165955, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 070.805.897-38, e **Leonardo Modesti Vedolin**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade nº 63945910, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 682.787.720-53, ambos com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2.028, 8º andar, conjunto 81, Bairro Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01310-200 ("Cindida" ou "Hospital São Domingos"); e
- (ii) **ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.884.855/0001-54, com sede na Cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2028, 8º andar, conjunto 81, Bela Vista, CEP 01.310-200, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social por seus Diretores **Rogério Reis de Castro**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 113165955, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 070.805.897-38, e **Gustavo dos Santos Fernandes**, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/DF sob o nº 016558 e no CPF/MF sob o nº 024.328.784-42, ambos com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2.028, 8º andar, conjunto 81, Bairro Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01310-200, ambos com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2.028, 8º andar, conjunto 81, Bairro Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01310-200 ("Cindenda" ou "Ímpar").

CONSIDERANDO QUE:

(a) a Cindida é, nesta data, sociedade empresária limitada e tem por objeto social, (i) o exercício da atividade de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; (ii) atividade de ressonância magnética; (iii) serviços de complementação diagnóstica e terapêutica (exames de função pulmonar, espirometria oxigenoterapia); (iv) serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizantes, exceto ressonância magnética; (v) serviços de diagnóstico por registro gráfico – ECG, EEG e outros exames análogos; (vi) serviços de diagnóstico por métodos ópticos – endoscopia e outros exames análogos; (vii) atividade médica ambulatorial restrita a consultas; (viii) atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; e (ix) serviços de vacinação e imunização humana;

(b) a Cindenda é, nesta data, sociedade por ações de capital fechado que tem por objeto



social a) prestação de assistência hospitalar; atendimento médico e ambulatorial nas suas instalações; servir de campo de aperfeiçoamento de médicos, enfermeiros e outros profissionais relacionados a essas atividades; proporcionar meios para a pesquisa e investigação científica; (b) atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares e também restrita a consultas; atenção ambulatorial não especificadas anteriormente; serviços de quimioterapia e radioterapia; atividades de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente; (c) atividades de enfermagem; de profissionais da nutrição; psicologia e psicanálise; fisioterapia; terapia ocupacional; fonoaudiologia; terapia alternativa; acupuntura; terapia de nutrição enteral e parenteral; profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente; (d) serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos; por métodos óticos; por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia; laboratórios clínicos; laboratórios de anatomia patologia e citologia; (e) atividades de atendimento hospitalar, pronto socorro e unidade hospitalares práticas integrativas e complementares em saúde humana; reprodução humana assistida; odontológica; serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências; UTI móvel; serviços de vacinação e imunização humana; (f) a participação em outras sociedades, empresárias ou não empresárias, voltadas à área da saúde, na qualidade de sócia; e (g) atividade de pesquisas clínicas, relacionadas à pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais.

(c) a Cindida, observados determinados termos e condições, pretende cindir uma parcela de seu patrimônio, composta por ativo imobilizado conforme descrito e detalhado na Cláusula 5.1 abaixo, e a Cindenda, observados determinados termos e condições, pretende incorporar a parcela do patrimônio destacada da Cindida; e

(d) O Hospital São Domingos e a Ímpar pretendem realizar a cisão parcial com incorporação da parcela cindida pela Ímpar.

Após procederem e concluírem estudos para a cisão parcial do Hospital São Domingos, resolvem, em atendimento ao disposto nos Artigos 224, 225, 226, 227 e 229 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das S.A.**"), da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 ("Código Civil") e da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, o presente "Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Cisão Parcial do Hospital São Domingos Ltda. com Incorporação da Parcela Patrimonial pela Ímpar Serviços Hospitalares S.A." observados os termos, cláusulas e condições adiante consubstanciados ("Protocolo e Justificação").

1. CONDIÇÕES GERAIS E JUSTIFICAÇÃO:

1.1 Este instrumento de Protocolo e Justificação tem por objeto consubstanciar as justificativas, os termos, as cláusulas e as condições da cisão parcial do patrimônio da Cindida e a incorporação da



parcela patrimonial destacada da Cindida pela Cindenda, de modo que, após a cisão parcial e respectiva incorporação da parcela cindida, a Cindida continuará existindo e a Cindenda sucederá a Cindida, a título universal, em relação aos elementos patrimoniais relacionados à parcela patrimonial cindida e incorporada pela Cindenda, observados os termos dos artigos 227 e 229 da Lei das S.A., tudo de acordo com e nos termos deste Protocolo e Justificação ("Cisão Parcial" ou "Operação").

1.2 Em decorrência da Operação, a totalidade dos elementos patrimoniais que integram a parcela cindida do patrimônio da Cindida, composta pelo ativo imobilizado descrito e detalhado na Cláusula 5.1 abaixo, serão vertidos para a Cindenda, a qual somente será responsável pelos ativos, dívidas, obrigações e passivos que lhe forem expressamente transferidos neste Protocolo e Justificação, não sendo solidariamente responsável por quaisquer outros ativos, dívidas, obrigações e passivos da Cindida, em consonância com o disposto no artigo 233, parágrafo único, da Lei das S.A.

1.3 A Operação insere-se no contexto de reorganização administrativa, operacional, financeira e jurídica dos negócios das Partes, e será realizada tendo em vista a necessidade de segregação e redistribuição de determinados elementos patrimoniais da Cindida em outra estrutura societária, visando otimizar a sua estrutura de capital e de gestão e, ao mesmo tempo, permitir a realocação destes elementos patrimoniais com maior eficiência.

2. INTERESSE DAS PARTES NA REALIZAÇÃO DA CISÃO PARCIAL:

2.1 A realização da Operação se justifica e é interessante para os sócios da Cindida e para a única acionista da Cindenda, após a realização dos estudos julgados necessários, pois será possível reorganizar e explorar os elementos patrimoniais segregados da Cindida de modo mais eficiente, mantendo o padrão e orientação geral de negócios. Além disso, a Operação trará consideráveis benefícios às Partes, de ordem administrativa, econômica e financeira, dentre os quais se destacam:

- (i) a racionalização e simplificação da gestão dos ativos das Partes; e
- (ii) a reorganização de determinados ativos imobilizados da Cindida permitirá o desenvolvimento de atividade empresarial pela Cindenda de forma segregada, otimizando, assim, os riscos relativos a este negócio para as Partes.

2.2 Uma vez aprovada a Cisão Parcial e o presente Protocolo e Justificação pelos sócios da Cindida e pela única acionista da Cindenda, a Cisão será implementada da seguinte forma:



3. COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL ANTES DA CISÃO PARCIAL:

3.1 Atual Composição do Capital Social da Cindida: O capital social do Hospital São Domingos, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 45.231.087,00 (quarenta e cinco milhões, duzentos e trinta e um mil e oitenta e sete reais), representado por 45.231.087,00 (quarenta e cinco milhões, duzentas e trinta e uma mil e oitenta e sete) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente detidas pela única sócia, ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.

Sócio	Número de Quotas	Capital Social (R\$)	%
ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.	45.231.087	45.231.087,00	100,00%
Total	45.231.087	45.231.087,00	100,00

3.2 Atual Composição do Capital Social da Cindenda: O capital social da ÍMPAR, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 7.249.875.297,31 (sete bilhões, duzentos e quarenta e nove milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos), divididos em 7.879.090.451 (sete bilhões, oitocentos e setenta e nove milhões, noventa mil, quatrocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, detidas pela única acionista DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.

Acionista	Número de Ações	Capital Social (R\$)	%
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	7.879.090.451	7.249.875.297,31	100,00%
Total	7.879.090.451	7.249.875.297,31	100,00

4. DIREITO DE RETIRADA E RECONSIDERAÇÃO DA OPERAÇÃO:

4.1 A Operação não constitui hipótese de exercício de direito de retirada pela sócia da Cindida, nos termos previstos nos arts. 136, caput, IX e 137, caput, III da Lei das S.A. Adicionalmente, tendo em vista que a única acionista titular da totalidade do capital social total e votante da Cindenda manifestou concordância com a Operação, não há que se falar em exercício do direito de retirada conforme previsto no artigo 137 da Lei das S.A.

4.2 Visto que não haverá acionista ou sócio legitimado para exercer o direito de retirada, seja da Cindida ou da Cindenda, conforme aplicável, conforme disposto acima, não haverá a possibilidade de reconsideração da Operação por risco à estabilidade financeira da Cindida, consoante previsto no §3º do art. 137 da Lei das S.A.



5. PARCELA CINDIDA:

5.1 Em razão da Operação, serão vertidos para a Cindenda, a título universal e sem solução de continuidade, os elementos patrimoniais integrantes do patrimônio da Cindida, conforme indicados no Laudo de Avaliação previsto na Cláusula 8.5 abaixo, sendo que, resumidamente, a parcela cindida será composta, única e exclusivamente, pelo ativo imobilizado e propriedades para investimentos, devidamente descrito no laudo anexo ("Parcela Cindida").

5.2 A Cindida declara, neste ato, ter pleno conhecimento sobre a situação, quantidade e estado do ativo imobilizado que compõe a Parcela Cindida ou de qualquer forma a ele relacionado que será transferido da Cindida à Cindenda em virtude da Operação no estado, quantidade e condição em que se encontra.

6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO E CAPITAL SOCIAL DA CINDIDA:

6.1 Nos termos do disposto na Cláusula 6.2 abaixo, a Operação importará em redução do patrimônio líquido da Cindida no valor do acervo líquido da Parcela Cindida, no montante de R\$ 32.433.747,76 (trinta e dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), conforme o Laudo de Avaliação previsto na Cláusula 8.5 abaixo.

6.2 A Operação acarretará a redução do capital social da Cindida no valor de 32.433.747,00 (trinta e dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e quarenta e sete reais) **desconsiderados os centavos da Parcela Cindida**, mediante o cancelamento de 32.433.747 (trinta e dois milhões, quatrocentas e trinta e três mil, setecentas e quarenta e sete) quotas de emissão da Cindida, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, todas elas de titularidade da Cindenda.

6.3 O capital social da Cindida será reduzido em razão da Operação, nos termos da Cláusula 6.2 acima, de forma que o valor do capital social após a Operação será de R\$ 12.797.340,00 (doze milhões, setecentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta reais), dividido em 12.797.340 (doze milhões, setecentas e noventa e sete mil, trezentas e quarenta) quotas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente detidas pela única sócia, ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.

Sócio	Número de Quotas	Capital Social (R\$)	%
ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.	12.797.340	12.797.340,00	100,00%
Total	12.797.340	12.797.340,00	100,00



7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO E CAPITAL SOCIAL DA CINDENDA:

7.1 A Operação não resultará em alteração no valor do patrimônio líquido ou aumento do capital social da Cindenda, uma vez que a Cindenda é a detentora, na presente data, de quotas representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Cindida.

7.2 O capital social da Cindenda, totalmente subscrito e integralizado, permanecerá no valor de R\$ 7.249.875.297,31 (sete bilhões, duzentos e quarenta e nove milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos), divididos em 7.879.090.451 (sete bilhões, oitocentos e setenta e nove milhões, noventa mil, quatrocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, detidas pela única acionista DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.

Acionista	Número de Ações	Capital Social (R\$)	%
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	7.879.090.451	7.249.875.297,31	100,00%
Total	7.879.090.451	7.249.875.297,31	100,00

8. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA PARCELA CINDIDA:

8.1 Critério de Avaliação. A Parcela Cindida foi realizada pelo critério de avaliação do valor patrimonial contábil dos bens, direitos e obrigações refletidos no balanço base da Cindida referentes à Parcela Cindida apurado de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, considerando-se, para tanto, o balanço da Cindida datado de 31 de janeiro de 2024 ("Data-Base"), bem como os seus respectivos livros e registros contábeis, fiscais, analíticos e auxiliares.

8.2 Empresa Avaliadora. As Partes contrataram a APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, CEP 20.021-290, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.681.365/0001-30, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob nº 005112/O-9, devidamente representada pelo seu perito/sócio ora nomeado, LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA, portador do CREA/RJ sob o nº 89100165-5, inscrito no CPF sob o nº 886.681.937- 91, e inscrito no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 118.236/P-0 ("Empresa Avaliadora"), para a elaboração do Laudo de Avaliação contábil da Parcela Cindida, nos termos dos artigos 226, 227 e 229 da Lei das S.A.



8.3 Ratificação da Contratação e Nomeação da Empresa Avaliadora. A escolha, a contratação e a nomeação da Empresa Avaliadora para elaboração do Laudo de Avaliação contábil da Parcela Cindida deverão ser ratificadas pelos sócios da Cindida e acionistas da Cindenda.

8.4 Declaração da Empresa Avaliadora. Nos termos da legislação vigente, a Empresa Avaliadora declarou, no momento de sua contratação: **(i)** não ser titular, direta ou indiretamente, de qualquer valor mobiliário ou derivativo referenciado em valor mobiliário de emissão da Cindida ou da Cindenda; **(ii)** não ter conflito de interesses que lhe diminuam a independência necessária ao desempenho de suas funções; e **(iii)** que não teve, por parte dos controladores e administradores das Partes, qualquer tipo de limitação à realização dos trabalhos necessários.

8.5 Laudo de Avaliação. O laudo de avaliação, que apresenta os resultados da avaliação contábil da Parcela Cindida, nos termos dos artigos 226, 227 e 229 da Lei das S.A., passa a integrar o presente Protocolo e Justificação na forma do **Anexo** ("Laudo de Avaliação").

8.6 Valor Atribuído. Conforme o Laudo de Avaliação, o valor total do acervo líquido da Parcela Cindida a ser vertido para a Cindenda corresponde a R\$ 32.433.747,76 (trinta e dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos).

8.7 Variações Patrimoniais. A Cindenda assumirá, absorverá e suportará as variações patrimoniais relativas à Parcela Cindida que ocorrerem entre a Data-Base e a data da efetiva realização da Operação, as quais serão refletidas no seu patrimônio líquido, conforme o caso.

9. EFEITOS DA CISÃO PARCIAL:

9.1 A operação não resultará na extinção da Cindida, que continuará existente, sem qualquer solução de continuidade.

10. SUCESSÃO; REGISTRO E AVERBAÇÃO

10.1 A Cindenda sucederá a Cindida, a título universal e sem solução de continuidade, em relação aos bens, direitos, pretensões, faculdades, poderes, imunidades, ações, exceções, deveres, obrigações, sujeições, ônus e responsabilidades exclusivamente relacionados à Parcela Cindida a ser incorporada pela Cindenda nos termos deste Protocolo e Justificação.

10.2 Nos termos do parágrafo único do art. 233 da Lei das S.A., a Cindenda assumirá a responsabilidade, isoladamente e exclusivamente, pelos elementos patrimoniais integrantes da Parcela Cindida. Desse modo, a Cindenda não será responsável solidária pelas dívidas,



obrigações, passivos, ônus, responsabilidades e contingências da Cindida que forem estranhas à Parcela Cindida.

10.3 Nos termos do art. 234 da Lei das S.A., a certidão da Operação passada pelo registro público de empresas mercantis será documento hábil para o registro e a averbação, nos registros públicos e privados competentes, incluindo os Cartórios de Registro de Imóveis competentes, da sucessão universal pela Cindida em todos os bens, direitos, pretensões, faculdades, poderes, imunidades, ações, exceções, deveres, obrigações, sujeições, ônus e responsabilidades da Cindida relacionados à Parcela Cindida.

11. APROVAÇÕES SOCIETÁRIAS:

11.1 Alteração do Contrato Social da Cindida. Deverá ser realizada alteração do Contrato Social da Cindida para deliberar e aprovar, dentre outras matérias: **(i)** os termos e condições deste Protocolo e Justificação; **(ii)** a ratificação da nomeação da Empresa Avaliadora para a elaboração do Laudo de Avaliação; **(iii)** a aprovação do Laudo de Avaliação contábil da Parcela Cindida; **(iv)** a Cisão Parcial, nos termos e condições do presente Protocolo e Justificação; **(v)** a redução do capital social da Cindida em decorrência da Operação; e **(vi)** a autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação da Operação.

11.2 Assembleia Geral Extraordinária da Cindenda. Deverá ser realizada Assembleia Geral Extraordinária da Cindenda para deliberar e aprovar, dentre outras matérias: **(i)** os termos e condições deste Protocolo e Justificação; **(ii)** a ratificação da nomeação da Empresa Avaliadora para a elaboração do Laudo de Avaliação; **(iii)** a aprovação do Laudo de Avaliação contábil da Parcela Cindida; **(iv)** a Cisão Parcial, nos termos e condições do presente Protocolo e Justificação; e **(v)** a inexistência de aumento do capital social da Cindenda em decorrência da Operação.

11.3 A Operação não resultará na abertura de novas filiais da Cindenda.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS:

12.1 Atos dos Administradores. Uma vez aprovada a Cisão Parcial e a incorporação da Parcela Cindida, os administradores das Sociedades ficarão responsáveis e autorizados a tomarem as medidas necessárias para a implementação dos termos e condições pactuados neste Protocolo e Justificação, em observância à legislação aplicável e aos seus respectivos Contratos Sociais.

12.2 Negócios Dependentes. Este Protocolo e Justificação é celebrado no contexto da simplificação da malha societária da Cindida e da Cindenda, conforme informado na Cláusula 2.1 deste instrumento. Os eventos descritos no presente Protocolo e Justificação, bem como as demais



matérias conexas submetidas aos acionistas e sócios das Partes nas assembleias gerais extraordinárias e reunião de sócios que deliberarem sobre este Protocolo e Justificação e a Operação são negócios jurídicos reciprocamente dependentes, sendo intenção das Partes que um negócio não tenha eficácia sem que os demais também a tenham.

12.3 Capacidade. Cada Parte assina este Protocolo e Justificação e declara: **(i)** estar ciente das obrigações decorrentes deste instrumento e da legislação que rege este instrumento; **(ii)** ter sido assistida por advogados e que, em virtude de suas atividades cotidianas na gestão de suas respectivas empresas, ter compreensão integral de todos os termos e condições deste instrumento; e **(iii)** não estar sujeita a qualquer necessidade econômica ou financeira excepcional, assumindo integralmente os encargos e riscos inerentes à Operação.

12.4 Custos e Despesas. Cada Parte deve arcar com suas respectivas despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da celebração deste Protocolo e Justificação e da consumação da Operação, incluindo, sem limitação, despesas com publicações, assessores jurídicos e financeiros, registros e averbações necessários, observadas as regras especificadas estipuladas neste protocolo.

12.5 Tributos. Cada uma das Partes deverá recolher e pagar pontualmente todos os tributos incidentes em razão da Operação e para os quais seja definida como contribuinte pela legislação tributária. Adicionalmente, as Partes autorizam-se mutuamente a reter e pagar em nome e por conta da outra todos os tributos para os quais a legislação tributária determine o recolhimento na fonte, observadas as regras especificadas estipuladas neste protocolo.

12.6 Requisitos e Aprovações. Este instrumento de Protocolo e Justificação contém as condições exigidas pela Lei das S.A. para a proposta da Operação, com a consequente incorporação da Parcela Cindida de titularidade da Cindida pela Cindenda, conforme previsto neste Protocolo e Justificação, e deverá ser submetido à apreciação e aprovação do acionista e sócio das Partes.

12.7 Acordo Integral. Este instrumento de Protocolo e Justificação constitui o único e integral acordo entre as Partes no tocante à Operação, que constitui seu objeto, substituindo e superando para todos os efeitos quaisquer outros documentos assinados anteriormente a esta data.

12.8 Sobrevivência de Cláusulas. Caso alguma cláusula, disposição, termo ou condição deste instrumento de Protocolo e Justificação venha a ser considerado inválido ou inexecutável, as demais cláusulas, disposições, termos e condições não afetados permanecerão válidos e em pleno vigor.

12.9 Renúncia; Não Exercício. O não exercício, ou o atraso no exercício, por qualquer das Partes, dos direitos a elas respectivamente conferidos nos termos deste Protocolo e Justificação não será interpretado como renúncia em relação a tal direito. Toda e qualquer renúncia aos direitos



ID - 18794

estabelecidos neste Protocolo e Justificação somente será válida quando entregue por escrito e assinada pela Parte renunciante.

12.10 Aditamentos. Este Protocolo e Justificação somente poderá ser alterado ou aditado por escrito, em instrumento particular assinado por todos os seus subscritores.

12.11 Cessão. É vedada a cessão de quaisquer dos direitos e obrigações pactuados no presente Protocolo e Justificação sem o prévio e expresso consentimento, por escrito, de cada uma das Partes.

12.12 Execução Específica. As obrigações assumidas neste Protocolo e Justificação serão objeto de execução específica por qualquer das Partes, nos termos dos arts. 493, 497, 501 e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada ("Código de Processo Civil"). As Partes não renunciam a qualquer ação ou providência a que tenham direito a qualquer tempo. As Partes expressamente admitem e se obrigam ao cumprimento específico de suas obrigações e a aceitar ordens judiciais ou quaisquer outros atos semelhantes. Este Protocolo e Justificação servirá como título executivo extrajudicial, para instruir qualquer demanda que vise ao seu cumprimento, conforme dispõe o art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

12.13 Anexos. Este instrumento particular de Protocolo e Justificação contém 2 (dois) anexos, cujas numerações são atribuídas conforme a cláusula que se refere a cada anexo, e fazem parte integrante e indissociável do presente instrumento.

12.14 Lei Aplicável. Este instrumento de Protocolo e Justificação será regido, interpretado e aplicado de acordo com a legislação vigente da República Federativa do Brasil.

12.15 Foro. Fica eleito o foro central da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir todas as questões oriundas do presente Protocolo e Justificação, com a renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

12.16 Assinatura Digital. As Partes concordam e declaram que a assinatura deste Protocolo e Justificação poderá ser feita por meio da plataforma DocuSign (www.docusign.com) e a declaram como meio válido e idôneo juntamente com as respectivas páginas de certificação, as quais são partes integrantes do presente. Este documento produz efeitos para todas as Partes a partir da data nele indicada, ainda que uma ou mais Partes realizem a assinatura eletrônica em data posterior. Ademais, ainda que alguma das partes venha a assinar eletronicamente este instrumento em local diverso, o local de celebração deste instrumento é, para todos os fins, a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, conforme abaixo indicado.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes, assinam o presente Protocolo e Justificação de



Página 11 de 13



ID - 18794

Incorporação em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, 30 de maio de 2024.

Hospital São Domingos LTDA. p. Rogério Reis de Castro	Hospital São Domingos LTDA. p. Leonardo Modesti Vedolin
Ímpar Serviços Hospitalares S.A. p. Rogério Reis de Castro	Ímpar Serviços Hospitalares S.A. p. Gustavo dos Santos Fernandes



ID - 18794

ANEXO

LAUDO DE AVALIAÇÃO





LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00149/24-01

Hospital São Domingos Ltda.



LAUDO DE AVALIAÇÃO: AP-00149I24-01

DATA-BASE: 31 de janeiro de 2024

LAUDO DE AVALIAÇÃO DO ACERVO LÍQUIDO DE HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA., APURADO POR MEIO DOS LIVROS CONTÁBEIS

1. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

A APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA., sociedade estabelecida na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 08.681.365I0001-30, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro sob o nº 005112IO-9, representada por seu sócio infra-assinado, LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA, contador, portador do documento de identidade nº 89100165-5ID (CREAIRJ), inscrito no CPF sob o nº 886.681.937-91 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 118.263IP-0, residente e domiciliado na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, foi nomeada pela administração de ÍMPAR SERVICOS HOSPITALARES S.A., doravante denominada ÍMPAR, com sede na Avenida Paulista, nº 2.028, 8º andar, Conjunto 81, Bela Vista, Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 60.884.855I0001-54, para proceder à avaliação do acervo líquido de HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA., doravante denominada HOSPITAL SÃO DOMINGOS, com sede na Avenida Jerônimo de Albuquerque, nº 540, Cohama, Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 11.006.293I0001-30, em 31 de janeiro de 2024, de acordo com as práticas contábeis brasileiras - que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) -, e apresenta a seguir o resultado de seus trabalhos.



2. OBJETIVO DA AVALIAÇÃO

A avaliação do acervo líquido de HOSPITAL SÃO DOMINGOS na data-base, nos termos dos artigos 226 e 229 da Lei nº 6.404/76, tem em vista verificar o valor contábil da parcela a ser vertida a ÍMPAR, para fins de cisão parcial, conforme detalhado no Anexo 2 deste Laudo.

3. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

A administração de HOSPITAL SÃO DOMINGOS é responsável pela escrituração dos livros e pela elaboração de informações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo CPC e aprovados pelo CFC, assim como pelos controles internos relevantes que ela definiu como necessários para permitir que tal processo seja livre de distorção significativa, independentemente se causada por fraude ou erro. O resumo das principais práticas contábeis adotadas pela companhia está descrito no Anexo 3 do Laudo de Avaliação.

4. ALCANCE DOS TRABALHOS E RESPONSABILIDADE DO CONTADOR

Nossa responsabilidade é apresentar uma conclusão sobre o valor contábil do acervo líquido formado por determinados ativos em 31 de janeiro de 2024, com base nos trabalhos conduzidos de acordo com o Comunicado Técnico CTG 2002, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o qual prevê o exame das contas que englobam os determinados ativos constantes do Anexo 1 deste Relatório e que, naquela data, estavam registrados no balanço patrimonial de HOSPITAL SÃO DOMINGOS. Assim, examinamos o referido acervo líquido conforme as normas contábeis aplicáveis, que requerem o cumprimento de exigências éticas, bem como um planejamento e uma execução com o objetivo de obter segurança razoável de que o objeto está livre de distorção relevante.

A emissão de laudo de avaliação envolve a execução de procedimentos selecionados para a obtenção de evidência a respeito dos valores contabilizados. Essa ação depende do julgamento do contador, incluindo a avaliação dos riscos de distorção significativa no acervo líquido, independentemente se causada por fraude ou erro. Em tal análise, o contador considera os controles internos pertinentes à elaboração do balanço patrimonial da empresa para planejar os processos apropriados às circunstâncias, mas não com vistas a expressar uma opinião sobre a efetividade de tais documentos.

O trabalho abarca, também, a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração. Acreditamos que a evidência obtida é suficiente e adequada para fundamentar nossa conclusão.



5. CONCLUSÃO

Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor de R\$ 32.433.747,76 (trinta e dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), referente ao acervo líquido resumido no Anexo 2, conforme constava no balanço patrimonial de HOSPITAL SÃO DOMINGOS na data-base, registrado nos livros contábeis, representa, em todos os aspectos relevantes, o acervo líquido da companhia, avaliado de acordo com as práticas contábeis brasileiras.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2024.

APSYS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA.

CRCIRJ-005112IO-9

LUIZ PAULO
CESAR
SILVEIRA:88
668193791

Assinado de forma
digital por LUIZ
PAULO CESAR
SILVEIRA:886681
93791
Dados: 2024.03.28
16:13:14 -03'00'

LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA
Vice-Presidente
Contador (CRCIRJ-118.263IP-0)



6. RELAÇÃO DE ANEXOS

1. Documentação de suporte
2. Resumo do acervo líquido
3. Resumo das principais práticas contábeis adotadas por HOSPITAL SÃO DOMINGOS
4. Glossário



ANEXO 1



	31/01/2024		31/01/2024
ATIVO		PASSIVO E PL	
Caixa e equivalentes de caixa	23.639.455,94	Fornecedores	60.925.825,53
Contas a receber de clientes	343.771.818,37	Empréstimos e financiamentos	5.747.305,18
Estoques	34.998.750,82	Obrigações sociais e trabalhistas	33.110.554,67
Tributos a recuperar	4.271.949,70	Imposto de renda e contribuição social a pagar	8.408.906,13
Outros créditos	10.627.537,62	Impostos e contribuições a recolher	22.411.908,03
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	417.309.512,45	Impostos parcelados	33.706.449,85
		Dividendos e juros sobre o capital próprio	28.187.784,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Passivos de arrendamentos	3.583.405,30
Tributos diferidos	59.963.753,36	Outras contas a pagar e provisões	218.558.464,90
Depósitos judiciais	1.889.595,92	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	414.640.603,65
Partes relacionadas	40.490.524,02		
Outros créditos.	3.872.094,16	Empréstimos e financiamentos	40.447.363,48
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.215.967,46	Impostos parcelados	5.443.680,39
		Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis	212.734.874,95
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		Partes relacionadas	71.000,00
Imobilizado	125.578.459,96	Passivos de arrendamentos	268.043.728,15
Intangível	3.520.011,64	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	526.740.646,97
Direito de uso	269.698.880,27		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	398.797.351,87	Capital Social	1.599.999,51
		Reservas de Lucros	18.244.685,81
		Resultados do Exercício	13.465.808,49
		Resultados Abrangentes	(96.000.000,00)
		Adiantamento de futuro aumento de capital	43.631.087,35
		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.058.418,84)
Total do Ativo	922.322.831,78	Total do Passivo e PL	922.322.831,78

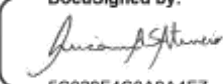
DocuSigned by:

 5C029F4C0A9A4E7...
Lucianne Assôf Sperandio
 Gerente Executivo de Controladoria
 CRC 15P264068/O-6



Hospital São Domingos Ltda.
CNPJ: 11.006.293/0001-30
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE JANEIRO DE 2024
(Valores expressos em reais)

	<u>31/01/2024</u>
Receita operacional bruta	92.673.633
Deduções da Receita	(8.088.418)
Custo dos serviços prestados	<u>(47.545.475)</u>
Lucro bruto	<u>37.039.740</u>
Despesas gerais e administrativas	(8.112.418)
Outras receitas operacionais	<u>151.098</u>
Lucro/Prej. antes de desp. financ., equiv. patr. e impostos	<u>(7.961.320)</u>
Resultado financeiro líquido	<u>(8.900.424)</u>
Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e contrib. social	<u>(8.900.424)</u>
Imposto de renda e contribuição social diferido	(8.576.284)
Imposto de renda e contribuição social corrente	<u>1.864.096</u>
Lucro ou Prejuízo do exercício	<u>(6.712.188)</u>
(=) Resultado Líquido	<u>13.465.808</u>

DocuSigned by:

5C029F4C0A9A4E7...
Lucianne Assôfra Sperandio Atencio
Gerente Executivo de Controladoria
CRC 1SP264068/O-6



ANEXO 2



HOSPITAL SÃO DOMINGOS	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	
BALANÇO PATRIMONIAL (R\$)	SALDOS EM 31/01/2024	ACERVO A SER CINDIDO
ATIVO CIRCULANTE	417.309.512,45	-
Caixa e equivalente de caixa	23.639.455,94	-
Contas a receber	343.771.818,37	-
Estoques	34.998.750,82	-
Impostos a recuperar	4.271.949,70	-
Outros ativos circulantes	10.627.537,62	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	505.013.319,33	32.433.747,76
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	106.215.967,46	-
Tributos diferidos	40.490.524,02	-
Depósitos judiciais	1.889.595,92	-
Impostos diferidos	59.963.753,36	-
Outros ativos não circulantes	3.872.094,16	-
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	6.723.784,32	6.723.784,32
IMOBILIZADO	118.854.675,64	25.709.963,44
INTANGÍVEL	3.520.011,64	-
DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	269.698.880,27	-
TOTAL DO ATIVO	922.322.831,78	32.433.747,76
PASSIVO CIRCULANTE	414.640.603,65	-
Fornecedores	60.925.825,53	-
Empréstimos e financiamentos	5.747.305,18	-
Salários e encargos a recolher	33.110.554,67	-
Impostos e contribuições a recolher	22.411.908,03	-
Imposto de Renda e Contribuição Social a recolher	8.408.906,13	-
Impostos parcelados	33.706.449,85	-
Dividendos e juros sobre o capital próprio	28.187.784,06	-
Arrendamento	3.583.405,30	-
Outros passivos circulantes	218.558.464,90	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	526.740.646,97	-
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	526.740.646,97	-
Empréstimos e financiamentos	40.447.363,48	-
Impostos parcelados	5.443.680,39	-
Partes relacionadas	71.000,00	-
Passivo de arrendamento	268.043.728,15	-
Provisão para contingências	212.734.874,95	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.058.418,84)	32.433.747,76
TOTAL DO PASSIVO	922.322.831,78	32.433.747,76

ANEXO 3



RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS POR HOSPITAL SÃO DOMINGOS**Propriedades para investimento**

Propriedades para investimento, registrados ao valor de custo original, referem-se a partes de edifícios operacionais da empresa.

Imobilizado

É registrado ao custo de aquisição, formação ou construção e acrescido de juros durante o período de construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (*impairment*) acumuladas, quando aplicável.

Passivos

São reconhecidos no balanço quando o HOSPITAL SÃO DOMINGOS tem uma obrigação presente (legal ou presumida) ou resultante de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-la. Alguns passivos envolvem incertezas quanto ao prazo e ao valor e são estimados por meio de provisão à medida que são incorridos e registrados. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.



ANEXO 4



GLOSSÁRIO

A

ABL

Área bruta locável.

ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Abordagem da renda

Método de avaliação pela conversão a valor presente de benefícios econômicos esperados.

Abordagem de ativos

Método de avaliação de empresas em que todos os ativos e passivos (incluindo os não contabilizados) têm seus valores ajustados aos de mercado. Também conhecido como patrimônio líquido a mercado.

Abordagem de mercado

Método de avaliação no qual são adotados múltiplos comparativos derivados de preço de vendas de ativos similares.

Ágio por expectativa de rentabilidade futura (fundo de comércio ou goodwill)

Benefícios econômicos futuros decorrentes de ativos não passíveis de serem individualmente identificados nem separadamente reconhecidos.

Amortização

Alocação sistemática do valor amortizável de ativo ao longo de sua vida útil.

Amostra

Conjunto de dados de mercado representativos de uma população.

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)

Refere-se à certificação de Engenheiros e Arquitetos.

Aproveitamento eficiente

Aquele recomendável e tecnicamente possível para o local, em uma data de referência, observada a tendência mercadológica nas circunvizinhanças, entre os diversos usos permitidos pela legislação pertinente.

Área Boma

Somatório de parte da área comum com a área útil.

Área equivalente de construção

Área construída sobre a qual é aplicada a equivalência de custo unitário de construção correspondente, de acordo com os postulados da ABNT.

Área homogeneizada

Área útil, privativa ou construída com tratamentos matemáticos, para fins de avaliação, segundo critérios baseados no mercado imobiliário.

Área privativa

Área útil acrescida de elementos construtivos (tais como paredes, pilares etc.) e *halde* elevadores (em casos particulares).

Área total de construção

Resultante do somatório da área real privativa e da área comum atribuídas a uma unidade autônoma, definidas conforme a ABNT.

Área útil

Área real privativa subtraída a área ocupada pelas paredes e por outros elementos construtivos que impeçam ou dificultem sua utilização.

Arrendamento mercantil financeiro

O que transfere substancialmente todos os riscos e benefícios vinculados à posse do ativo, o qual pode ou não ser futuramente transferido. O arrendamento que não for financeiro é operacional.

Arrendamento mercantil operacional

O que não transfere substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à posse do ativo. O arrendamento que não for operacional é financeiro.

Ativo

Recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados dos quais se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade.

Ativo imobilizado

Ativos tangíveis disponibilizados para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, na locação por outros, investimento, ou fins administrativos, esperando-se que sejam usados por mais de um período contábil.

Ativo intangível

Ativo identificável não monetário sem substância física. Tal ativo é identificável quando: a) for separável, isto é, capaz de ser separado ou dividido da entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, tanto individualmente quanto junto com contrato, ativo ou passivo relacionados; b) resulta de direitos contratuais ou outros direitos legais, quer esses direitos sejam transferíveis quer sejam separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações.

Ativo tangível

Ativo de existência física como terreno, construção, máquina, equipamento, móvel e utensílio.

Ativos não operacionais

Aqueles não ligados diretamente às atividades de operação da empresa (podem ou não gerar receitas) e que podem ser alienados sem prejuízo do seu funcionamento.

Ativos operacionais

Bens fundamentais ao funcionamento da empresa.

Avaliação

Ato ou processo de determinar o valor de um ativo.



B

BDI (Budget Difference Income)

Benefícios e Despesas Indiretas. Percentual que indica os benefícios e as despesas indiretas incidentes sobre o custo direto da construção.

Bem

Coisa que tem valor, suscetível de utilização ou que pode ser objeto de direito, que integra um patrimônio.

Benefícios econômicos

Benefícios como receitas, lucro líquido, fluxo de caixa líquido etc.

Beta

Medida de risco sistemático de uma ação; tendência do preço de determinada ação a estar correlacionado com mudanças em determinado índice.

Beta alavancado

Valor de beta refletindo o endividamento na estrutura de capital.

C

Campo de arbítrio

Intervalo de variação no entorno do estimador pontual adotado na avaliação, dentro do qual se pode arbitrar o valor do bem desde que justificado pela existência de características próprias não contempladas no modelo.

CAPEX (Capital Expenditure)

Investimento em ativo permanente.

CAPM (Capital Asset Pricing Model)

Modelo no qual o custo de capital para qualquer ação ou lote de ações equivale à taxa livre de risco acrescida de prêmio de risco proporcionado pelo risco sistemático da ação ou lote de ações em estudo. Geralmente utilizado para calcular o Custo de Capital Próprio ou Custo de Capital do Acionista.

CFC

Conselho Federal de Contabilidade.

Códigos alocados

Ordenação numeral (notas ou pesos) para diferenciar as características qualitativas dos imóveis.

Combinação de negócios

União de entidades ou negócios separados produzindo demonstrações contábeis de uma única entidade que reporta. Operação ou outro evento por meio do qual um adquirente obtém o controle de um ou mais negócios, independente da forma jurídica da operação.

Controlada

Entidade, incluindo aquela sem personalidade jurídica, tal como uma associação, controlada por outra entidade (conhecida como controladora).

Controladora

Entidade que possui uma ou mais controladas.

Controle

Poder de direcionar a gestão estratégica política e administrativa de uma empresa.

CPC

Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

Custo

Total dos gastos diretos e indiretos necessários à produção, manutenção ou aquisição de um bem em uma determinada data e situação.

Custo de capital

Taxa de retorno esperado requerida pelo mercado como atrativa de fundos para determinado investimento.

Custo de reedição

Custo de reprodução, descontada a depreciação do bem, tendo em vista o estado em que se encontra.

Custo de reprodução

Gasto necessário para reproduzir um bem, sem considerar eventual depreciação.

Custo de substituição

Custo de reedição de um bem, com a mesma função e características assemelhadas ao avaliando.

Custo direto de produção

Gastos com insumos, inclusive mão de obra, na produção de um bem.

Custo indireto de produção

Despesas administrativas e financeiras, benefícios e demais ônus e encargos necessários à produção de um bem.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

D

Dado de mercado

Conjunto de informações coletadas no mercado relacionadas a um determinado bem.

Data-base

Data específica (dia, mês e ano) de aplicação do valor da avaliação.

Data de emissão

Data de encerramento do laudo de avaliação, quando as conclusões da avaliação são transmitidas ao cliente.



DCF (Discounted Cash Flow)

Fluxo de caixa descontado.

D&A

Depreciação e Amortização.

Depreciação

Alocação sistemática do valor depreciável de ativo durante a sua vida útil.

Dívida líquida

Caixa e equivalentes, posição líquida em derivativos, dívidas financeiras de curto e longo prazo, dividendos a receber e apagar, recebíveis e contas a pagar relacionadas a debêntures, déficits de curto e longo prazo com fundos de pensão, provisões, outros créditos e obrigações com pessoas vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

Documentação de suporte

Documentação levantada e fornecida pelo cliente na qual estão baseadas as premissas do laudo.

E

EBIT (Earnings Before Interests and Taxes)

Lucro antes de juros e impostos.

EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)

Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

Empreendimento

Conjunto de bens capaz de produzir receitas por meio de comercialização ou exploração econômica. Pode ser: imobiliário (ex.: loteamento, prédios comerciais/residenciais), de base imobiliária (ex.: hotel, shopping center, parques temáticos), industrial ou rural.

Empresa

Entidade comercial, industrial, prestadora de serviços ou de investimento detentora de atividade econômica.

Enterprise value

Valor econômico da empresa.

Equity value

Valor econômico do patrimônio líquido.

Estado de conservação

Situação física de um bem em decorrência de sua manutenção.

Estrutura de capital

Composição do capital investido de uma empresa entre capital próprio (patrimônio) e capital de terceiros (endividamento).

F

Fator de comercialização

Razão entre o valor de mercado de um bem e seu custo de reedição ou substituição, que pode ser maior ou menor que 1 (um).

FCFF (Free Cash Flow to Firm)

Fluxo de caixa livre para a firma, ou fluxo de caixa livre desalavancado.

Fluxo de caixa

Caixa gerado por um ativo, grupo de ativos ou empresa durante determinado período de tempo. Geralmente o termo é complementado por uma qualificação referente ao contexto (operacional, não operacional etc.).

Fluxo de caixa do capital investido

Fluxo gerado pela empresa a ser revertido aos financiadores (juros e amortizações) e acionistas (dividendos) depois de considerados custo e despesas operacionais e investimentos de capital.

Fração ideal

Percentual pertencente a cada um dos compradores (condôminos) no terreno e nas coisas comuns da edificação.

G

Gleba urbanizável

Terreno passível de receber obras de infraestrutura urbana, visando ao seu aproveitamento eficiente, por meio de loteamento, desmembramento ou implantação de empreendimento.

Goodwill

Ver Ágio por expectativa de rentabilidade futura.

H

Homogeneização

Tratamento dos preços observados, mediante a aplicação de transformações matemáticas que expressem, em termos relativos, as diferenças entre os atributos dos dados de mercado e os do bem avaliando.

I

IAS (International Accouting Standard)

Normas Internacionais de Contabilidade.

IASB (International Accouting Standards Board)

Junta Internacional de Normas Contábeis.

Idade aparente

Idade estimada de um bem em função de suas características e estado de conservação no momento da vistoria.

IFRS (International Financial Reporting Standard)

Normas Internacionais de Relatórios Financeiros, conjunto de pronunciamentos de contabilidade internacionais publicados e revisados pelo IASB.

Imóvel

Bem constituído de terreno e eventuais benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser classificado como urbano ou rural, em função da sua localização, uso ou vocação.



Imóvel de referência

Dado de mercado com características comparáveis às do imóvel avaliando.

Impairment

Ver Perdas por desvalorização.

Inferência estatística

Parte da ciência estatística que permite extrair conclusões sobre a população a partir de amostra.

Infraestrutura básica

Equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, redes de esgoto sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de acesso.

Instalações

Conjunto de materiais, sistemas, redes, equipamentos e serviços para apoio operacional a uma máquina isolada, linha de produção ou unidade industrial, conforme grau de agregação.

IVSC

International Valuation Standards Council.

L

Liquidação forçada

Condição relativa à hipótese de uma venda compulsória ou em prazo menor que a média de absorção pelo mercado.

Liquidez

Capacidade de rápida conversão de determinado ativo em dinheiro ou em pagamento de determinada dívida.

Loteamento

Subdivisão de gleba em lotes destinados a edificações, com abertura de novas vias de circulação de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das já existentes.

Luvas

Quantia paga pelo futuro inquilino para assinatura ou transferência do contrato de locação, a título de remuneração do ponto comercial.

M

Metodologia de avaliação

Uma ou mais abordagens utilizadas na elaboração de cálculos avaliatórios para a indicação de valor de um ativo.

Modelo de regressão

Modelo utilizado para representar determinado fenômeno, com base em uma amostra, considerando-se as diversas características influenciadoras.

Múltiplo

Valor de mercado de uma empresa, ação ou capital investido, dividido por uma medida da empresa (EBITDA, receita, volume de clientes etc).

N

Normas Internacionais de Contabilidade

Normas e interpretações adotadas pela IASB. Elas englobam: Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS); Normas Internacionais de Contabilidade (IAS); e interpretações desenvolvidas pelo Comitê de Interpretações das Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente de Interpretações (SIC).

P

Padrão construtivo

Qualidade das benfeitorias em função das especificações dos projetos, de materiais, execução e mão de obra efetivamente utilizados na construção.

Parecer técnico

Relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico, emitido por um profissional capacitado e legalmente habilitado, sobre assunto de sua especificidade.

Passivo

Obrigação presente que resulta de acontecimentos passados, em que se espera que a liquidação desta resulte em afluxo de recursos da entidade que incorporam benefícios econômicos.

Patrimônio líquido a mercado

Abordagem de ativos.

Perdas por desvalorização (impairment)

Valor contábil do ativo que excede, no caso de estoques, seu preço de venda menos o custo para completá-lo e despesa de vendê-lo; ou, no caso de outros ativos, seu valor justo menos a despesa para a venda.

Perícia

Atividade técnica realizada por profissional com qualificação específica para averiguar e esclarecer fatos, verificar o estado de um bem, apurar as causas que motivaram determinado evento, avaliar bens, seus custos, frutos ou direitos.

Pesquisa de mercado

Conjunto de atividades de identificação, investigação, coleta, seleção, processamento, análise e interpretação de resultados sobre dados de mercado.

Planta de valores

Representação gráfica ou listagem dos valores genéricos de metro quadrado de terreno ou do imóvel em uma mesma data.

Ponto comercial

Bem intangível que agrega valor ao imóvel comercial, decorrente de sua localização e expectativa de exploração comercial.

População

Totalidade de dados de mercado do segmento que se pretende analisar.



Preço

Quantia pela qual se efetua uma transação envolvendo um bem, um fruto ou um direito sobre ele.

Prêmio de controle

Valor ou percentual de um valor pró-rata de lote de ações controladoras sobre o valor pró-rata de ações sem controle, que refletem o poder do controle.

Profundidade equivalente

Resultado numérico da divisão da área de um lote pela sua frente projetada principal.

Propriedade para investimento

Imóvel (terreno, construção ou parte de construção, ou ambos) mantido pelo proprietário ou arrendatário sob arrendamento, tanto para receber pagamento de aluguel quanto para valorização de capital, ou ambos, que não seja para: uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, como também para fins administrativos.

R

Rd (Custo da Dívida)

Medida do valor pago pelo capital provindo de terceiros, sob a forma de empréstimos, financiamentos, captações no mercado, entre outros.

Re (Custo de Capital Próprio)

Retorno requerido pelo acionista pelo capital investido.

Risco do negócio

Grau de incerteza de realização de retornos futuros esperados do negócio, resultantes de fatores que não alavancagem financeira.

S

Seguro

Transferência de risco garantida por contrato, pelo qual uma das partes se obriga, mediante cobrança de prêmio, a indenizar a outra pela ocorrência de sinistro coberto pela apólice.

Sinistro

Evento que causa perda financeira.

T

Taxa de desconto

Qualquer divisor usado para a conversão de um fluxo de benefícios econômicos futuros em valor presente.

Taxa interna de retorno

Taxa de desconto onde o valor presente do fluxo de caixa futuro é equivalente ao custo do investimento.

Testada

Medida da frente de um imóvel.

Tratamento de dados

Aplicação de operações que expressem, em termos relativos, as diferenças de atributos entre os dados de mercado e os do bem avaliando.

U

Unidade geradora de caixa

Menor grupo de ativos identificáveis gerador de entradas de caixa que são, em grande parte, independentes de entradas geradas por outros ativos ou grupos de ativos.

V

Valor atual

Valor de reposição por novo depreciado em função do estado físico em que se encontra o bem.

Valor contábil

Valor em que um ativo ou passivo é reconhecido no balanço patrimonial.

Valor da perpetuidade

Valor ao final do período projetivo a ser adicionado no fluxo de caixa.

Valor de dano elétrico

Estimativa do custo do reparo ou reposição de peças, quando ocorre um dano elétrico no bem. Os valores são tabelados em percentuais do Valor de Reposição e foram calculados através de estudos dos manuais dos equipamentos e da experiência em manutenção corretiva dos técnicos da Apsis.

Valor de investimento

Valor para um investidor em particular, baseado em interesses particulares no bem em análise. No caso de avaliação de negócios, este valor pode ser analisado por diferentes situações, tais como sinergia com demais empresas de um investidor, percepções de risco, desempenhos futuros e planejamentos tributários.

Valor de liquidação forçada

Valor de um bem colocado à venda no mercado fora do processo normal, ou seja, aquele que se apuraria caso o bem fosse colocado à venda separadamente, levando-se em consideração os custos envolvidos e o desconto necessário para uma venda em um prazo reduzido.

Valor de liquidação imediata

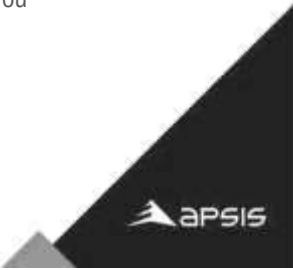
Igual ao Valor de Liquidação Forçada, mas com percentual de liquidação mais agressivo.

Valor depreciável

Custo do ativo, ou outra quantia substituta do custo (nas demonstrações contábeis), menos o seu valor residual.

Valor de reposição por novo

Valor baseado no que o bem custaria (geralmente em relação a preços correntes de mercado) para ser reposto ou substituído por outro novo, igual ou similar.



Valor de seguro

Valor pelo qual uma companhia de seguros assume os riscos e não se aplica ao terreno e às fundações, exceto em casos especiais.

Valor de sucata

Valor de mercado dos materiais reaproveitáveis de um bem, na condição de desativação, sem que estes sejam utilizados para fins produtivos.

Valor em risco

Valor representativo da parcela do bem que se deseja segurar e que pode corresponder ao valor máximo segurável.

Valor em uso

Valor de um bem em condições de operação no estado atual, como uma parte integrante útil de uma indústria, incluídas, quando pertinentes, as despesas de projeto, embalagem, impostos, fretes e montagem.

Valor (justo) de mercado

Valor pelo qual um ativo pode ser trocado de propriedade entre um potencial vendedor e um potencial comprador, quando ambas as partes têm conhecimento razoável dos fatos relevantes e nenhuma está sob pressão de fazê-lo.

Valor justo menos despesa para vender

Valor que pode ser obtido com a venda de ativo ou unidade geradora de caixa menos as despesas da venda, em uma transação entre partes conhecedoras, dispostas a tal e isentas de interesse.

Valor máximo de seguro

Valor máximo do bem pelo qual é recomendável que seja segurado. Este critério estabelece que o bem com depreciação maior que 50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro igual a duas vezes o Valor Atual; e aquele com depreciação menor que 50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro igual ao Valor de Reposição.

Valor presente

Estimativa do valor presente descontado de fluxos de caixa líquidos no curso normal dos negócios.

Valor recuperável

Valor justo mais alto de ativo (ou unidade geradora de caixa) menos as despesas de venda comparado com seu valor em uso.

Valor residual

Valor do bem novo ou usado projetado para uma data, limitada àquela em que o mesmo se torna sucata, considerando estar em operação durante o período.

Valor residual de ativo

Valor estimado que a entidade obterá no presente com a alienação do ativo, após deduzir as despesas estimadas desta, se o ativo já estivesse com a idade e condição esperadas no fim de sua vida útil.

Variáveis-chave

Variáveis que, *a priori* e tradicionalmente, são importantes para a formação do valor do imóvel.

Variáveis independentes

Variáveis que dão conteúdo lógico à formação do valor do imóvel, objeto da avaliação.

Variáveis qualitativas

Variáveis que não podem ser medidas ou contadas, apenas ordenadas ou hierarquizadas, de acordo com atributos inerentes ao bem (por exemplo, padrão construtivo, estado de conservação e qualidade do solo).

Variáveis quantitativas

Variáveis que podem ser medidas ou contadas (por exemplo, área privativa, número de quartos e vagas de garagem).

Variável dependente

Variável que se pretende explicar pelas independentes.

Variável dicotômica

Variável que assume apenas dois valores.

Vida remanescente

Vida útil que resta a um bem.

Vida útil econômica

Período no qual se espera que um ativo esteja disponível para uso, ou o número de unidades de produção ou similares que se espera obter do ativo pela entidade.

Vistoria

Constatação local de fatos, mediante observações criteriosas em um bem e nos elementos e condições que o constituem ou o influenciam.

Vocação do imóvel

Uso economicamente mais adequado de determinado imóvel em função das características próprias e do entorno, respeitadas as limitações legais.

W

WACC (Weighted Average Cost of Capital)

Modelo no qual o custo de capital é determinado pela média ponderada do valor de mercado dos componentes da estrutura de capital (próprio e de terceiros).

WARA (Weighted Average Return on Assets)

Taxa média ponderada de retorno esperado para os ativos e passivos que compõem a companhia objeto de análise, incluindo o *goodwill*.





Rio de Janeiro | +55 21 2212-6850
apsis.rj@apsis.com.br

São Paulo | 55 11 4550-2701
apsis.sp@apsis.com.br

Minas Gerais | +55 31 98299-6678
apsis.mg@apsis.com.br

apsis.com.br





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02432878442	GUSTAVO DOS SANTOS FERNANDES
07080589738	ROGERIO REIS DE CASTRO
68278772053	LEONARDO MODESTI VEDOLIN

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2024 18:10 SOB Nº 20241094208.
PROTOCOLO: 241094208 DE 03/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12414781298. CNPJ DA SEDE: 11006293000130.
NIRE: 21200147819. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/05/2024.
HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.

CNPJ/MF nº 11.006.293/0001-30

NIRE 21.2.0014781-9

24ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.884.855/0001-54, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.028, 8º andar, conjunto 81, Bairro Bela Vista, CEP 01310-200, com seu Estatuto Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.3.0002082-1, neste ato representada por seus Diretores **Rogério Reis de Castro**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 113165955, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 070.805.897-38, e **Gustavo dos Santos Fernandes**, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/DF sob o nº 016558 e no CPF/MF sob o nº 024.328.784-42, ambos com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2.028, 8º andar, conjunto 81, Bairro Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01310-200, ambos com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2.028, 8º andar, conjunto 81, Bairro Bela Vista, CEP 01310-200 ("**ÍMPAR**"); única sócia do **HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.**, sociedade limitada com sede na Avenida Jeronimo de Albuquerque, nº 540, Bairro Cohama, Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, CEP 65060-645, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.006.293/0001-30, e registrada perante a Junta Comercial do Estado do Maranhão ("**JUCEMA**") sob o NIRE 21.2.0014781-9 ("**Sociedade**"); resolve alterar e consolidar o contrato social da Sociedade, de acordo com as seguintes disposições:

1. CISÃO PARCIAL E REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

1.1. A única sócia aprova, sem quaisquer ressalvas, a cisão parcial da Sociedade com a versão da parcela cindida de seu patrimônio para a ÍMPAR ("**Cisão Parcial**"), nos termos do "Protocolo e Justificação de Cisão Parcial do Hospital São Domingos Ltda. com Incorporação da Parcela Cindida pela ÍMPAR", celebrado pela administração da Sociedade e da ÍMPAR ("**Cindenda**"), cuja cópia integra a presente alteração contratual na forma do Anexo I.

1.2. Ato contínuo, a sócia ratifica a nomeação e a contratação da APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, CEP 20.021-290, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.681.365/0001-30, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob nº 005112/O-9, devidamente representada pelo seu perito/sócio ora nomeado, LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA, portador do CREA/RJ sob o nº 89100165-5, inscrito no CPF sob o nº 886.681.937-91, e inscrito no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 118.236/P-0 ("**Empresa Avaliadora**"), responsável pela avaliação a valor contábil da parcela cindida do patrimônio líquido da Sociedade



HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.

CNPJ/MF nº 11.006.293/0001-30

NIRE 21.2.0014781-9

24ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

cindida e cindenda pela ÍMPAR, com base no balanço patrimonial da Sociedade levantado em 31 de janeiro de 2024 ("Parcela Cindida"), bem como pela elaboração do respectivo laudo de avaliação ("Laudo de Avaliação").

1.3. A única sócia aprova ainda o Laudo de Avaliação, cuja cópia consta do Anexo 8.5 ao Protocolo e Justificação.

1.3.1. A Parcela Cindida a ser incorporada pela Cindenda é composta, única e exclusivamente, por ativo imobilizado de titularidade da Sociedade conforme descrito no Anexo 5.1 do Protocolo e Justificação.

1.3.2. Nos termos do Laudo de Avaliação, o valor total líquido contábil da Parcela Cindida corresponde ao montante total de R\$ 32.433.747,76 (trinta e dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos).

1.3.3. As variações patrimoniais relativas à Parcela Cindida ocorridas entre a Data-Base e a presente data serão absorvidos exclusivamente pela Cindenda.

1.4. A única sócia aprova a Cisão Parcial, de acordo com os termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação, conforme descrito no Anexo 5.1 e considerando a sua aprovação pela acinista da Cindenda.

1.4.1. Nos termos do §1º do art. 229 da Lei das S.A., a Cindenda sucederá a Sociedade, a título universal e sem solução de continuidade, em todos os elementos patrimoniais de titularidade da Sociedade e integrantes ou relacionados à Parcela Cindida.

1.4.2. Nos termos do parágrafo único do art. 233 da Lei das S.A., a Cindenda será responsável exclusivamente pelos elementos patrimoniais que lhe forem expressamente transferidos neste ato, sem qualquer solidariedade com a Sociedade.

1.4.3. Nos termos da Cláusula 6.2 do Protocolo e Justificação, consignar que a Operação acarretará a redução do capital social da Sociedade, no valor total de R\$ 32.433.747,00 (trinta e dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e quarenta e sete reais), desprezando-se os centavos da Parcela Cindida, com o cancelamento de



HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.

CNPJ/MF nº 11.006.293/0001-30

NIRE 21.2.0014781-9

24ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

32.433.747 (trinta e dois milhões, quatrocentas e trinta e três mil, setecentas e quarenta e sete) quotas de emissão da Sociedade, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real).

1.4.4. A Cisão Parcial não resultará na extinção da Sociedade, que continuará existindo, sem qualquer solução de continuidade.

1.5. Ademais, a única sócia ratifica os atos praticados pelos administradores da Sociedade no presente instrumento e autoriza a realização de todas as medidas necessárias à implementação da Cisão Parcial, incluindo as diligências perante quaisquer entidades públicas e privadas competentes.

2. CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

2.1. Em face das deliberações tomadas nos itens acima, a sócia, neste ato, decide alterar a Cláusula 5ª e consolidar o Contrato Social, que passa a vigor, a partir desta data, com a seguinte nova redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO

HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.

CNPJ/MF nº 11.006.293/0001-30

NIRE 21.2.0014781-9

Capítulo I. Denominação, Sede, Objeto e Duração

Cláusula 1ª. A Sociedade Limitada Unipessoal terá a denominação de **HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.**, sendo regida por este Contrato Social e pelas disposições da Lei nº 10.406/02, aplicáveis a este tipo societário.

Cláusula 2ª. A Sociedade tem sede na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, nº 540, Bairro Cohama, CEP 65160-642 e poderá, por deliberação da administração, constituir e encerrar filiais, em qualquer parte do País ou no exterior.

Parágrafo Único. A sociedade possui as seguintes filiais:

- (i) Avenida Jerônimo de Albuquerque, nº 540, anexo Cardiologia, Bairro Cohama, Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, CEP 65060-645, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.006.293/0002-11 e na JUCEMA sob o NIRE 21.9.0015577-6;



HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.

CNPJ/MF nº 11.006.293/0001-30

NIRE 21.2.0014781-9

24ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

- (ii) Avenida Contorno Norte, nº 145, Shopping Passeio, Térreo, Lojas 125 e 141, Bairro Cohatrac IV, Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, CEP 65054-375, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.006.293/0005-64 e na JUCEMA sob o NIRE 21.9.0026235-1;
- (iii) Estrada de São José de Ribamar, nº 1000, ROD.MA 201, KM 05, Lojas 164-C, 164-D, 165, 165-A, 166 e 167, Shopping Pátio Norte, Bairro Saramanta, Cidade de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, CEP 65110-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.006.293/0006-45 e na JUCEMA sob o NIRE 21.9.0026402-8;
- (iv) Avenida dos Holandeses, nº 200, Golden Shopping, Loja 42 A, Bairro Calhau, Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, CEP 65071-380, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.006.293/0007-26 e na JUCEMA sob o NIRE 21.9.0029259-5;
- (v) Estrada de Ribamar, nº 1000, KM 05, ROD.MA 201, Lojas 03 e 170, Bairro Saramanta, Cidade de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, CEP 65110-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.006.293/0008-07 e na JUCEMA sob o NIRE 21.9.0032481-1;
- (vi) Avenida São Luís de França, nº 8, Rio Anil Shopping Center, Anexo LUC N. 1093 – PISO L, Bairro Turu, Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, CEP 65065-470, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.006.293/0009-98 e na JUCEMA sob o NIRE 21.9.0032482-9; e,
- (vii) Avenida São Luís de França, nº 8, Rio Anil Shopping Center, Anexo LUC N. 1094 – PISO L1, Bairro Turu, Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, CEP 65065-470, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.006.293/0010-21 e na JUCEMA sob o NIRE 21.9.0032480-2.

Cláusula 3ª. A Sociedade tem por objeto social: (i) o exercício da atividade de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; (ii) atividade de ressonância magnética; (iii) serviços de complementação diagnóstica e terapêutica (exames de função pulmonar, espirometria oxigenoterapia); (iv) serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizantes, exceto ressonância magnética; (v) serviços de diagnóstico por registro gráfico – ECG, EEG e outros exames análogos; (vi) serviços de diagnóstico por métodos ópticos – endoscopia e outros exames análogos; (vii) atividade médica ambulatorial restrita a consultas; (viii) atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; e (ix) serviços de vacinação e imunização humana.

Cláusula 4ª. O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.



HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.

CNPJ/MF nº 11.006.293/0001-30

NIRE 21.2.0014781-9

24ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Capítulo II. Capital Social

Cláusula 5ª. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 12.797.340,00 (doze milhões, setecentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta reais), representado por 12.797.340 (doze milhões, setecentas e noventa e sete mil, trezentas e quarenta) quotas, com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente detidas pela única sócia, **ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.**

Parágrafo Único. A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, que responde pela integralização do capital social, nos termos do Artigo 1.052, Parágrafo 1º, do Código Civil, incluído pela Lei nº 13.874/19.

Capítulo III. Administração

Cláusula 6ª. A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta por um Diretor Presidente e os demais Diretores sem Designação Específica, embora possam vir a adotar denominações pertinentes às suas funções, conforme vier a ser estabelecido na sua eleição, observadas as atribuições constantes deste Contrato Social.

Parágrafo 1º. Os Diretores, que deverão ser residentes e domiciliados no Brasil, serão eleitos e destituídos em Alterações do Contrato Social, ou ainda em instrumento específico em apartado que, devidamente arquivado perante a Junta Comercial do Estado da sede da Sociedade, servirá como prova suficiente de sua nomeação e capacidade.

Parágrafo 2º. Os Diretores serão eleitos pelo prazo de 3 (três) anos, sendo possível sua renúncia ou destituição a qualquer tempo, devendo, necessariamente, ser formalizada em documento escrito assinado pelo referido Diretor.

Parágrafo 3º. Compete aos Diretores a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes a esse fim, incluindo o dever de zelar pela observância da lei e deste Contrato Social, bem como pelo cumprimento das deliberações tomadas nas Reuniões dos Sócios, dispondo, entre outros poderes, dos necessários para:

- (i) a aprovação das contas da administração;
- (ii) administrar, gerir e superintender os negócios sociais no âmbito do objeto social;
- (iii) expedir regimentos internos, regulamentos e outras normas da mesma natureza no tocante à administração da Sociedade;



HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.

CNPJ/MF nº 11.006.293/0001-30

NIRE 21.2.0014781-9

24ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

(iv) distribuir, entre os seus membros, as funções de administração da Sociedade, observadas as disposições deste Contrato Social e outras que venham a ser decididas pelos sócios; e

(v) outorgar mandatos em nome da Sociedade, observada a forma de representação prevista no Contrato Social.

Parágrafo 4º. O Diretor Presidente terá por atribuições superintender as atividades de administração da Sociedade, coordenando e supervisionando as atividades dos membros da Diretoria.

Parágrafo 5º. Competirá aos Diretores sem Designação Específica a prática dos atos que vierem a ser estabelecidos pelo Diretor Presidente, respondendo pelas decisões relativas à sua respectiva área de competência, observados os limites deste Contrato Social e das normas internas.

Parágrafo 6º. A Sociedade será representada (a) por quaisquer 2 (dois) Diretores em conjunto; ou (b) por um Diretor e um procurador nomeado com poderes específicos; ou, ainda, (c) por um ou mais procuradores, observado o disposto no Parágrafo 8º abaixo.

Parágrafo 7º. As procurações serão outorgadas em nome da Sociedade por quaisquer 2 (dois) Diretores em conjunto. As procurações outorgadas deverão especificar os poderes e terão prazo de validade limitado ao máximo de 3 (três) anos. As procurações para fins de representação judicial ou para fins de representação perante as repartições aduaneiras, Receita Federal, Secretarias Estaduais da Fazenda, Prefeituras, INSS, FGTS, Delegacias Regionais do Trabalho, Delegacias de Polícia, órgãos de proteção e defesa do consumidor, dentre outros órgãos públicos, excepcionalmente, a Sociedade poderá ser representada de forma isolada, por qualquer Diretor ou qualquer procurador, desde que devidamente constituído na forma deste Contrato Social. Apenas as procurações para fins de representação judicial serão outorgadas sem limitação do prazo de validade.

Parágrafo 8º. A administração da Sociedade será exercida, nos termos deste Capítulo, pelos Srs. (i) Diretor Presidente: **Rogério Reis de Castro**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 113165955, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 070.805.897-38; (ii) Diretor Financeiro: **Murilo Faria Mariani**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº



HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.

CNPJ/MF nº 11.006.293/0001-30

NIRE 21.2.0014781-9

24ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

352255596, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 348.364.918-27; (iii) Diretora de Governança Clínica: **Gláucia Andrade e Silva Palácio**, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12950001999-6, expedida pela SSP/MA, inscrita no CPF/MF sob o nº 529.054.543-34; (iv) Diretores sem designação específica: (a) **Marcelino da Cunha Machado Neto**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade RG nº 039204582010-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 790.901.337-04; (b) **Leonardo Modesti Vedolin**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 4036073999, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 682.787.720-53; e (c) **Maria José Martinez Fernandez Campos**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 8460351, expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 073.280.738-70; todos com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Bairro Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-010.

Cláusula 7ª. É expressamente vedada a sócia, aos Diretores, aos empregados e aos procuradores da Sociedade, contraírem obrigações de qualquer natureza, em nome da Sociedade, em operações estranhas ao seu objeto social, sendo tais atos considerados nulos e sem efeito com relação à Sociedade.

Capítulo IV. Deliberações Sociais

Cláusula 8ª. As deliberações sociais serão tomadas por decisão da sócia que ocorrerá, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social da Sociedade para (a) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o resultado econômico da Sociedade; (b) designar administradores, quando for o caso; e (c) tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim exigirem.

Parágrafo 1º. A Sociedade poderá, mediante deliberação da sócia, levantar balanços mensais, trimestrais ou semestrais e distribuir os lucros neles evidenciados.

Parágrafo 2º. O lucro apurado, depois de feitas as deduções previstas em lei, terá a destinação que for dada pela sócia, representante da totalidade do capital social.

Parágrafo 3º. As deliberações a respeito das matérias abaixo listadas dependerão de aprovação da sócia, além das matérias que, nos termos da lei, dependem de autorização de sócios: (i) operações de fusão, cisão ou incorporação; (ii) alteração no objeto social que implique mudança substancial nas atividades desempenhadas pela Sociedade; (iii)



HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.

CNPJ/MF nº 11.006.293/0001-30

NIRE 21.2.0014781-9

24ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

celebração ou alteração de contratos, acordos, entendimentos ou transações entre a Sociedade e pessoas físicas ou jurídicas que, direta ou indiretamente, vierem a participar de seu capital social; (iv) celebração ou alteração de contratos cujo objeto seja avaliado em montante igual ou superior a 1% do Patrimônio Líquido (PL) da sociedade controladora ou a R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), prevalecendo o de menor valor; (v) a renúncia de direitos, celebração ou alteração de contratos, acordos, entendimentos e transações entre a Sociedade e/ou sociedades em que detenha participação societária; e (vi) pedido de recuperação, judicial ou extrajudicial, autofalência ou, ainda, o início de processo de dissolução, liquidação ou extinção da Sociedade.

Parágrafo 4º. As operações devem estar em conformidade com o capital social da Companhia vigente à época dos fatos, garantindo a preservação da estrutura financeira da empresa. Qualquer transação que ultrapasse os limites estabelecidos requererá aprovação prévia por Reunião de Sócios, conforme definido neste contrato social.

Capítulo V. Cessão e Transferência de Quotas

Cláusula 9ª. As quotas da Sociedade são indivisíveis e poderão ser cedidas, transferidas, alienadas, caucionadas ou gravadas, em favor de terceiros, devendo ainda serem observadas outras deliberações que vierem a ser tomadas por escrito pela sócia a respeito da transferência de quotas da Sociedade.

Capítulo VI. Liquidação da Sociedade

Cláusula 10ª. Em caso de liquidação ou dissolução da Sociedade, o liquidante será nomeado pela sócia. Neste caso, os ativos deverão ser utilizados para pagar todas as dívidas da Sociedade. No caso de haver ativo remanescente, este deverá ser destinado à sócia.

Capítulo VII. Disposições Gerais

Cláusula 11. A nulidade, no todo ou em parte, de qualquer disposição deste Contrato Social não afetará a validade ou exequibilidade de qualquer outra disposição ou parte deste Instrumento.

Cláusula 12. Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.

Cláusula 13. Toda e qualquer controvérsia oriunda deste instrumento ou a ele de qualquer forma relacionada, inclusive quanto a sua existência, validade, cumprimento, interpretação e extinção, será definitivamente resolvida pelo juízo da Comarca da Capital do Estado do Maranhão.



HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.
CNPJ/MF nº 11.006.293/0001-30
NIRE 21.2.0014781-9

24ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

E, assim, assinam o presente instrumento, eletronicamente, dispensando-se assinaturas físicas, em conformidade com a legislação aplicável.

São Luís, 31 de maio de 2024.

Sócia:

Ímpar Serviços Hospitalares S.A. Rogério Reis de Castro	Ímpar Serviços Hospitalares S.A. Gustavo dos Santos Fernandes
---	---



ID - 18794

PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE CISÃO PARCIAL DO
HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.
COM INCORPORAÇÃO DA PARCELA CINDIDA PELA
ÍMPAR SERVIÇOS HOSPÍTALARES S.A.

30 DE MAIO DE 2024



**PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE CISÃO PARCIAL DO HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.
COM INCORPORAÇÃO DA PARCELA CINDIDA PELA
ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.**

- (i) **HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.006.293/0001-30, com sede na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, nº 540, Bairro Cohama, CEP 65.160-642, neste ato representada na forma de seu Contrato Social por seus administradores **Rogério Reis de Castro**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 113165955, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 070.805.897-38, e **Leonardo Modesti Vedolin**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade nº 63945910, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 682.787.720-53, ambos com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2.028, 8º andar, conjunto 81, Bairro Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01310-200 ("Cindida" ou "Hospital São Domingos"); e
- (ii) **ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.884.855/0001-54, com sede na Cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2028, 8º andar, conjunto 81, Bela Vista, CEP 01.310-200, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social por seus Diretores **Rogério Reis de Castro**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 113165955, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 070.805.897-38, e **Gustavo dos Santos Fernandes**, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/DF sob o nº 016558 e no CPF/MF sob o nº 024.328.784-42, ambos com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2.028, 8º andar, conjunto 81, Bairro Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01310-200, ambos com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2.028, 8º andar, conjunto 81, Bairro Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01310-200 ("Cindenda" ou "Ímpar").

CONSIDERANDO QUE:

(a) a Cindida é, nesta data, sociedade empresária limitada e tem por objeto social, (i) o exercício da atividade de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; (ii) atividade de ressonância magnética; (iii) serviços de complementação diagnóstica e terapêutica (exames de função pulmonar, espirometria oxigenoterapia); (iv) serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizantes, exceto ressonância magnética; (v) serviços de diagnóstico por registro gráfico – ECG, EEG e outros exames análogos; (vi) serviços de diagnóstico por métodos ópticos – endoscopia e outros exames análogos; (vii) atividade médica ambulatorial restrita a consultas; (viii) atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; e (ix) serviços de vacinação e imunização humana;

(b) a Cindenda é, nesta data, sociedade por ações de capital fechado que tem por objeto



social a) prestação de assistência hospitalar; atendimento médico e ambulatorial nas suas instalações; servir de campo de aperfeiçoamento de médicos, enfermeiros e outros profissionais relacionados a essas atividades; proporcionar meios para a pesquisa e investigação científica; (b) atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares e também restrita a consultas; atenção ambulatorial não especificadas anteriormente; serviços de quimioterapia e radioterapia; atividades de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente; (c) atividades de enfermagem; de profissionais da nutrição; psicologia e psicanálise; fisioterapia; terapia ocupacional; fonoaudiologia; terapia alternativa; acupuntura; terapia de nutrição enteral e parenteral; profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente; (d) serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos; por métodos óticos; por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia; laboratórios clínicos; laboratórios de anatomia patologia e citologia; (e) atividades de atendimento hospitalar, pronto socorro e unidade hospitalares práticas integrativas e complementares em saúde humana; reprodução humana assistida; odontológica; serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências; UTI móvel; serviços de vacinação e imunização humana; (f) a participação em outras sociedades, empresárias ou não empresárias, voltadas à área da saúde, na qualidade de sócia; e (g) atividade de pesquisas clínicas, relacionadas à pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais.

(c) a Cindida, observados determinados termos e condições, pretende cindir uma parcela de seu patrimônio, composta por ativo imobilizado conforme descrito e detalhado na Cláusula 5.1 abaixo, e a Cindenda, observados determinados termos e condições, pretende incorporar a parcela do patrimônio destacada da Cindida; e

(d) O Hospital São Domingos e a Ímpar pretendem realizar a cisão parcial com incorporação da parcela cindida pela Ímpar.

Após procederem e concluírem estudos para a cisão parcial do Hospital São Domingos, resolvem, em atendimento ao disposto nos Artigos 224, 225, 226, 227 e 229 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das S.A.**"), da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 ("Código Civil") e da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, o presente "Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Cisão Parcial do Hospital São Domingos Ltda. com Incorporação da Parcela Patrimonial pela Ímpar Serviços Hospitalares S.A." observados os termos, cláusulas e condições adiante consubstanciados ("Protocolo e Justificação").

1. CONDIÇÕES GERAIS E JUSTIFICAÇÃO:

1.1 Este instrumento de Protocolo e Justificação tem por objeto consubstanciar as justificativas, os termos, as cláusulas e as condições da cisão parcial do patrimônio da Cindida e a incorporação da



ID - 18794

parcela patrimonial destacada da Cindida pela Cindenda, de modo que, após a cisão parcial e respectiva incorporação da parcela cindida, a Cindida continuará existindo e a Cindenda sucederá a Cindida, a título universal, em relação aos elementos patrimoniais relacionados à parcela patrimonial cindida e incorporada pela Cindenda, observados os termos dos artigos 227 e 229 da Lei das S.A., tudo de acordo com e nos termos deste Protocolo e Justificação ("Cisão Parcial" ou "Operação").

1.2 Em decorrência da Operação, a totalidade dos elementos patrimoniais que integram a parcela cindida do patrimônio da Cindida, composta pelo ativo imobilizado descrito e detalhado na Cláusula 5.1 abaixo, serão vertidos para a Cindenda, a qual somente será responsável pelos ativos, dívidas, obrigações e passivos que lhe forem expressamente transferidos neste Protocolo e Justificação, não sendo solidariamente responsável por quaisquer outros ativos, dívidas, obrigações e passivos da Cindida, em consonância com o disposto no artigo 233, parágrafo único, da Lei das S.A.

1.3 A Operação insere-se no contexto de reorganização administrativa, operacional, financeira e jurídica dos negócios das Partes, e será realizada tendo em vista a necessidade de segregação e redistribuição de determinados elementos patrimoniais da Cindida em outra estrutura societária, visando otimizar a sua estrutura de capital e de gestão e, ao mesmo tempo, permitir a realocação destes elementos patrimoniais com maior eficiência.

2. INTERESSE DAS PARTES NA REALIZAÇÃO DA CISÃO PARCIAL:

2.1 A realização da Operação se justifica e é interessante para os sócios da Cindida e para a única acionista da Cindenda, após a realização dos estudos julgados necessários, pois será possível reorganizar e explorar os elementos patrimoniais segregados da Cindida de modo mais eficiente, mantendo o padrão e orientação geral de negócios. Além disso, a Operação trará consideráveis benefícios às Partes, de ordem administrativa, econômica e financeira, dentre os quais se destacam:

- (i) a racionalização e simplificação da gestão dos ativos das Partes; e
- (ii) a reorganização de determinados ativos imobilizados da Cindida permitirá o desenvolvimento de atividade empresarial pela Cindenda de forma segregada, otimizando, assim, os riscos relativos a este negócio para as Partes.

2.2 Uma vez aprovada a Cisão Parcial e o presente Protocolo e Justificação pelos sócios da Cindida e pela única acionista da Cindenda, a Cisão será implementada da seguinte forma:



3. COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL ANTES DA CISÃO PARCIAL:

3.1 Atual Composição do Capital Social da Cindida: O capital social do Hospital São Domingos, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 45.231.087,00 (quarenta e cinco milhões, duzentos e trinta e um mil e oitenta e sete reais), representado por 45.231.087,00 (quarenta e cinco milhões, duzentas e trinta e uma mil e oitenta e sete) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente detidas pela única sócia, ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.

Sócio	Número de Quotas	Capital Social (R\$)	%
ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.	45.231.087	45.231.087,00	100,00%
Total	45.231.087	45.231.087,00	100,00

3.2 Atual Composição do Capital Social da Cindenda: O capital social da ÍMPAR, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 7.249.875.297,31 (sete bilhões, duzentos e quarenta e nove milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos), divididos em 7.879.090.451 (sete bilhões, oitocentos e setenta e nove milhões, noventa mil, quatrocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, detidas pela única acionista DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.

Acionista	Número de Ações	Capital Social (R\$)	%
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	7.879.090.451	7.249.875.297,31	100,00%
Total	7.879.090.451	7.249.875.297,31	100,00

4. DIREITO DE RETIRADA E RECONSIDERAÇÃO DA OPERAÇÃO:

4.1 A Operação não constitui hipótese de exercício de direito de retirada pela sócia da Cindida, nos termos previstos nos arts. 136, caput, IX e 137, caput, III da Lei das S.A. Adicionalmente, tendo em vista que a única acionista titular da totalidade do capital social total e votante da Cindenda manifestou concordância com a Operação, não há que se falar em exercício do direito de retirada conforme previsto no artigo 137 da Lei das S.A.

4.2 Visto que não haverá acionista ou sócio legitimado para exercer o direito de retirada, seja da Cindida ou da Cindenda, conforme aplicável, conforme disposto acima, não haverá a possibilidade de reconsideração da Operação por risco à estabilidade financeira da Cindida, consoante previsto no §3º do art. 137 da Lei das S.A.



5. PARCELA CINDIDA:

5.1 Em razão da Operação, serão vertidos para a Cindenda, a título universal e sem solução de continuidade, os elementos patrimoniais integrantes do patrimônio da Cindida, conforme indicados no Laudo de Avaliação previsto na Cláusula 8.5 abaixo, sendo que, resumidamente, a parcela cindida será composta, única e exclusivamente, pelo ativo imobilizado e propriedades para investimentos, devidamente descrito no laudo anexo ("Parcela Cindida").

5.2 A Cindida declara, neste ato, ter pleno conhecimento sobre a situação, quantidade e estado do ativo imobilizado que compõe a Parcela Cindida ou de qualquer forma a ele relacionado que será transferido da Cindida à Cindenda em virtude da Operação no estado, quantidade e condição em que se encontra.

6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO E CAPITAL SOCIAL DA CINDIDA:

6.1 Nos termos do disposto na Cláusula 6.2 abaixo, a Operação importará em redução do patrimônio líquido da Cindida no valor do acervo líquido da Parcela Cindida, no montante de R\$ 32.433.747,76 (trinta e dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), conforme o Laudo de Avaliação previsto na Cláusula 8.5 abaixo.

6.2 A Operação acarretará a redução do capital social da Cindida no valor de 32.433.747,00 (trinta e dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e quarenta e sete reais) **desconsiderados os centavos da Parcela Cindida**, mediante o cancelamento de 32.433.747 (trinta e dois milhões, quatrocentas e trinta e três mil, setecentas e quarenta e sete) quotas de emissão da Cindida, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, todas elas de titularidade da Cindenda.

6.3 O capital social da Cindida será reduzido em razão da Operação, nos termos da Cláusula 6.2 acima, de forma que o valor do capital social após a Operação será de R\$ 12.797.340,00 (doze milhões, setecentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta reais), dividido em 12.797.340 (doze milhões, setecentas e noventa e sete mil, trezentas e quarenta) quotas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente detidas pela única sócia, ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.

Sócio	Número de Quotas	Capital Social (R\$)	%
ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.	12.797.340	12.797.340,00	100,00%
Total	12.797.340	12.797.340,00	100,00



7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO E CAPITAL SOCIAL DA CINDENDA:

7.1 A Operação não resultará em alteração no valor do patrimônio líquido ou aumento do capital social da Cindenda, uma vez que a Cindenda é a detentora, na presente data, de quotas representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Cindida.

7.2 O capital social da Cindenda, totalmente subscrito e integralizado, permanecerá no valor de R\$ 7.249.875.297,31 (sete bilhões, duzentos e quarenta e nove milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos), divididos em 7.879.090.451 (sete bilhões, oitocentos e setenta e nove milhões, noventa mil, quatrocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, detidas pela única acionista DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.

Acionista	Número de Ações	Capital Social (R\$)	%
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	7.879.090.451	7.249.875.297,31	100,00%
Total	7.879.090.451	7.249.875.297,31	100,00

8. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA PARCELA CINDIDA:

8.1 Crítério de Avaliação. A Parcela Cindida foi realizada pelo critério de avaliação do valor patrimonial contábil dos bens, direitos e obrigações refletidos no balanço base da Cindida referentes à Parcela Cindida apurado de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, considerando- se, para tanto, o balanço da Cindida datado de 31 de janeiro de 2024 ("Data-Base"), bem como os seus respectivos livros e registros contábeis, fiscais, analíticos e auxiliares.

8.2 Empresa Avaliadora. As Partes contrataram a APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, CEP 20.021-290, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.681.365/0001-30, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob nº 005112/O-9, devidamente representada pelo seu perito/sócio ora nomeado, LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA, portador do CREA/RJ sob o nº 89100165-5, inscrito no CPF sob o nº 886.681.937- 91, e inscrito no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 118.236/P- 0 ("Empresa Avaliadora"), para a elaboração do Laudo de Avaliação contábil da Parcela Cindida, nos termos dos artigos 226, 227 e 229 da Lei das S.A.



8.3 Ratificação da Contratação e Nomeação da Empresa Avaliadora. A escolha, a contratação e a nomeação da Empresa Avaliadora para elaboração do Laudo de Avaliação contábil da Parcela Cindida deverão ser ratificadas pelos sócios da Cindida e acionistas da Cindenda.

8.4 Declaração da Empresa Avaliadora. Nos termos da legislação vigente, a Empresa Avaliadora declarou, no momento de sua contratação: **(i)** não ser titular, direta ou indiretamente, de qualquer valor mobiliário ou derivativo referenciado em valor mobiliário de emissão da Cindida ou da Cindenda; **(ii)** não ter conflito de interesses que lhe diminuam a independência necessária ao desempenho de suas funções; e **(iii)** que não teve, por parte dos controladores e administradores das Partes, qualquer tipo de limitação à realização dos trabalhos necessários.

8.5 Laudo de Avaliação. O laudo de avaliação, que apresenta os resultados da avaliação contábil da Parcela Cindida, nos termos dos artigos 226, 227 e 229 da Lei das S.A., passa a integrar o presente Protocolo e Justificação na forma do **Anexo** ("Laudo de Avaliação").

8.6 Valor Atribuído. Conforme o Laudo de Avaliação, o valor total do acervo líquido da Parcela Cindida a ser vertido para a Cindenda corresponde a R\$ 32.433.747,76 (trinta e dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos).

8.7 Variações Patrimoniais. A Cindenda assumirá, absorverá e suportará as variações patrimoniais relativas à Parcela Cindida que ocorrerem entre a Data-Base e a data da efetiva realização da Operação, as quais serão refletidas no seu patrimônio líquido, conforme o caso.

9. EFEITOS DA CISÃO PARCIAL:

9.1 A operação não resultará na extinção da Cindida, que continuará existente, sem qualquer solução de continuidade.

10. SUCESSÃO; REGISTRO E AVERBAÇÃO

10.1 A Cindenda sucederá a Cindida, a título universal e sem solução de continuidade, em relação aos bens, direitos, pretensões, faculdades, poderes, imunidades, ações, exceções, deveres, obrigações, sujeições, ônus e responsabilidades exclusivamente relacionados à Parcela Cindida a ser incorporada pela Cindenda nos termos deste Protocolo e Justificação.

10.2 Nos termos do parágrafo único do art. 233 da Lei das S.A., a Cindenda assumirá a responsabilidade, isoladamente e exclusivamente, pelos elementos patrimoniais integrantes da Parcela Cindida. Desse modo, a Cindenda não será responsável solidária pelas dívidas,



obrigações, passivos, ônus, responsabilidades e contingências da Cindida que forem estranhas à Parcela Cindida.

10.3 Nos termos do art. 234 da Lei das S.A., a certidão da Operação passada pelo registro público de empresas mercantis será documento hábil para o registro e a averbação, nos registros públicos e privados competentes, incluindo os Cartórios de Registro de Imóveis competentes, da sucessão universal pela Cindida em todos os bens, direitos, pretensões, faculdades, poderes, imunidades, ações, exceções, deveres, obrigações, sujeições, ônus e responsabilidades da Cindida relacionados à Parcela Cindida.

11. APROVAÇÕES SOCIETÁRIAS:

11.1 Alteração do Contrato Social da Cindida. Deverá ser realizada alteração do Contrato Social da Cindida para deliberar e aprovar, dentre outras matérias: **(i)** os termos e condições deste Protocolo e Justificação; **(ii)** a ratificação da nomeação da Empresa Avaliadora para a elaboração do Laudo de Avaliação; **(iii)** a aprovação do Laudo de Avaliação contábil da Parcela Cindida; **(iv)** a Cisão Parcial, nos termos e condições do presente Protocolo e Justificação; **(v)** a redução do capital social da Cindida em decorrência da Operação; e **(vi)** a autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação da Operação.

11.2 Assembleia Geral Extraordinária da Cindenda. Deverá ser realizada Assembleia Geral Extraordinária da Cindenda para deliberar e aprovar, dentre outras matérias: **(i)** os termos e condições deste Protocolo e Justificação; **(ii)** a ratificação da nomeação da Empresa Avaliadora para a elaboração do Laudo de Avaliação; **(iii)** a aprovação do Laudo de Avaliação contábil da Parcela Cindida; **(iv)** a Cisão Parcial, nos termos e condições do presente Protocolo e Justificação; e **(v)** a inexistência de aumento do capital social da Cindenda em decorrência da Operação.

11.3 A Operação não resultará na abertura de novas filiais da Cindenda.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS:

12.1 Atos dos Administradores. Uma vez aprovada a Cisão Parcial e a incorporação da Parcela Cindida, os administradores das Sociedades ficarão responsáveis e autorizados a tomarem as medidas necessárias para a implementação dos termos e condições pactuados neste Protocolo e Justificação, em observância à legislação aplicável e aos seus respectivos Contratos Sociais.

12.2 Negócios Dependentes. Este Protocolo e Justificação é celebrado no contexto da simplificação da malha societária da Cindida e da Cindenda, conforme informado na Cláusula 2.1 deste instrumento. Os eventos descritos no presente Protocolo e Justificação, bem como as demais



matérias conexas submetidas aos acionistas e sócios das Partes nas assembleias gerais extraordinárias e reunião de sócios que deliberarem sobre este Protocolo e Justificação e a Operação são negócios jurídicos reciprocamente dependentes, sendo intenção das Partes que um negócio não tenha eficácia sem que os demais também a tenham.

12.3 Capacidade. Cada Parte assina este Protocolo e Justificação e declara: **(i)** estar ciente das obrigações decorrentes deste instrumento e da legislação que rege este instrumento; **(ii)** ter sido assistida por advogados e que, em virtude de suas atividades cotidianas na gestão de suas respectivas empresas, ter compreensão integral de todos os termos e condições deste instrumento; e **(iii)** não estar sujeita a qualquer necessidade econômica ou financeira excepcional, assumindo integralmente os encargos e riscos inerentes à Operação.

12.4 Custos e Despesas. Cada Parte deve arcar com suas respectivas despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da celebração deste Protocolo e Justificação e da consumação da Operação, incluindo, sem limitação, despesas com publicações, assessores jurídicos e financeiros, registros e averbações necessários, observadas as regras especificadas estipuladas neste protocolo.

12.5 Tributos. Cada uma das Partes deverá recolher e pagar pontualmente todos os tributos incidentes em razão da Operação e para os quais seja definida como contribuinte pela legislação tributária. Adicionalmente, as Partes autorizam-se mutuamente a reter e pagar em nome e por conta da outra todos os tributos para os quais a legislação tributária determine o recolhimento na fonte, observadas as regras especificadas estipuladas neste protocolo.

12.6 Requisitos e Aprovações. Este instrumento de Protocolo e Justificação contém as condições exigidas pela Lei das S.A. para a proposta da Operação, com a consequente incorporação da Parcela Cindida de titularidade da Cindida pela Cindenda, conforme previsto neste Protocolo e Justificação, e deverá ser submetido à apreciação e aprovação do acionista e sócio das Partes.

12.7 Acordo Integral. Este instrumento de Protocolo e Justificação constitui o único e integral acordo entre as Partes no tocante à Operação, que constitui seu objeto, substituindo e superando para todos os efeitos quaisquer outros documentos assinados anteriormente a esta data.

12.8 Sobrevivência de Cláusulas. Caso alguma cláusula, disposição, termo ou condição deste instrumento de Protocolo e Justificação venha a ser considerado inválido ou inexecutável, as demais cláusulas, disposições, termos e condições não afetados permanecerão válidos e em pleno vigor.

12.9 Renúncia; Não Exercício. O não exercício, ou o atraso no exercício, por qualquer das Partes, dos direitos a elas respectivamente conferidos nos termos deste Protocolo e Justificação não será interpretado como renúncia em relação a tal direito. Toda e qualquer renúncia aos direitos



ID - 18794

estabelecidos neste Protocolo e Justificação somente será válida quando entregue por escrito e assinada pela Parte renunciante.

12.10 Aditamentos. Este Protocolo e Justificação somente poderá ser alterado ou aditado por escrito, em instrumento particular assinado por todos os seus subscritores.

12.11 Cessão. É vedada a cessão de quaisquer dos direitos e obrigações pactuados no presente Protocolo e Justificação sem o prévio e expresso consentimento, por escrito, de cada uma das Partes.

12.12 Execução Específica. As obrigações assumidas neste Protocolo e Justificação serão objeto de execução específica por qualquer das Partes, nos termos dos arts. 493, 497, 501 e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada ("Código de Processo Civil"). As Partes não renunciam a qualquer ação ou providência a que tenham direito a qualquer tempo. As Partes expressamente admitem e se obrigam ao cumprimento específico de suas obrigações e a aceitar ordens judiciais ou quaisquer outros atos semelhantes. Este Protocolo e Justificação servirá como título executivo extrajudicial, para instruir qualquer demanda que vise ao seu cumprimento, conforme dispõe o art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

12.13 Anexos. Este instrumento particular de Protocolo e Justificação contém 2 (dois) anexos, cujas numerações são atribuídas conforme a cláusula que se refere a cada anexo, e fazem parte integrante e indissociável do presente instrumento.

12.14 Lei Aplicável. Este instrumento de Protocolo e Justificação será regido, interpretado e aplicado de acordo com a legislação vigente da República Federativa do Brasil.

12.15 Foro. Fica eleito o foro central da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir todas as questões oriundas do presente Protocolo e Justificação, com a renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

12.16 Assinatura Digital. As Partes concordam e declaram que a assinatura deste Protocolo e Justificação poderá ser feita por meio da plataforma DocuSign (www.docusign.com) e a declaram como meio válido e idôneo juntamente com as respectivas páginas de certificação, as quais são partes integrantes do presente. Este documento produz efeitos para todas as Partes a partir da data nele indicada, ainda que uma ou mais Partes realizem a assinatura eletrônica em data posterior. Ademais, ainda que alguma das partes venha a assinar eletronicamente este instrumento em local diverso, o local de celebração deste instrumento é, para todos os fins, a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, conforme abaixo indicado.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes, assinam o presente Protocolo e Justificação de



Página 11 de 13



ID - 18794

Incorporação em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, 30 de maio de 2024.

Hospital São Domingos LTDA. p. Rogério Reis de Castro	Hospital São Domingos LTDA. p. Leonardo Modesti Vedolin
Ímpar Serviços Hospitalares S.A. p. Rogério Reis de Castro	Ímpar Serviços Hospitalares S.A. p. Gustavo dos Santos Fernandes



ID - 18794

ANEXO

LAUDO DE AVALIAÇÃO





LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00149/24-01

Hospital São Domingos Ltda.



LAUDO DE AVALIAÇÃO: AP-00149I24-01

DATA-BASE: 31 de janeiro de 2024

LAUDO DE AVALIAÇÃO DO ACERVO LÍQUIDO DE HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA., APURADO POR MEIO DOS LIVROS CONTÁBEIS

1. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

A APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA., sociedade estabelecida na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 08.681.365I0001-30, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro sob o nº 005112IO-9, representada por seu sócio infra-assinado, LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA, contador, portador do documento de identidade nº 89100165-5ID (CREAIRJ), inscrito no CPF sob o nº 886.681.937-91 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 118.263IP-0, residente e domiciliado na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, foi nomeada pela administração de ÍMPAR SERVICOS HOSPITALARES S.A., doravante denominada ÍMPAR, com sede na Avenida Paulista, nº 2.028, 8º andar, Conjunto 81, Bela Vista, Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 60.884.855I0001-54, para proceder à avaliação do acervo líquido de HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA., doravante denominada HOSPITAL SÃO DOMINGOS, com sede na Avenida Jerônimo de Albuquerque, nº 540, Cohama, Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 11.006.293I0001-30, em 31 de janeiro de 2024, de acordo com as práticas contábeis brasileiras - que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) -, e apresenta a seguir o resultado de seus trabalhos.



2. OBJETIVO DA AVALIAÇÃO

A avaliação do acervo líquido de HOSPITAL SÃO DOMINGOS na data-base, nos termos dos artigos 226 e 229 da Lei nº 6.404/76, tem em vista verificar o valor contábil da parcela a ser vertida a ÍMPAR, para fins de cisão parcial, conforme detalhado no Anexo 2 deste Laudo.

3. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

A administração de HOSPITAL SÃO DOMINGOS é responsável pela escrituração dos livros e pela elaboração de informações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo CPC e aprovados pelo CFC, assim como pelos controles internos relevantes que ela definiu como necessários para permitir que tal processo seja livre de distorção significativa, independentemente se causada por fraude ou erro. O resumo das principais práticas contábeis adotadas pela companhia está descrito no Anexo 3 do Laudo de Avaliação.

4. ALCANCE DOS TRABALHOS E RESPONSABILIDADE DO CONTADOR

Nossa responsabilidade é apresentar uma conclusão sobre o valor contábil do acervo líquido formado por determinados ativos em 31 de janeiro de 2024, com base nos trabalhos conduzidos de acordo com o Comunicado Técnico CTG 2002, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o qual prevê o exame das contas que englobam os determinados ativos constantes do Anexo 1 deste Relatório e que, naquela data, estavam registrados no balanço patrimonial de HOSPITAL SÃO DOMINGOS. Assim, examinamos o referido acervo líquido conforme as normas contábeis aplicáveis, que requerem o cumprimento de exigências éticas, bem como um planejamento e uma execução com o objetivo de obter segurança razoável de que o objeto está livre de distorção relevante.

A emissão de laudo de avaliação envolve a execução de procedimentos selecionados para a obtenção de evidência a respeito dos valores contabilizados. Essa ação depende do julgamento do contador, incluindo a avaliação dos riscos de distorção significativa no acervo líquido, independentemente se causada por fraude ou erro. Em tal análise, o contador considera os controles internos pertinentes à elaboração do balanço patrimonial da empresa para planejar os processos apropriados às circunstâncias, mas não com vistas a expressar uma opinião sobre a efetividade de tais documentos.

O trabalho abarca, também, a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração. Acreditamos que a evidência obtida é suficiente e adequada para fundamentar nossa conclusão.



5. CONCLUSÃO

Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor de R\$ 32.433.747,76 (trinta e dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), referente ao acervo líquido resumido no Anexo 2, conforme constava no balanço patrimonial de HOSPITAL SÃO DOMINGOS na data-base, registrado nos livros contábeis, representa, em todos os aspectos relevantes, o acervo líquido da companhia, avaliado de acordo com as práticas contábeis brasileiras.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2024.

APSYS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA.

CRCIRJ-005112IO-9

LUIZ PAULO
CESAR
SILVEIRA:88
668193791

Assinado de forma
digital por LUIZ
PAULO CESAR
SILVEIRA:886681
93791
Dados: 2024.03.28
16:13:14 -03'00'

LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA
Vice-Presidente
Contador (CRCIRJ-118.263IP-0)



6. RELAÇÃO DE ANEXOS

1. Documentação de suporte
2. Resumo do acervo líquido
3. Resumo das principais práticas contábeis adotadas por HOSPITAL SÃO DOMINGOS
4. Glossário



ANEXO 1



Hospital São Domingos Ltda.
CNPJ: 11.006.293/0001-30
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE JANEIRO DE 2024
(Valores expressos em reais)

	31/01/2024		31/01/2024
ATIVO		PASSIVO E PL	
Caixa e equivalentes de caixa	23.639.455,94	Fornecedores	60.925.825,53
Contas a receber de clientes	343.771.818,37	Empréstimos e financiamentos	5.747.305,18
Estoques	34.998.750,82	Obrigações sociais e trabalhistas	33.110.554,67
Tributos a recuperar	4.271.949,70	Imposto de renda e contribuição social a pagar	8.408.906,13
Outros créditos	10.627.537,62	Impostos e contribuições a recolher	22.411.908,03
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	417.309.512,45	Impostos parcelados	33.706.449,85
		Dividendos e juros sobre o capital próprio	28.187.784,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Passivos de arrendamentos	3.583.405,30
Tributos diferidos	59.963.753,36	Outras contas a pagar e provisões	218.558.464,90
Depósitos judiciais	1.889.595,92	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	414.640.603,65
Partes relacionadas	40.490.524,02		
Outros créditos.	3.872.094,16	Empréstimos e financiamentos	40.447.363,48
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.215.967,46	Impostos parcelados	5.443.680,39
		Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis	212.734.874,95
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		Partes relacionadas	71.000,00
Imobilizado	125.578.459,96	Passivos de arrendamentos	268.043.728,15
Intangível	3.520.011,64	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	526.740.646,97
Direito de uso	269.698.880,27		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	398.797.351,87	Capital Social	1.599.999,51
		Reservas de Lucros	18.244.685,81
		Resultados do Exercício	13.465.808,49
		Resultados Abrangentes	(96.000.000,00)
		Adiantamento de futuro aumento de capital	43.631.087,35
		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.058.418,84)
Total do Ativo	922.322.831,78	Total do Passivo e PL	922.322.831,78

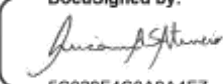
DocuSigned by:

 5C029F4C0A9A4E7...
 Lucianne Assôfa Sperandio
 Gerente Executiva de Controladoria
 CRC 1SP264068/O-6



Hospital São Domingos Ltda.
CNPJ: 11.006.293/0001-30
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE JANEIRO DE 2024
(Valores expressos em reais)

	<u>31/01/2024</u>
Receita operacional bruta	92.673.633
Deduções da Receita	(8.088.418)
Custo dos serviços prestados	<u>(47.545.475)</u>
Lucro bruto	<u>37.039.740</u>
Despesas gerais e administrativas	(8.112.418)
Outras receitas operacionais	<u>151.098</u>
Lucro/Prej. antes de desp. financ., equiv. patr. e impostos	<u>(7.961.320)</u>
Resultado financeiro líquido	<u>(8.900.424)</u>
Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e contrib. social	<u>(8.900.424)</u>
Imposto de renda e contribuição social diferido	(8.576.284)
Imposto de renda e contribuição social corrente	<u>1.864.096</u>
Lucro ou Prejuízo do exercício	<u>(6.712.188)</u>
(=) Resultado Líquido	<u>13.465.808</u>

DocuSigned by:

5C029F4C0A9A4E7...
Lucianne Assôfra Sperandio Atencio
Gerente Executivo de Controladoria
CRC 1SP264068/O-6



ANEXO 2



HOSPITAL SÃO DOMINGOS	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	
BALANÇO PATRIMONIAL (R\$)	SALDOS EM 31/01/2024	ACERVO A SER CINDIDO
ATIVO CIRCULANTE	417.309.512,45	-
Caixa e equivalente de caixa	23.639.455,94	-
Contas a receber	343.771.818,37	-
Estoques	34.998.750,82	-
Impostos a recuperar	4.271.949,70	-
Outros ativos circulantes	10.627.537,62	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	505.013.319,33	32.433.747,76
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	106.215.967,46	-
Tributos diferidos	40.490.524,02	-
Depósitos judiciais	1.889.595,92	-
Impostos diferidos	59.963.753,36	-
Outros ativos não circulantes	3.872.094,16	-
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	6.723.784,32	6.723.784,32
IMOBILIZADO	118.854.675,64	25.709.963,44
INTANGÍVEL	3.520.011,64	-
DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	269.698.880,27	-
TOTAL DO ATIVO	922.322.831,78	32.433.747,76
PASSIVO CIRCULANTE	414.640.603,65	-
Fornecedores	60.925.825,53	-
Empréstimos e financiamentos	5.747.305,18	-
Salários e encargos a recolher	33.110.554,67	-
Impostos e contribuições a recolher	22.411.908,03	-
Imposto de Renda e Contribuição Social a recolher	8.408.906,13	-
Impostos parcelados	33.706.449,85	-
Dividendos e juros sobre o capital próprio	28.187.784,06	-
Arrendamento	3.583.405,30	-
Outros passivos circulantes	218.558.464,90	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	526.740.646,97	-
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	526.740.646,97	-
Empréstimos e financiamentos	40.447.363,48	-
Impostos parcelados	5.443.680,39	-
Partes relacionadas	71.000,00	-
Passivo de arrendamento	268.043.728,15	-
Provisão para contingências	212.734.874,95	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.058.418,84)	32.433.747,76
TOTAL DO PASSIVO	922.322.831,78	32.433.747,76

ANEXO 3



RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS POR HOSPITAL SÃO DOMINGOS**Propriedades para investimento**

Propriedades para investimento, registrados ao valor de custo original, referem-se a partes de edifícios operacionais da empresa.

Imobilizado

É registrado ao custo de aquisição, formação ou construção e acrescido de juros durante o período de construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (*impairment*) acumuladas, quando aplicável.

Passivos

São reconhecidos no balanço quando o HOSPITAL SÃO DOMINGOS tem uma obrigação presente (legal ou presumida) ou resultante de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-la. Alguns passivos envolvem incertezas quanto ao prazo e ao valor e são estimados por meio de provisão à medida que são incorridos e registrados. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.



ANEXO 4



GLOSSÁRIO

A

ABL

Área bruta locável.

ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Abordagem da renda

Método de avaliação pela conversão a valor presente de benefícios econômicos esperados.

Abordagem de ativos

Método de avaliação de empresas em que todos os ativos e passivos (incluindo os não contabilizados) têm seus valores ajustados aos de mercado. Também conhecido como patrimônio líquido a mercado.

Abordagem de mercado

Método de avaliação no qual são adotados múltiplos comparativos derivados de preço de vendas de ativos similares.

Ágio por expectativa de rentabilidade futura (fundo de comércio ou goodwill)

Benefícios econômicos futuros decorrentes de ativos não passíveis de serem individualmente identificados nem separadamente reconhecidos.

Amortização

Alocação sistemática do valor amortizável de ativo ao longo de sua vida útil.

Amostra

Conjunto de dados de mercado representativos de uma população.

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)

Refere-se à certificação de Engenheiros e Arquitetos.

Aproveitamento eficiente

Aquele recomendável e tecnicamente possível para o local, em uma data de referência, observada a tendência mercadológica nas circunvizinhanças, entre os diversos usos permitidos pela legislação pertinente.

Área Boma

Somatório de parte da área comum com a área útil.

Área equivalente de construção

Área construída sobre a qual é aplicada a equivalência de custo unitário de construção correspondente, de acordo com os postulados da ABNT.

Área homogeneizada

Área útil, privativa ou construída com tratamentos matemáticos, para fins de avaliação, segundo critérios baseados no mercado imobiliário.

Área privativa

Área útil acrescida de elementos construtivos (tais como paredes, pilares etc.) e *halde* elevadores (em casos particulares).

Área total de construção

Resultante do somatório da área real privativa e da área comum atribuídas a uma unidade autônoma, definidas conforme a ABNT.

Área útil

Área real privativa subtraída a área ocupada pelas paredes e por outros elementos construtivos que impeçam ou dificultem sua utilização.

Arrendamento mercantil financeiro

O que transfere substancialmente todos os riscos e benefícios vinculados à posse do ativo, o qual pode ou não ser futuramente transferido. O arrendamento que não for financeiro é operacional.

Arrendamento mercantil operacional

O que não transfere substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à posse do ativo. O arrendamento que não for operacional é financeiro.

Ativo

Recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados dos quais se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade.

Ativo imobilizado

Ativos tangíveis disponibilizados para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, na locação por outros, investimento, ou fins administrativos, esperando-se que sejam usados por mais de um período contábil.

Ativo intangível

Ativo identificável não monetário sem substância física. Tal ativo é identificável quando: a) for separável, isto é, capaz de ser separado ou dividido da entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, tanto individualmente quanto junto com contrato, ativo ou passivo relacionados; b) resulta de direitos contratuais ou outros direitos legais, quer esses direitos sejam transferíveis quer sejam separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações.

Ativo tangível

Ativo de existência física como terreno, construção, máquina, equipamento, móvel e utensílio.

Ativos não operacionais

Aqueles não ligados diretamente às atividades de operação da empresa (podem ou não gerar receitas) e que podem ser alienados sem prejuízo do seu funcionamento.

Ativos operacionais

Bens fundamentais ao funcionamento da empresa.

Avaliação

Ato ou processo de determinar o valor de um ativo.



B

BDI (Budget Difference Income)

Benefícios e Despesas Indiretas. Percentual que indica os benefícios e as despesas indiretas incidentes sobre o custo direto da construção.

Bem

Coisa que tem valor, suscetível de utilização ou que pode ser objeto de direito, que integra um patrimônio.

Benefícios econômicos

Benefícios como receitas, lucro líquido, fluxo de caixa líquido etc.

Beta

Medida de risco sistemático de uma ação; tendência do preço de determinada ação a estar correlacionado com mudanças em determinado índice.

Beta alavancado

Valor de beta refletindo o endividamento na estrutura de capital.

C

Campo de arbítrio

Intervalo de variação no entorno do estimador pontual adotado na avaliação, dentro do qual se pode arbitrar o valor do bem desde que justificado pela existência de características próprias não contempladas no modelo.

CAPEX (Capital Expenditure)

Investimento em ativo permanente.

CAPM (Capital Asset Pricing Model)

Modelo no qual o custo de capital para qualquer ação ou lote de ações equivale à taxa livre de risco acrescida de prêmio de risco proporcionado pelo risco sistemático da ação ou lote de ações em estudo. Geralmente utilizado para calcular o Custo de Capital Próprio ou Custo de Capital do Acionista.

CFC

Conselho Federal de Contabilidade.

Códigos alocados

Ordenação numeral (notas ou pesos) para diferenciar as características qualitativas dos imóveis.

Combinação de negócios

União de entidades ou negócios separados produzindo demonstrações contábeis de uma única entidade que reporta. Operação ou outro evento por meio do qual um adquirente obtém o controle de um ou mais negócios, independente da forma jurídica da operação.

Controlada

Entidade, incluindo aquela sem personalidade jurídica, tal como uma associação, controlada por outra entidade (conhecida como controladora).

Controladora

Entidade que possui uma ou mais controladas.

Controle

Poder de direcionar a gestão estratégica política e administrativa de uma empresa.

CPC

Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

Custo

Total dos gastos diretos e indiretos necessários à produção, manutenção ou aquisição de um bem em uma determinada data e situação.

Custo de capital

Taxa de retorno esperado requerida pelo mercado como atrativa de fundos para determinado investimento.

Custo de reedição

Custo de reprodução, descontada a depreciação do bem, tendo em vista o estado em que se encontra.

Custo de reprodução

Gasto necessário para reproduzir um bem, sem considerar eventual depreciação.

Custo de substituição

Custo de reedição de um bem, com a mesma função e características assemelhadas ao avaliando.

Custo direto de produção

Gastos com insumos, inclusive mão de obra, na produção de um bem.

Custo indireto de produção

Despesas administrativas e financeiras, benefícios e demais ônus e encargos necessários à produção de um bem.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

D

Dado de mercado

Conjunto de informações coletadas no mercado relacionadas a um determinado bem.

Data-base

Data específica (dia, mês e ano) de aplicação do valor da avaliação.

Data de emissão

Data de encerramento do laudo de avaliação, quando as conclusões da avaliação são transmitidas ao cliente.



DCF (Discounted Cash Flow)

Fluxo de caixa descontado.

D&A

Depreciação e Amortização.

Depreciação

Alocação sistemática do valor depreciável de ativo durante a sua vida útil.

Dívida líquida

Caixa e equivalentes, posição líquida em derivativos, dívidas financeiras de curto e longo prazo, dividendos a receber e apagar, recebíveis e contas a pagar relacionadas a debêntures, déficits de curto e longo prazo com fundos de pensão, provisões, outros créditos e obrigações com pessoas vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

Documentação de suporte

Documentação levantada e fornecida pelo cliente na qual estão baseadas as premissas do laudo.

E

EBIT (Earnings Before Interests and Taxes)

Lucro antes de juros e impostos.

EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)

Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

Empreendimento

Conjunto de bens capaz de produzir receitas por meio de comercialização ou exploração econômica. Pode ser: imobiliário (ex.: loteamento, prédios comerciais/residenciais), de base imobiliária (ex.: hotel, shopping center, parques temáticos), industrial ou rural.

Empresa

Entidade comercial, industrial, prestadora de serviços ou de investimento detentora de atividade econômica.

Enterprise value

Valor econômico da empresa.

Equity value

Valor econômico do patrimônio líquido.

Estado de conservação

Situação física de um bem em decorrência de sua manutenção.

Estrutura de capital

Composição do capital investido de uma empresa entre capital próprio (patrimônio) e capital de terceiros (endividamento).

F

Fator de comercialização

Razão entre o valor de mercado de um bem e seu custo de reedição ou substituição, que pode ser maior ou menor que 1 (um).

FCFF (Free Cash Flow to Firm)

Fluxo de caixa livre para a firma, ou fluxo de caixa livre desalavancado.

Fluxo de caixa

Caixa gerado por um ativo, grupo de ativos ou empresa durante determinado período de tempo. Geralmente o termo é complementado por uma qualificação referente ao contexto (operacional, não operacional etc.).

Fluxo de caixa do capital investido

Fluxo gerado pela empresa a ser revertido aos financiadores (juros e amortizações) e acionistas (dividendos) depois de considerados custo e despesas operacionais e investimentos de capital.

Fração ideal

Percentual pertencente a cada um dos compradores (condôminos) no terreno e nas coisas comuns da edificação.

G

Gleba urbanizável

Terreno passível de receber obras de infraestrutura urbana, visando ao seu aproveitamento eficiente, por meio de loteamento, desmembramento ou implantação de empreendimento.

Goodwill

Ver Ágio por expectativa de rentabilidade futura.

H

Homogeneização

Tratamento dos preços observados, mediante a aplicação de transformações matemáticas que expressem, em termos relativos, as diferenças entre os atributos dos dados de mercado e os do bem avaliando.

I

IAS (International Accouting Standard)

Normas Internacionais de Contabilidade.

IASB (International Accouting Standards Board)

Junta Internacional de Normas Contábeis.

Idade aparente

Idade estimada de um bem em função de suas características e estado de conservação no momento da vistoria.

IFRS (International Financial Reporting Standard)

Normas Internacionais de Relatórios Financeiros, conjunto de pronunciamentos de contabilidade internacionais publicados e revisados pelo IASB.

Imóvel

Bem constituído de terreno e eventuais benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser classificado como urbano ou rural, em função da sua localização, uso ou vocação.



Imóvel de referência

Dado de mercado com características comparáveis às do imóvel avaliando.

Impairment

Ver Perdas por desvalorização.

Inferência estatística

Parte da ciência estatística que permite extrair conclusões sobre a população a partir de amostra.

Infraestrutura básica

Equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, redes de esgoto sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de acesso.

Instalações

Conjunto de materiais, sistemas, redes, equipamentos e serviços para apoio operacional a uma máquina isolada, linha de produção ou unidade industrial, conforme grau de agregação.

IVSC

International Valuation Standards Council.

L

Liquidação forçada

Condição relativa à hipótese de uma venda compulsória ou em prazo menor que a média de absorção pelo mercado.

Liquidez

Capacidade de rápida conversão de determinado ativo em dinheiro ou em pagamento de determinada dívida.

Loteamento

Subdivisão de gleba em lotes destinados a edificações, com abertura de novas vias de circulação de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das já existentes.

Luvas

Quantia paga pelo futuro inquilino para assinatura ou transferência do contrato de locação, a título de remuneração do ponto comercial.

M

Metodologia de avaliação

Uma ou mais abordagens utilizadas na elaboração de cálculos avaliatórios para a indicação de valor de um ativo.

Modelo de regressão

Modelo utilizado para representar determinado fenômeno, com base em uma amostra, considerando-se as diversas características influenciadoras.

Múltiplo

Valor de mercado de uma empresa, ação ou capital investido, dividido por uma medida da empresa (EBITDA, receita, volume de clientes etc).

N

Normas Internacionais de Contabilidade

Normas e interpretações adotadas pela IASB. Elas englobam: Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS); Normas Internacionais de Contabilidade (IAS); e interpretações desenvolvidas pelo Comitê de Interpretações das Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente de Interpretações (SIC).

P

Padrão construtivo

Qualidade das benfeitorias em função das especificações dos projetos, de materiais, execução e mão de obra efetivamente utilizados na construção.

Parecer técnico

Relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico, emitido por um profissional capacitado e legalmente habilitado, sobre assunto de sua especificidade.

Passivo

Obrigação presente que resulta de acontecimentos passados, em que se espera que a liquidação desta resulte em afluxo de recursos da entidade que incorporam benefícios econômicos.

Patrimônio líquido a mercado

Abordagem de ativos.

Perdas por desvalorização (impairment)

Valor contábil do ativo que excede, no caso de estoques, seu preço de venda menos o custo para completá-lo e despesa de vendê-lo; ou, no caso de outros ativos, seu valor justo menos a despesa para a venda.

Perícia

Atividade técnica realizada por profissional com qualificação específica para averiguar e esclarecer fatos, verificar o estado de um bem, apurar as causas que motivaram determinado evento, avaliar bens, seus custos, frutos ou direitos.

Pesquisa de mercado

Conjunto de atividades de identificação, investigação, coleta, seleção, processamento, análise e interpretação de resultados sobre dados de mercado.

Planta de valores

Representação gráfica ou listagem dos valores genéricos de metro quadrado de terreno ou do imóvel em uma mesma data.

Ponto comercial

Bem intangível que agrega valor ao imóvel comercial, decorrente de sua localização e expectativa de exploração comercial.

População

Totalidade de dados de mercado do segmento que se pretende analisar.



Preço

Quantia pela qual se efetua uma transação envolvendo um bem, um fruto ou um direito sobre ele.

Prêmio de controle

Valor ou percentual de um valor pró-rata de lote de ações controladoras sobre o valor pró-rata de ações sem controle, que refletem o poder do controle.

Profundidade equivalente

Resultado numérico da divisão da área de um lote pela sua frente projetada principal.

Propriedade para investimento

Imóvel (terreno, construção ou parte de construção, ou ambos) mantido pelo proprietário ou arrendatário sob arrendamento, tanto para receber pagamento de aluguel quanto para valorização de capital, ou ambos, que não seja para: uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, como também para fins administrativos.

R

Rd (Custo da Dívida)

Medida do valor pago pelo capital provindo de terceiros, sob a forma de empréstimos, financiamentos, captações no mercado, entre outros.

Re (Custo de Capital Próprio)

Retorno requerido pelo acionista pelo capital investido.

Risco do negócio

Grau de incerteza de realização de retornos futuros esperados do negócio, resultantes de fatores que não alavancagem financeira.

S

Seguro

Transferência de risco garantida por contrato, pelo qual uma das partes se obriga, mediante cobrança de prêmio, a indenizar a outra pela ocorrência de sinistro coberto pela apólice.

Sinistro

Evento que causa perda financeira.

T

Taxa de desconto

Qualquer divisor usado para a conversão de um fluxo de benefícios econômicos futuros em valor presente.

Taxa interna de retorno

Taxa de desconto onde o valor presente do fluxo de caixa futuro é equivalente ao custo do investimento.

Testada

Medida da frente de um imóvel.

Tratamento de dados

Aplicação de operações que expressem, em termos relativos, as diferenças de atributos entre os dados de mercado e os do bem avaliando.

U

Unidade geradora de caixa

Menor grupo de ativos identificáveis gerador de entradas de caixa que são, em grande parte, independentes de entradas geradas por outros ativos ou grupos de ativos.

V

Valor atual

Valor de reposição por novo depreciado em função do estado físico em que se encontra o bem.

Valor contábil

Valor em que um ativo ou passivo é reconhecido no balanço patrimonial.

Valor da perpetuidade

Valor ao final do período projetivo a ser adicionado no fluxo de caixa.

Valor de dano elétrico

Estimativa do custo do reparo ou reposição de peças, quando ocorre um dano elétrico no bem. Os valores são tabelados em percentuais do Valor de Reposição e foram calculados através de estudos dos manuais dos equipamentos e da experiência em manutenção corretiva dos técnicos da Apsis.

Valor de investimento

Valor para um investidor em particular, baseado em interesses particulares no bem em análise. No caso de avaliação de negócios, este valor pode ser analisado por diferentes situações, tais como sinergia com demais empresas de um investidor, percepções de risco, desempenhos futuros e planejamentos tributários.

Valor de liquidação forçada

Valor de um bem colocado à venda no mercado fora do processo normal, ou seja, aquele que se apuraria caso o bem fosse colocado à venda separadamente, levando-se em consideração os custos envolvidos e o desconto necessário para uma venda em um prazo reduzido.

Valor de liquidação imediata

Igual ao Valor de Liquidação Forçada, mas com percentual de liquidação mais agressivo.

Valor depreciável

Custo do ativo, ou outra quantia substituta do custo (nas demonstrações contábeis), menos o seu valor residual.

Valor de reposição por novo

Valor baseado no que o bem custaria (geralmente em relação a preços correntes de mercado) para ser reposto ou substituído por outro novo, igual ou similar.



Valor de seguro

Valor pelo qual uma companhia de seguros assume os riscos e não se aplica ao terreno e às fundações, exceto em casos especiais.

Valor de sucata

Valor de mercado dos materiais reaproveitáveis de um bem, na condição de desativação, sem que estes sejam utilizados para fins produtivos.

Valor em risco

Valor representativo da parcela do bem que se deseja segurar e que pode corresponder ao valor máximo segurável.

Valor em uso

Valor de um bem em condições de operação no estado atual, como uma parte integrante útil de uma indústria, incluídas, quando pertinentes, as despesas de projeto, embalagem, impostos, fretes e montagem.

Valor (justo) de mercado

Valor pelo qual um ativo pode ser trocado de propriedade entre um potencial vendedor e um potencial comprador, quando ambas as partes têm conhecimento razoável dos fatos relevantes e nenhuma está sob pressão de fazê-lo.

Valor justo menos despesa para vender

Valor que pode ser obtido com a venda de ativo ou unidade geradora de caixa menos as despesas da venda, em uma transação entre partes conhecedoras, dispostas a tal e isentas de interesse.

Valor máximo de seguro

Valor máximo do bem pelo qual é recomendável que seja segurado. Este critério estabelece que o bem com depreciação maior que 50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro igual a duas vezes o Valor Atual; e aquele com depreciação menor que 50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro igual ao Valor de Reposição.

Valor presente

Estimativa do valor presente descontado de fluxos de caixa líquidos no curso normal dos negócios.

Valor recuperável

Valor justo mais alto de ativo (ou unidade geradora de caixa) menos as despesas de venda comparado com seu valor em uso.

Valor residual

Valor do bem novo ou usado projetado para uma data, limitada àquela em que o mesmo se torna sucata, considerando estar em operação durante o período.

Valor residual de ativo

Valor estimado que a entidade obterá no presente com a alienação do ativo, após deduzir as despesas estimadas desta, se o ativo já estivesse com a idade e condição esperadas no fim de sua vida útil.

Variáveis-chave

Variáveis que, *a priori* e tradicionalmente, são importantes para a formação do valor do imóvel.

Variáveis independentes

Variáveis que dão conteúdo lógico à formação do valor do imóvel, objeto da avaliação.

Variáveis qualitativas

Variáveis que não podem ser medidas ou contadas, apenas ordenadas ou hierarquizadas, de acordo com atributos inerentes ao bem (por exemplo, padrão construtivo, estado de conservação e qualidade do solo).

Variáveis quantitativas

Variáveis que podem ser medidas ou contadas (por exemplo, área privativa, número de quartos e vagas de garagem).

Variável dependente

Variável que se pretende explicar pelas independentes.

Variável dicotômica

Variável que assume apenas dois valores.

Vida remanescente

Vida útil que resta a um bem.

Vida útil econômica

Período no qual se espera que um ativo esteja disponível para uso, ou o número de unidades de produção ou similares que se espera obter do ativo pela entidade.

Vistoria

Constatação local de fatos, mediante observações criteriosas em um bem e nos elementos e condições que o constituem ou o influenciam.

Vocação do imóvel

Uso economicamente mais adequado de determinado imóvel em função das características próprias e do entorno, respeitadas as limitações legais.

W

WACC (Weighted Average Cost of Capital)

Modelo no qual o custo de capital é determinado pela média ponderada do valor de mercado dos componentes da estrutura de capital (próprio e de terceiros).

WARA (Weighted Average Return on Assets)

Taxa média ponderada de retorno esperado para os ativos e passivos que compõem a companhia objeto de análise, incluindo o *goodwill*.





Rio de Janeiro | +55 21 2212-6850
apsis.rj@apsis.com.br

São Paulo | 55 11 4550-2701
apsis.sp@apsis.com.br

Minas Gerais | +55 31 98299-6678
apsis.mg@apsis.com.br

apsis.com.br





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02432878442	
07080589738	
68278772053	



AO JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS, DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS - MA

Processo nº 0801310-44.2026.8.10.0001

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA FERNANDES, representado por seu genitor **ALESSANDRO MACIEL FERNANDES**, vem, através seu procurador infra-assinado, declarar ciência do cumprimento da decisão liminar e confirmar a veracidade dos fatos.

Termos em que pede deferimento.

São Luís - MA, 21 de janeiro de 2026.

Jefferson Carneiro de Oliveira Júnior

OAB/MA 25.841



Processo n.º 0801310-44.2026.8.10.0001 | PJE

Tipo de ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

Autor: SEGREDO DE JUSTIÇA

Advogado do(a) AUTOR: JEFFERSON CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - OABMA 25841

Requerido: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Ato disponibilizado no DJE nos termos do Provimento n.º 39/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão: Nesta data, realizo a intimação da PARTE AUTORA, por intermédio de seus representantes legais, para que, em 5 (cinco) dias, se manifeste acerca da petição de id n.º 169775042, podendo o seu inteiro teor ser visualizada por meio do sistema PJE. São Luís, 20/01/2026. KASSIO ROGERIO DE MORAES RIBEIRO, Diretor de Secretaria da 1ª Vara da Infância e Juventude de São Luís.



AO JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO TERMO JUDICIÁRIO DE
SÃO LUÍS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS – MA

PROCESSO Nº 0801310-44.2026.8.10.0001

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, devidamente qualificada nos autos da presente demanda ajuizada por **ALESSANDO MACIEL FERNANDES**, e **JOSÉ HENRIQUE DA SILVA FERNANDES**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar

O INTEGRAL CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA

Conforme se comprova pelo documento ora anexado.

1. Em atenção à decisão liminar proferida nos autos, que determinou à **Requerida a autorização e o custeio integral da internação e de todos os procedimentos necessários à manutenção e preservação da vida do paciente**, vem a Requerida informar o **integral cumprimento da medida deferida**, nos exatos termos do comando judicial.

2. Para fiel observância da ordem judicial, a Requerida **procedeu à autorização imediata da internação**, bem como ao **custeio dos procedimentos médicos necessários**, assegurando o tratamento integral e especializado indicado pela equipe assistencial, conforme determinado por este Juízo.

3. O cumprimento da tutela encontra-se **devidamente comprovado pelos documentos ora anexados**, que demonstram a autorização da internação sob força de liminar, a validação do pedido e o custeio dos procedimentos correspondentes, evidenciando o atendimento integral à determinação judicial.

BRASÍLIA SÃO PAULO ARACAJU CURITIBA RECIFE

juridico@seixasadv.com

seixasadv.com



4. Diante do exposto, requer a requerida seja reconhecido o cumprimento da decisão liminar, para que produza seus regulares efeitos, com o consequente afastamento de qualquer penalidade ou medida coercitiva relacionada ao referido comando judicial.

Termos em que pede deferimento.
(Local e data da assinatura eletrônica)

YASMIN BREHMER HANDAR

OAB/DF nº 64.819

OAB/PR nº 97.751

OAB/AP nº 5.448

OAB/SE nº 1.754A

OAB/SP nº 535.137

BRASÍLIA

SÃO PAULO

ARACAJU

CURITIBA

RECIFE

juridico@seixasadv.com

seixasadv.com



1 - Registro ANS 326305	3 - Número da Guia Atribuído pela Operadora	
4 - Data da Autorização 15/01/2026	5 - Senha 202600025635	6 - Data de Validade da Senha 16/03/2026

7 - Número da carteira 095391714	8 - Validade da carteira _/_/ _/_/ _/_/_/_	9 - Atendimento a RN N
-------------------------------------	---	---------------------------

50- Nome Social

10 - Nome
JOSE HENRIQUE DA SILVA FERNANDES

12 - Código na Operadora 10461132		13 - Nome do contratado HOSPITAL SAO DOMINGOS				
14 - Nome do Profissional Solicitante HELIDA CRISTINA ALCANTARA VICENTE		15 - Conselho Profissional 6	16 - Número no Conselho 4026		17 - UF MA	18 - Código CBO 225124

19 - Código na Operadora / CNPJ 1046113-2		20 - Nome do Hospital/Local Solicitado HOSPITAL SAO DOMINGOS			21 - Data sugerida para internação _/_/__/_____	
22 - Caráter do Atendimento 2	23-Tipo de Internação 4	24-Regime de Internação 1	25-Qtde. Diárias Solicitadas 1	26 - Previsão de uso de OPME N	27 - Previsão de uso de quimioterápico N	

28 - Indicação Clínica
PACIENTE COM FEBRE,DISPNEICO,COM TOSSE LADRANTE,POUCA MELHORA NA OBSERVAÇÃO NECESSITA DE MONITORIZAÇÃO E OXIGENIOTERAPIA

29 - CID 10 Principal (Opcional) J040	30 - CID10 (2) (Opcional) [][][][][][]	31 - CID10 (3) (Opcional) [][][][][][]	32 - CID10 (4) (Opcional) [][][][][][]	33 - Indicação de Acidente (acidente ou doença relacionada) 9
--	---	---	---	--

34-Tabela	35-Código do Procedimento ou Assistencial	Item	36-Descrição	37-Qtde Solic	38-Qtde Aut
01- 22	10104011		Atendimento Do Intensivista Diarista (Por Dia E Por Paciente)	01	01
02- 22	10104020		Atendimento Médico Do Intensivista Em Uti Geral Ou Pediátrica (Plantão De	02	02
03- ☐	☐	☐		☐	☐
04- ☐	☐	☐		☐	☐
05- ☐	☐	☐		☐	☐
06- ☐	☐	☐		☐	☐
07- ☐	☐	☐		☐	☐
08- ☐	☐	☐		☐	☐
09- ☐	☐	☐		☐	☐
10- ☐	☐	☐		☐	☐
11- ☐	☐	☐		☐	☐
12- ☐	☐	☐		☐	☐

39 - Data Provável da Admissão Hospitalar []/[]/[]	40 - Qtde. Diárias Autorizadas 1	41 - Tipo da Acomodação Autorizada 31
42 - Código na Operadora / CNPJ autorizado 1046113-2	43 - Nome do Hospital / Local Autorizado HOSPITAL SAO DOMINGOS	44 - Código CNES 2308665

45 - Observação / Justificativa APROVADO SOB LIMINAR - Pedido: 487139417
ESTA E UMA INTERNAC?O CLINICA, CASO O PACIENTE NECESSITE REALIZAR PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DURANTE ESTA INTERNAC?O, SOLICITAR AUTORIZAC?O PREVIAMENTE

46 - Data da Solicitação 11/01/2026	47 - Assinatura do Profissional Solicitante	48 - Assinatura do Beneficiário ou Responsável	49 - Assinatura do Responsável pela Autorização
--	---	--	---



Histórico Pedido

Nº Pedido

487139417

Situação

Autorizado

Pendências Analisadas

Data Situação

15/01/2026

Usuário Situação

MCSROCHA

Origem

Via Prestador / Digitado

Motivo Aprovação

Autorização pelo Analista

Beneficiário

095391714

JOSE HENRIQUE DA SILVA FERNANDES

Operadora

AMIL

Filial/Unidade

SÃO PAULO / São Paulo

Linha de Produto

AMIL 2024

Número Contrato

2507234001

TOLEDO NORDESTE

Regulamentado

Plano

967071 - PRATA QC COPART

Rede

1078 - Prata QC

Acomodação

Coletivo

Acompanhante

27 - Menor de 18 anos e maior de 60 anos

Situação

Ativo desde 18/08/2025 (151 dias)

Data Nasc.

06/03/2025

0 anos

Sexo

Masculino

Tipo Atendimento

INTERNAÇÃO - PEDIÁTRICA

Liminar

Liminar

Carencia

Contr

Dados complementares

Tel. Residencial

98

32168135

Tel. Celular

E-mail

agendamentocirurgicohsd@dasa.com.br

Nº Senha Corporativo

202600025635

Nº Guia

487139417seq001

Informações

CID Principal (Opcional)

0040

Laringite aguda

Solicitação Pedido

11/01/2026

Resp. Custo

Liminar

Nº Liminar

08013104420268100001

Atendimento RN

☐ Sim ☒ Não

Indicação de Acidente

Não Acidente

Motivo Encerramento Atendimento

Previsão de uso

☐ OPME ☐ Quimioterápico

Indicação Clínica

PACIENTE COM FEBRE, DISPNEICO, COM TOSSE LADRANTE, POUCA MELHORA NA OBSERVAÇÃO NECESSITA DE MONITORIZAÇÃO E OXIGENIOTERAPIA

Recusa de Indicação de Rede por parte do Prestador

☐

Recusa de Indicação de Rede por parte do Beneficiário

☐

Autorização

15/01/2026

Validade

16/03/2026

Data/Hora Conf.

15/01/2026

Usuário Conf.

10461132

Origem Conf.

Portal

TOKEN.

Executante

Prestador

10461132

HOSPITAL SAO DOMINGOS

Local Internação

10461132

HOSPITAL SAO DOMINGOS

End. Internação

DERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, 540, BEQUIMAO, SAO LUIS, MA

Nº CNES

2308665

[CBHPM]

Solicitante

Nome

10461132

HOSPITAL SAO DOMINGOS

Nome Profissional

HELIDA CRISTINA ALCANTARA VICENTE

Conselho

CRM

Número

4026

UF

MA

CBO-S

225124

Médico pediatra

Divergência Técnica

☐ Sim ☒ Não

Carater

☐ Eletivo ☒ Urgência / Emergência

Tipo Acomodação

☐ Individual ☒ Coletivo

Acomodação

Enfermaria (3 leitos)

https://sisamil.amil.com.br/atd/asp/atd0021a.asp?pt=Histórico%20Pedido&ind_forma_abertura=P&botao_voltar=S&num_pedido=48713... 15/01/2026

Número do documento: 26011516084672700000157226282

https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26011516084672700000157226282

Assinado eletronicamente por: YASMIN BREHMER HANDAR - 15/01/2026 16:08:46

Num. 169775044 - Pág. 2

Internação11/01/2026Hora08:21

Possui OPME?☐ Sim☒ Não

Saldo da Taxa de Operacionalização OPME0,00Histórico

Diárias Liberadas até12/01/2026

	Principal	Inicial	Prorrogação anteriores	Prorrogação atual	Total
		1	0	0	1
	Acessória	1	0	0	1

Selecione uma sequência

Sequências:Data solicitação de Pedido Médico:11/01/2026

Procedimentos / Serviços

Sequência	Data autorização	Senha	Data solicitação	Monitorização Invasiva / PAM	Respirador	Anexos	Outras Informações												
1	15/01/2026	202600025635	11/01/2026				Detalhes												
Código	Descrição	Qtde.Solic.	Sessões Autorizadas	Sessões Planejadas	Período	Crítica	Tipo	Situação	Usuário Inclusão	Usuário Alteração	Conf. Anestesiista?	Executante Particular?	Executante	Inf.Compl.	Pre. Lib. Oper.	Técnica	Via	Upcoding	Sob
60000473	DIÁRIA DE ACOMPANHANTE SOMENTE COM	1					Secundário	Aprovado	10461132	MCSROCHA	☐	☐	-				Via única	☐	
60001054	DIÁRIA DE UTI INFANTIL/PEDIÁTRICA	1					Secundário	Aprovado	10461132	MCSROCHA	☐	☐	10461132-HOSPITAL SAO DOMINGOS			Convencional	Via única	☐	
10104020	Atendimento Médico Do Intensivista Em Uti	2					Principal	Aprovado	10461132	MCSROCHA	☐	☐	10461132-HOSPITAL SAO DOMINGOS			Convencional	Via única	☐	
10104011	Atendimento Do Intensivista Diarista (Por 1	1					Secundário	Aprovado	10461132	MCSROCHA	☐	☐	10461132-HOSPITAL SAO DOMINGOS			Convencional	Via única	☐	

Qtde. Proc. Autorizados

Total Diárias

Pacotes

Prestador Executante: Não existem pacotes negociados e ou validados ou parametrizados para a sequência selecionada.

Local Internação: Não existem pacotes negociados e ou validados ou parametrizados para a sequência selecionada.

Observações

Observação Emissão

APROVADO SOB LIMINAR

980 caracteres restantes.

Observação Exclusiva Operadora

4000 caracteres restantes.

Anexos

Ocorrência	Descrição	Sequência	A
11/01/2026 08:21	Pedido Médico e Laudo de Exame	1	
11/01/2026 08:21	Pedido Médico e Laudo de Exame	1	
11/01/2026 08:21	Pedido Médico e Laudo de Exame	1	
11/01/2026 08:21	Pedido Médico e Laudo de Exame	1	
11/01/2026 08:21	Pedido Médico e Laudo de Exame	1	

Exigências

Abertura	Encerramento	Descrição	
11/01/2026 10:11:14	11/01/2026 10:38:43	Necessário contato do Hospital com a operadora.	!

Guias

Código	Descrição	Procedimento	Executante
12	Clínico	10104020	10461132 - HOSPITAL SAO DOMINGOS
12	Clínico	10104011	10461132 - HOSPITAL SAO DOMINGOS

Ocorrências

Tipo	Ocorrência	Registro	Sequência	Comunicação	Observação Exclusiva Operadora	Observação de Emissão
Exibir todas ocorrências						

Tempo de execução da página : 1,39s

https://sisamil.amil.com.br/atd/asp/atd0021a.asp?pt=Histórico%20Pedido&ind_forma_abertura=P&botao_voltar=S&num_pedido=48713... 15/01/2026

Número do documento: 26011516084672700000157226282
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26011516084672700000157226282
Assinado eletronicamente por: YASMIN BREHMER HANDAR - 15/01/2026 16:08:46

Num. 169775044 - Pág. 4



ANEXO DE OUTRAS DESPESAS
(para Guia de SP/SADT e Resumo de Internação)



1-Registro ANS
326305

2- Número da Guia Referenciada
487139417seq001

Dados do Contratado Executante

3- Código na Operadora
10461132

4- Nome do Contratado
HOSPITAL SAO DOMINGOS

5- Código CNES
2308665

Despesas Realizadas										
6- CD	7- Data	8- Hora Inicial	9- Hora Final	10- Tabela	11- Código do Item	12- Qtde.	13- Unidade de Medida	14- Fator Red.. / Acrésc	15- Valor Unitário - R\$	16- Valor Total - R\$
17- Registro Anvisa do Material		18-Referência do material no fabricante								
		19- Nº Autorização de Funcionamento								
1 -			a	18	60001054	1,0000		1,00		
20 - Descrição		DIÁRIA DE UTI INFANTIL/PEDIÁTRICA								
2 -			a	18	60000473	1,0000		1,00		
20 - Descrição		DIÁRIA DE ACOMPANHANTE SOMENTE COM CAFÉ DA MANHÃ								
3 -			a							
20 - Descrição										
4 -			a							
20 - Descrição										
5 -			a							
20 - Descrição										
6 -			a							
20 - Descrição										
7 -			a							
20 - Descrição										
8 -			a							
20 - Descrição										
9 -			a							
20 - Descrição										
10 -			a							
20 - Descrição										

21- Total de Gases Medicinais (R\$)

22- Total de Medicamentos(R\$)

23- Total de Materiais (R\$)

24- Total de OPME (R\$)

25- Total de Taxas e Aluguéis (R\$)

26- Total de Diárias (R\$)

27- Total Geral (R\$)

Carência

Carência				
Classificação ANS	Carência	Qtd. Dias	Data Início	Data Fim
Procedimento Parto a Termo	Internações para obstetrícia e neonatologia	268	18/08/2025	14/06/2026
Procedimentos Hospitalares	Diálise ou hemodiálise (não relacionada a doenças preexistentes)	148	18/08/2025	14/02/2026
Procedimentos Ambulatoriais	Diálise ou hemodiálise (não relacionada a doenças preexistentes)	148	18/08/2025	14/02/2026
Procedimentos Ambulatoriais	Exames de Endoscopia Digestiva, Respiratória e Urológica	148	18/08/2025	14/02/2026
Procedimentos Hospitalares	Exames de Hemodinâmica, Exames Cardiovasculares em Medicina Nuclear Diagnóstica e Imunocintilografia	148	18/08/2025	14/02/2026
Procedimentos Ambulatoriais	Exames de Hemodinâmica, Exames Cardiovasculares em Medicina Nuclear Diagnóstica e Imunocintilografia	148	18/08/2025	14/02/2026
Procedimentos Ambulatoriais	Exames de Ultrassonografia	148	18/08/2025	14/02/2026
Procedimentos Ambulatoriais	Exames e Procedimentos especiais em regime ambulatorial ,exceto os que possuem cláusula específica	148	18/08/2025	14/02/2026
Procedimentos Hospitalares	Hemodinâmica terapêutica e angioplastias (não relacionada a doenças preexistentes)	148	18/08/2025	14/02/2026
Procedimentos Hospitalares	Hemoterapia	148	18/08/2025	14/02/2026
Procedimentos Hospitalares	Internações Day Hospital	148	18/08/2025	14/02/2026
Procedimentos Hospitalares	Internações em geral (não relacionadas às doenças preexistentes)	148	18/08/2025	14/02/2026
Procedimentos Hospitalares	Procedimentos para artroscopia	148	18/08/2025	14/02/2026
Procedimentos Hospitalares	Procedimentos para litotripsia	148	18/08/2025	14/02/2026
Procedimentos Ambulatoriais	Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos	148	18/08/2025	14/02/2026
Procedimentos Hospitalares	Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos	148	18/08/2025	14/02/2026
Procedimentos Ambulatoriais	Quimioterapia e Radioterapia (não relacionada a doenças preexistentes)	148	18/08/2025	14/02/2026
Procedimentos Hospitalares	TC, RNM ,neurorradiologia, cardiografia ,mielografia,radiologia intervencionista	148	18/08/2025	14/02/2026
Procedimentos Ambulatoriais	TC, RNM ,neurorradiologia, cardiografia ,mielografia,radiologia intervencionista	148	18/08/2025	14/02/2026
Procedimentos Ambulatoriais	Terapias	148	18/08/2025	14/02/2026
Procedimentos Hospitalares	Terapias	148	18/08/2025	14/02/2026
Procedimentos Hospitalares	Videolaparoscopia e procedimentos vídeo-assistidos com fim terapêutico/diaqnóstico ambulatorial	148	18/08/2025	14/02/2026
Procedimentos Ambulatoriais	Consulta Eletiva em consultórios, clínicas ou centros médicos	0	18/08/2025	Cumprida
Procedimentos Ambulatoriais	Exames e Procedimentos básicos em regime ambulatorial, exceto Terapias	0	18/08/2025	Cumprida
Procedimentos Hospitalares	Consulta em Pronto Socorro	0	18/08/2025	Cumprida



EXCELENTÍSSIMO (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO

AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.309.127/0001-79, sociedade com filial localizada na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, 6º ao 21º andar, Torre B, Empreendimento EZ Towers, bairro Vila Francisco, São Paulo/SP, CEP 04711-904, vem, respeitosamente, por sua advogada signatária, visando o exercício do contraditório e a ampla defesa, requerer

HABILITAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO

Ademais, a Peticionária requer seja determinado o cadastramento da advogada **Yasmin Brehmer Handar, OAB/PR 97.751**, indicando o e-mail: acessotribunais@seixasadv.com para recebimento das futuras publicações e intimações pertinentes ao feito, sob pena de nulidade nos termos do artigo 272, § 1º e 2º do Código de Processo Civil.

I – DO INÍCIO DA ATUAÇÃO PROCESSUAL E DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS

1. Informa a requerente que o escritório Seixas Advogados iniciará formalmente sua atuação no presente feito a partir do dia da habilitação, data em que passará a acompanhar regularmente o andamento processual, promovendo as medidas judiciais cabíveis à adequada defesa dos interesses da parte representada.
2. Considerando a recente constituição de nova representação judicial, com a substituição da assessoria anteriormente responsável, requer-se, por cautela e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, **A DEVOLUÇÃO DOS EVENTUAIS PRAZOS PROCESSUAIS EM CURSO**, a fim de que a nova patrona possa analisar integralmente os autos e adotar, de forma técnica e fundamentada, as medidas processuais pertinentes.

BRASÍLIA

SÃO PAULO

ARACAJU

CURITIBA

RECIFE

juridico@seixasadv.com

seixasadv.com



3. A pretensão visa assegurar a efetiva tutela do direito de defesa e a boa condução do processo, em conformidade com os arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil, que consagram a cooperação processual e a boa-fé objetiva.

Brasília | DF, (Data da assinatura eletrônica)

YASMIN BREHMER HANDAR

OAB/DF nº 64.819

OAB/PR nº 97.751

OAB/AP nº 5.448

OAB/SE nº 1.754 A

OAB/SP nº 535.137

BRASÍLIA

SÃO PAULO

ARACAJU

CURITIBA

RECIFE

juridico@seixasadv.com

seixasadv.com



Número do documento: 26011512122822900000157198385

<https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26011512122822900000157198385>

Assinado eletronicamente por: YASMIN BREHMER HANDAR - 15/01/2026 12:12:28

PROCURAÇÃO

2051/AMIL/2025

OUTORGANTE: **AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.309.127/0001-79, com sede na Avenida Doutor Chucri Zaidan, s/nº, Torre B, Empreendimento EZ Towers, 6º, 7º, 8º, 9º, 16º, 20º e 23º andar, Vila São Francisco, São Paulo/SP, CEP 04711-130, e todas as suas filiais, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, por seus Diretores, **FABIAN ROCHA**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade nº 172.574, expedida pela OAB/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 116.844.158-70 e **RICARDO SANTOS MORAES DE BURGOS**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 302315603, inscrito no CPF/MF sob o nº 041.480.486-45, ambos com endereço comercial na Avenida Doutor Chucri Zaidan, s/nº, Torre B, Empreendimento EZ Towers, 6º, 7º, 8º, 9º, 16º, 20º e 23º andar, Vila São Francisco, São Paulo/SP, CEP 04711-130.

OUTORGADOS: **JOSÉ LAURO SEIXAS LIMA**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SE sob o nº 5579 e no CPF/MF sob o nº 012.778.605-80; **MARILIA ARAUJO FONTENELE DE CARVALHO**, brasileira, advogada, inscrita na OAB/DF sob o nº 43.260 e no CPF/MF sob o nº 019.823.581-06; **YASMIN BREHMER HANDAR**, brasileira, advogada, inscrita na OAB/DF sob o nº 64.819 e no CPF/MF sob o nº 098.378.809-02; e **FÁBIO ARAUJO DE OLIVEIRA**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/DF sob o nº 80.182 e no CPF/MF sob o nº 096.299.431-09; todos integrantes do escritório **JOSÉ LAURO SEIXAS LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.672.848/0001-99, sediado na SHIS QL 24, conjunto 9, casa 20, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71665-095.

PODERES: A **OUTORGANTE** confere aos **OUTORGADOS**, em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de nomeação, poderes da cláusula “*ad judicia*” para o foro em geral, podendo acordar, discordar, recorrer, desistir, transigir, negociar, em quaisquer Instâncias e Tribunais, inclusive perante os Juizados Especiais Cíveis, podendo ainda receber citações, assinar termos de compromissos, realizar levantamentos, nomear ou representar como preposto, ou representante legal da Outorgante, podendo o preposto ou representante participar de Audiências (de Julgamento, Conciliação ou Mediação), celebrar acordos e receber notificações ou intimações; poderão também os Outorgados assinar carta de preposto ou de nomeação de representante, bem como, propor as ações que se mostrarem necessárias para a defesa dos interesses da Outorgante e tudo o mais que se fizer necessário para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, **sendo vedado o substabelecimento**.

Os **OUTORGADOS** ora constituídos ficam cientes de que os poderes concedidos terão validade apenas enquanto vinculados ao escritório de advocacia e durante a prestação de serviços à **OUTORGANTE**, sendo automaticamente revogados na ausência de tais condições.

VIGÊNCIA: Indeterminada.

São Paulo, 28 de outubro de 2025.

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

Fabian Rocha

Ricardo Santos Moraes de Burgos

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Santos Moraes De Burgos e Fabian Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://amil.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 0FF4-84D3-2231-BDC8.

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Santos Moraes De Burgos e Fabian Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://amil.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 0FF4-84D3-2231-BDC8.





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://amil.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0FF4-84D3-2231-BDC8> ou vá até o site <https://amil.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0FF4-84D3-2231-BDC8



Hash do Documento

6005B57ECBF1A6F3EF3EB3675885703E39F8908D1A12F76FF4DBA35A2B2CD779

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/10/2025 é(são) :

- ☒ Ricardo Santos Moraes De Burgos (Vice-Presidente de Capital Humano) - 041.480.486-45 em 29/10/2025 10:47 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☒ Fabian Rocha (Vice-Presidente Jurídico) - 116.844.158-70 em 29/10/2025 10:22 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNAC

CNPJ n.º 29.309.127/0001-79

NIRE 35.3.00378148



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2024**

1. **Data, Horário e Local:** Realizada no dia 13 de dezembro de 2024, às 10h horas, na sede social da Amil Assistência Médica Internacional S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Chucrí Zaidan, s/nº, Torre B, Empreendimento EZ Towers, 6º, 7º, 8º, 9º, 16º, 20º e 23º andar, Vila São Francisco, São Paulo, SP, CEP: 04711-130.

2. **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

3. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fabian Rocha, e secretariados pelo Sr. Ricardo Santos Moraes de Burgos.

4. **Ordem do Dia:**

4.1. Deliberar sobre a alteração do endereço da Matriz da Companhia e consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social; e

4.2. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

5. **Deliberações:** Instalada a Assembleia e após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, o acionista presente deliberou e aprovou, sem ressalvas, o quanto segue:

5.1. Conforme deliberado na Ata de Reunião de Diretoria realizada em 29 de novembro de 2024, registrada perante a JUCESP sob o nº 437.806/24-7, em 09/12/2024, resolve o acionista aprovar a atualização do endereço da Matriz da Companhia inscrita no CNPJ nº 29.309.127/0001-79, decorrente de alteração realizada pela Prefeitura de São Paulo, a qual passou da Rua Arquiteto Olavo Redig De Campos, nº 105, 06º ao 21º Andar, Torre B, Empreendimento EZ Towers, Vila Francisco, CEP: 04711-904, São Paulo, SP para Avenida Doutor Chucrí Zaidan, s/nº, Torre B, Empreendimento EZ Towers, 6º, 7º, 8º, 9º, 16º, 20º e 23º andar, Vila São Francisco, São Paulo, SP, CEP: 04711-130, de forma que o artigo 2º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 2º - A Companhia tem sede e domicílio legal na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Chucrí Zaidan, s/nº, Torre B, Empreendimento EZ Towers, 6º, 7º, 8º, 9º, 16º, 20º e 23º andar, Vila São Francisco, São Paulo, SP, CEP:

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Santos Moraes De Burgos e Fabian Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portalde-assinaturas.com.br> e utilize o código E930-A386-1178-F36R.

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Santos Moraes De Burgos e Fabian Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portalde-assinaturas.com.br> e utilize o código E930-A386-1178-F36R.



04711-130, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir e/ou encerrar filiais, depósitos, escritórios, representações e quaisquer outros estabelecimentos no País ou no exterior.º.

5.2. Em consequência das deliberações acima, o acionista aprovou a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que fica arquivado em sua Sede.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme disposto no art. 130, §1º da Lei das S.A., a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. **Local e data:** São Paulo, 13 de dezembro de 2024. **Mesa:** Presidente: Fabian Rocha; Secretário: Ricardo Santos Moraes de Burgos. **Presença:** Acionista José Seripieri Filho.

Certifico que a presente é a cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

Mesa:

Fabian Rocha
Presidente

Ricardo Santos Moraes de Burgos
Secretário



Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Santos Moraes De Burgos e Fabian Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://amr.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código E830-A386-1178-F36B.

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Santos Moraes De Burgos e Fabian Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://amr.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código E830-A386-1178-F36B.



ANEXO

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO

ESTATUTO SOCIAL DA
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
CNPJ nº 29.309.127/0001-79
NIRE 35.3.00378148

CAPÍTULO I DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Artigo 1º - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. ("Companhia") é uma sociedade por ações que se rege pelo presente Estatuto Social e pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações").

Artigo 2º - A Companhia tem sede e domicílio legal na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Chucril Zaidan, s/nº, Torre B, Empreendimento EZ Towers, 6º, 7º, 8º, 9º, 16º, 20º e 23º andar, Vila São Francisco, São Paulo, SP, CEP: 04711-130, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir e/ou encerrar filiais, depósitos, escritórios, representações e quaisquer outros estabelecimentos no País ou no exterior.

Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: (i) operar planos privados de assistência à saúde através da cobertura de custos de assistência médica e odontológica de seus associados em todas as modalidades previstas pela legislação brasileira pertinente e (ii) participar, como sócia, acionista ou quotista, em outras sociedades simples ou empresárias que desempenhem funções relacionadas ao seu objeto social, no Brasil e no exterior.

Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II DO CAPITAL SOCIAL, DAS AÇÕES E DOS ACIONISTAS

Artigo 5º - O capital social é de R\$ 11.137.439.481,09 (onze bilhões, cento e trinta e sete milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e um reais e nove centavos), totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda nacional e bens, dividido em 12.632.348.148 (doze bilhões, seiscentas e trinta e duas milhões, trezentas e quarenta e oito mil, cento e quarenta e oito) ações ordinárias, todas nominativas sem valor nominal.

Parágrafo Único – É proibida a emissão de partes beneficiárias

Artigo 6º - O capital social será representado exclusivamente por ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e a cada ação ordinária corresponderá a 01 (um) voto nas deliberações da Assembleia Geral.

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Santos Moraes De Borges e Fabian Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://amil.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código E930-A380-1178-F36B.

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Santos Moraes De Borges e Fabian Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://amil.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código E930-A380-1178-F36B.



Artigo 7º - A Companhia poderá manter todas as ações da sua emissão em contas de depósito, em nome de seus titulares, junto a instituições financeiras autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Parágrafo Único - Observados os limites máximos fixados pela Comissão de Valores Mobiliários, o custo de transferência e averbação, assim como o custo do serviço relativo às ações escriturais poderá ser cobrado diretamente do acionista pela instituição depositária, conforme definido em contrato de escrituração de ações.

Artigo 8º - No caso de abertura de seu capital, a Companhia deverá aderir a segmento especial de bolsa de valores ou entidade mantenedora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, os níveis diferenciados de práticas de governança corporativa previstos no presente Estatuto Social.

CAPÍTULO III DA ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 9º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do exercício e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem, quando convocada nos termos da Lei das Sociedades por Ações ou deste Estatuto Social, sendo permitida a realização simultânea de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária.

Parágrafo Primeiro - As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria de votos presentes, ressalvadas as exceções previstas na Lei de Sociedades por Ações e observado o disposto neste Estatuto Social.

Parágrafo Segundo - A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações, os quais deverão constar do respectivo edital de convocação, que deverá ser publicado por no mínimo 03 (três) vezes, no respectivo órgão oficial de imprensa e em jornal de grande circulação, com no mínimo 8 (oito) dias de antecedência, devendo conter data, hora e local da Assembleia Geral.

Parágrafo Terceiro - A Assembleia Geral será considerada validamente convocada e instalada, sem a entrega ou publicação de qualquer edital de convocação, se todos acionistas nela estiverem presentes.

Artigo 10 - A Assembleia Geral será convocada por qualquer Diretor e presidida pelo Diretor Presidente ou, na sua ausência ou impedimento, por qualquer Diretor ou acionista indicado por escrito pelo Diretor Presidente. Caso o Diretor Presidente não realize tal indicação, o presidente da Assembleia Geral será escolhido por maioria de votos dos acionistas presentes. O presidente da Assembleia Geral indicará até 02 (dois) Secretários.

Artigo 11 – Compete à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei:

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Santos Moraes De Burgos e Fabian Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26011512122839400000157198388> e utilize o código E330-A366-1178-F368.

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Santos Moraes De Burgos e Fabian Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26011512122839400000157198388> e utilize o código E330-A366-1178-F368.



- I. eleger e destituir os Diretores da Companhia;
- II. fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;
- III. tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas;
- IV. aprovar a emissão de ações ou quaisquer valores mobiliários conversíveis em ações da Companhia, conforme aplicável, por um valor inferior ao valor justo de mercado;
- V. deliberar a respeito de reforma do Estatuto Social;
- VI. deliberar a respeito de qualquer aditamento ou alteração do objeto social da Companhia;
- VII. deliberar a respeito da criação de uma ou mais novas classes de ações ou da conversão de qualquer classe de ações existente da Companhia;
- VIII. deliberar sobre qualquer plano de dissolução, liquidação, auto-falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou dissolução da Companhia;
- IX. deliberar sobre qualquer reestruturação societária da Companhia, quer por incorporação, incorporação de ações, cisão, fusão, recapitalização, transformação ou qualquer outra forma;
- X. atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos de ações;
- XI. aprovar planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos seus administradores e empregados ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou à sociedade sob seu controle, assim como aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia;
- XII. deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos;
- XIII. eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação;
- XIV. deliberar sobre a emissão de debêntures, observado o disposto na Lei de Sociedades por Ações;
- XV. aprovar quaisquer transações a serem realizadas pela Companhia ou qualquer de suas subsidiárias com, ou envolvendo, quaisquer de seus acionistas ou qualquer afiliada de seus acionistas (exceto pela Companhia ou qualquer de suas subsidiárias) ou qualquer parte relacionada de qualquer acionista da Companhia, exceto por qualquer transação que esteja sujeita a disposições comutativas usuais no Brasil;
- XVI. autorizar a Companhia a prestar garantias a obrigações de terceiros que não sejam sociedades controladas pela Companhia, exceto quando se tratar de fiança locatícia para empregados da Companhia;
- XVII. aprovar qualquer alienação de bens ou direitos do ativo permanente cujo valor da alienação deste(s) seja igual ou superior a R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); e
- XVIII. aprovar a criação de ônus reais sobre os bens ou direitos da Companhia ou a outorga de garantias a terceiros, observado o disposto no inciso xvi acima.

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Santos Moraes De Burgos e Fabian Rodra. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portal.dados.abn.intel.com.br> e utilize o código E930-A386-1178-F36B.

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Santos Moraes De Burgos e Fabian Rodra.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portal.dados.abn.intel.com.br> e utilize o código E930-A386-1178-F36B.



CAPÍTULO IV DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

Seção I Das Disposições Gerais

Artigo 12 - A Companhia será administrada por uma Diretoria, de acordo com as disposições legais aplicáveis e o presente Estatuto.

Parágrafo Primeiro - A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado no Livro de Atas de Reunião de Diretoria, assinado pelo Administrador empossado, dispensada qualquer garantia de gestão, e está condicionada ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.

Parágrafo Segundo - Os administradores, quando da investidura em seus cargos, deverão prestar as declarações exigidas pela regulamentação pertinente.

Parágrafo Terceiro - A Assembleia Geral fixará uma verba global anual para a remuneração dos administradores e caberá à Assembleia Geral deliberar sobre a distribuição da verba individualmente, observado o disposto neste Estatuto.

Seção II Da Diretoria

Artigo 13 - A Diretoria será composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 4 (quatro) Diretores, dentre os cargos, conforme abaixo, sendo um deles, necessariamente, o Diretor Presidente:

- (i) 1 (um) Diretor Presidente;
- (ii) 1 (um) Diretor Financeiro;
- (iii) 1 (um) Diretor Jurídico;
- (iv) 1 (um) Diretor de Capital Humano.

É permitida a cumulação de cargos. Todos com atribuições definidas na forma do art. 16 e parágrafos deste estatuto social.

Parágrafo Primeiro - Os Diretores serão eleitos para mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos.

Parágrafo Segundo - Os membros da Diretoria não reeleitos permanecerão no exercício dos respectivos cargos até a posse dos novos Diretores.

Parágrafo Terceiro - Na hipótese de impedimento definitivo ou vacância do cargo de Diretor, a Assembleia Geral deverá ser imediatamente convocada para eleição de substituto.

Parágrafo Quarto - A ausência ou impedimento de qualquer Diretor por período contínuo superior

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Santos Moraes De Bargas e Fabian Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://amit.portaldessinalizaras.com.br> e utilize o código E930 A386-1178-F30B.

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Santos Moraes De Bargas e Fabian Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://amit.portaldessinalizaras.com.br> e utilize o código E930 A386-1178-F30B.



a 30 (trinta) dias, acarretará o término do respectivo mandato, aplicando-se o disposto no Parágrafo Terceiro deste artigo, exceto se de outra forma autorizado pela Assembleia Geral.

Parágrafo Quinto - Um Diretor não poderá substituir, simultaneamente, mais do que um outro Diretor.

Artigo 14 - A Diretoria reunir-se-á por convocação de seu Diretor Presidente ou por quaisquer 02 (dois) Diretores em conjunto, sempre que os interesses sociais assim exigirem.

Parágrafo Único - Todas as deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no respectivo livro da Diretoria Executiva e assinadas pelos Diretores presentes.

Artigo 15 - Compete aos Diretores:

- I. administrar e gerir os negócios da Companhia, podendo estabelecer Política de Delegação de Alçada própria;
- II. deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral, quando julgar conveniente, ou no caso do Artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações;
- III. rever e atualizar as práticas de administração e gestão da Companhia, tendo em vista as necessidades de ampliação dos negócios, as modernas técnicas de administração e as conquistas da medicina;
- IV. aprovar a abertura e encerramento de filiais, escritórios, centros médicos e quaisquer outros estabelecimentos relacionados ao objeto social da Companhia, no País ou no exterior;
- V. cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações da Assembleia Geral de Acionistas;
- VI. submeter, anualmente, à apreciação da Assembleia Geral, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de aplicação dos lucros apurados no exercício anterior;
- VII. aprovar os resultados trimestrais das operações da Companhia e suas controladas;
- VIII. aprovar qualquer alienação de bens ou direitos do ativo permanente cujo valor da alienação deste(s) seja igual ou maior que R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e inferior a R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais);
- IX. deliberar sobre qualquer reestruturação societária das subsidiárias da Companhia, quer por incorporação, incorporação de ações, cisão, fusão, recapitalização, transformação ou qualquer outra forma;
- X. deliberar sobre a prestação de fiança locatícia para empregados da Companhia.

Artigo 16 - Além das funções, atribuições e poderes atribuídos pela Assembleia Geral, os Diretores terão as seguintes atribuições:

Parágrafo Primeiro - Compete ao Diretor Presidente dirigir a execução das atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia, coordenar e supervisionar as atividades

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Santos Moraes De Burgos e Fabien Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://emil.portaldestassinaturas.com.br> e utilize o código E930-A368-1175-F368

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Santos Moraes De Burgos e Fabien Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://emil.portaldestassinaturas.com.br> e utilize o código E930-A368-1175-F368



de administração da Companhia, elaborar e apresentar à Assembleia Geral o plano anual de negócios e o orçamento anual da Companhia, convocar e presidir as reuniões da Diretoria e representar a Companhia ativa e passivamente, em juízo ou fora dele.

Parágrafo Segundo - Compete ao Diretor Financeiro propor alternativas de financiamento, empréstimo e concessão de garantias, aprovar condições financeiras dos negócios da Companhia, administrar o caixa e as contas a pagar e a receber da Companhia, dirigir as áreas contábil, de planejamento financeiro e fiscal, representar a Companhia perante instituições financeiras e auxiliar o Diretor Presidente no que for necessário.

Parágrafo Quinto - Compete ao Diretor Jurídico coordenar, administrar, dirigir e supervisionar a área jurídica da Companhia, planejar, propor e implantar políticas e atuações da Companhia em questões jurídicas, supervisionar e coordenar os serviços jurídicos da Companhia, opinar sobre a contratação de advogados externos, representar a Companhia em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades Federais, Estaduais e Municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista, entidades paraestatais, e entidades e sociedades privadas e auxiliar o Diretor Presidente no que for necessário.

Parágrafo Sexto - Compete ao Diretor de Capital Humano gerir o quadro de pessoal da Companhia, tendo em vista assegurar a correspondência entre a composição e o perfil dos recursos humanos e as necessidades empresariais, elaborar, implementar e controlar as normas e diretrizes do plano de cargos e salários, de benefícios, de recrutamento e seleção de pessoal e auxiliar o Diretor Presidente no que for necessário.

Artigo 17 - A Companhia será representada da seguinte forma:

- (a) Por quaisquer 2 (dois) Diretores, em conjunto;
- (b) Por qualquer Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes específicos;
- (c) Por 2 (dois) procuradores com poderes específicos, em conjunto; e
- (d) Por 1 (um) procurador nos mandatos com cláusula "ad judicium", bem como naqueles que demandem poderes específicos por exigência legal ou a critério da Companhia.

Parágrafo único - As procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia por quaisquer 2 (dois) Diretores, em conjunto. As procurações outorgadas pela Companhia mencionarão expressamente os poderes conferidos e deverão conter um período de validade limitado, não superior a 12 (doze) meses, com exceção daqueles para fins judiciais, que poderão ter prazo indeterminado.

Seção III Do Conselho Fiscal

Artigo 18 - O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os poderes e atribuições a ele conferidos por lei, e somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido dos acionistas, nas hipóteses previstas em lei.

Parágrafo Primeiro - O Conselho Fiscal da Companhia com as atribuições estabelecidas em lei

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Santos Moraes De Burgos e Fabian Roche. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://pamf.portaldassinaturas.com.br> e utilize o código 8220-A385-1170-F368.

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Santos Moraes De Burgos e Fabian Roche.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://pamf.portaldassinaturas.com.br> e utilize o código 8220-A385-1170-F368.



será composto de 03 (três) a 05 (cinco) membros e igual número de suplentes.

Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho Fiscal terão o mandato unificado de 01 (um) ano, podendo ser reeleitos.

Parágrafo Terceiro - Os membros do Conselho Fiscal, em sua primeira reunião, elegerão o seu Presidente.

Parágrafo Quarto - A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado no Livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal da Companhia, assinado pelo membro do Conselho Fiscal empossado, condicionada ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.

Parágrafo Quinto - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos pelo respectivo suplente.

Parágrafo Sexto - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar; não havendo suplente, a Assembleia Geral será convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago.

Artigo 19 - Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre que necessário e analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras.

Parágrafo Primeiro - Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal.

Parágrafo Segundo - O Conselho Fiscal se manifesta por maioria absoluta de votos, presente a maioria dos seus membros.

Parágrafo Terceiro - Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos Conselheiros presentes.

Parágrafo Quarto - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral Ordinária que os eleger, observado o Parágrafo Terceiro do Artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações.

CAPÍTULO V DAS RELAÇÕES COM OS ACIONISTAS E PARTES RELACIONADAS

Artigo 20 - Todo e qualquer acordo de acionistas existente entre os acionistas da Companhia, bem como os contratos com partes relacionadas e programas de aquisição de ações e de outros títulos e valores mobiliários da Companhia, deverão ser arquivados na sede social da Companhia e disponibilizados aos acionistas da Companhia que desejem ter acesso ao seu conteúdo.

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Santos Moraes De Albuquerque e Fabian Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://amfportaldeassinaturas.com.br> e utilize o código E930-A385-117A-F36B.

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Santos Moraes De Albuquerque e Fabian Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://amfportaldeassinaturas.com.br> e utilize o código E930-A385-117A-F36B.



CAPÍTULO VI
DO EXERCÍCIO SOCIAL, DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
E DE RESULTADOS

Artigo 21 - O exercício social se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada ano.

Parágrafo Único - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria elaborará as demonstrações financeiras da Companhia, com observância dos preceitos legais pertinentes, que deverão ser auditadas por auditores independentes devidamente registrados na Comissão de Valores Mobiliários, observadas as normas então vigentes.

Artigo 22 - Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, a Diretoria apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, calculado após a dedução das participações referidas no Artigo 190 da Lei das Sociedades por Ações, ajustado para fins do cálculo de dividendos nos termos do Artigo 202 da mesma lei, observada a seguinte ordem de dedução:

- a) 5% (cinco por cento) serão aplicados antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social. No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido do montante das reservas de capital, de que trata o Parágrafo Primeiro do artigo 182 da Lei das Sociedades por Ações, exceder 30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal;
- b) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores, nos termos do artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações;
- c) uma parcela será destinada ao pagamento do dividendo anual mínimo obrigatório aos acionistas;
- d) no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, observado o disposto no artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações;
- e) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações; e
- f) a Companhia manterá a reserva de lucros estatutária denominada "Reserva de Expansão", que terá por fim financiar a expansão das atividades da Companhia e/ou de suas empresas controladas e coligadas, inclusive por meio da subscrição de aumentos de capital ou criação de novos empreendimentos, a qual será formada com até 100% (cem por cento) do lucro líquido que remanescer após as deduções legais e estatutárias e cujo saldo, somado aos saldos das demais reservas de lucros, excetuadas a reserva de lucros a realizar e a reserva para contingências, não poderá ultrapassar 100% (cem

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Santos-Morais De Burgos e Fabian Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código E83D-A388-1178-F368.

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Santos-Morais De Burgos e Fabian Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código E83D-A388-1178-F368.



por cento) do capital social subscrito da Companhia.

Parágrafo Primeiro - Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo obrigatório anual não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado na forma prevista no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.

Parágrafo Segundo - A Assembleia Geral poderá atribuir aos membros da Diretoria uma participação nos lucros, desde que o seu total não ultrapasse a remuneração anual dos administradores nem 10% (dez por cento) dos lucros, prevalecendo o limite que for menor, nos casos, forma e limites legais.

Parágrafo Terceiro - Caso o saldo das reservas de lucros ultrapasse o capital social, a Assembleia Geral deliberará sobre aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital social ou, ainda, na distribuição de dividendos aos acionistas.

Artigo 23 - Por proposta da Diretoria, aprovada pela Assembleia Geral, poderá a Companhia pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio destes últimos, observada a legislação aplicável. As eventuais importâncias assim desembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo obrigatório previsto neste Estatuto Social.

Parágrafo Primeiro - Em caso de creditamento de juros aos acionistas no decorrer do exercício social e atribuição dos mesmos ao valor do dividendo obrigatório, os acionistas serão compensados com os dividendos a que têm direito, sendo-lhes assegurado o pagamento de eventual saldo remanescente. Na hipótese do valor dos dividendos ser inferior ao que lhes foi creditado, a Companhia não poderá cobrar dos acionistas o saldo excedente.

Parágrafo Segundo - O pagamento efetivo dos juros sobre o capital próprio, tendo ocorrido o creditamento no decorrer do exercício social, se dará por deliberação da Assembleia Geral, no curso do exercício social ou no exercício seguinte, mas nunca após as datas de pagamento dos dividendos.

Artigo 24 - A Companhia poderá levantar balanço semestral, ou em períodos inferiores, e declarar, por deliberação da Assembleia Geral:

- (a) dividendo ou juros sobre capital próprio, à conta do lucro apurado em balanço semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver, e
- (b) dividendo ou juros sobre capital próprio à conta de lucro apurado em balanço relativo a período inferior a 06 (seis) meses, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver, desde que o total de dividendo pago em cada semestre do exercício social não exceda ao montante das reservas de capital.

Parágrafo Único - A Companhia poderá, ainda, por deliberação da Assembleia Geral, declarar dividendo intermediário ou juros sobre capital próprio, à conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Santos Moraes De Burgos e Fabian Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://amfportalassinaturas.com.br> e utilize o código E930-A366-1173-F36B.

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Santos Moraes De Burgos e Fabian Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://amfportalassinaturas.com.br> e utilize o código E930-A366-1173-F36B.



houver.

Artigo 25 - Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 03 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia.

CAPÍTULO VII DO JUÍZO ARBITRAL

Artigo 26 - Qualquer discrepância, litígio, controvérsia ou demanda decorrentes ou relacionados a este estatuto, incluindo, dentre outros, assuntos relativos à sua validade, interpretação, cumprimento, implementação, rescisão ou qualquer violação (doravante denominado "Litígio") deverá ser exclusiva e definitivamente resolvido, sem recurso à apelação, por meio de arbitragem definitiva e vinculativa. A arbitragem deverá ser instruída e conduzida na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, onde a sentença arbitral será proferida. A arbitragem será administrada pela Corte Internacional de Arbitragem da Câmara Internacional do Comércio (doravante denominada "ICC") de acordo com as normas da ICC ("Câmara de Arbitragem" e "Normas de Arbitragem").

Artigo 27 - A arbitragem deverá ser conduzida em inglês, apesar de documentos e testemunho poderem ser apresentados em outros idiomas, juntamente com tradução.

Artigo 28 - A Câmara de Arbitragem deverá ser formada por três árbitros. O primeiro árbitro deverá ser nomeado pela parte requerente. O segundo árbitro deverá ser nomeado pela parte demandada. O terceiro árbitro deverá ser nomeado pelos árbitros nomeados pelas duas partes em 15 (quinze) dias contados a partir da data de confirmação do árbitro nomeado pela segunda parte. Se qualquer uma das partes deixar de nomear um árbitro no período exigido, ou se os dois árbitros não conseguirem chegar a um acordo sobre o terceiro árbitro dentro dos prazos aplicáveis, a nomeação deverá ser feita pela ICC de acordo com as Normas de Arbitragem. Caso o Litígio envolva mais de uma parte requerente, essas partes requerentes deverão conjuntamente nomear o primeiro árbitro. Caso o Litígio envolva mais de uma parte requerida, essas partes requeridas deverão conjuntamente nomear o segundo árbitro.

Artigo 29 - Os acionistas e a Companhia concordam com a consolidação das arbitragens iniciadas conforme os termos previstos neste estatuto ou no Acordo de Acionistas em vigor ("Acordo de Acionistas") ou qualquer Acordo com Partes Relacionados (conforme definido no Acordo de Acionistas), conforme as Normas de Arbitragem.

Artigo 30 - Qualquer decisão da Câmara de Arbitragem deverá ser apresentada por escrito e informar os motivos nos quais foi fundamentada (em cada caso, doravante denominada uma "Decisão Final"). A Decisão Final deverá ser definitiva e vinculativa às partes e seus sucessores, e uma sentença sobre tal Decisão Final poderá ser reconhecida e executada em qualquer tribunal competente. Os custos da arbitragem e outras despesas razoáveis e documentadas das partes vencedoras da arbitragem, incluindo os honorários advocatícios razoáveis, deverão ser arcados

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Santos Moraes De Burgois e Fabian Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://amf.portaldesignaturas.com.br> e utilize o código E93D-A366-1176-F36B.

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Santos Moraes De Burgois e Fabian Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://amf.portaldesignaturas.com.br> e utilize o código E93D-A366-1176-F36B.



conforme determinado pela Câmara de Arbitragem.

Artigo 31 - Assim que o processo tiver sido transmitido a ela, a Câmara de Arbitragem poderá, a pedido de uma parte, sentenciar qualquer medida provisória ou cautelar que julgar apropriada. A Câmara de Arbitragem poderá sujeitar a concessão de uma medida à apresentação de garantia apropriada pela parte requerente. Qualquer medida em questão deverá tomar a forma de uma ordem, apresentando os motivos, ou de uma decisão parcial, conforme a Câmara de Arbitragem julgar apropriado. Antes de o processo ser transmitido à Câmara de Arbitragem, e mesmo subsequentemente em circunstâncias adequadas, as partes poderão requerer a qualquer autoridade judicial competente medidas provisórias ou cautelares. O requerimento de uma parte a qualquer autoridade judicial por tais medidas ou pela implementação de medidas ordenadas pela Câmara de Arbitragem não deverá ser considerada como uma infração ou renúncia ao acordo de arbitragem, tampouco deverá afetar os poderes necessários atribuídos à Câmara de Arbitragem.

Artigo 32 - A promessa dos acionistas e da Companhia de resolver todos os Litígios conforme os termos aqui previstos é feita em contraprestação de promessa similar da outra parte. Os acionistas e a Companhia concordam que a entrega de qualquer processo, citação, notificação ou documento nos respectivos endereços das partes previstos na cláusula 11.02 do Acordo de Acionistas deverá consistir uma entrega efetiva de citação no que se refere a qualquer ação, medida ou processo instaurado conforme os termos do presente estatuto. Os detalhes ou a existência de quaisquer Litígios, quaisquer processos e reuniões formais ou informais realizados conforme este estatuto, e qualquer descoberta feita em relação à arbitragem, deverão ser mantidos em sigilo absoluto e não poderão ser divulgados nem discutidos com terceiros (excluindo os advogados, contadores, seguradoras e outros agentes e representantes da parte pertinente, conforme razoavelmente exigido em relação a qualquer processo de solução de Litígio aqui previsto), salvo conforme de outro modo exigido por qualquer lei ou norma de bolsa de valores em que as ações de uma parte sejam negociadas, e conforme exigido nos processos judiciais para a execução ou desconsideração da decisão arbitral.

CAPÍTULO VIII DA DISSOLUÇÃO OU DA LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA

Artigo 33 - A Companhia será dissolvida ou entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assembleia Geral estabelecer a forma de liquidação e eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, fixando seus poderes e estabelecendo suas remunerações, obedecidas as formalidades legais.

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Santos Moraes De Búrgho e Fabiano Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portalpje.jus.br/portalpje/assinaturas> com o código E93B-A366-1178-F36B.

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Santos Moraes De Búrgho e Fabiano Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portalpje.jus.br/portalpje/assinaturas> com o código E93B-A366-1178-F36B.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://amil.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E930-A386-1178-F36B> ou vá até o site <https://amil.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E930-A386-1178-F36B



Hash do Documento

4490C00A5DEEF24CBAC85C1C6956601FC790619467CA3175D6ACC04373502930

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/12/2024 é(são) :

- ☒ Ricardo Santos Moraes De Burgos (Vice-Presidente de Capital Humano) - 041.480.486-45 em 13/12/2024 16:49 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Fabian Rocha (Vice-Presidente Jurídico) - 116.844.158-70 em 13/12/2024 16:37 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital



SUBSTABELECIMENTO

Substabelecete

Na forma dos poderes que me foram conferidos por **AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.309.127/0001-79, situada na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, no 105, 6º aos 21º andares, Torre B, Empreendimento EZ Towers, Vila São Francisco, Cidade e Estado de São Paulo, CEP: 04711-904, por sua advogada que esta subscreve **YASMIN BREHMER HANDAR**, brasileira, advogada, inscrita na OAB/PR 97.751, sócia do escritório **SEIXAS ADVOGADOS**, com sede na SHIS, QL 24, conjunto 9, casa 20, CEP: 71.665-095, Brasília/DF, e-mail: acessotribunais@seixasadv.com, **SUBSTABELEÇO**, com reservas, os(as) advogados(as):

Substabelecidos

Ana Beatriz Vieira Cipriano Gomes – OAB/DF 72.519
Brunna da Silva Carvalho de Paula – OAB/DF 74.631
Fábio Araujo de Oliveira – OAB/DF 80.182

para tanto, podendo firmar compromissos e acordos, transigir, confessar, receber e dar quitação em nome da outorgante, prestar depoimento, assinando quaisquer documentos para o fiel cumprimento da Outorgante a proceder às diligências necessárias nos autos, vedado o recebimento de qualquer intimação por parte do substabelecido, devendo as intimações serem efetuadas unicamente em nome da advogada subscritora do presente.

Brasília | DF, 16 de dezembro de 2025

YASMIN BREHMER HANDAR
OAB/DF nº 64.819
OAB/PR nº 97.751
OAB/AP nº 5.448
OAB/SE nº 1.754 A
OAB/SP nº 535.137



CARTA DE PREPOSIÇÃO

Preponente

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.309.127/0001-79, situada na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, no 105, 6º aos 21º andares, Torre B, Empreendimento EZ Towers, Vila São Francisco, Cidade e Estado de São Paulo, CEP: 04711-904, por sua advogada que esta subscreve **YASMIN BREHMER HANDAR**, brasileira, advogada, inscrita na OAB/PR 97.751, sócia do escritório **SEIXAS ADVOGADOS**, com sede na SHIS, QL 24, conjunto 9, casa 20, CEP: 71.665-095, Brasília/DF, e-mail: acessotribunais@seixasadv.com, nomeia e constitui como prepostos(as):

Prepostos

Juliana Vieira da Cruz Silva, inscrito(a) no CPF sob o nº 038.614.095-26;
Larissa Leite Santana, inscrito(a) no CPF sob o nº 050.425.215-18,
Thainá Mascarenhas Bispo, inscrito(a) no CPF sob o nº 064.918.755-55;
Sandy Leite Santana, inscrito(a) no CPF sob o nº 050.425.205-46;
Jeane Alencar Santana Bahia, inscrito(a) no CPF sob o nº 009.700.745-57.

Brasília | DF, (Data da assinatura eletrônica)

YASMIN BREHMER HANDAR
OAB/DF nº 64.819
OAB/PR nº 97.751
OAB/AP nº 5.448
OAB/SE nº 1.754 A
OAB/SP nº 535.137



AO JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS, DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS - MA

Processo nº 0801310-44.2026.8.10.0001

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA FERNANDES, representado por seu genitor **ALESSANDRO MACIEL FERNANDES**, vem, através seu procurador infra-assinado, declarar ciência da decisão liminar proferida em **ID. 169486445** e informar o **AGUARDADO DE SEU CUMPRIMENTO POR PARTE DOS RÉUS, visto que até o presente momento não houve**. Em contato feito com a ouvidoria da AMIL, registrado através do protocolo nº 32630520260114013897, estes afirmaram que a demanda estava sob supervisão do jurídico e estes se manifestariam nos autos. Quanto ao Hospital São Domingos, em diligência presencial, realizada por este subscritor, na data de 13/01/2026, fora solicitado o envio da decisão liminar através dos e-mails informados por estes, o que fora cumprido pela parte autora, conforme documento, em anexo.

Por fim, se requer o prosseguimento do feito.

Termos em que pede deferimento.

São Luís - MA, 14 de janeiro de 2025.

Jefferson Carneiro de Oliveira Júnior

OAB/MA 25.841





Jefferson Oliveira Jr. <jeffersonoliveirajr.adv@gmail.com>

Decisão

1 mensagem

Jefferson Oliveira Jr. <jeffersonoliveirajr.adv@gmail.com> 13 de janeiro de 2026 às 14:34
Para: internacao.emergencia@dasa.com.br
Cc: juridicocivel.hospitais@dasa.com.br, emergenciahsd@dasa.com.br

Prezados,

Boa tarde!

Segue decisão liminar.

At.te

 **Decisão.pdf**
64K



MM. Juízo,

Ciente o MPMA, pelo Promotor de Justiça signatário, da decisão liminar de id. 169486445.

De acordo o MPMA por atender ao superior interesse da criança.

Manifesta-se pelo prosseguimento do feito.

São Luís, data da assinatura eletrônica.

ROSALVO BEZERRA DE LIMA FILHO

Promotor de Justiça respondendo





ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS
1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS
Fórum "Des. Sarney Costa" (7º Andar) - Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, CEP 65076-820
Telefone (98) 2055 2516 / Email: secinf1_slz@tjma.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - [Tratamento médico-hospitalar]
Processo Judicial Eletrônico n.º 0801310-44.2026.8.10.0001
REQUERENTE: ALESSANDRO MACIEL FERNANDES e outros
REQUERIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE: **AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.**, na pessoa de seu **representante legal**, com endereço no(a) **Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, andar 6º ao 21º - Torre B, empreendimento Ez Towers, Vila São Francisco (Zona Sul), São Paulo/SP – CEP: 04711-904, nesta cidade.**

FINALIDADE: 1. **Citá-lo** para querendo, **contestar no prazo de 15 (quinze) dias** a presente ação; 2. **Intimá-lo(s)** a fim de que, tome ciência da decisão proferida nos autos mencionados.

ANEXOS: Cópia da petição inicial e da decisão.

SEDE DO JUÍZO: Secretaria Judicial da 1ª Vara da Infância e Juventude, Av. Prof. Carlos Cunha, s/n.º, 7º andar, Calhau - Fórum Des. Sarney Costa, nesta cidade.

Eu, Waldemir Cardoso Alves, Técnico Judiciário, digitei, subscrevi e assino de ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca, José Américo Abreu Costa, com fulcro nos artigos 247 c/c 270, ambos do CPC, o presente mandado que será encaminhado via domicílio judicial eletrônico.

São Luís - MA, 13/01/2026.

Waldemir Cardoso Alves

Técnico Judiciário da 1ª Vara da Infância e Juventude do Termo Judiciário de São Luís
(Documento assinado eletronicamente nos termos da Lei Federal n.º 11.419/2006)





ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS
1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS
Fórum "Des. Sarney Costa" (7º Andar) - Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, CEP 65076-820
Telefone (98) 2055 2516 / Email: secinf1_slz@tjma.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - [Tratamento médico-hospitalar]
Processo Judicial Eletrônico n.º 0801310-44.2026.8.10.0001
REQUERENTE: ALESSANDRO MACIEL FERNANDES e outros
REQUERIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE: **HOSPITAL SÃO DOMINGOS**, com endereço no(a) **Av. Jerônimo de Albuquerque, nº 540, Bequimão, nesta cidade.**

FINALIDADE: 1. **Citá-lo** para querendo, **contestar no prazo de 15 (quinze) dias** a presente ação; 2. **Intimá-lo(s)** a fim de que, tome ciência da decisão proferida nos autos mencionados.

ANEXOS: Cópia da petição inicial e da decisão.

SEDE DO JUÍZO: Secretaria Judicial da 1ª Vara da Infância e Juventude, Av. Prof. Carlos Cunha, s/n.º, 7º andar, Calhau - Fórum Des. Sarney Costa, nesta cidade.

Eu, Waldemir Cardoso Alves, Técnico Judiciário, digitei, subscrevi e assino de ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca, José Américo Abreu Costa, com fulcro nos artigos 247 c/c 270, ambos do CPC, o presente mandado que será encaminhado via domicílio judicial eletrônico.

São Luís - MA, 13/01/2026.

Waldemir Cardoso Alves

Técnico Judiciário da 1ª Vara da Infância e Juventude do Termo Judiciário de São Luís
(Documento assinado eletronicamente nos termos da Lei Federal n.º 11.419/2006)





ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS

Processo n.º 0801310-44.2026.8.10.0001

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Nesta data, nos termos do Provimento n.º 22/2018 da CGJMA, INTIMO eletronicamente o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para que se manifeste nos autos como fiscal da ordem jurídica. São Luís, 13/01/2026.

WALDEMIR CARDOSO ALVES

Tecnico Judiciario Sigiloso



Processo n.º 0801310-44.2026.8.10.0001 | PJE

Tipo de ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

Autor: SEGREDO DE JUSTIÇA

Advogado do(a) AUTOR: JEFFERSON CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MA25841

Advogado do(a) REPRESENTANTE LEGAL: JEFFERSON CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MA25841

Requerido: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Ato disponibilizado no DJE nos termos do Provimento n.º 39/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão: Nesta data, realizo a intimação da PARTE AUTORA, por intermédio de seus representantes legais, para ciência e cumprimento da deliberação judicial de id n.º 169486445, podendo o seu inteiro teor ser visualizada por meio do sistema PJE. São Luís, 13/01/2026. WALDEMIR CARDOSO ALVES, Tecnico Judiciario Sigiloso da 1ª Vara da Infância e Juventude de São Luís.



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS
1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS

Processo nº 0801310-44.2026.8.10.0001

VISTOS

Autos em correição. Nada a regularizar.

I. Análise da inicial

1.1. Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer c/c pedido de Reparação de Danos Morais c/c Tutela de Urgência, ajuizada por José Henrique da Silva Fernandes, representado por seu genitor Alessandro Maciel Fernandes, em face de Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Hospital São Domingos LTDA, pelos fatos e fundamentos descritos na prefacial.

1.2. Em síntese, segundo a petição inicial, o infante, nascido em 06/03/2025, deu entrada no Hospital São Domingos no dia 11/01/2026, pois apresentou quadro de tosse ladrante, febre e intensa prostração. O médico assistente indicou a necessidade de internação em UTI pediátrica, contudo houve a negativa da OPS sob a alegação de que o contrato ainda se encontrava em período de carência. Diante do grave quadro de saúde, requer que a OPS autorize e custeie a internação do infante e todo o tratamento indicado (Id. 169408191)

1.3. Decisão da Vara de Saúde Suplementar (Id. 169415667), declarando a incompetência e determinando a redistribuição dos autos para esta Unidade Judicial.

II. Fundamentação

Da tutela de urgência



2.1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige os requisitos normativos clássicos: a) probabilidade do direito e (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Passo à análise dos pressupostos em referência.

Da probabilidade do direito

2.2. A probabilidade do direito invocado pela parte autora ficou evidenciada nos autos, conforme a prova documental alojada à prefacial no Id. 169408191. Há laudo médico atualizado (Id. 169408196) indicando de forma clara a necessidade da internação do infante prescrito pela pediatra dra. Antonia de Jesus Barros de Sousa – CRM 2336. O quadro de saúde do infante evidencia a urgência da internação (Id. 169408196).

2.3. Portanto, conforme a médica assistente, devido à necessidade de monitorização hospitalar, suporte de oxigênio e administração de medicamento de uso exclusivo hospitalar, o infante necessita da internação (Id. 169408196).

2.4. Oportuno ressaltar que a Constituição Federal, no artigo 227, garante a proteção integral de crianças e adolescentes. Essa obrigação vincula a sociedade, a família e o Estado. O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, nos artigos 7º e 11º, garantem o direito à vida e saúde da população infantoadolescente, incluindo atendimento médico através do sistema único de saúde (SUS).

2.5. A Lei 9.656/98, que disciplina sobre os planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde, em seu art. 12, II, alíneas a e b e V, alínea c, definem que é assegurada a cobertura do atendimento de internação hospitalar, sendo obedecida o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas, nos casos de urgência e emergência. *In verbis*:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] II - quando incluir internação hospitalar: a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; [...] b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente; [...] V - quando fixar períodos de carência: [...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [...] e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; [...]

2.6. Neste sentido, o artigo 35-C da Lei nº 9.656/98 estabelece que a operadora de plano de saúde tem obrigação de garantir cobertura nos atendimentos de urgência e emergência, especialmente quando houver risco imediato à vida ou possibilidade de lesão grave ao paciente:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; [...]



2.7. Assim, os requisitos do instituto aplicável a este caso estão plenamente demonstrados.

O perigo de dano no caso concreto

2.9. O perigo de dano previsto no artigo 300 do CPC, pressupõe a existência da ocorrência de um dano urgente, atual e capaz de frustrar o direito, caso não concedida a medida pugnada. Neste caso, a urgência é evidente. A ausência de autorização da internação pode ocasionar piora no quadro de saúde do infante, inclusive com risco à vida deste.

2.10. In casu, há perigo de dano no caso concreto, o demandado não autorizou a internação do infante, apesar de o laudo médico apontar a necessidade (Id. 169408196). A ausência de autorização viola frontalmente o princípio de acesso à saúde.

Das medidas garantidoras do cumprimento da medida liminar

2.11. O escopo teleológico de toda decisão judicial reside na sua eficácia no plano prático, sob pena de violação do princípio da obrigatoriedade da jurisdição, consagrado no artigo 5º XXXV, da Constituição Federal Brasileira. No plano da existência, quem procura a Justiça espera um provimento favorável; uma vez obtido, sua execução é decorrência naturalística e lógica da tutela constitucional e processual efetivada. Certeza obriga!

2.12. Pois bem. Concedida e tutela antecipada de urgência, espera-se que a parte suplicada, Amil Assistência Médica Internacional, cumpra tempestivamente as determinações deste Juízo, todavia, é cediço que em diversas situações - quase a sua totalidade - o requerido não dá cumprimentos às deliberações deste Órgão Jurisdicional. Neste sentido, não havendo o cumprimento da medida liminar, esbarramos, mais uma vez, numa conduta cujas consequências são extremamente negativas para o Estado de Direito, pois desafiar a eficácia das decisões judiciais é provocar um desequilíbrio no sistema móvel da Justiça, gerando uma insegurança que se configura como nefasta semente da desordem social e individual, germen nocivo da própria anomia, da ausência ou desrespeito coletivo das normas em vigor.

2.13. Diante desse desequilíbrio no sistema da eficácia dos provimentos judiciais, as leis adjetivas indicam mecanismos próprios e eficazes de restauração do Estado de Direito. No país, o atual Código de Processo Civil estabelece como meios seguros e cogentes da eficácia das decisões judiciais *“as providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”* (artigo 497 do CPC).

2.14. De todas as dimensões da vida, a que mais exsurge como urgente e carecedora de um provimento judicial imediato é a saúde. Por razões ávidas, pois a sobrevivência, para além de um dado instintual, é dever sacrossanto do Estado de Direito. Neste sentido, os Tribunais Superiores, notadamente o E. Superior Tribunal de Justiça, pacificou entendimento segundo o qual:



“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE - CUSTEIO DE INTERNAÇÃO - DESCUMPRIMENTO REITERADO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES - MEDIDA COERTIVA - NECESSIDADE - Com base no artigo 297, CPC, o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória - O não cumprimento da tutela permite seja determinado o bloqueio de valores a fim de que seja cumprida a medida deferida. (TJ-MG - AI: 25684612720228130000, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 13/04/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-mg/1810384831>)”

2.15. Ressalta-se, ainda, a jurisprudência maranhense aplicável ao tema:

“A jurisprudência das Cortes Superiores tem mitigado o comando legal e admitido o bloqueio de verbas públicas em situações excepcionais, mormente quando se trata de debelar risco iminente ao direito à vida e à saúde do administrado. Reputa-se lícito ao Julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado de tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão legal de as hipóteses fáticas. 7. Agravo de instrumento conhecido e improvido. 8. Unanimidade (Agravo de Instrumento nº 0803177-56.2018.8.10.0000, 5ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Ricardo Dualibe, Dje, 23.10.2018)”. In www.jurisplenum.com.br.

Dos Princípios da Instrumentalidade das Formas e da Concentração dos Atos Processuais

2.16. Conforme o art. 188 do CPC, os atos e termos judiciais independem de forma determinada, salvo quando a lei o exigir, sendo considerados válidos aqueles que, embora praticados de modo diverso, alcancem sua finalidade essencial. Neste sentido, o dispositivo consagra o Princípio da Instrumentalidade das Formas, segundo o qual, inexistindo exigência legal específica, o ato judicial será reputado válido sempre que cumprir a finalidade essencial.

2.17. Portanto, é possível inferir que, com base no Princípio da Instrumentalidade das Formas, tendo em vista que o objetivo da presente liminar é satisfazer o bem essencial da saúde da parte autora, mostra-se necessário consignar neste ato a possibilidade do bloqueio judicial de verbas, acaso os requeridos não cumpram as determinações emanadas por este Juízo.

III. Comando judicial

3.1. Ante o exposto, defiro a medida liminar pleiteada e determino que o demandado autorize e custeie integralmente a internação e todos os procedimentos necessários para a manutenção e preservação da vida do infante José Henrique da Silva Fernandes, de forma imediata, a contar da intimação desta decisão, com a garantia de tratamento e atendimento integral e especializado.



3.2. Em caso de descumprimento fixo multa diária no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, a ser revertida para o FMDCA.

3.3. Em caso de descumprimento da obrigação no prazo estipulado no item 3.1, determino o bloqueio de valores via SISBAJUD e BRBJud, em contas vinculadas ao CNPJ da parte requerida, no montante necessário para o custeio do tratamento inicial de 03 (três meses), condicionado à apresentação de orçamento atualizado.

3.4. Determino a citação dos requeridos para, querendo, apresentarem contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

3.5. Dada a urgência da presente situação, esta decisão servirá como mandado judicial.

3.6. Expedientes necessários. Cumpra-se.

São Luís, data registrada no sistema.

JOSÉ AMÉRICO ABREU COSTA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Infância e Juventude do Termo Judiciário de São Luís





VARA DA SAÚDE SUPLEMENTAR DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS

Endereços: Av. Prof. Carlos Cunha, s/n - Calhau, São Luís - MA, 65076-905 - Telefone: (98) 2055-2495 - E-mail: varasaudesup_slz@tjma.jus.br

Processo nº : 0801310-44.2026.8.10.0001

Parte Autora : ALESSANDRO MACIEL FERNANDES e outros

Parte Ré : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

TERMO DE REMESSA

CERTIFICO que, em cumprimento à determinação judicial faço remessa dos autos para a 1ª Vara da Infância e Juventude de São Luís.

O acima disposto é verdade e dou fé.

São Luís(MA), Segunda-feira, 12 de Janeiro de 2026.

PEDRO BERGE CUTRIM FILHO

Diretor de Secretaria



VARA DE SAÚDE SUPLEMENTAR DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS

Endereços: Av. Prof. Carlos Cunha, s/n - Calhau, São Luís - MA, 65076-905 - Telefone: (98) 2055-2495- E-mail: varasaudesup_slz@tjma.jus.br

PROCESSO: 0801310-44.2026.8.10.0001

AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: J. H. D. S. F. (REP. ALESSANDRO MACIEL FERNANDES)

Advogado do(a) AUTOR: JEFFERSON CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB MA25841

Advogado do(a) REPRESENTANTE LEGAL: JEFFERSON CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB MA25841

REU: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., HOSPITAL SAO DOMINGOS LTDA.

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO

Trata-se de ação ordinária com pedido liminar de urgência ajuizada por J. H. D. S. F., criança, neste ato representada por seu pai, ALESSANDRO MACIEL FERNANDES, em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e HOSPITAL SAO DOMINGOS LTDA, qualificados nos autos.

Narra o autor que titular de plano de saúde da primeira requerida e deu entrada na emergência do segundo requerido em 11 de janeiro de 2026, apresentando quadro clínico grave de tosse ladrante, febre e prostração intensa.

Relatar que houve requisição médica para internação imediata em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido ao risco iminente à saúde e necessidade de suporte de oxigênio e monitorização, o que, entretanto, foi negado pela operadora de plano de saúde sob o fundamento de carência contratual, mantendo a negativa mesmo após tentativa de resolução administrativa via protocolo nº 32630520260111001721.

Requer, em sede liminar, que a operadora ré seja compelida a autorizar/custear a internação de urgência necessária ao reestabelecimento de sua saúde.

É o relatório. Decido.

A Vara de Saúde Suplementar do termo judiciário de São Luís, criada pela Lei



Complementar nº 283, de 24 de fevereiro de 2025, é competente para processar e julgar as ações referentes a planos, seguros e serviços de Saúde privados, qualquer que seja o valor da causa, **ressalvada a competência das Varas da Infância e Juventude, quando se tratar de menor incapaz em situação de risco ou vulnerabilidade** (art. 9º, XX do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Maranhão).

Por outro lado, o art. 9º, inciso I, do referido Código de Divisão e Organização Judiciária (LC 14/91), confere competência à 1ª Vara da Infância e da Juventude de São Luís para apreciação das demandas cíveis e administrativas definidas na legislação específica.

Com efeito, em atenção ao disposto no art. 209 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), tem-se a competência absoluta dos Juízos da Infância e Juventude a apuração de eventual ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente referentes ao não oferecimento ou oferta irregular de “*acesso às ações e serviços de saúde*” (art. 208, inciso VII do ECA).

No mesmo sentido é o disposto no inciso IV do art. 148 do ECA, que atribui à Vara da Infância e da Juventude competência para “conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos, afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209”.

Diante disso, versando a presente ação sobre eventual dever do plano de saúde de custeio de tratamento médico da autora, criança de 10 meses que necessita de internação hospitalar (ID 169408196) em evidente situação de risco, face o seu estado de saúde, o objeto da demanda é matéria afeta a competência especializada das Varas da Infância e Juventude, restando configurada a competência absoluta acima delineada, devendo os autos serem remetidos ao juízo competente, observada as determinações legais, sob pena de operar-se trabalho nulo de pleno direito.

Ante o exposto, **declaro a incompetência deste juízo** para processar e julgar esta demanda, e **determino a redistribuição dos autos** para a 1ª Vara da Infância e Juventude de São Luís, com a devida baixa no sistema desta unidade.

Intime-se. Cumpra-se com urgência.

São Luís, data da assinatura eletrônica.

Odete Maria Pessoa Mota Trovão

Juíza de Direito, respondendo pela Vara de Saúde Suplementar



**AO JUÍZO DA VARA DE SAÚDE SUPLEMENTAR DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS,
DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS - MA**

Benefício da Justiça Gratuita

Tutela de Urgência de Natureza Antecipada

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA FERNANDES, brasileiro, solteiro, menor impúbere, inscrito no CPF sob nº 131.904.983-42, representado neste ato por meu genitor e representante legal, o sr. **ALESSANDO MACIEL FERNANDES**, brasileiro, casado, gerente administrativo, portador do RG nº 0207343620025/SESP-MA, inscrito no CPF sob nº 051.521.763-86, residente e domiciliado na Rua 4G, nº 04, Cidade Operária, São Luís/MA – CEP: 65058-247, vem, por intermédio de seus advogados constituídos, que abaixo subscrevem (Doc. 01 – pág.: 01), à presença de Vossa Excelência, por força do art. 319 do CPC, propor a presente:

**—AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c —
TUTELA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARS”**

em face de **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 29.309.127/0001-79, sediada à Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, andar 6º ao 21º - Torre B, empreendimento Ez Towers, Vila São Francisco (Zona Sul), São Paulo/SP – CEP: 04711-904, com endereço eletrônico: amiljuridicoemergencial@uhgbrasil.com.br e **HOSPITAL SAO DOMINGOS LTDA**, sociedade empresaria limitada, inscrita no CNPJ sob nº 11.006.293/0001-30, sediada na Avenida Jeronimo de Albuquerque, nº 540, Bequimão, São Luís/MA – CEP: 65060-645, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:



I. DOS FATOS

O menor, devidamente representado por seu responsável legal, é **usuário titular do plano de saúde** administrado pelo **primeiro requerido**, encontrando-se regularmente vinculado e adimplente com as obrigações contratuais assumidas.

No dia **11 de janeiro de 2025**, o menor deu entrada na **emergência do Hospital São Domingos, segundo requerido**, apresentando **quadro clínico grave**, caracterizado por **tosse ladrante, febre e intensa prostração**, sintomas que indicavam risco iminente à sua saúde.

Após a devida avaliação médica, o profissional responsável **requisitou a imediata internação do menor em Unidade de Terapia Intensiva (UTI)**, diante da **necessidade de monitorização hospitalar intensiva, suporte contínuo de oxigênio**, bem como **administração medicamentosa adequada**, medidas indispensáveis à preservação de sua vida e integridade física (**Doc. 05**).

Todavia, após a requisição médica, o plano de saúde, ora primeiro requerido, negou a autorização para a internação em UTI e para a realização dos procedimentos necessários, sob a alegação de suposta carência contratual (Doc. 06).

Em ato contínuo, o genitor entrou em contato com o plano de saúde, através do protocolo de nº **32630520260111001721**, onde mantiveram a negativa e se negaram em formalizar por e-mail.

Tal negativa mostrou-se **manifestamente ilegal e abusiva**, sobretudo por se tratar de **atendimento de urgência/emergência**, envolvendo **paciente menor de idade**, em situação de risco concreto, circunstância que afasta qualquer limitação contratual fundada em período de carência.

Diante da recusa injustificada do plano de saúde em garantir o tratamento prescrito pelo médico assistente, não restou alternativa aos representantes legais do menor senão recorrer ao Poder Judiciário, a fim de assegurar o direito fundamental à saúde e à vida, bem como o imediato custeio da internação e dos procedimentos indicados.

II. DA PRELIMINAR DE MÉRITO

2.1 Benefício da Justiça Gratuita



Inicialmente, pleiteia o requerente pelos benefícios da assistência judiciária gratuita, assegurados pela Constituição Federal (art. 5º, LXXIV), pela Lei 1.050/60 e Lei 13.105/2015 (art. 98 e seguintes), tendo em vista não poder arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, visto que em sua residência apenas seu genitor está empregado, tendo que arcar com despesas de plano de saúde e demais despesas do menor e da residência.

III. DO DIREITO

3.1 Da aplicação do CDC - Da Inversão do Ônus da Prova – Sumula 608 do STJ.

Inicialmente, verifica-se que o presente caso trata-se de relação de consumo, sendo amparada pela lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que trata especificamente das questões em que fornecedores e consumidores integram a relação jurídica, principalmente no que concerne à matéria probatória.

Trata-se de negócio jurídico em que o réu assume a obrigação de garantir contra os riscos à saúde e a cobertura da prestação de serviços médico hospitalares em favor dos beneficiários do plano, mediante remuneração, enquadrando-se perfeitamente nos conceitos legais de consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor) - que definem a natureza da relação contratual de consumo.

O beneficiário é consumidor, pois utiliza os serviços na condição de destinatário final (art. 2º), enquanto, que, o réu se enquadra na definição de fornecedor, uma vez que presta serviços (art. 3º) de assistência à saúde ao beneficiário, sendo esses serviços prestados mediante remuneração (parágrafo 2º do art. 3º).

Não há dúvida, assim, de que o Plano de Saúde Individual/Familiar reveste todas as características de um típico contrato de consumo e, como tal, deve ser regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, o STJ já se pronunciou através da **Súmula 608: “Aplica-se o Código de**



Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Pertinente ainda a aplicação da disciplina do Código de Defesa do Consumidor quanto a Cláusula que limita a realização de exames de emergência, alegando período de carência do plano, configurando-se extremamente abusiva, por colocar em desvantagem exagerada o beneficiário, ora consumidor, infringindo assim o artigo 51, IV do CDC.

Tal legislação, ainda faculta ao magistrado determinar a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme seu artigo 6º, VIII:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII- A facilitação da defesa de seus direitos, **inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor**, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência" (grifamos).

Da simples leitura deste dispositivo legal, verifica-se, sem maior esforço, ter o legislador conferido ao arbítrio do juiz, de forma subjetiva, a incumbência de presentes o requisito da verossimilhança das alegações ou quando o consumidor for hipossuficiente, poder inverter o ônus da prova.

Assim, presentes a verossimilhança do direito alegado e a hipossuficiência da parte autora para o deferimento da inversão do ônus da prova no presente caso, dá-se como certo seu deferimento.

3.2 Da Obrigação de Fazer – Internação imediata

Como bem informado no tópico dos fatos, o menor encontra-se acometido por quadro clínico grave e complexo, apresentando tosse ladrante, febre persistente e intensa prostração, sintomas estes que, conforme expressamente consignado em requisição médica, indicam risco iminente à sua saúde e à própria vida, exigindo internação imediata em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A conduta médica especializada foi clara ao atestar a necessidade imperiosa de cuidados intensivos, diante da possibilidade de



rápida evolução do quadro respiratório, o que inviabiliza qualquer demora ou substituição do tratamento indicado. A negativa/omissão no cumprimento da requisição médica expõe o menor a perigo concreto e atual, configurando violação aos direitos fundamentais à vida e à saúde, assegurados pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, bem como pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que consagra a prioridade absoluta na proteção da criança e do adolescente.

Diante da urgência e da gravidade do quadro clínico apresentado, impõe-se a condenação dos requeridos à obrigação de fazer, consistente na imediata internação do menor em leito de UTI, em unidade pública ou privada, às suas expensas, enquanto perdurar a indicação médica, como medida indispensável à preservação da saúde e da vida do paciente.

3.3 Da Responsabilidade Objetiva dos Réus - Do Dano Moral ocasionado

Os danos morais suportados pelo requerente tornam-se evidentes diante dos fatos que deram origem a presente ação. Eles decorrem da injustificada ausência de prestação dos serviços de saúde contratado pelo requerente quando este mais necessitou do atendimento, diante do estado de saúde com **tosse ladrante, febre e intensa prostração**, sintomas que indicam risco iminente à sua saúde. Tais sintomas, a princípio, podem direcionar para diversos problemas e doenças do trato respiratório.

Tal falha na prestação dos serviços é causa de danos morais porque abala diretamente o estado psicológico causando grande aflição e angústia aos genitores do requerente e desconforto patente do menor.

Vale salientar que é requerente tem apenas 10 meses de vida, portanto, necessita de monitoramento constante e eficaz.

A negativa de internação em UTI, em atendimento de emergência, por parte do plano, em virtude da alegação de carência, é medida ilegal e caracteriza dano moral, conforme vasta jurisprudência pátria, senão vejamos:

PLANO DE SAÚDE – **Negativa de cobertura – Autor de tenra idade, diagnosticado com infecções agudas das vias aéreas superiores de localizações múltiplas não especificadas, com prescrição de internação em UTI**



Pediátrica, o que torna inequívoco o caráter emergencial do atendimento - Negativa de cobertura com fundamento na vigência do período de carência da contratação - Recusa indevida, prolongando a dor e o risco desnecessariamente do paciente dispensando maiores descrições, por ser presumido o dano decorrente do risco - Dano moral in re ipsa - Caracterização – Valor bem

fixado – Honorários advocatícios que devem incidir sobre o custo total da internação e a indenização por dano moral - Recurso do autor provido em parte e desprovida a apelação da Operadora.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1014158-17.2022.8 .26.0020 São Paulo, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 16/05/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2024).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. **NEGATIVA QUANTO À INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA RELATADA PELA SOLICITAÇÃO MÉDICA QUE PREVALECE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO.** MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO CONSOANTE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Em situação de excepcionalidade, dado o caráter de urgência e emergência, é devida a cobertura integral da internação não autorizado pelo plano de saúde. 2. Há nexo de causalidade entre o ato ilícito, que consistiu na não autorização da internação na UTI pediátrica, e o dano moral experimentado, razão pela qual resta configurado o dever de indenizar. 3. In casu, observando os parâmetros assegurados por esta Corte de Justiça em casos semelhantes, relativo à tratamento de saúde em caso de urgência, há de ser mantida a importância indenizatória fixada na sentença. 4. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp



173.860/MS, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04/02/2016, DJe 18/05/2016) 5. Apelo conhecido e desprovido.

(TJ-RN - AC: 08054241920178205124, Relator.: VIRGILIO FERNANDES DE MACEDO JUNIOR, Data de Julgamento: 27/01/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/02/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. **CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA.** Sentença de parcial procedência, para determinar às rés a cobertura da internação e de todos e quaisquer procedimentos médicos de que tenha precisado ou ainda precise a autora por causa do fato que substância a demanda. RECURSO DA RÉ NOTRE DAME. Preliminar de ausência de interesse de agir da autora para a propositura da demanda afastada. Operadora que confirmou, em todas as manifestações, a negativa da internação em razão de prazo de carência. Elementos dos autos que também apontam nesse sentido. Mérito. Insurgência que não prospera. Incontrovertida a necessidade de internação em caráter emergencial, constante expressamente dos relatórios médicos e não impugnado de forma específica pela operadora. **É abusiva a negativa de cobertura em atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de que está em curso período de carência que não seja o prazo de 24 horas estabelecido na Lei n. 9.656/98. Inteligência das Súmulas 597 do STJ e 103 deste Tribunal.** Limitação da internação hospitalar em 12 horas de atendimento que também se revela abusiva. **Aplicabilidade da Súmula 302 do STJ. Precedentes.** RECURSO DA AUTORA. Acolhimento parcial. A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano moral in re ipsa. Entendimento do STJ nesse sentido. Fixação em R\$ 10



.000,00, em observância às peculiaridades do caso e aos precedentes desta Câmara. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ NOTRE DAME. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO." (v. 40696)

(TJ-SP - AC: 10000046820228260545 SP 1000004-68.2022.8 .26.0545, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 25/11/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022).

Especificamente em nosso estado, o **Tribunal de Justiça - TJMA** também vem entendendo pela ilegalidade na negativa de atendimento de urgência e emergência, em virtude de cláusula contratual de carência do plano, arbitrando, inclusive, danos morais no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), como caráter **compensatório e pedagógica, bem como o porte econômico e conduta desidiosa da seguradora**. Vejamos julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. **NEGATIVA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. URGÊNCIA. CARÊNCIA. DESCABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL.** RECURSO IMPROVIDO. 1. A Lei n.º 9.656/98 - que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde - excepciona nos artigos 12, inciso V, alínea 'c' e 35-C, inciso I, o cumprimento do prazo de carência para cobertura de emergência, que implicar em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, passando a carência a ser de 24 (vinte e quatro) horas. 2. *In casu*, a apelante cometeu ato ilícito ao recusar atendimento à apelada, baseando-se em cláusulas contratuais relativas a prazos de carência que desbordam da legislação de regência (Lei n.º 9.656/98), quando o grave quadro clínico da paciente reclamava atendimento de urgência. 3. "Embora geralmente o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava



a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada" (STJ, REsp 1411293/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 12/12/2013). 4. Nas hipóteses de injusta recusa do plano de saúde, "(...) não há necessidade de comprovação do sofrimento ou do abalo psicológico numa situação como essa, sendo presumida a sua ocorrência, configurando o chamado dano moral *in re ipsa*" (AgRg no REsp 1243202/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 24/06/2013). Precedentes do STJ. **5. Na espécie, não se mostra desarrazoada ou desproporcional a fixação do quantum indenizatório em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando, para tanto, sua dupla função (compensatória e pedagógica), o porte econômico e conduta desidiosa da seguradora.** Precedentes do STJ e deste Tribunal. 6. Apelação improvida.

(TJ-MA - AC: 00531528220158100001 MA 0322752019, Relator.: KLEBER COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 21/11/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2019 00:00:00).

Por fim, em mesma toada, entendimento da nossa **Corte Superior**, acerca do tema em comento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). **2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de ser abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência**



ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recusa de cobertura que enseja indenização por danos morais. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2002772 DF 2022/0142011-3, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022).

Dessa forma, não resta menor dúvida que o requerente sofreu abalo psíquico em razão de todo o ocorrido, já que tem apenas 10 meses de idade, necessitando, portanto, com urgência, da internação na UTI e o acompanhamento necessário.

Dito isto, torna-se demasiadamente crível o sofrimento, a aflição, o desalento do requerente, que em todos os meses do ano assiste a cobrança da mensalidade do plano de saúde, que é paga sempre rigorosamente, mas quando realmente necessita usá-lo, vê-se desamparado.

Resta demonstrada, assim, a relação de causalidade entre a negativa injustificada de atendimento por falha na prestação do serviço contrato e o sofrimento experimentado pelo requerente, de tal modo que os requeridos têm o dever de indenizar o dano moral provocado.

Nada obstante, é notória ainda a responsabilidade objetiva dos requeridos, a qual independe do grau de culpabilidade, uma vez que incorrem em lamentáveis falhas, gerando o dever de indenizar, pois houve defeito relativo à prestação de serviços. O Código de Defesa do Consumidor consagra a matéria em seu artigo 14, dispondo que:

Art. 14. **O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços**, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos

Além do CDC, o dano moral, encontra embasamento no artigo 5º, incisos V e X da Constituição Federal, e artigos 186 e 927 do Código Civil que dispõem:



Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

V- é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.

X- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927 – Aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Imperativo, portanto, que o requerente seja indenizado pelo abalo moral em decorrência dos atos ilícitos praticados, em razão de ter sido vítima de completa e total falha e negligência dos demandados.

A análise quanto da fixação do *quantum* indenizatório deve observar ainda outros parâmetros, destacando-se o poderio financeiro das partes culpadas, com o objetivo de desestimular a prática dos atos abusivos e ilegais.

Sendo assim, pugna-se pelo reconhecimento da **responsabilidade objetiva** dos réus acerca do dano moral ocasionado, bem como a fixação do *quantum* indenizatório em **R\$ 10.000,00 (dez mil reais)**.

IV. DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA “INAUDITA ALTERA PARS”.

Conforme exaustivamente demonstrado pelo arcabouço jurídico-probatório, a negativa de realização do exame por parte da Amil e do Hospital São Domingos fora indevido, visto que não observou o prazo de



carência de 24 horas, determinado pelo art. 12, inciso V da Lei 9.656/98, para casos de urgência e emergência.

Desse modo, é imperioso que as empresas rés, Amil e Hospital São Domingos, sejam compelidas imediatamente a autorizar a internação na UTI, garantindo todo o suporte necessário no tratamento, inclusive com suporte de oxigênio e administração medicamentosa.

Nessa linha, o artigo 300 do Código de Processo Civil vigente estabelece que:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu, certamente se encontram preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Quanto à **PROBABILIDADE DO DIREITO**, o autor juntou aos autos a requisição médica (**Doc. 05**), informando a necessidade de internação na UTI, acompanhada da negativa por parte do plano de saúde, tanto por aplicativo (**Doc. 06**) como por telefone, conforme protocolo acima informado, demonstrando assim a urgência no procedimento, somado à jurisprudência pátria e o direito constitucional à saúde, que tornam prováveis o direito cuja efetivação se requer.



Já no tocante ao **PERIGO DE DANO**, é notório que a não autorização de internação na UTI, para uma criança acometida por doença respiratória e com 10 meses de idade, irá agravar ainda mais o quadro de saúde, com severos riscos de piora e possíveis sequelas graves, à exemplo uma parada cardiorespiratória.

Outrossim, convém ressaltar que **não há perigo de irreversibilidade da obrigação de fazer**, ou seja, da obrigação de autorização e realização do exame, pelo plano e hospital, respectivamente. Isso porque além de ser um direito do autor, caso o pleito seja improcedente (o que se admite apenas por hipótese), a operadora de plano de saúde poderá cobrar do mesmo o valor correspondente.

De suma importância a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada *inaudita altera pars*, bem como a fixação de multa pecuniária no sentido de coibir o descumprimento da liminar que, por certo, com base nos fundamentos expostos, será deferida, nos termos dos arts. 537 do CPC/2015 e 84 do CDC, *in fine*:

Art. 537. A **multa** independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, **em tutela provisória** ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja **suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.**

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará **providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.**

(...)

§ 3º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao Juiz conceder a tutela liminarmente (...).

§ 4º. O Juiz poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, **impor multa diária ao réu, independentemente de pedido**



**do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação,
fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.**

Ante o exposto, requer a Vossa Excelência a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, a fim de determinar que a internação do menor em UTI e o acompanhamento e procedimentos necessário sejam autorizados e realizados, pelo plano de saúde e hospital, respectivamente, **sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 (mil reais), esta a ser revertida a parte autora.**

V. DOS REQUERIMENTOS

Ex positis, se requer de Vossa Excelência:

- A)** A concessão do benefício de **Gratuidade de Justiça**, com espeque no art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal de 1988 e art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, haja vista a impossibilidade econômica e financeira do autor de arcar com as custas, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família;
- B)** A concessão da **TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPA “inaudita altera pars”**, determinando que as requeridas, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A e HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA, autorize e realize a internação do menor em UTI, respectivamente, no prazo mais curto possível, **sob pena de multa diária no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais);**
- C)** A citação das requeridas, na pessoa de seus representantes legais, no endereço declinado para, querendo, contestarem os termos da presente, sob pena de revelia;
- D)** Determinar a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor em razão da vulnerabilidade e da hipossuficiência do autor em face das requeridas,



sendo **invertido o ônus da prova** nos termos do art. 6º, VIII, do diploma em comento;

E) Ao final, que se mantenha a tutela deferida, **mantendo-se a autorização e realização da internação do menor em UTI e todo o acompanhamento necessário, solicitado em caráter de urgência e/ou emergência**, nos termos contratados pelo requerente;

F) Que sejam condenadas as requeridas ao pagamento do valor de **R\$ 10.000,00 (dez mil reais)** a título de compensação pelos danos morais suportados pelo consumidor, em atenção aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, e com vistas ao caráter preventivo-pedagógicos e punitivo reparador;

G) A condenação das requeridas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de **20% (vinte por cento)** sobre o valor da causa, além de juros de 1% ao mês e correção monetária, devidos até a data do efetivo pagamento.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas e cabíveis à espécie, especialmente pelos documentos acostados, depoimento testemunhal, oitiva das partes e perícia, caso se faça necessário, sem excluir qualquer outro que seja necessário.

Dá-se à presente o valor de **R\$ 10.000,00 (dez mil reais)**.

Termos em que pede deferimento.

São Luís – MA, 11 de janeiro de 2026.

Rodrigo César Altenkirch Borba Pessoa

OAB/MA nº 6.127

Jefferson Carneiro de Oliveira Júnior

OAB/MA nº 25.841

João Gabriel Dias da Silva

OAB/MA nº 25.618



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA FERNANDES, brasileiro, solteiro, menor impúbere, inscrito no CPF sob nº 131.904.983-42, representado neste ato por meu genitor e representante legal, o sr. **ALESSANDO MACIEL FERNANDES**, brasileiro, casado, gerente administrativo, portador do RG nº 0207343620025/SESP-MA, inscrito no CPF sob nº 051.521.763-86, residente e domiciliado na Rua 4G, nº 04, Cidade Operária, São Luís/MA – CEP: 65058-247.

OUTORGADOS: RODRIGO CESAR ALTENKIRCH BORBA PESSOA, brasileiro, casado, advogado, inscrito nos quadros da **OAB/MA sob nº 6.127**; **JEFFERSON CARNEIRO DE OLIVEIRA JÚNIOR**, brasileiro, casado, advogado, inscrito nos quadros da **OAB/MA sob nº 25.841** e **JOÃO GABRIEL DIAS DA SILVA**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito nos quadros da **OAB/MA sob nº 25.618**, integrantes da sociedade **ALTENKIRCH, OLIVEIRA & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS**, inscrita no CNPJ sob nº 48.840.587/0001-73 e na OAB/MA sob nº 1.554, com endereço eletrônico e físico descritos no rodapé deste documento.

PODERES: O outorgante concede aos outorgados os poderes da cláusula “**ad judicia et extra**”, para o **foro geral**, podendo, portanto, promover quaisquer medidas no âmbito judicial ou administrativo, assinar termo, substabelecer com ou sem reserva de poderes e, praticar ainda, todos e quaisquer atos necessários e convenientes ao bom e fiel desempenho deste mandato, por efeito do art. 105 do CPC. A presente procuração outorga ainda aos advogados acima descritos, os **poderes específicos** para, em nome do(a) outorgante, receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso, assinar declaração de hipossuficiência econômica, pedir justiça gratuita, bem como levantar e/ou receber alvará, por força do art. 334, §10º. Tais poderes específicos acima outorgados poderão ou não ser substabelecidos.

São Luís – MA, 11 de janeiro de 2026.

Assinado digitalmente via ZapSign por
ALESSANDO MACIEL FERNANDES
Data 11/01/2026 14:29:14.915 (UTC-0300)

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA FERNANDES

Representado por **ALESSANDO MACIEL FERNANDES**

☎ (98) 3301-5334

✉ contato@aosadvogados.adv.br

📍 Avenida Jerônimo de Albuquerque, nº 27, Ed. Trade Center II, sala 104, Cohafuma (Curva do 90), São Luís/MA
ZapSign e588a13c-7878-4c24-a659-cd829827c80c. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Número do documento: 26011115445314100000156901291

<https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26011115445314100000156901291>

Assinado eletronicamente por: JEFFERSON CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - 11/01/2026 15:44:53

Num. 169408192 - Pág. 1

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA

Eu, **JOSÉ HENRIQUE DA SILVA FERNANDES**, brasileiro, solteiro, menor impúbere, inscrito no CPF sob nº 131.904.983-42, representado neste ato por meu genitor e representante legal, o sr. **ALESSANDO MACIEL FERNANDES**, brasileiro, casado, gerente administrativo, portador do RG nº 0207343620025/SESP-MA, inscrito no CPF sob nº 051.521.763-86, residente e domiciliado na Rua 4G, nº 04, Cidade Operária, São Luís/MA – CEP: 65058-247, **DECLARO**, através de meu genitor, para fins de prova junto ao Poder Judiciário do Estado do Maranhão, que sou carente de recursos, não dispondo de condições econômicas para custas e despesas de processos judiciais, bem como honorários advocatícios, sem sacrifício do meu sustento e de minha família. Por ser a expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade pelas declarações acima e sob as penas da lei, assino, através de meu genitor, a presente declaração para que produza seus efeitos legais.

São Luís – MA, 11 de janeiro de 2026.



Declarante

Assinado digitalmente via ZapSign por
ALESSANDO MACIEL FERNANDES
Data 11/01/2026 14:29:14.915 (UTC-0300)



Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 11 Janeiro 2026, 14:29:15



Status: Assinado
Documento: Doc. 01 - Procuração E Declaração De Hipossuficiência - José Henrique Da Silva Fernandes.Pdf
Número: e588a13c-7878-4c24-a659-cd829827c80c
Data da criação: 11 Janeiro 2026, 14:17:22
Hash do documento original (SHA256): b0583b8cd505d33440859ab66b01742643e1fe3a94095bfd03512f9616b3e776



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora ALESSANDO MACIEL FERNANDES Data e hora da assinatura: 11/01/2026 14:29:14 Token: 11b4ceea-6369-4aba-be43-bb02dd2b93fc		Assinatura
Pontos de autenticação: Telefone: + 5598988274397 E-mail: sandromf26@gmail.com		ALESSANDO MACIEL FERNANDES
		IP: 177.54.139.175 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número e588a13c-7878-4c24-a659-cd829827c80c, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign e588a13c-7878-4c24-a659-cd829827c80c. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Número do documento: 26011115445314100000156901291
<https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26011115445314100000156901291>
Assinado eletronicamente por: JEFFERSON CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - 11/01/2026 15:44:53



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS



CERTIDÃO DE NASCIMENTO
JOSÉ HENRIQUE DA SILVA FERNANDES

MATRÍCULA:
031385 01 55 2025 | 00648 152 0281708 15

CPF:
131.904.983-42

DATA DE NASCIMENTO POR EXTENSO DIA MÊS ANO
QUINTA-FEIRA, SEIS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO 06 03 2025

HORA NATURALIDADE
17:26 SÃO LUÍS - MA

MUNICÍPIO DE REGISTRO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO LOCAL DE NASCIMENTO SEXO
SÃO LUÍS - MA MACMA, SÃO LUÍS - MA MASCULINO

FILIAÇÃO
ALESSANDRO MACIEL FERNANDES
MAYSA CALDAS DA SILVA

AVÓS
ADILSON PESTANA FERNANDES e ANA CRISTINA SOUZA MACIEL
ISAC CALDAS SILVA e IDELMARA BATISTA DA SILVA

GÊMEO NOME E MATRÍCULA DO(S) GÊMEO(S)
Não ND

DATA DO REGISTRO POR EXTENSO NÚMERO DA DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO
SEGUNDA-FEIRA, DEZ DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO 30901490220
ÀS 12:25

OBSERVAÇÕES E AVERBAÇÕES
Não há.

CARTÓRIO DA 4ª ZONA - MARLY SARNEY
ENOCH RIBEIRO DE VASCONCELOS - REGISTRADOR OFICIAL
DA 4ª ZONA
SÃO LUÍS - MA
AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, 205, COHAB

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
SÃO LUÍS, 10 de Março de 2025.

Poder Judiciário - TJMA - Selo:
REGN50013850ZNU09MPW1BVA-U70, 10/03/2025
12:20:10, Atx: 14.e, Partes(s): JOSE HENRIQUE DA SILVA
FERNANDES, Total R\$ 0,00 Emol R\$ 0,00 FERC R\$ 0,00
FADEP R\$ 0,00 FEMP R\$ 0,00 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Adriana de Fátima Rodrigues Padilha
ADRIANA DE FÁTIMA RODRIGUES PADILHA

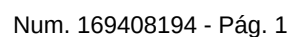
Adriana de Fátima Rodrigues Padilha
Escritorinha Juramentada
Cartório 4ª Serventia

ARPENBRASIL BA 031857457 BRP



I<BRA05648D141<4D1<<<<<<<<<<<<
9311262M320B162BRA<<<<<<<<<<<<2
ALESSANDRO<<MACIEL<FERNANDES<<

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM

ALESSANDRO MACIEL FERNANDES
R 4G 04
CIDADE OPERARIA
65058-247 SAO LUIS MA

Seu número Claro
98 98827 4397

Período de uso
de 20/10/2025 a 19/11/2025

Vencimento
12/12/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

- 1. Plano Contratado R\$ 65,58
- 2. Outros Lançamentos R\$ 71,43

Total a pagar R\$ 137,01

MENSAGENS IMPORTANTES:
O Ajuste SINIEF nº 25/2025 permite prorrogar, até agosto de 2026, a obrigatoriedade da NFCom, mais informações sobre elegibilidade e aplicações, consulte no site www.claro.com.br/danfe.

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.claro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braille ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO	VALOR R\$
Oferta Conjunta Claro MIX	65,58
Aplicativos Digitais	
Claro Controle 15GB [163] - de 20/10/2025 a 10/11/2025	
Claro Controle 15GB [163] - de 12/11/2025 a 19/11/2025	
Fidelidade até 26/05/2023	
Serviços Inclusos no seu Plano	
15GB de Internet do seu plano	
Bônus de relacionamento promocional - 6GB	
Instagram, Facebook e Twitter ilimitados sem descontar da internet do seu plano	
Ligações Ilimitadas com o código 21	
Waze ilimitado sem descontar da internet do seu plano	
WhatsApp ilimitado sem descontar da internet do seu plano	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 65,58

2. OUTROS LANÇAMENTOS	VALOR R\$
Débitos Anteriores - Ref 11/2025	69,24
Juros	0,69
Multa	1,50
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 71,43

TOTAL A PAGAR R\$ 137,01

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 28473751/112025		
Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Claro banca Premium		5,87

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
ALESSANDRO MACIEL FERNANDES

Débito Automático
153315764

Data de Vencimento
12/12/2025

Valor
R\$ 137,01



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

Pág. 1/ 4

Nome: Jose Henrique da Silva Fernandes

Dt. Nasc.: 06/03/2025

Idade: 10m 3d

Data: 11/01/2026

CRIANÇA 10 MESES DEU ENTRADA EM GRANDE SALA COM TOSSE LADRANTE E FEBRE E PROSTAÇÃO

REG, ACIANÓTICO, ANICTÉRICO, FEBRIL, NORMOCORADO, SUDOREICO, CHOROSO, DESCONFORTO RESPIRATORIO

AR: MV PRESENTE, ESTRIDOR LARÍNGEO

MENOR PRECISA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DEVIDO NECESSIDADE DE MONITORIZAÇÃO HOSPITALAR, SUPORTE DE OXIGENIO E ADIMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO EXCLUSIVO HOSPITALAR


ANTONIO DE JESUS BARROS DE SOUSA
CRM 2336

Antonio de Jesus Barros de Sousa
CRM 2336

Hospital São Domingos Ltda. - Fone (98) 3216-8100R. Jerônimo de Albuquerque, 540 São Luis - Maranhão - CEP 65060-642



MEU HSD
* Baixe o aplicativo que ajuda a cuidar de você

WHATSAPP HSD
Agende também seus exames através do nosso Whatsapp





HOSPITAL SAO DOMINGOS

INTERNAÇÃO - PEDIÁTRICA

Pedido: 487139417

Protocolo: 326305202601114871394171

Data: 11/01/2026



Procedimento/Serviço

SEQUÊNCIA 1

11/01/2026



Atendimento Do Intensivista Diarista (Por Dia E Por Paciente)

Quantidade: 1

Situação: Não Validado

Executante: HOSPITAL SAO DOMINGOS

Atendimento Médico Do Intensivista Em Uti Geral Ou Pediátrica (Plantão De 12 Horas - Por Paciente)

Quantidade: 2

Situação: Não Validado

Executante: HOSPITAL SAO DOMINGOS

Motivo: Beneficiário em carência para o proce...

DIÁRIA DE UTI INFANTIL/PEDIÁTRICA

Quantidade: 1

Situação: Não Validado

Executante: HOSPITAL SAO DOMINGOS

DIÁRIA DE ACOMPANHANTE SOMENTE COM CAFÉ DA MANHÃ

Quantidade: 1

Situação: Não Validado





Detalhes das etapas da solicitação



SOBRE O PROCEDIMENTO

Sequência 1

Protocolo

326305202601114871394171

Procedimento

Atendimento Do Intensivista Diarista (Por Dia E Por Paciente)

Atendimento Médico Do Intensivista Em Uti Geral Ou Pediátrica (Plantão De 12 Horas - Por Paciente)

DIÁRIA DE UTI INFANTIL/PEDIÁTRICA

DIÁRIA DE ACOMPANHANTE SOMENTE COM CAFÉ DA MANHÃ



Etapas da solicitação



Recebemos o seu pedido
11/01/2026



Analizando seu contrato
11/01/2026



Análise técnica
11/01/2026





Detalhes Token

Paciente)

DIÁRIA DE UTI INFANTIL/PEDIÁTRICA

DIÁRIA DE ACOMPANHANTE SOMENTE COM CAFÉ
DA MANHÃ



Etapas da solicitação



Recebemos o seu pedido

11/01/2026



Analizando seu contrato

11/01/2026



Análise técnica

11/01/2026



Compra de material

11/01/2026



Análise Concluída

11/01/2026



Motivo da devolução



Carência contratual



Beneficiário em carência contratual para o
procedimento solicitado

